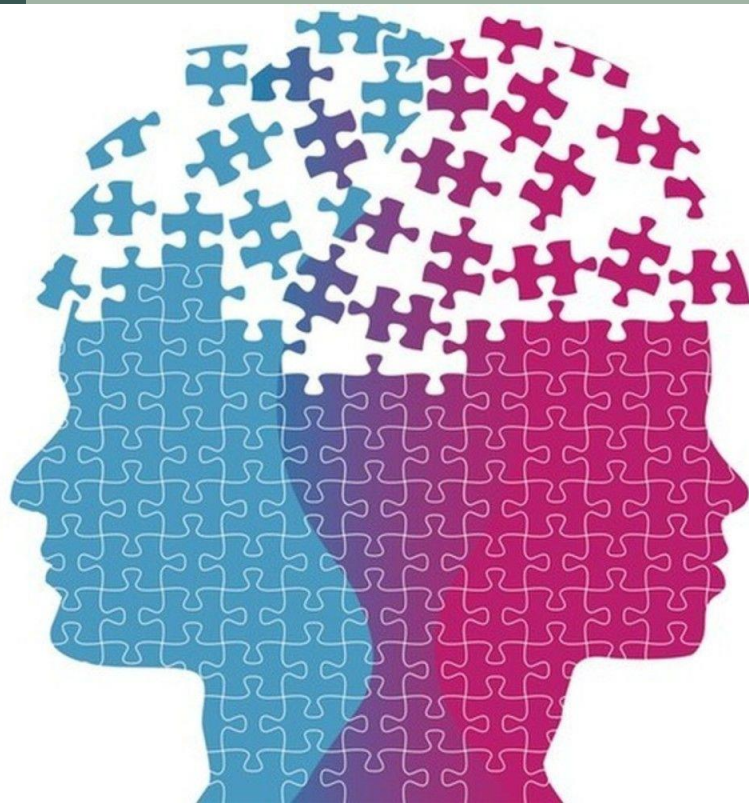




ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я ТА РЕЗИЛЬЄНТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ

Монографія



**АКАДЕМІЯ ПРАЦІ,
СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН І
ТУРИЗМУ**

ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я ТА РЕЗИЛЬЄНТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ

Монографія

За загальною редакцією
Г. А. Пріба, Л. Є. Бегези

**Київ
2025**

УДК: 159. 923.35 (02)

М50

Затверджено Вченою радою Академії праці,
соціальних відносин і туризму (протокол № 6 від 27.12.2024 р.)

Рецензенти:

Дробот О. В. – доктор психологічних наук, професор, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, кафедри психології, філософії та суспільних наук, завідувач кафедри

Журавльова О. В. – доктор психологічних наук, професор, Волинський національний університет імені Лесі Українки, кафедра загальної та клінічної психології, завідувач кафедри

Раєвська Я. М. – доктор психологічних наук, професор, кафедра психології Міжрегіональної Академії управління персоналом, завідувач кафедри

Психічне здоров'я та резильєнтність особистості : колективна монографія.
Академія праці, соціальних відносин і туризму / За заг. ред. : Г. А. Пріба, Л. Є. Бегези – Київ : Ф-ОП Гуляєв О.В., 2025. 392 с.

ISBN 978-617-8181-22-2

DOI 10.5281/zenodo.14765840

У колективній монографії представлено результати науково-дослідної роботи, проведеної науково-педагогічними працівниками, здобувачами вищої освіти з спеціальності 053 «Психологія» кафедри психології Академії праці, соціальних відносин і туризму у 2024–2025 роках.

Наукові й теоретичні моделі та практичні розробки, що представлені у монографії, будуть цікаві для використання фахівцям сфер соціономічного напрямку в якості методичного підґрунтя при психологічному супроводі психічного здоров'я та резильєнтності особистості у викликах сьогодення. Видання стане корисним науково-методичним інструментарієм для здобувачів вищої освіти у галузі спеціальності 053 «Психологія», психологів практиків, соціальних працівників, також будуть цікавими для використання у навчальній фаховій підготовці кваліфікованих кадрів на етапі перед- та післядипломної освіти.

Розповсюджувати і тиражувати без офіційного дозволу Академії праці, соціальних відносин і туризму забороняється.

Матеріали друкуються в авторській редакції. Автори несуть відповідальність за достовірність фактичних даних і мовностилістичний рівень матеріалів.

© Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2025

© Колектив авторів, 2025

ЗМІСТ

ВСТУП.....	7
------------	---

ЧАСТИНА 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ТА РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

РОЗДІЛИ:

1.1. Психологічні особливості професійно-комунікативної компетентності лікаря.....	9
<i>Бегеза О. С.</i>	
1.2. Психологічні особливості формування відповідального ставлення до материнства.....	19
<i>Бегеза Л.Є., Калітка Р.Д.</i>	
1.3. До питання адаптації особистості: види, чинники, напрями дослідження	29
<i>Бегеза Л. Є., Таран Л. К.</i>	
1.4. Соціальна підтримка та якість життя клієнток стоматологічних клінік з тривожними станами в умовах травматичних подій	39
<i>Бичук М.І.</i>	
1.5. Особливості прояву депресивних станів в юнацькому віці та шляхи їх подолання	50
<i>Болсуновська Н. А.</i>	
1.6. Сексуальні та психосоціальні аспекти сімейного спілкування	58
<i>Бондар С. С.</i>	
1.7. Соціальні та терапевтичні підходи до роботи з ветеранами з посткомуністичним синдромом	67
<i>Борець О.А.</i>	
1.8. Життєстійкість як детермінанта психологічної резильєнтності та адаптаційного потенціалу особистості	80
<i>Борець О. А., Сокоренко М.О.</i>	
1.9. Теоретичні основи формування самооцінки індивідуума	86
<i>Борець О. А., Шакур В. С.</i>	

1.10. Особливості надання психологічної допомоги дружинам військовослужбовцям	95
<i>Зубченко К.В.</i>	
1.11. Взаємозв'язок психологічних чинників розладів харчової поведінки у дітей та підлітків з методами їх діагностики та корекції	103
<i>Єнтіс Я.І.</i>	
1.12. Необхідність дослідження і розвитку стресостійкості особистості як позитивного ресурсу особистості	114
<i>Ковальчук М.С.</i>	
1.13. Психічне здоров'я працівників організації в умовах війни	123
<i>Лозовська О. В.</i>	
1.14. Здолання дезадаптації як чинник професійного розвитку осіб, які працюють в умовах підвищеної стресогенності	133
<i>Лопінська Т.В.</i>	
1.15. Особливості психічних станів жінок часто хворіючих дітей	142
<i>Мазур Н.В.</i>	
1.16. Психологічна готовність до материнства	152
<i>Мілютіна К. Л., Гаврилюк Л.А.</i>	
1.17. Ставлення внутрішньо переміщених осіб до життєвої кризи та її подолання	164
<i>Мілютіна К.Л., Мозгун С. А.</i>	
1.18. Психологічні чинники виникнення агресивно-девіантної поведінки у учасників навчально-виховного процесу та шляхи їх подолання	173
<i>Могилко Т. Р.</i>	
1.19. Теоретична генеза поняття «віктимна поведінка» у психологічній літературі	181
<i>Морозова О. В., Шпаляренко Т. О.</i>	
1.20. Методи психологічної реабілітації військовослужбовців, які зазнали бойової психічної травми	192
<i>Келін Д.О.</i>	
1.21. Теоретичні аспекти визначення дисгармонійної родини в сучасній психології	201
<i>Сулима О.А.</i>	

ЧАСТИНА 2.

МЕНТАЛЬНЕ ЗДОРОВ'Я ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА РЕЗИЛЬЄНТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ

РОЗДІЛИ:

2.1. Психологічні особливості професійної діяльності іт-фахівців у комерційних організаціях	211
<i>Бегеза Л. Є., Чугай О. В.</i>	
2.2. Емоційний інтелект як чинник соціалізації особистості.....	219
<i>Бегеза Л.Є., Канафоцька Л. М.</i>	
2.3. Ціннісні орієнтації майбутнього психолога в координаті психічного здоров'я	229
<i>Бондар С. І., Тетерук С. П.</i>	
2.4. Психолого-педагогічні засади навчання особистості протягом життя як складова європейської соціальної моделі неперервної освіти	239
<i>Гончаренко Н.М.</i>	
2.5. Роль сучасних інтернет-технологій у наданні психологічної підтримки особистості.....	249
<i>Житинська М.О.</i>	
2.6. Психологічні аспекти резильєнтності персоналу агроіндустрії в ситуації невизначеності та ризику.....	258
<i>Ісак А.М.</i>	
2.7. Підвищення мотивації до працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів через психологічний супровід в умовах стресогенності.....	268
<i>Ларченко І.В.</i>	
2.8. Чинники психологічного благополуччя ветеранів в організації.....	277
<i>Мілютіна К.Л., Лебединська В.В.</i>	
2.9. Резильєнтність менеджерів у контексті продажів	287
<i>Мілютіна К. Л., Панасюк В. В.</i>	
2.10. Психологічні стреси у діяльності працівників агробізнесу в довготривалих кризових умовах	295
<i>Міщенко Д.А.</i>	
2.11. Роль soft skills та емоційного інтелекту у подоланні наслідків професійного стресу працівників сфери обслуговування	306
<i>Лосієвська О.Г., Мальнев А.С.</i>	

2.12. Психологічні основи формування резильєнтності медіатора у кризових умовах	319
<i>Лосієвська О. Г., Мироненко С. М.</i>	
2.13. Психологічні особливості та рівень задоволеності працю персоналом організацій в ситуації невизначеності.....	328
<i>Пріб Г.А.</i>	
2.14. Аналіз психологічної готовності молоді до сімейного життя	337
<i>Пріб Г. А., Яковенко О. С.</i>	
2.15. Вплив війни на психічне здоров'я працівників адвокатури	349
<i>Скиданова Ю. О.</i>	
2.16. Розвиток резильєнтності як методу профілактики професійного вигорання медичних працівників стаціонарних відділень	358
<i>Синицька О.</i>	
2.17. Соціально-психологічні бар'єри професійної діяльності фахівців сфери ІТ	370
<i>Янушевський А.О.</i>	
ВИСНОВКИ.....	380

ВСТУП

Агресія проти України призвела до великої кількості жертв серед мирного населення, спричинила руйнування економіки, викликала моральні та психологічні страждання населення.

Сьогодні стало очевидним, що населення України упродовж багатьох років буде долати психологічні наслідки війни. Наразі суспільство переглядає підходи до охорони психічного здоров'я населення, окремо з внутрішньо переміщеними особами, постраждалими, учасниками або інвалідами бойових дій, у тому числі на робочому місці. Попередні стратегії допомоги нездатні впоратися з психологічною травматизацією населення, спричинених війною.

Верховна Рада України 15.01.2025 року ухвалила Закон №12030 «Про систему охорони психічного здоров'я». Його мета це створення сучасної, ефективної та злагодженої системи, яка відповідатиме європейським нормам та стандартам й працюватиме для всіх громадян країни. Закон спрямований на забезпечення доступу до якісних послуг, захист прав людей із психічними розладами та іншими проблемами, що стосуються психічного здоров'я, запобігання виникненню психічних розладів й усунення шкідливих факторів, що впливають на психічне здоров'я українців.

Політика держави узгоджується з пріоритетними завданнями Європейського Союзу у сфері реагування на виклики психічного здоров'я та ґрунтуються на рекомендаціях Єврокомісії вирішувати питання психічного здоров'я в усіх сферах національної політики.

Враховуючи виклики та вимоги сьогодення, кафедрою психології напрацьований потужний теоретико-практичний матеріал, який розкриває результати досліджень психічного здоров'я та резильєнтності особистості. Саме з метою реагування на запити сучасності укладено колективну монографію «Психічне здоров'я та резильєнтність особистості», що містить низку практичних розробок, кожна з яких є своєрідним інструментарієм, оволодіння котрим надає можливість фахівцям ефективно співпрацювати з різними категоріями клієнтів,

особливо в контексті запровадження нових моделей надання психологічних та психотерапевтичних послуг.

Перша частина монографії складається з розділів, присвячених теоретико-методологічним та практичним підходам до забезпечення психічного здоров'я та резильєнтності особистості. У другій частині монографії представлено розділи, в яких надано результати дослідження ментального здоров'я персоналу організацій та резильєнтність особистості.

Пропоновані матеріали стануть корисним методичним інструментарієм для практичних психологів, соціальних працівників, здобувачів вищої освіти у галузі клінічної психології, психології бізнесу та управління, а також будуть цікавими для фахівців, які займаються проблемами становлення і самоактуалізації особистості.

ЧАСТИНА 1.

**ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ТА
РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ**

РОЗДІЛИ:

**1.1. Психологічні особливості професійно-комунікативної
компетентності лікаря**

Бегеза О. С.

Актуальність. Компетентність персоналу медичних закладів є основою для надання медичної допомоги. Психологічний контекст на різних етапах професійної діяльності медичних працівників (консультування, анамнез, діагностика, за потреби консилиум – власне, процес лікування пацієнтів) відіграють вирішальну роль у лікуванні та догляді за пацієнтами. Пояснення пацієнтові стратегії лікування, підбір індивідуальної тактики ведення пацієнта згідно міжнародних та українських протоколів лікування, формують довіру в системі комунікації «лікар-пацієнт». Комунікація між медичними працівниками та пацієнтами є цілісною та системною взаємодією, що спрямована на допомогу пацієнту у підтримці власного здоров'я. Такий стиль взаємодії – «медичний працівник – пацієнт» – допомагає пацієнтам відчувати себе комфортно та впевнено, що їхні потреби та питання будуть враховані, проблеми можуть бути вирішені в залежності від стану пацієнта та ступеню захворювання, яке в нього наявне та інших чинників, які можуть впливати на загальний стан.

У закладах охорони здоров'я одним із факторів формування комунікативних та психологічних компетентностей медичного персоналу є професійне навчання лікарів як за вузькою спеціальністю, так і колективу вцілому. Серед таких навчальних моделей можуть бути: стажування, участь у конференціях, доступ до міжнародних інтернет-ресурсів, сайтів медичних академій чи навчальних курсів

при медичних школах, університетах, академіях та ін. Це в свою чергу сприяє розвитку медичного персоналу у наданні медичної допомоги на вищому, якісному, рівні, що обумовлюється готовністю медичного персоналу розвивати професійний та психоемоційний ресурси, які сприятимуть удосконаленню професійних компетентностей.

Мета. Теоретичний аналіз соціально-психологічних факторів та психологічних особливостей комунікації у системі взаємодії «лікар–пацієнт».

Результати дослідження. Важливим елементом у формуванні сфери надання медичних послуг є розуміння медичної етики, яка буде вирішувати та враховувати права та обов'язки як лікарів так і пацієнтів. Тому поглиблення даних основ у розуміння психотипів пацієнтів, вмінні доносити інформацію щодо стану пацієнта, врахування етичних принципів у комунікації із родичами дають можливість у майбутньому швидшого отримання професіоналізму, знижувати рівень професійного вигорання.

«Деонтологія є однією з основних теорій етики і включає систему принципів, які регулюють моральну поведінку. У контексті медзакладів, деонтологічні принципи відіграють важливу роль у встановленні стандартів й норм поведінки для медичного персоналу, а також у взаємодії з пацієнтами» [1, с. 8].

«Деонтологія – це наука про професійну поведінку людей, сукупність етичних норм, необхідних для виконання ними своїх професійних обов'язків. Деонтологія лікарська (медична) – суміжна дисципліна між етикою і медициною, галузь медичної етики, що має свою специфіку; вчення про моральний обов'язок, етичні обов'язки і етичні норми поведінки медичного персоналу, що забезпечують оптимальну якість і результативність його роботи з відновлення і збереження здоров'я людей» [2 с. 5-6].

У залежності від спеціалізації лікаря, віку пацієнта, «...розрізняють медичну деонтологію терапевта, хірурга, акушера-гінеколога, педіатра, онколога, психіатра, дерматовенеролога та інших. Основні сфери регуляції загальної і спеціальної деонтології:

- взаємини між лікарем і пацієнтом, зокрема у присутності інших хворих і у присутності колег – відносини «по вертикалі»;
- взаємини між лікарем і пацієнтами-дітьми;
- взаємини між лікарем і близькими пацієнта, зокрема у присутності останнього і у присутності сторонніх;
- взаємини між лікарем і його колегами, зокрема у присутності пацієнта, його близьких і сторонніх – відносини «по горизонталі»;
- взаємини між лікарями і середнім (молодшим) медперсоналом, зокрема у присутності хворих;
- відношення лікаря до лікарської таємниці і його право на розповсюдження інформації;
- право лікаря на експеримент і етичні проблеми медичних досліджень; – проблема юридичної відповідальності лікаря;
- проблема матеріальної і моральної винагороди лікаря» [2, с. 6].

На розвиток й удосконалення професійної діяльності лікаря, безпосередньо та опосередковано впливають: психологічний клімат у колективі, організаційно-професійна система комунікації серед медичних працівників, комунікація у системі професійного статусу та ін. Враховуючи взаємодію «лікар-пацієнт-керівник» потрібно враховувати фактори, що будуть впливати на дану комунікацію. Фактори у свою чергу можуть сприяти соціально-психологічному розумінню розвитку як одиниці медичної ланки – лікаря, так і розумінню очікувань пацієнтів про отримані послуги (популярності серед пацієнтів того чи іншого закладу).

Теоретичний аналіз літератури у напрямі соціальної медицини та практичний досвід дають можливість зробити висновок про вплив факторів на розвиток комунікативної компетентності лікаря акушера-гінеколога. Дані фактори, на наш погляд, представляють теоретичну модель комунікативної компетентності лікаря акушера-гінеколога, що містить компоненти, які представлені у рис. 1.

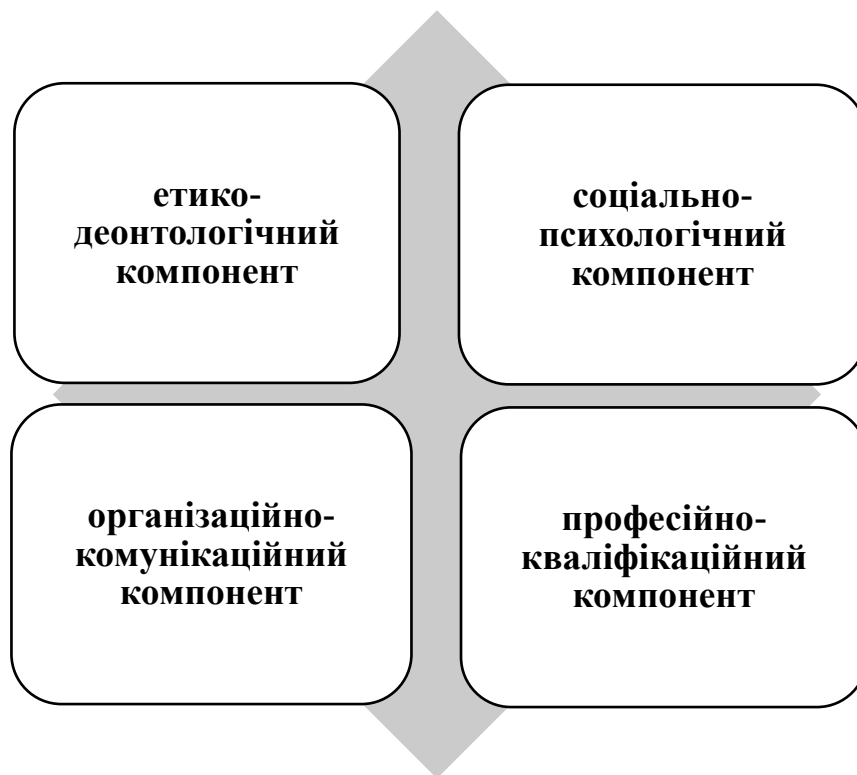


Рис. 1. Теоретична модель комунікативної компетентності лікаря акушера-гінеколога*.

**Розроблено автором*

Розглянемо детальніше компоненти теоретичної моделі комунікативної компетентності лікаря акушера-гінеколога.

1. Етико-деонтологічний компонент професійної діяльності лікаря акушера-гінеколога.

Завдяки етичним правам та деонтологічній складовій в роботі лікарів формуються моральні принципи та статuti при роботі із пацієнтами так і в медичному колективі. Медичні директори мають не розмежовувати етичні норми при роботі із співробітниками в залежності від посади займаної в медичній установі. Деякі спеціальності мають етичні та деонтологічні особливості, що дають змогу краще адаптуватися під запит пацієнта та якомога розносторонніше, просто і зрозуміло надати інформацію щодо стану здоров'я самого пацієнта чи його родичів. Тому, на керівників лежить одна із відповідальностей формування та навчання медичного персоналу не тільки у комунікації із пацієнтом, а підтримки

рівня комунікації медичного персоналу не тільки серед медичної спільноти, а й із керівниками відділень лікувального закладу, медичного директора.

«Деонтологія як галузевий розділ розглядає питання обов'язку, нормативів, моральних вимог й загалом зобов'язань, які є специфічною формою прояву соціальної необхідності. При цьому, деонтологія є наукою, що вивчає професійну поведінку працівників й включає сукупність етичних норм, котрі є необхідні щоб виконувати професійні обов'язки» [1, с. 8].

У продовження вищевказаної думки необхідно додати, що медична етика та деонтологія формує такі рівні комунікації та прийняття рішення:

- особиста етика лікаря – вміння використовувати свої знання та вміння у комунікації із пацієнтом, надання медичної допомоги в терміновому порядку, встановлення курсу лікування та самостійне прийняття рішення щодо подальшої тактики ведення пацієнта, обговорення деталей лікування із самим пацієнтом чи його родичами у випадку не можливості прийняття рішень щодо свого стану самими пацієнтом;
- професійно-соціальна етика – включає деонтологічні принципи в роботі із колегами, методів розподілу медичних ресурсів у наданні доступного лікування пацієнтів, медичні консилиуми для покращення ефективності або знаходження правильної лікувальної тактики для конкретного пацієнта;
- етичні проблеми у зв'язку із станом пацієнта – формування законодавчих прав та норм у зв'язку із здоров'ям пацієнта, погіршення його стану, або навпаки формування законів, що дозволяють розвиватися репродуктивній медицині та захищають права і обов'язки як лікаря так і пацієнта.

Стрімкий розвиток біо-технологій та нових підходів до лікування вивчених захворювань є предиктором для корисного та сучасного підходу у вирішенні генетичних чи хронічних захворювань, які можуть призвести до конкретного захворювання у пацієнта, але й нести певні ризики або фактори, які законодавчим шляхом поки важко врегулювати, спираючись на етичні, професійні, особисто-вольові чинники як медичних працівників і закладу, який надає чи формує такі послуги, так і пацієнтів, які готові інколи ризикувати власним станом здоров'я

зادля отримання або закриття дефіциту, до якого призводить їх захворювання чи стан.

2. Соціально-психологічний компонент взаємодії у системі комунікації «керівник – лікар акушер-гінеколог».

Наступним важливим чинником у формуванні та розвитку комунікативних навичок між керівником та медичним персоналом є чітке формування та встановлення правил і норм, які забезпечують комфортний психоемоційний стан медичних працівників та дозволять керівникам мати довірливі відносини в колективі і завдяки цьому впровадження ефективної моделі надання медичних послуг населенню.

Фактори, що впливають на психологічний та моральний стан медичних працівників у медичному закладі:

- корпоративні або внутрішньо-організаційні правила та чіткі обов'язки медичних працівників в залежності від типу закладу;
- вік та досвід керівника, що керує медичним закладом, його морально-етичні норми, вміння адаптуватися та вирішувати складні ситуації;
- умови праці та гідна та вчасна оплата роботи медичного персоналу;
- стиль комунікації між медичними працівниками в колективі, у відділенні (вік, професійний стаж, наявність комунікативних навичок у спілкуванні з колегами);
- психологічна адаптативна здатність кожного працівника у роботі із колегами, вміння поступитися власним его чи вміння відокремлювати професійні від соціально-культурних аспектів у спілкуванні з колегами;
- вміння керівників підрозділів та медичного директора швидко та ефективно надавати допомогу у вирішенні не тільки медичних питань у медичному колективі, формувань варіантів відпочинку та зміни вектору професійної діяльності лікаря для зменшення емоційного вигорання.

Основними цінностями та важливими предикторами в роботі керівника та підлеглого в медичній сфері є безумовно психологічні підтримка, формування емоційно-психологічних позитивних ланцюгів у вирішенні будь якого рівня

складності викликів та проблем, які безумовно щодня очікують всі ланки медичної сфери у будь якому медичному закладі не в залежності від форми управління та приналежності до державної чи приватної ланки. Завдяки цьому буде формуватися та реалізовуватися знання та вміння працівників не в залежності від рівня освіти та надання медичної допомоги в закладі. І це в свою чергу дозволить як працівникам отримувати не тільки емоційно-лабільний стан, позитивні емоції, а й керівникам закривати потреби та питання професійності медичних кадрів, що розвиватимуть даний заклад.

«Сприятливий морально-психологічний клімат у трудовому колективі закладу охорони здоров'я виступає одним із важливих критеріїв функціонування системи охорони здоров'я, що дає змогу досягнути основну ціль, яка передбачає емоційне здоров'я населення та надання їм необхідної якісної медичної допомоги. Хороші взаємовідносини у трудовому колективі медичних працівників є запорукою успіху медичного закладу загалом » [3, с. 3].

Психологічний клімат у колективі формує морально-вольові зв'язки між колегами, допомагає ефективно та швидко комунікувати в колективі для вирішення складних задач та діагностичних пошуків для лікування чи покращення стану пацієнта. Вагомим значенням у підтримці психологічного клімату є визнання роботи лікаря як у колективі так у взаємовідносинах із пацієнтом, що стимулюватиме та посилювати інтерес до своєї роботи медичних працівників даватиме нові можливості для росту і розвитку у професійній сфері. І це в свою чергу буде задовольняти матеріальну складову і закриватиме базові потреби лікаря, та зменшуватиме ризик емоційного вигорання.

3. Організаційно-комунікаційний компонент взаємодії у системі комунікації «керівник – лікар акушер-гінеколог»

Одним із важливих та впливових чинників є ефективна комунікація між керівником та лікарем, адже це буде ефективно сприяти на формування як професіональних чинників та покращення показників роботи так і психологічних чинників та задовольнятиме потреби як керівника так і медичного працівника.

Враховуючи основний принцип керівник-лікар варто врахувати чинники, які будуть закривати потреби як керівників так і лікарів, а саме:

- оплата праці враховуючи стаж, спеціалізацію лікаря та виконання медичних послуг чи процедур(кількість пролікованих пацієнтів, кількість оперативних втручань, кількість та якість надання інших медичних маніпуляцій);
- визначення стратегії закладу (вік та стаж лікаря, які спеціальності першочергові та популярні в даному закладі, створення бренду та реклами медичного закладу, який буде збільшувати пацієнтопотік в медичній установі, внутрішньолікарняний розпорядок та створення власних протоколів лікування тих чи інших захворювань по типу колегіальності для зменшення факторів скарг пацієнтів на «не якісне та різне лікування та підходи того чи іншого лікаря»);
- надання якісного та сучасного медичного обладнання, яке дозволить як забезпечувати більший відсоток визначення стану пацієнта та поглиблювати і розвивати навички лікарів;
- створення медичних консиліумів між лікарями різних спеціальностей задля формування позитивного психологічно-емоційного клімату серед лікарів та розширення комунікації між ними, розвитку клінічного мислення кожного працівника незалежно від стажу роботи.

4. Професійно-кваліфікаційний компонент професійного розвитку лікаря акушера-гінеколога

Важливим аспектом у покращенні медичних навичок та інтелектуального потенціалу медичного персоналу є постійний розвиток управлінської верхівки. Адже вміння адаптувати власні навички у роботі та комунікації із медичним персоналом формує управлінський потенціал керівників закладів охорони здоров'я. Завдяки керівникам формуються моделі розподілу матеріально-технічних ресурсів, лікувально-діагностичних та психологічно-комунікативних у медичних закладах. Це в свою чергу формує лідерські навички в керівника, який повноцінно розуміє всі етапи надання медичних послуг та потреб медичних працівників у колективі, розвивати практичні навички та інтелектуальний потенціал не тільки медичного відділення, а й лікаря як медичної одиниці в даному

закладі. І це в свою чергу призведе до вдосконалення як психологічного аспекту колективу так і розвитку медичного закладу.

«Забезпечення безпеки працівників та пацієнтів також є невід’ємною корпоративної етики. Професійні медпрацівники повинні дотримуватися стандартів безпеки, а медзаклад має забезпечувати необхідні умови для безпечного оточення. Відкритість до навчання та постійного професійного розвитку є важливими аспектами корпоративної етики. Медпрацівники мають бути відкриті до нових знань, оновленням і покращенням своїх навичок » [1, с. 51].

Висновки. Теоретичне вивчення факторів, які впливають на професійну діяльність лікаря, яка в свою чергу буде опосередковано впливати на його розвиток, комунікацію як внутрішньолікарняному середовищі так із керівництвом й пацієнтом. Адже враховуючи взаємо-співзалежні стани лікар-пацієнт-керівник можна визначити та дослідити фактори, що будуть впливати в даній системі комунікації. Дані фактори можуть сприяти глибинному розумінню розвитку та прогресу як одиниці медичної ланки – лікаря, так і розуміння розвитку та прогресу, популярності серед пацієнтів того чи іншого закладу.

«В сучасних умовах господарювання саме працівники є головною цінністю закладу охорони здоров’я, є джерелом інновацій, креативності, що забезпечують високий рівень конкурентоспроможності закладу на ринку медичних послуг. Якісне надання медичної допомоги та замученість працівників до розвитку медичного закладу забезпечують стабільність та високі показники ефективності роботи закладу. Морально-психологічний клімат у трудовому колективі закладу охорони здоров’я визначається як сукупність емоційних ознак, які формуються між працівниками, а також між керівництвом та його підлеглими. Такий клімат відображає робочу атмосферу у колективі, ставлення працівників один до одного та до роботи, взаємодопомогу, а також створює сприятливу позитивну атмосферу в якій працівники почувають себе комфортно та збільшують свою продуктивність праці» [3, с. 21]. «Принцип «поваги прав і гідності особистості» передбачає, що людина має бути поважана як незалежна особистість зі своїми власними правами і гідністю. Цей принцип виходить з усвідомлення того, що людина має право на

повагу до своєї автономії, приватності, гідності і недоторканості. У контексті медицини і біології, цей принцип означає, що пацієнти повинні бути поважані як автономні особистості, і їх права та гідність мають бути захищені. Як бачимо, пацієнти мають мати право на інформований згоду перед проведенням будь-яких медичних процедур або досліджень, а їхня конфіденційність повинна бути збережена. Принцип «поваги прав і гідності особистості» також наголошує на важливості уникання будь-якої форми дискримінації, примусу чи незаслуженої образи в контексті меддопомоги, досліджень або генетичних досліджень. Всі особи повинні бути рівними перед законом, мати можливість отримувати належну меддопомогу, захист прав, захист гідності. Принцип «поваги прав і гідності особистості» є основою для етичних розглядів і прийняття рішень у багатьох сферах біоетики, включаючи медичну етику, етику досліджень на людях, етику репродукції та генетичну етику. Цей принцип спрямований щоб забезпечити захист прав й гідності особистості, які є центральними в цих галузях» [1, с. 13].

Література.

1. Губаль М.В. Деонтологія персоналу в закладі охорони здоров'я. Тернопіль. 2023. 65 с.
2. Деонтологія в медицині. Ч. 1 : метод. вказ. для самост. роботи студентів з курсу за вибором / упоряд. Т. В. Ащеулова, Т. М. Амбросова, Н. М. Герасимчук. Харків : ХНМУ, 2021. 36 с.
<https://repo.knmu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/cfd21713-9820-42f8-8bc9-2ff63b52de82/content>
3. Карпенюк Ю.І. Удосконалення морально-психологічного клімату в трудовому колективі закладу охорони здоров'я. Тернопіль. 2023. 76 с.

1.2. Психологічні особливості формування відповідального ставлення до материнства

*Бегеза Л.Є.
Калітка Р.Д.*

Актуальність. На сучасному етапі розвитку українського суспільства характерні зміни моделей сімейних стосунків. Поширення ринкових відносин, зниження духовно-моральних орієнтирів негативно впливають на виховну функцію сім'ї, послаблюють її виховні традиції. Що, в свою чергу, призводить до протиріччя: зростання кількості осиротілих дітей при живих батьках, з одного боку, і матері, які не готові або не мають бажання виконувати материнські функції, з іншого боку. Усе зазначене актуалізує важливість вивчення психологічного аспекту феномену материнства і підготовки до нього. Питання важливості формування відповідального ставлення до материнства у дівчат старшого шкільного віку вивчаються в працях українських науковців О. Тіунової, Л. Яворської, Л. Яценко [3, 6, 7]. В роботах зарубіжних дослідників висвітлено аналіз пропозицій щодо впровадження різноманітних освітніх програм з підготовки дівчат-старшокласниць до материнства.

Мета. Надати аналіз теоретичних аспектів, що впливають на психологічні умови формування відповідального ставлення дівчат старшого шкільного віку до материнства.

Результати досліджень. Проблема материнства, його ролі в суспільстві, можливості позитивного впливу на його функціонал розглядаються у роботах як вітчизняних, так і іноземних науковців. Так, В. Шахрай, досліджуючи ціннісне ставлення до материнства у дівчат-старшокласниць, стверджує, що значну увагу науковці приділяють питанню материнства в контексті батьківства в цілому [4].

Феномен материнства досліджують в різних сферах науки, зокрема, у психології, соціології, біології поведінки, фізіології, медицині, культурології, історії тощо. Кожен з цих напрямків дає своє визначення материнству, виходячи зі своїх завдань та мети. Наукова цікавість до вивчення феномену материнства

з'явилася на світ відносно недавно, проте й донині чіткого визначення цьому поняттю немає. Так, у великому тлумачному словнику сучасної української мови сутність і зміст поняття материнства розкривається з двох позицій [8]. З точки зору біології материнство – це функція жіночого організму, спрямована на продовження людського роду, тобто стан жінки під час вагітності, пологів, годування дитини. Якщо ж розглянути материнство як соціальну функцію матері, то вона полягає у вихованні дитини. Це почуття жінки- матері до дитини, бажання стати матір'ю. Енциклопедія сучасної України визначає материнство як біо-соціально-психологічно-правовий стан жінки від моменту вагітності та народження дитини й до кінця життя жінки або її дітей [9]. На успішну адаптацію жінки до материнства впливають різноманітні чинники: власна особистість жінки, історія життя, особливості стосунків у подружньому житті, досвід взаємин із власною матір'ю, особливості сімейної моделі батьків, можливості взаємодії із немовлятами і поява інтересу до них у дитинстві та ін.

У психологічній науці зустрічається таке поняття материнства, як «складне явище, яке сформувалося під впливом родинного та соціального середовища, а також від впливу різноманітних генетичних або біологічних чинників» [2]. З точки зору цих авторів материнство розглядається з двох сторін: як частина особистісної сфери жінки та як забезпечення умов для розвитку дитини [2, с.245]. Отже, материнство є багатогранним поняттям і може мати різні значення для кожної жінки. Воно залежить від культурних, соціальних, економічних та особистісних факторів.

Психолого-педагогічний підхід до вивчення феномену психологічної готовності до материнства ґрунтується на ідеї, що готовність до материнства є результатом тривалого процесу щодо прийняття материнської ролі, який має здійснюватися з дитинства, ґрунтуватися на вікових та особистісних характеристиках дівчини і жінки, і враховувати існуючі соціальні фактори.

Готовність до материнства – це комплексний стан, який охоплює різні аспекти життя жінки. Він включає в себе не лише фізичну готовність, але й психологічну, соціальну та економічну.

Фізична готовність до материнства включає в себе здоров'я жінки, здатність її організму виносити і народити дитину, відсутність протипоказань до вагітності, здоровий спосіб життя, правильне харчування.

Складовими психологічної готовності є емоційна зрілість і стабільність, розуміння відповідальності материнства, готовність до змін у житті, бажання виховувати дитину, розуміння відповідальності, яку несе матір, здатність до самопожертви та турботи про іншу людину.

До складу соціальної готовності можна включити наявність підтримки з боку партнера, родини, друзів; наявність соціальних зв'язків, спільноти, готовність до обмеження соціальної активності після народження дитини.

Економічна готовність – це стабільне матеріальне становище, можливість забезпечити дитину житлом, одягом, харчуванням, освітою; наявність резервного фонду на випадок непередбачених ситуацій.

Важливо розуміти, що готовність до материнства – це індивідуальний процес. Кожна жінка відчуває її по-своєму і в різний час. Не існує єдиного правильного віку або ідеальних умов для народження дитини. Таким чином, до чинників, які можуть впливати на готовність до материнства, можна віднести: вік жінки; культурні та соціальні норми; особистісні якості жінки; досвід виховання в дитинстві; матеріальні умови.

Розглянемо деякі з них більш детально.

Фізіологічна компонента готовності до материнства – це важливий аспект, який визначає здатність жіночого організму виносити і народити здорову дитину. Вона включає в себе ряд фізіологічних процесів і станів, які забезпечують оптимальні умови для розвитку плоду. Основними фізіологічними складовими готовності до материнства є: здорова репродуктивна система; гормональний баланс; загальний стан здоров'я, який включає в себе здоровий імунітет, відсутність шкідливих звичок; адекватне збалансоване харчування, яке забезпечить організм необхідними вітамінами та мінералами; фізична активність.

До факторів, що впливають на фізіологічну компоненту готовності до материнства, можна включити: вік: оптимальний репродуктивний вік для жінки –

20-35 років; вага тіла: надмірна або недостатня вага можуть ускладнити вагітність та пологи; хронічні захворювання; попередні вагітності та пологи.

Розглянемо генетичну компоненту готовності до материнства. Генетичні фактори відіграють важливу роль у формуванні здатності жінки до зачаття, виношування та народження дитини. Хоча багато аспектів репродуктивного здоров'я залежать від загального стану організму та зовнішніх впливів, генетична схильність може значно вплинути на ці процеси. Наприклад: хромосомні аномалії: наявність додаткових або відсутніх хромосом може призвести до порушень розвитку репродуктивної системи та підвищувати ризик викиднів або народження дітей з генетичними захворюваннями; генетичні мутації: окремі генетичні мутації можуть впливати на функціонування гормональної системи; полігенні ознаки: багато аспектів репродуктивного здоров'я визначаються не одним, а кількома генами; мітохондральна ДНК, мутації якої можуть впливати на розвиток плоду та призводити до різних захворювань.

Сучасна медицина пропонує широкий спектр діагностики та лікування, які допомагають подолати труднощі. Важливо пам'ятати, що медична готовність до материнства – це динамічний процес. Стан здоров'я жінки може змінюватися з часом, тому регулярні огляди у лікаря є необхідними.

Психологічну компоненту готовності до материнства розглянемо через виокремлення соціально-психологічних і індивідуально-психологічних аспектів.

Соціально-психологічні аспекти готовності до материнства – це широке коло факторів, які виходять за межі індивідуальних характеристик жінки і пов'язані з її соціальним оточенням, культурними нормами, життєвими обставинами та суспільними очікуваннями. До основних соціально-психологічних аспектів можна віднести такі:

- соціальні норми та очікування (вікові норми, соціальний статус, роль жінки у суспільстві);
- сімейні цінності та традиції (приклад батьків);
- соціальна підтримка (партнера, друзів, родини);
- культурні особливості і релігійні погляди;

- соціально-економічні умови (матеріальна забезпеченість, соціальні програми, наявність підтримки держави сімей з дітьми);
- соціальні страхи та стереотипи (страх втрати кар'єри, фінансових труднощів).

Серед цих факторів можна виділити ті, що позитивно впливають на готовність до материнства:

- створення суспільством привабливого образу материнства, що мотивує жінок до народження дітей;
- зняття соціальних бар'єрів: підтримка жінок, які вирішили стати матерями, допомога їм в подоланні труднощів і реалізації в ролі матері;
- формування відповідального ставлення до материнства через інформування про планування сім'ї, контрацепцію, здоров'я матері і дитини.

Соціально-психологічні аспекти є складними і багатограними. Вони формуються протягом усього життя жінки під впливом різних факторів. Розуміння цих факторів допомагає краще підготуватися до материнства і забезпечити благополуччя як матері, так і дитини.

Розглянемо індивідуально – психологічні особливості готовності до материнства. Ними є сукупність внутрішніх факторів, які впливають на усвідомлене рішення жінки стати матір'ю та її здатність успішно виконати цю роль. Це досить складний феномен, який формується під впливом багатьох чинників, таких як особистісні особливості, життєвий досвід, цінності, соціальне оточення тощо. Серед основних індивідуально-психологічних аспектів готовності до материнства можна виділити такі: бажання мати дітей, емоційна зрілість, самооцінка, мотивація, суть особистого ставлення до материнства, готовність до змін у житті, підтримка оточення і фінансова стабільність.

Бажання мати дітей є основним і найважливішим фактором, яке може бути свідомим і обґрунтованим рішенням, або ж виникає під впливом соціальних стереотипів, тиску родини чи суспільства. Емоційна зрілість надає здатність приймати відповідальні рішення, контролювати свої емоції, адаптуватися до змін; дозволяє краще справлятися з труднощами материнства. Позитивний статус

самооцінки допомагає жінці вірити у свої сили та можливості, що важливо для успішного материнства. Мотиваційний аспект допоможе краще зрозуміти готовність жінки до материнства через знаходження відповідей на питання: чому жінка хоче мати дітей? Які мотиви її рухають? При цьому важливо, який образ матері сформувався у жінки в дитинстві, які очікування вона має від самого материнства. Ця подія кардинально змінює життя жінки, тому потрібно бути готовою до змін у розпорядку дня, пріоритетах, соціальному колі. При цьому підтримка партнера, родини, друзів може бути важливим ресурсом для майбутньої матері, а матеріальна забезпеченість дозволить відчувати себе впевненіше і зосередитися на вихованні дитини.

Психологічна готовність до материнства сприяє більш спокійному перебігу вагітності та пологів, допомагає жінці легше адаптуватися до нового статусу матері і знижує ризик розвитку післяпологової депресії, а емоційно зріла мати здатна побудувати міцні стосунки зі своєю дитиною. Як же можна розвинути психологічну готовність до материнства? До цього можна прийти через:

- психологічне самопізнання (визначити свої цінності, бажання, страхи);
- комунікацію (обговорення своїх почуттів з партнером, родичами, друзями);
- психологічну підтримку (при відчутті тривоги або невпевненості звернутися до психолога);
- роботу з самопідготовки до змін (ознайомитися з перевірених джерел з інформацією про стан жінки при вагітності, пологах, про догляд за немовлям);
- створення сприятливого оточення (організувати свій простір, забезпечити собі достойний відпочинок).

Таким чином, індивідуально-психологічна готовність до материнства – це процес, який потребує часу і уваги. Важливо розуміти, що єдиного правильного підходу немає, оскільки кожна жінка індивідуальна.

З'ясувавши важливість впливу різних чинників на формування готовності до материнства, з'являється необхідність знайти відповіді на такі питання : коли

починає вона формуватися; коли варто приділити максимум уваги цьому процесу; від кого ця увага повинна бути скерована?

На підставі аналізу досліджень з біології і психології материнства Г. Філіппова виділила шість етапів розвитку материнської потребнісно-мотиваційної сфери в онтогенезі [4]:

- 1) етап взаємодії з власною матір'ю;
- 2) ігровий;
- 3) етап няньчення;
- 4) етап диференціації мотиваційних основ материнської та статевої сфер;
- 5) взаємодія з власною дитиною;
- 6) утворення прихильності і любові до дитини як особистості [4].

Перший етап – взаємодія з власною матір'ю – починається ще з внутрішньоутробного періоду розвитку і триває все подальше життя. Найбільш впливовішим є дитячий і ранній вік, бо в цей час формуються базові основи особистості і ставлення до світу. Великий сенс при цьому має задоволеність матері своєю материнською роллю. Взаємодія з власною матір'ю і спостереження за взаємодією інших дорослих, як вони сприймають і переживають необхідність турботи про дитину, наповнює змістом потребу в турботі і охороні у самої дитини. При цьому активно засвоюється спосіб мовного спілкування з немовлям. Це формує у дівчат модель материнства власної матері.

Під час другого етапу – ігрового – в сюжетно-рольових іграх в дочки-матері і в сім'ю дівчинка приймає на себе роль матері. Таким чином відбувається конкретизація і розвиток деяких компонентів материнської сфери. Під час ігор дошкільнята реально випробовують модель материнства своєї матері і модифікують її, додаючи елементи власної фантазії і досвід інших дітей.

Етап няньчення має чіткі вікові межі: з 4,5 років і до початку статевого дозрівання. Найбільш чутливим до впливу є вік від 6 до 10 років. У цьому віці вже добре розвинена сюжетно-рольова гра, є уявлення про процес взаємодії дорослих з немовлям і додано власний досвід гри з моделлю-лялькою. На цьому етапі виокремлюється і формується цінність дитини, з'являється база цінності

материнства , які разом з материнською моделлю і під впливом власного досвіду перетворюються у власні цінності.

На наступному, четвертому, етапі відбувається конкретизація культурної моделі зв'язку статевої і материнської сфер. Г. Філіппова [4] зазначає, що «зникнення заборони на позашлюбні статеві зв'язки, зниження віку вступу в статеві стосунки поряд зі збільшенням віку залежності від батьків, множинність моделей поведінки в сучасному суспільстві і багато іншого роблять розвиток цінностей материнства в період статевого дозрівання надзвичайно складним». До того ж, даний етап є найменш вивченим. В результаті, маємо нову модель особистості, для якої ще не сформована і не розвинена модель материнства. Тому жінка на порозі материнства не має знань про особливості розвитку дитини і своїх функцій в догляді і спілкуванні з нею. Найчастіше, перше немовля, з яким стикається мати, є її власна дитина. Можна зробити висновок, що формування відповідального материнства в сучасному суспільстві не обмежується тільки веденням вагітності і відомостями про догляд за дитиною. Потрібно ще розвиток емоційної сфери, інтуїції, знань способів спілкування з дитиною до і після народження тощо. Таким чином зростає потреба психологічної допомоги майбутній мамі в період формування її власної моделі відповідального материнства, який якраз , як ми бачимо, і припадає на старший шкільний вік. Для старшого підлітку це період активних змін як фізичних , так і психологічних. Поряд із фізичним розвитком, у період статевого дозрівання відбувається перебудова психічного статусу, рівня свідомості, ведучої форми психічної діяльності. Якщо ігнорувати психологічні особливості підлітків, це обов'язково призводить до повного нерозуміння їх поведінки, вікової сегрегації. А це, в свою чергу, дасть поштовх до формування неповноцінності в характері, яке перешкоджає нормальному психологічному дозріванню. В цей час формуються і закріплюються навички та стереотипи поведінки, які багато в чому визначають подальший спосіб життя. А це можуть бути куріння, зловживання алкоголем, наркоманія, токсикоманія. В переважній більшості дівчат виникають нові для них поведінкові реакції, які так дивують дорослих: виражена тяга до групування із ровесниками, захоплення (хобі) і,

звичайно, гіперсексуальність. Ці особливості співпадають зі змінами характеру і умов навчання, життя, вибором професії. Від'їзд із батьківського дому, розставання з членами сім'ї та друзями звичайно впливає на якість життя і його сприйняття. Потрібно пам'ятати, що репродуктивне здоров'я залежить від загального розвитку організму саме в цей час [4].

Формування готовності до відповідального материнства у підлітковому віці – це складний процес, на який впливає безліч факторів. Серед них можна виділити такі: соціальне оточення, що включає приклад батьків, вплив друзів, соціальні норми; соціально-економічні фактори, до яких можна включити рівень освіти, фінансовий стан сім'ї, відсутність перспектив; біологічні (раннє статеве дозрівання); відсутність інформації і страх звернутися за допомогою; бажання бути дорослою, і за рахунок материнства вбачати спосіб швидкого дорослішання. Вплив запропонованих факторів може бути як позитивним, так і негативним.

Висновки. Роль психологічних факторів на формування материнства у дівчат старшого шкільного віку набуває актуальності. Зростає значущість розвитку рівня самооцінки, емоційної зрілості, які забезпечать здатність приймати відповідальні рішення, контролювати емоції та передбачати наслідки вчинків. Переконавання, викладені у статті, свідчить про необхідність допомоги клінічних психологів у розвитку відповідального материнства під час статевого дозрівання дівчат, який припадає на старший шкільний вік. Тому, діяльність фахівців-психологів допоможе у організації просвітницько-профілактичної роботи у формуванні здоров'язберігаючих підходів до попередження чинників, які можуть негативно вплинути на психічний розвиток дівчат старшого шкільного віку щодо формування відповідального ставлення до майбутнього материнства.

Література.

1. Гончар Л., Куркіна О. Теоретичні й практичні аспекти формування у дівчат-старшокласниць готовності до відповідального батьківства. http://www.aphn-journal.in.ua/archive/34_2020/part_2/35.pdf.
2. Сидоренко Т.С. , Грисенко Н.В. Роль взаємовідносин з матір'ю в дитинстві у формуванні ставлення жінки до власного материнства. «Молодий

<http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/11/51.pdf>

3. Тіунова О. Психологічні умови формування відповідального ставлення до материнства у дівчат-старшокласниць: дис. .. канд. псих. наук : 2008/ Тернопольський національний педагогічний ун-т імені Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2008. 183 с.

4. Філіппова Р. Психологія материнства. 2018.
https://stud.com.ua/127337/psihologiya/psihologiya_materinstva

5. Шахрай В. Формування готовності старшокласників до відповідального батьківства: основні поняття дослідження. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. Кн.1. 2022. № 26. С. 206-221

6. Яворська Л. Підготовка молоді до сімейного життя в США. Статева соціалізація та підготовка учнівської молоді до сімейного життя у педагогіці та шкільній практиці зарубіжних країн : монографія. 2009. Тернопіль. С. 20–46.

7. Яценко Л. Сутнісні характеристики готовності до відповідального батьківства. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. 2013. Вип. 17(2). С. 513–521.

8. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. В. Бусел.– К.: Ірпінь: ВТФ-Перун. 2004. <https://1531.slovaronline.com/80077-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE>

9. Енциклопедія сучасної України. Encyclopedia of modern ukraine.
<https://esu.com.ua/article-66951>

10. Дівчинка-підліток: психологічні особливості.
<https://osvita.ua/vnz/reports/psychology/28948/>

1.3. До питання адаптації особистості: види, чинники, напрями дослідження

Бегеза Л. Є.

Таран Л. К.

Актуальність. Сучасний світ постійно змінюється та вимагає змінюватися разом з ним. Зміни в особистому та професійному житті, а також більш глобальні виклики – втрата роботи, переїзд у іншу країну, несприятливі впливи професійного середовища, розрив відносин тощо, впливають на життєдіяльність особистості. Такі зміни досить часто супроводжуються невпевненістю, втратою контролю та розвитком стресових станів, які при певних несприятливих умовах можуть посилюватися, провокуючи розвиток психосоматичних і психічних захворювань. Організм людини починає пристосовуватися до умов зовнішнього середовища починаючи з народження та цей процес триває протягом усього життя, й супроводжується аналізом власної здатності відновлювати потенційні фізичні та моральні ресурси впродовж усієї життєдіяльності. А отже, вміння пристосуватися, адаптуватися до цих змін дозволяє досягти успіху та гармонії в нашому житті. Психологія є однією із галузей науки, що досліджує психологічний компонент процесу адаптації. Психологами визначаються підходи та техніки, які виявляють чинники, потреби, особливості адаптації особистості, а також віднайти внутрішню гармонію та ресурси для подолання труднощів, зниження нервово-психічної напруги завдяки застосуванню відповідних психокорекційних заходів. Актуальність дослідження адаптації зумовлена швидкими змінами в суспільстві, освіті, науці та професійній сфері, які вимагають від індивідуума здатності пристосовуватися до нових викликів не втрачаючи власної ефективності та формуючи стресостійкість. Створення технологій адаптації, які можуть враховувати усі сучасні вимоги та позитивний досвід науковців.

Мета. Розглянути психологічні особливості адаптації, чинники, що обумовлюють даний процес.

Результати дослідження. Проблема адаптації людини розглядається як предмет дослідження в багатьох науках (біологія, соціологія, медицина, педагогіка, психологія тощо). В першу чергу адаптація це процес пристосовування (лат. *Adaptatio* – пристосовування, *adaptare* – пристосовування). Так, у «Психологічному словнику» адаптація тлумачиться як «процес пристосовування організму, особистості до зміни оточуючих умов життя, діяльності за допомогою фізіологічних, психічних і соціальних реакцій, спрямованих на створення передумов нормального функціонування у незвичних умовах» [1]. Таким чином, адаптація як відповідь на дію одного фактору зустрічається не часто та притаманна зазвичай умовам лабораторного експерименту. Найчастіше організм людини перебуває під впливом групи різних чинників різної спрямованості, іноді не пов'язаних один з одним. Тому адаптація це пошук організмом рівноваги із чинниками внутрішнього та зовнішнього середовища.

Людина це біологічна істота, тому адаптація в біологічному значенні це зміни в структурі або функціонуванні організму, що дозволяють організму пристосовуватися до умов впливу різних чинників зовнішнього середовища. Вивчення адаптації було розпочате саме із загальнобіологічного підходу німецького фізіолога Г. Ауберта 1865 р., який першим запропонував термін «адаптація», для характеристики явища пристосовування органів чуття (зору, слуху тощо) до впливу відповідних зовнішніх подразників різної інтенсивності. Його наступником був Ж. Б. Ламарк, який адаптаційними змінами в організмі пояснював виникнення окремих видів та їх еволюцію. Крім того, виділяють фізіологічну адаптацію, як пристосовування власне самого організму до умов його існування та біологічну – коли йде мова про пристосовування організму як виду до зовнішніх умов в процесі еволюції [2]. Оскільки людина має своє специфічне місце існування – соціум, то поряд з біологічними механізмами адаптації, логічно розглядати і соціальний аспект даного явища. У соціології поняття адаптація характеризує взаємодію організму як особистості чи в складі соціальної групи з навколишнім світом, це обумовлює процес засвоєння норм і цінностей світу в процесі соціалізації, а також прийняття тих змін, які сприяють перетворенню оточуючого світу відповідно до нових цілей діяльності особистості. Соціальна адаптація формується на основі індивідуальних особливостей

особистості (рівень освіти, виховання, притаманні їй цінності, культурні норми та ін.) та в результаті її інтеграції в соціальні відносини формуються поведінкові, комунікативні, міжособистісні взаємини [3].

У педагогіці адаптація розглядається як активний процес пристосування особистості (як здобувача освіти так і педагога) до нових умов навчання, складових навчального процесу: до нового предметного змісту навчальної роботи, до нових форм навчання, до конкретного здобувача освіти, / педагога, до застосування нових технічних засобів, до умов взаємодії та вимог освітнього середовища тощо. Це явище зазвичай охоплює як соціальні так і психологічні аспекти, пов'язані з успішною інтеграцією в освітню систему. Соціальні інститути впливають на соціалізацію особистості, а також на особливості її професійна діяльність. Професійна адаптація це процес або результат процесу пристосування працівника до особливостей організації робочого місця та праці, зазвичай у початковий період трудової діяльності. На процес адаптації впливає рівень професійної підготовки, інтелектуальний та емоційний розвиток, а також вміння взаємодіяти з колегами. Вважається, що стаж професійної діяльності має вплив на соціально-психологічну та професійну адаптацію.

Професійна адаптація це довготривалий динамічний процес, що постійно змінюється під впливом змін соціально-економічних умов, змін технологічних процесів, вікових, психологічних, фізіологічних особливостей працівника, його попереднього соціального і трудового досвіду, рівня професійної майстерності [4].

У цілому психологія розглядає адаптацію як об'єкт дослідження, з точки зору вивчення процесу взаємодії особистості та зовнішнього середовища під впливом різних чинників, як зовнішнього так і внутрішнього походження. Адже психологічна адаптація відбувається постійно, упродовж всього життя, та є необхідною умовою процесу існування особистості і середовища існування, що забезпечується певною системою відповідних механізмів (рефлексія, емпатія, соціальний зворотний зв'язок тощо) [4].

Пристосування, як початковий елемент адаптаційних процесів, відображає форму первинної взаємодії особистості із середовищем. Здатність до адаптації є проявом адаптаційних можливостей системи вищої нервової діяльності, оскільки

головна роль у цьому процесі належить психічній сфері людини. Загалом рівень адаптаційних можливостей особистості відображає рівень розвитку суспільства в цілому, економіки, науки, культури тощо.

Враховуючи це у соціальній психології виділяють два види адаптації, які взаємопов'язані та мають вплив одна на одну – професійна та соціально-психологічна. Професійна адаптація, розглядається як різновид соціальної адаптації яка полягає у пристосуванні особистості до професійного середовища та взаємодії з ним. Це складний, багатоаспектний процес, який включає в себе професійний ріст особистості, набуття професійних навичок та вмінь, формування якостей необхідних для існування в колективі [5].

В професійній адаптації людини виділяють 4 основні рівні. Перший рівень початковий, він полягає в підготовці до професійної діяльності – допрофесійна підготовка, профорієнтація, створення базового психофізичного, морального та інтелектуального потенціалу, що необхідний для ефективної професійної діяльності. На другому рівні відбувається пошук сприятливих умов праці із урахуванням особистісних рис характеру, інтелекту та професійної підготовки. На третьому рівні здійснюється пристосування як до умов праці (режим, особливості трудової діяльності тощо), так і до колективу (особливості взаємодії, встановлення особистісних контактів). Четвертий рівень – це вищий рівень адаптації особистості в колективі, професійний ріст та розвиток професійної творчості. Тобто розвивається соціально-психологічна адаптація, коли людина долучається до системи взаємовідносин в колективі, асимілюється до умов в певному середовищі [5]. Ключовою складовою кожного рівня є навчання. Активне навчання необхідне як на початковому рівні, для набуття потрібних вмінь та навичок, розвитку міжособистісних зв'язків, так і на останньому рівні, коли з'являється потреба у відділеному результаті – професійному зростанні, керуванні групою тощо.

Процес професійної адаптації вважається завершеним, якщо людина опанувала необхідний обсяг знань та вмінь, його поведінка відповідає встановленим нормативам, є бажання удосконалювати свої навички, з'являється відчуття задоволення своєю професійною діяльністю.

Соціально-психологічна і професійна адаптації пов'язані між собою та впливають одна на одну. Дані наукових досліджень свідчать, що процес професійної адаптації обумовлений особливостями соціально-психологічної адаптації особистості в колективі. Це зумовлено тим, що успішне перебування в професійному середовищі неможливе без встановлення гармонійних стосунків із колегами, прийняття норм і правил групової взаємодії, а також адаптації до нових соціальних ролей, отримання соціальної підтримки, адекватний пошук можливостей інтегруватися і взаємодіяти як у офіційних нормах так і у неформальних структурах колективу.

Психологічна адаптація це узагальнений показник стану особистості, його можливостей виконувати біологічно-соціальні функції – взаємодіяти з іншими людьми та динамічно змінюватися під впливом різних чинників зовнішнього середовища. При цьому особистість виступає як суб'єкт, так і об'єкт адаптаційного процесу. Емпатія, рефлексія та інші механізми забезпечують психологічну адаптацію особистості.

Психологічна адаптація також розглядається з точки зору клінічної психології, адже адаптація важлива в умовах стресу, хвороби, травматичних подій і психічних розладів. Психологічна адаптація це процес, під час якого людина пристосовується до нових умов внутрішнього та зовнішнього середовища, зберігаючи при цьому психічну рівновагу, здатність до самореалізації та працездатність. В клінічній психології успішна адаптація вважається однією з ознак психічного благополуччя. Ефективне функціонування людини в соціальному, професійному та особистісному аспектах забезпечується здатністю нашої психіки адаптуватися в умовах зовнішнього середовища, що постійно змінюються. В той же час, порушення адаптації може бути ознакою та проявом психологічних чи психіатричних проблем (тривожні розлади, депресія, психози тощо).

Клінічна психологія виділяє наступні типи психологічної адаптації: нормативна адаптація – успішне пристосування до змін зовнішнього середовища (новий колектив, початок навчання, кардинальні життєві зміни); патологічна адаптація – патологічні емоційні переживання чи порушення соціального

функціонування особистості внаслідок проблем які виникли в дитинстві, порушення самовизначення або потреба в зовнішньому схваленні та ін., що може в подальшому призводити до порушень психічного стану; реадаптація – повторна адаптація особистості до зовнішнього середовища після тривалого перебування в умовах ізоляції, важкої хвороби, травми чи кризи.

У клінічна психології, розглядаючи процес адаптації особистості в суспільстві, виділяють ряд механізмів які забезпечують перебіг цього процесу. Ресурсні механізми це особистісні механізми, які сприяють нормативній адаптації – оптимізм, віра у власні сили, підтримка рідних та близьких, колег тощо. Іншим механізмом є психологічні захисти, це несвідомі способи регулювання внутрішнього конфлікту (заперечення, забування, регресія, раціоналізація, витіснення, сублімація, регресія). Дані захисти є корисними в процесі подолання стресових ситуацій, проте можуть бути небезпечними якщо ними зловживати. В процесі адаптації особистість використовує власні копінг-стратегії, що базуються на основі особистісного досвіду та резервів психіки. Копінг-стратегії це спосіб вирішення проблеми шляхом використання кола альтернативних рішень для ефективної адаптації в соціумі. До базисних копінг-стратегій відносять розв'язання проблем, пошук соціальної підтримки та уникання. Копінг-стратегії передбачають аналіз стресової ситуації та шляхів її вирішення.

У клінічні практики також розглядаються порушення процесу адаптації у вигляді адаптаційних розладів (тривожність, апатія, конфліктність, невротичні симптоми, психогенні захворювання в результаті перебування в стресовій ситуації), дезадаптації (неможливість виконувати соціальні, професійні чи особисті функції людиною) та соматизації (прояв емоційних проблем патологічними змінами функціонування організму – головний біль, безсоння тощо).

Для дослідження процесів психологічної адаптації в клінічній психології застосовуються психодіагностичні методики (клінічне інтерв'ювання, анамнестичний та експериментально-психологічний методи) та тести на стресостійкість (наприклад, опитувальники копінг-стратегій). Для пристосування до умов зовнішнього світу людина, як особистість, володіє певними властивостями

які й визначають стійкість її характеру, що є унікальним. Всі ці властивості або чинники, або суперфактори за Г. Айзенком [6] характеризують індивідуально-психологічні властивості характеру людини які й забезпечують її пристосування до зовнішнього світу: темперамент, емоційна стабільність чи лабільність, рівень тривожності, самоповага тощо. На процес адаптації також впливають такі особистісні риси як тактовність, комунікабельність, принциповість, працелюбність, ентузіазм, відповідальність та інші. Реалізація адаптивної поведінки залежить від інтенсивності перебігу психічних процесів, проявів імпульсивності, емоційності. Крім того, мають значення емоційно-вольові якості особистості, характер набутих вмінь та життєвого досвіду, який дозволяє швидко пристосуватися до нових умов. Власне, вивчення цих чинників особистості й дозволяє оцінити адаптацію людини з позиції її внутрішнього середовища, тобто встановити переважання одних факторів над іншими та пояснити певні форми поведінки через фізіологічне функціонування центральної нервової системи. Іншою групою чинників, що мають вплив на формування адаптації особистості є соціально-психологічні: соціальне оточення, соціальна самоідентифікація, самооцінка, оцінка з боку інших людей тощо. Всі ці чинники забезпечують стимулювання певних рис характеру та формують досвід, що в свою чергу впливає на розвиток і становлення особистості, яке змінюється під впливом різноманітних факторів, оточуючих умов і мінливих життєвих обставин [7].

Крім того, клінічна психологія виділяє ще одну групу патологічних чинників, які можуть впливати на процес адаптації людини в зовнішньому середовищі, це наявність хронічних захворювань, перенесених чи існуючих психічних розладів, травматичного досвіду тощо.

Враховуючи, що процес психологічної адаптації є динамічним та багатфакторним, існує багато підходів до її вивчення. Так, С. М. Кулик виділяє такі основні підходи у вивченні адаптації: біофізіологічний, психологічний, інформаційно-комунікативний [8]. Біолого-фізіологічний підхід розглядає адаптацію як біологічний процес спрямований на пристосування та активне підтримання необхідного рівня відповідності структури та функціонування

організму до внутрішніх та зовнішніх факторів навколишнього середовища – біологічних, хімічних, екологічних, фізіологічних тощо. Цей підхід досліджує наступні види адаптації: біологічну, фізіологічну, анатомічну, медичну, екологічну, ергономічну. Психологічний підхід спрямований на вивчення діалектичної єдності діяльнісних і соціально-психологічних відносин особистості та соціального середовища. Виділяють як індивідуальний підхід так і систему внутрішньо-групових відносин в колективі та пристосування до них. Цей підхід досліджує психологічну, соціальну, соціально-психологічну, особистісну та професійну адаптацію.

Інформаційно-комунікативний підхід досліджує взаємну адаптацію психосемантичних систем, як процес зміни й пристосування психіки, шляхом вивчення зміни структури або функціонування системи та керуючих впливів на основі одержаних даних і поточної інформації для досягнення оптимального стану при змінених умовах життєдіяльності. Тобто, психосемантичні системи забезпечують сприйняття, осмислення й організацію інформації, що надходить ззовні, та формування на цій основі поведінки, яка відповідатиме вимогам середовища, в результаті чого процес адаптації допомагає людині підтримати та зберігати цілісність самосвідомості в умовах змін зовнішнього середовища [8]. В. Д. Кислий виділяє три основні напрями дослідження проблеми адаптації з позицій психофізіології. Ним запропоновано: а) клініко-психологічні дослідження стресу (адаптація вивчається виокремлено, не пов'язано із предметною діяльністю); б) вивчення реакцій конкретних органів та психічних процесів на робоче навантаження або на несприятливі умови діяльності (шум, гіпоксія, тиск); в) комплексне вивчення психічного і фізіологічного стану особистості в процесі адаптації [9].

Якщо об'єднати запропоновані науковцями напрями дослідження адаптаційних процесів то можна виділити наступні підходи [10]. Системний підхід, який полягає в тому, що головна властивість організму як біологічної саморегулюючої системи виявляється в її здатності до гнучкої поведінки у середовищі. Для таких систем характерні невизначеність (неповний детермінізм) і надмірність. Концепція системності трудової діяльності людини розглядає процеси

адаптації не лише на індивідуальному рівні, але й на вищих рівнях, включаючи антропобіоценоз, біосферу, ноосферу. Діяльнісний підхід розглядає адаптацію як взаємопов'язаний процес пристосування до змінних чинників зовнішнього середовища, рідше до себе. Це пояснюється труднощами вивчення адаптації у внутрішньо-особистісному просторі людини. Психологія, як і філософія, соціологія, політологія та педагогіка не заперечує біологічну складову в понятті адаптації людини, а навпаки розширює її, від поняття природне середовище до соціального, виділяючи соціальні чинники як ті, що впливають через індивідуальні особливості на її адаптацію в суспільстві [5]. Тому процес адаптації в першу чергу й розглядається з точки зору соціалізації особистості, її взаємодії з суспільством. Соціально-психологічний аспект адаптації пов'язаний з труднощами взаємодії особистості з суспільством, пристосування до оточення, набуття певного соціального статусу та його підтримка, засвоєння нових соціальних норм. Також в соціально-психологічній адаптації розділяють поняття «пристосування» та власне «адаптація», тобто відмічається тенденція від пасивного пристосування до оточення і до розвитку продуктивних взаємовідносин між особистістю та суспільством.

Висновки. Проведений аналіз наукових досліджень дозволив встановити, що поняття адаптації включає біологічну, соціальну, психологічну складову та характеризує взаємодію особистості із зовнішнім середовищем, ефективність якої залежить від ступеня узгодженості умов середовища з можливостями організму та психіки людини. Крім того, процес адаптації обумовлений взаємозалежністю фізіологічних та психологічних особливостей особистості, особливостей психологічних реакцій на стреси, особливостей професійної діяльності людини, технологічного, науково-інформаційного розвитку суспільства. Адаптація є складним та багатогранним процесом, який передбачає резерви людини і їх оптимальне використання у професійній реалізації за умови пристосування до підвищеної стресогенності у викликах сьогодення. Зміни, що відбуваються на сьогодні в суспільстві, обумовлюють необхідність в подальших дослідженнях із встановлення проблеми впливу умов середовища на процес адаптації людини до нього та вивчення чинників, які сприятимуть оптимальному перебігу цього процесу.

Література.

1. Синявський В. В., Сергєєнкова О.П. Адаптація. Психологічний словник. Київ: Науковий світ, 2007. С. 12.
2. Sikora Y. Адаптація як об'єкт наукового дослідження: психолого-педагогічний аналіз. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота».2022. № 2 (51). С. 135–139. doi.:10.24144/2524-0609.2022.51.135-139.
3. Шиделко А. В. Психологічні чинники професійної адаптації особистості. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2016. № 2. С. 151–159.
4. Бондаренко І. І. Психологічні умови ефективної професійної адаптації психологів-початківців: автореф. дис. ... канд. психол.наук. К., 2004. 19 с.
5. Блажівський М. І. Поняття адаптації у сучасній науковій літературі. Науковий вісник Львівського держ. Уніве. Внутріш. Справ. 2014. № 1. С. 232–242.
6. Scheibe V. M., Brenner A. M., de Souza G. R. et all. The Eysenck Personality Questionnaire Revised – abbreviated (EPQR-A): psychometric properties of the Brazilian Portuguese version. Trends Psychiatry Psychother. 2023. Vol. 45. Article: 20210342. doi: 10.47626/2237-6089-2021-0342.
7. Швень Ю. Р. Соціально-психологічні чинники формування самооцінки особистості. ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки. Гуманітарні науки: зб. тез доп. XXI Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 2021. Т. 1. С. 106–107.
8. Кулик С. М. Психологічні особливості управління професійною адаптацією вчителів: дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України. К., 2004. 140 с.
9. Кислий В. Д. Особливості соціально-психологічної адаптації офіцерів-випускників до діяльності в особливих умовах: автореф. дис. ... к.пс. н. Х., 2003. 23 с.
10. Солодухова О. Г. Становлення особистості вчителя у процесі професійної адаптації: монографія. Донецьк: ТОВ «Лебідь», 1996. 176 с.

1.4. Соціальна підтримка та якість життя клієнток стоматологічних клінік з тривожними станами в умовах травматичних подій

Бичук М.І.

Актуальність. Якість життя та соціальна підтримка разом є ваговою складовою соціально-підтримуючого процесу. Саме соціальна підтримка виконує особливу роль у процесі подолання стресових і проблемних ситуацій будучи взаємопов'язаною з фізичним здоров'я та поведінкою особистості [1,2]. Соціальна підтримка є динамічним утворенням, форми та якості якої змінюються услід за зміною життєвої ситуації і самої особистості. Треба зазначити, що ефективність соціальної підтримки (не враховуючи базисної копінг-стратегії пошуку соціальної підтримки) визначається позитивністю її сприйняття, адекватна і гармонійна взаємодія яких є одним з важливих факторів, що визначають успішність лікувально-діагностичного, психотерапевтичного та реабілітаційного процесів.

За визначенням S. Cobb [3] соціальна підтримка – це інформація, яка призводить особистість до впевнення, що вона потрібна, її кохають та цінують, що вона є частиною мережі взаємовідносин та взаємних зобов'язань. Крім того соціальна підтримка визначається як обмін ресурсами між різною кількістю людей, принаймні, двома – донором підтримки та її реципієнтом (одержувачем) і є функцією соціальних мереж, які характеризують соціальне середовище особистості [3].

Аналізуючи різні аспекти соціальної підтримки необхідно вказати про мережу соціальної підтримки. Мережа соціальної підтримки це структури, здатні надати людині допомогу, які включають різні взаєностосунки між людьми, сприяючі підтримці здоров'я [4]. Досліджені жінки, що мають соціальну підтримку від сім'ї, друзів, інших значущих осіб володіють кращим здоров'ям, можуть краще справляються із стресами, стійкіші до розвитку тривожних станів. Тобто, соціальна підтримка, а у більшому ступені психосоціальна підтримка є важливим процесом у подоланні стресових і проблемних ситуацій, що враховує наступні напрямки:

1. Здатність жінки із тривожним станом приймати психосоціальну допомогу від оточуючих – сприйняття соціальної підтримки.

2. Здатність знаходити людей, які можуть надати психосоціальну допомогу – пошук соціальної підтримки.

3. Наявність можливостей здатних надати підтримку (члени сім'ї, друзі, значущі особи, програмні заходи) – мережі соціальної підтримки.

Виокремлено види соціальної підтримки:

а) Емоційна – довіра, співпереживання, турбота і т. ін.

б) Інструментальна –забезпечення ресурсами та фінансова допомога, допомога колег.

в) Інформаційна – вирішенні проблеми застосуванням важливої інформації.

г) Зворотний зв'язок – оцінка вирішення проблем.

С. Cohen до компонентів соціальної підтримки відніс:

– структура (сімейний статус, друзі, зв'язки з родичами, членами формальних і неформальних організацій і т. ін.);

– функції (емоційна, інформаційна, ресурсна);

– ефект (задоволеність підтримкою) [1].

Подолання тривожного стану та стресу у людини при соціальної підтримці відбувається наступним шляхом: – відновлення (підвищення) самооцінки; за рахунок думки значущої особи, що призводить до зміни емоційної відповіді на дію стресового чинника та дозволяє побачити ситуацію по іншому; за рахунок допомоги інших у стресовій ситуації.

При тривожних станах соціальна підтримка пом'якшує дію стресу високої інтенсивності, виступає як буфер між стресором і особистістю. Висока соціальна підтримка нейтралізує негативний вплив стресу й є профілактикою розвитку тривожного стану. Низька соціальна підтримка не створює буферного ефекту, що не захищає від розвитку тривожного стану. С. Cohen із співавт. зазначають, що соціальна підтримка знижує негативну дію стресу, підвищує самооцінку, посилює міцність імунної системи, в наслідок чого зменшується сприйнятливність до розладів, у тому числі тривожного спектру [2].

Мета. Дослідити соціальну підтримку та якість життя жінок з тривожними станами. Завдання – встановити особливості соціальної підтримки та якості життя жінок у стоматологічній практиці в умовах травматичних подій.

Матеріали та методи досліджень. З дотриманням принципів біоетики та деонтології протягом 2023–2024 рр. за умови інформаційної згоди проведено комплексне обстеження 236 осіб, клієнток стоматологічних послуг м. Канів. Дослідження проведено з дотриманням принципів етики Американської психологічної асоціації [5], «Кодексу етики» протокол № 10 від 14.07.2016 [6], «Положення про академічну доброчесність Академії праці, соціальних відносин і туризму» протокол № 7 від 12.04.2018 р. [7]. Після первинної обробки даних у дослідження включено 200 осіб, серед яких проведено порівняльний аналіз результатів дослідження та які розподілилися наступним чином: дослідна група – ДГ, N=150 та контрольна група – КГ, N=50. Дослідження виконувалося за допомогою методик: «Шкала соціальної підтримки» [8], «Опитувальник якості життя» [9]. Аналіз, обробка і підрахунок процентних характеристик і коефіцієнтів кореляції здійснювалися за допомогою програми SPSS 10.0.5 for Windows [10, 11]. Частина досліджень виконана за допомогою Google Forms у форматі інтерв'ювання (Computer Assisted Personal Interviewing, CAPI) та веб-опитування (Computer Aided Web Interviewing, CAWI) [12].

Результати досліджень. Дослідження соціальної підтримки жінок із тривожним станом в умовах травматичних подій проводилося за допомогою методики «Шкала соціальної підтримки» (багатомірна шкала сприйняття соціальної підтримки – MSPSS, автор. Д. Зімет, адаптації В.М. Ялттонський, Н.А. Сирота) [8]. Методикою встановлено суб'єктивне сприйняття соціальної підтримки жінками за трьома аспектами: «родина», «друзі», «інші значущі особи». Розподіл клієнток стоматологічної клініки за суб'єктивним сприйняттям соціальної підтримки відображено у табл. 1.

Таблиця 1

**Розподіл клієнток стоматологічної клініки за суб'єктивним сприйняттям
соціальної підтримки (тест MSPSS)**

Аспект	Групи			
	ДГ, n=150 (100,0%)		КГ, n=50 (100,0 %)	
	N	%	N	%
Родина				
Так	85	56,7	35	70,0
Ні	65	43,3	15	30,0
Всього	150	100,0	50	100,0
Друзі				
Так	80	53,3	34	68,0
Ні	70	46,7	16	32,0
Всього	150	100,0	50	100,0
Інші значущі особи				
Так	79	52,7	31	62,0
Ні	71	47,3	19	38,0
Всього	150	100,0	50	100,0

Примітка. Достовірність розбіжностей показників шкал у групах $p \leq 0,05$.

Данні табл. 2.21, свідчать, що 56,7 % жінок ДГ сприймали родину у якості системи соціальної підтримки, у свою чергу 43,3 % так не вважали. У КГ 70,0 % жінок сприймали родину у якості системи соціальної підтримки, у свою чергу 30,0 % так не вважали ($p \leq 0,01$). Виявлено, що 53,3 % жінок ДГ сприймали друзів у якості системи соціальної підтримки, у свою чергу 46,7 % так не вважали. У КГ – 68,0 % жінок сприймали родину у якості системи соціальної підтримки, у свою

чергу 32,0 % так не вважали ($p \leq 0,01$). Встановлено, що 52,7 % жінок ДГ сприймали інших значущих осіб у якості системи соціальної підтримки, у свою чергу 47,3 % так не вважали. У КГ – 62,0 % жінок сприймали родину у якості системи соціальної підтримки, у свою чергу 38,0 % так не вважали ($p \leq 0,01$). Можна зазначити, що суб'єктивно усі види соціальної підтримки у ДГ у порівнянні із жінками КГ є менш значущими, тобто жінки з тривожними станами не розглядали родину, друзів, інших значущих осіб в якості міцного ресурсу для адаптації ($p \leq 0,01$). Враховуючи вищевикладений розподіл показників за суб'єктивним сприйняттям соціальної підтримки досліджено загальний рівень (середній бал) суб'єктивного сприйняття соціальної підтримки клієнток стоматологічної клініки (тест MSPSS), що відображено на рис. 1.

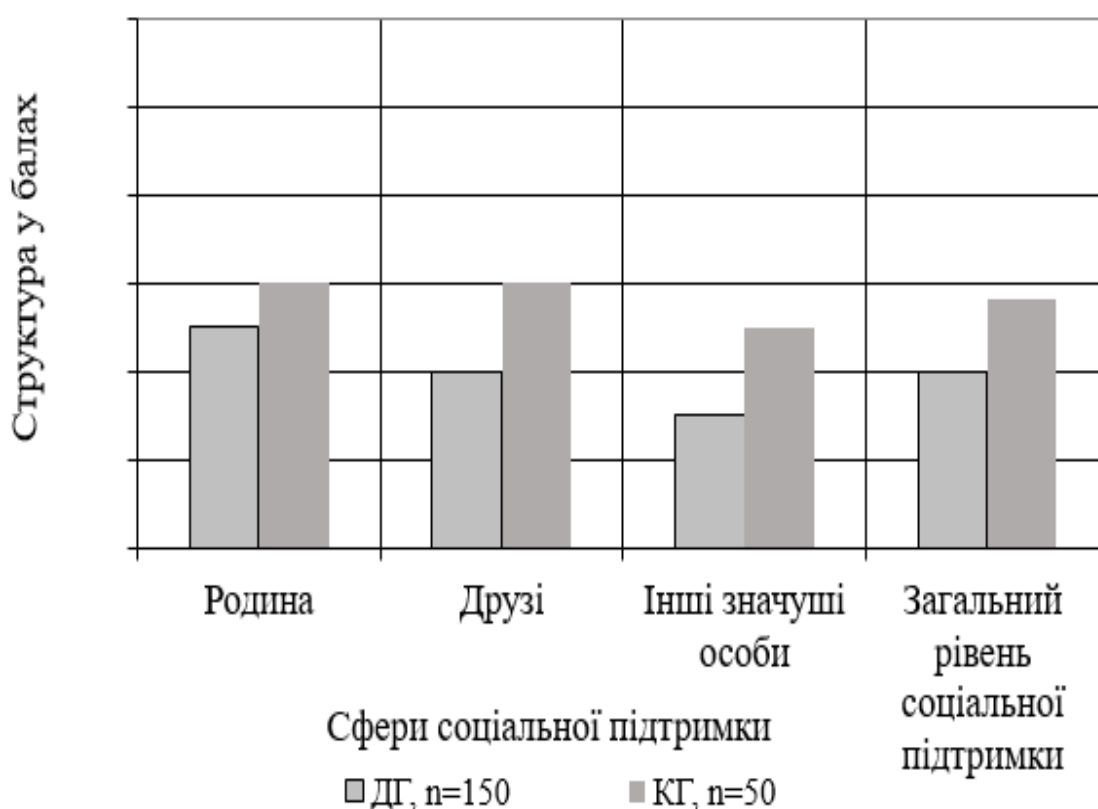


Рис. 1. Середній бал суб'єктивного сприйняття соціальної підтримки клієнток стоматологічної клініки (тест MSPSS)

За аналізом даних рис. 2.3, можна стверджувати, що середній бал у жінок ДГ дорівнює: підтримка родини – 5,0, друзів – 4,0, інших значущих осіб – 3,0, інтегральний рівень – 4,0 балів.

У обстежених КГ середній бал склав: підтримка родини – 6,0, друзів – 6,0, інших значущих осіб – 5,0, інтегральний рівень – 5,7 балів. В цілому можна зазначити, що жінки ДГ вважали низькою соціальну підтримку від родини, друзів та інших значущих осіб ($p \leq 0,05$).

Узагальнюючі можна зазначити, що встановлена у ДГ низька соціальна підтримка значно впливала на формування негативних поведінкових та соціальних патернів, що призводило до формування неадаптивних форм поведінки. Так, родинна підтримка в умовах травматичних подій не дозволяла знизити тривожний стан та уникнути дезадаптуючої поведінки. Друзі і значущі особи характеризувалися як протективні фактори стримування дезадаптивної поведінки, але значно не впливали в якості чинника зниження тривожності. Аналіз взаємозв'язків виявив зв'язки загального інтегрального показника з: недостатньою/низькою соціальною інтеграцією ($r = 0,34$, $p < 0,05$), емоційною підтримкою ($r = 0,27$, $p < 0,05$), родинними проблемами ($r = 0,62$, $p < 0,05$). Встановлено, що «значущі особи» виступають в якості підтримки ($r = 0,40$, $p < 0,05$) надають інформаційну ($r = 0,51$, $p < 0,05$), емоційну ($r = 0,69$, $p < 0,05$), інструментальну ($r = 0,40$, $p < 0,05$) підтримку. В цілому можна зазначити, що інформаційна підтримка яку надають значущі особи є дуже важливою та цінною для жінок з тривожними станами. У свою чергу прогностично не сприятливою ознакою виявлено відсутність кореляційного зв'язку між загальним інтегральним рівнем соціальної підтримки та ступенем суб'єктивної задоволеності життям жінками. Виявлену ситуацію можна характеризувати наступним чином: соціальні чинники не є постійно стримуючими при формуванні дезадаптуючої поведінки жінки в травматичному середовищі. Для встановлення ступеня впливу соціальних чинників як предикторів впливу на задоволеність соціальною підтримкою використано метод регресійного аналізу. Виявлено, що лише на 15,0 % соціальні чинники впливають на задоволеність жінкою соціальною підтримкою ($p \leq 0,05$), що

можна розглядати як маркер для психокоррекційного супроводу, якій повинен враховувати наступне: – консультативна робота із родиною або значущими особами жінки; – зміною очікувань жінки від себе з перебудовою поведінкових соціальних патернів; – адаптація жінки до соціального середовища.

Наступним етапом у дослідженні стало вивчення якості життя жінок із тривожним станом в умовах травматичних подій, яка оцінювалася за допомогою опитувальника якості життя, розробленого Mezzich, Cohen, Ruiperez, Liu & Yoon (1999) [9]. За класичною технологією оцінки якості життя відокремлено три компоненти її аналізу: 1. Суб'єктивного благополуччя / задоволеності; 2. Виконання (соціальних) ролей; 3. Зовнішні життєві умови (матеріальні і соціальні, наприклад соціальна мережа й соціальна підтримка). Важливо зазначити, оцінювання сфер життя відбувалося з точки зору «багатоаспектної оцінки», так як якість особистості є різною у різних сферах (наприклад «поганою» у одній родині й дуже доброю у трудовій діяльності і т. ін.). На першому етапі психокоррекційний супровід спрямований на надання допомоги жінки з тривожним станом де виявлялися найбільші труднощі. При дослідженні якості життя жінок, як клієнток стоматологічних клінік ми намагалися враховувати усі складові компоненти (суб'єктивне благополуччя/задоволеність, функціональний стан, контекстуальні чинники), швидкість змін в даних сферах та зміну думки жінки внаслідок тривожного стану в умовах травматичних подій.

Розподіл показників якості життя у клієнток стоматологічної клініки відображено у табл. 2. З представлених у табл. 2.22 даних, видно, що структура якості життя за оцінкою досліджених ДГ та КГ є різною. Проте в цілому за ранжуванням середнього індексу, як об'єктивного показнику з врахування трьох суб'єктивних точок зору: жінки, фахівця, члена родини у загальної структури визначено наступне: фізичне благополуччя – ДГ – 10,7 %, КГ – 8,9 %; самообслуговування – ДГ – 8,9 %, КГ – 10,0 %; працездатність – ДГ – 12,5 %, КГ – 10,8 %, соціо-емоційна підтримка – ДГ – 10,7 %, КГ – 11,1 %; суспільна та службова підтримка ДГ – 7,1 %, КГ – 10,0 %; самореалізація ДГ – 8,9 %, КГ – 10,0 %; духовна реалізація ДГ – 8,9 %, КГ – 8,9 %; загальне сприйняття якості життя – ДГ – 10,7 %, КГ – 8,9 %.

КГ – 10,0 ($p \leq 0,05$). Середній бал – показник якості життя у досліджених ДГ склав 5,6 балів, у КГ відповідно 9,0 балів.

Таблиця 2

**Розподіл показників якості життя у клієнток стоматологічної клініки
(середній індекс об'єктивного показнику)**

Тип ставлення до стану здоров'я	ДГ, n=150		КГ, n=50	
	Середній бал	%	Середній бал	%
Фізичне благополуччя	6	10,7	8	8,9
Психологічне / емоційне благополуччя	5	8,9	9	10,0
Самообслуговування та незалежність у діях	7	12,5	9	10,0
Працездатність	7	12,5	9	10,0
Міжособистісна взаємодія	5	8,9	10	11,1
Соціо-емоційна підтримка	6	10,7	10	11,1
Суспільна та службова підтримка	4	7,1	9	10,0
Самореалізація	5	8,9	9	10,0
Духовна реалізація	5	8,9	8	8,9
Загальне сприйняття якості життя	6	10,7	9	10,0
Кількість балів	56	100,0	90	100,0
Середній бал	5,6	—	9,0	—

З метою визначення ієрархії проблем якості життя для побудови програми психокорекційного супроводу жінок проведено кореляційний аналіз взаємозв'язків та їх ранжування між показниками якості життя жінок. Кореляційний аналіз з виокремленням тісноти зв'язків між шкалами здійснено за кожною думкою жінки. Для встановлення первинних напрямків психокорекційного супроводу проведено аналіз кореляційних показників із виокремленням міцних, значущих кореляційних

зв'язків. Виявлено, що за думкою жінок зв'язок між деяким показниками був обґрунтований як незначний або у ієрархії дана проблема не зазначалася як важлива, але у загальному кореляційному аналізі данні проблеми визначені (міцний рівень зв'язку) як важливі. Виявлено, що у жінок ДГ існує позитивний кореляційний зв'язок між усіма шкалами. У КГ позитивних кореляційних зв'язків з руйнуючим ефектом показників не виявлено ($p \leq 0,05$). Найбільший міцний взаємозв'язок у жінок ДГ встановлено між психологічним / емоційним благополуччям – самообслуговуванням – незалежністю у діях ($r=0,95$) – соціо-емоційною підтримкою ($r=0,96$) – міжособистісною взаємодією ($r=0,92$). Тобто на першій план психокорекційного супроводу у жінок виходять проблеми відчуття себе психологічно та емоційно чужою в умовах травматичних подій війни з наростаючим відчуттям «змушено» відторгнутою у мікро- та макро- соціальному середовищі. Так ситуація породжує коло причинно-наслідкових зв'язків функціонування жінки ДГ: знижена адаптивна здатність вирішення психосоціальних проблем у суспільстві та родини є наслідком ситуаційно-обумовленого травмуючого впливу війни, що у свою чергу посилюється зниженням комунікативних ланок між жінкою та середовищем внаслідок тривожного стану.

Встановлені данні свідчать, що у жінок ДГ якість життя страждає комплексно в усіх сферах функціонування. Для психокорекційного супроводу жінок запропоновано наступні рекомендації:

а) Індивідуальні та групові психотерапевтичні заходи повинні спиратися не оцінку окремих сфер функціонування, а на показник загального сприйняття якості життя.

б) Первинним об'єктом психотерапевтичного впливу повинен бути тривожний компонент у контексті розгляду впливу травматичної дії війни з відновлення самообслуговування та незалежності у діях.

в) Невілювання відчуття тривожності/тривоги, які у жінок почасти є фоном для виникнення проблем у сферах функціонування з відновлення загального психологічного та емоційного благополуччя.

Висновки. Дослідження соціальної підтримки виявлено що родину у якості системи соціальної підтримки сприймали 56,7 %, друзів 53,3 %, інших значущих осіб 52,7 % жінок, тобто суб'єктивно у ДГ у порівнянні із КГ соціальна підтримка є менш значущою, а родина, друзі, інші значущі особи не сприймаються в якості ресурсу для адаптації ($p \leq 0,01$). У свою чергу середній бал у жінок ДГ дорівнював: підтримка родини – 5,0, друзів – 4,0, інших значущих осіб – 3,0, інтегральний рівень – 4,0 балів, а жінки вважали соціальну підтримку від родини, друзів та інших значущих осіб низькою ($p \leq 0,05$). Низька соціальна підтримка у ДГ значно впливала на формування негативних поведінкових та соціальних патернів, що призводило до формування неадаптивних форм поведінки. Так, родинна підтримка в умовах травматичних подій не дозволяла знизити тривожний стан та уникнути дезадаптувальної поведінки. Друзі і значущі особи характеризувалися як фактори стримування дезадаптивної поведінки, але значно не впливали в якості чинника зниження тривожності.

Дослідження якості життя виявило, що середній бал у ДГ склав 5,6 балів, у КГ 9,0 балів. Найбільший міцний взаємозв'язок у ДГ встановлено між психологічним / емоційним благополуччям – самообслуговуванням – незалежністю у діях ($r=0,95$) – соціо-емоційною підтримкою ($r=0,96$) – міжособистісною взаємодією ($r=0,92$). Тобто на першій план корекційного супроводу у ДГ виходять проблеми відчуття себе психологічно та емоційно чужою в умовах війни з наростаючим відчуттям «змушено» відторгнутою у мікро- та макро-соціальному середовищі. Виявлено коло причинно-наслідкових зв'язків функціонування жінки, а саме: знижена адаптивна здатність вирішення психосоціальних проблем у суспільстві та родини є наслідком ситуаційно-обумовленого травмуючого впливу війни, що у свою чергу посилюється зниженням комунікативних ланок між жінкою та середовищем внаслідок тривожного стану. Встановлено, що у жінок якість життя страждає комплексно в усіх сферах функціонування.

Література.

1. Cohen S., Wills T. Stress, social support, and the buffering hypothesis. *Psychological Bulletin*, Vol 98(2), Sep 1985, 310–357.
2. Cohen, S., & Syme, S. L. (Eds.). *Social support and health*. New York: Academic Press. Chapter 1: Issues in the study and application of social support – 1985.
3. Cobb S. Social support as a moderator of life stress. *Psychosom. Med.* 38:300-14, 1976. IBrown University. Providence. Rh.
4. Quick, J. D., Nelson, D., Matuszek, P., Whittington, J. L., & Quick, J. C. (1996). Social support, secure attachments, and health. In C. L. Cooper, *Handbook of stress, medicine, and health*. Boca Raton, FL: CRC Press.
5. Ethical principles of psychologists and code of conduct. American Psychological Association. Effective June 1, 2003 (as amended 2010, 2016). Effective January 1, 2017. <https://www.apa.org/ethics/code/ethics-code-2017.pdf>
6. Кодекс етики Академії праці, соціальних відносин і туризму. Протокол 10. Київ : АПСВТ. 2016. <https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/KodeksEtyky.pdf>.
7. Положення про академічну доброчесність Академії праці, соціальних відносин і туризму. Протокол №7, 12.04.2018. <https://www.socosvita.kiev.ua/sites/all/themes/apsv/pologenja.pdf>
8. Мельник Ю. Б., Стаднік А. В. Багатомірна шкала сприйняття соціальної підтримки: метод. посіб. (укр. версія). Харків: ХОГОКЗ. 2023. 12 с. <https://doi.org/10.26697/melnyk.stadnik.6.2023>
9. Марута Н.А., Панько Т.В., Явдак І.А., Семикіна О.Є. Критерій якості життя у психіатричній практиці. Харків: РІФ Арсіс, ЛТД, 2004. 240 с.
10. Landau S., Everitt B.S. *A Handbook of Statistical Analyses using SPSS*. Chapman & Hall / CRC Press LLC. 2004. 339 p.
11. Климчук В.О. Математичні методи у психології. Навчальний посібник для студ. психол. спец. Київ : Освіта України. 2009. 288 с.
12. Wimmer R. D., Dominick J. R. *Mass Media Research: An Introduction*. Cengage Learning. 2011. 260 p.

1.5. Особливості прояву депресивних станів в юнацькому віці та шляхи їх подолання

Болсуновська Н. А.

Актуальність. Депресивні стани в юнацькому віці є однією з найпоширеніших проблем психічного здоров'я, що значно впливають на якість життя, соціальну адаптацію і подальший розвиток особистості. Юнацький вік характеризується складними фізіологічними та психологічними змінами, які можуть провокувати підвищену емоційну вразливість. Попри широку поширеність депресії серед молоді, ця проблема часто недооцінюється через стигматизацію психічних розладів або незнання про їхні ознаки та наслідки. Важливим є пошук ефективних шляхів діагностики, лікування та профілактики депресивних станів, а також створення сприятливих умов для збереження психологічного благополуччя юнаків та дівчат.

Мета. Дослідити особливості прояву депресивних станів у юнацькому віці та визначення ефективних підходів до їх подолання, включаючи психотерапевтичні та профілактичні заходи.

Результати дослідження. Юнацький вік є критичним періодом для формування особистості, у якому фізичні, соціальні та психологічні зміни часто стають тригерами для розвитку депресивних станів. Однією з основних причин виникнення депресії є гормональні перебудови, які впливають на функціонування нервової системи. Суттєву роль відіграють і соціальні фактори, зокрема тиск з боку однолітків, конфлікти в сім'ї, академічні труднощі та високі очікування з боку дорослих. Характерними ознаками депресивних станів у юнацькому віці є стійке відчуття смутку, втрати інтересу до улюблених занять, зниження самооцінки, порушення сну та апетиту, а також схильність до ізоляції. У деяких випадках можуть проявлятися суїцидальні думки, що вимагає негайної уваги з боку батьків, педагогів і медичних фахівців.

Ефективні шляхи подолання депресії включають індивідуальну та групову психотерапію, яка допомагає юнакам усвідомити причини їхнього стану і розвинути навички емоційного регулювання.

Когнітивно-поведінкова терапія є одним із найпоширеніших підходів, оскільки вона дозволяє змінити негативні установки і розвинути позитивний погляд на життя. У важких випадках може бути доцільним застосування медикаментозної терапії, але її призначення має відбуватися лише під контролем лікаря-психіатра.

Превентивні заходи включають створення сприятливого соціального середовища, зниження рівня стресу в освітніх закладах, впровадження програм психологічної освіти для молоді та їхніх батьків. Важливу роль відіграє підтримка з боку близьких людей, зокрема батьків і вчителів, які можуть допомогти виявити ранні ознаки депресії та сприяти зверненню до спеціалістів [1, с. 12].

Таким чином, вирішення проблеми депресивних станів у юнацькому віці вимагає комплексного підходу, що включає співпрацю медичних, освітніх і соціальних інституцій, спрямовану на формування здорового та гармонійного розвитку особистості.

Особливості депресивних станів у юнацькому віці є предметом численних наукових досліджень, які виявляють багатогранність цього явища. Зокрема, українські вчені, такі як О.Я. Бутенко, Л.М. Коваль та інші, акцентують увагу на значенні соціальних факторів у виникненні депресії. У своїх роботах вони зазначають, що основними тригерами можуть бути дезадаптація в шкільному середовищі, недостатня увага з боку батьків або їх надмірна критика, а також труднощі у формуванні власної ідентичності.

Л.М. Коваль у своїх дослідженнях підкреслює роль сімейного середовища у розвитку депресивних станів у підлітків та юнаків. Вона зазначає, що стиль виховання, типи комунікації в родині та рівень довіри між батьками і дітьми суттєво впливають на психоемоційний стан молодшої людини. Негативні взаємини можуть призводити до формування почуття безпорадності та втрати сенсу життя, що є передумовою для розвитку депресивних симптомів[2, с. 38].

Інші дослідники, такі як В.М. Слюсаренко, наголошують на впливі соціальних медіа на психічне здоров'я молоді. Науковець досліджував кореляцію між тривалим використанням соціальних мереж, порівнянням себе з іншими користувачами та підвищеним рівнем депресивних станів. Висновки його роботи свідчать про необхідність просвітницької роботи серед молоді щодо відповідального використання соціальних платформ та розвитку критичного мислення.

Український вчений О.Я. Бутенко зосереджує увагу на важливості профілактичних заходів у боротьбі з депресивними станами. Його дослідження показують, що впровадження програм психологічної підтримки в освітніх установах сприяє зниженню рівня емоційної напруги серед учнів. Зокрема, розроблені ним методики з розвитку емоційного інтелекту і стресостійкості демонструють ефективність у формуванні позитивного емоційного фону у молоді.

Ю.М. Кузьменко у своїй роботі наголошує на необхідності врахування індивідуальних особливостей юнаків у процесі терапевтичної роботи. Вона вважає, що для подолання депресивних станів важливо використовувати методи арт-терапії, музикотерапії та інші творчі підходи, які дозволяють виразити приховані емоції та знайти ресурси для подолання кризи.

Українські науковці одностайні в тому, що вирішення проблеми депресії серед молоді потребує комплексного підходу. Наприклад, Н.В. Гончаренко пропонує інтеграцію зусиль психологів, педагогів, лікарів та соціальних працівників у рамках міждисциплінарних програм. Такий підхід дозволяє виявляти ризик розвитку депресії на ранніх стадіях та надавати своєчасну допомогу [3, с. 54].

Отже, наукові дослідження, проведені в Україні, дають підстави для висновку, що депресивні стани у молоді мають багатофакторну природу і вимагають комплексних заходів для їх подолання. Науково обґрунтовані рекомендації сприяють покращенню якості діагностики та лікування, а також створенню ефективних превентивних програм.

Депресивні стани в юнацькому віці є складним і багатогранним явищем, яке зумовлене поєднанням біологічних, психологічних і соціальних чинників, що впливають на емоційний і психічний стан молоді в період її активного розвитку.

Юнацький вік характеризується значними змінами в організмі, які супроводжуються гормональними перебудовами, що можуть призводити до виникнення емоційної нестабільності, відчуття тривоги, пригніченості, а в деяких випадках – до розвитку клінічної депресії. Важливо зазначити, що особливості цього вікового періоду включають пошук власної ідентичності, самоствердження, встановлення міжособистісних стосунків і адаптацію до нових соціальних ролей, що також створює додаткове навантаження на психіку молодих людей.

Однією з головних особливостей прояву депресивних станів у юнацькому віці є складність у розпізнаванні симптомів, оскільки вони можуть маскуватися під типові для цього періоду поведінкові зміни, такі як емоційна лабільність, зниження інтересу до навчання або конфліктність у спілкуванні з однолітками та дорослими.

Депресивний стан у молоді часто супроводжується такими ознаками, як тривале відчуття смутку, втрати сенсу життя, почуття безпорадності, зниження самооцінки, відчуття провини або сорому. Крім того, спостерігаються когнітивні порушення, що включають зниження концентрації уваги, труднощі з прийняттям рішень, уповільнення мислення, що негативно впливає на навчальну діяльність і соціальну адаптацію [4, с. 68].

Особливо тривожним є те, що депресивні стани в юнацькому віці нерідко супроводжуються соматичними симптомами, такими як порушення сну, апетиту, зниження енергії, що може викликати фізичний дискомфорт і додатково посилювати емоційну напругу.

У деяких випадках депресія може проявлятися в асоціальній поведінці, зокрема у відчуженні від соціального середовища, небажанні взаємодіяти з оточенням, уникненні соціальних контактів. Крім того, у молоді часто спостерігається схильність до імпульсивних вчинків, включаючи самопошкодження або зловживання психоактивними речовинами, що вимагає особливої уваги з боку батьків, педагогів та фахівців.

Психосоціальні аспекти відіграють важливу роль у розвитку депресивних станів у молоді. Соціальні очікування, високий рівень конкуренції в освітньому середовищі, тиск з боку однолітків, булінг і конфлікти в родині є основними стресовими факторами, які здатні викликати емоційне виснаження. Наприклад, у дослідженнях українських вчених О.М. Суханової та Л.М. Коваль зазначено, що недостатня підтримка з боку батьків, відсутність довірливих стосунків у родині та критика з боку значущих дорослих можуть сприяти розвитку у підлітків почуття ізоляції та відчуття власної неповноцінності [5, с. 87].

Одним із ключових аспектів подолання депресивних станів є рання діагностика та своєчасна психотерапевтична допомога, що дозволяє мінімізувати ризики розвитку серйозних наслідків для психічного здоров'я. Зокрема, когнітивно-поведінкова терапія є одним із найбільш ефективних методів лікування депресії, оскільки вона дозволяє ідентифікувати та змінити негативні думки й поведінкові патерни, які сприяють підтриманню депресивного стану.

За даними українських психотерапевтів, таких як О.В. Рябцева, застосування когнітивно-поведінкових технік у роботі з молоддю сприяє формуванню нових навичок емоційного регулювання, що дозволяє юнакам краще справлятися зі стресом і конфліктними ситуаціями [6, с. 99].

Іншим важливим напрямом у терапії депресивних станів є арт-терапія, яка використовується як допоміжний метод для вираження емоцій через творчість. Цей підхід, за словами дослідниці О.В. Демиденко, особливо корисний для підлітків, які мають труднощі з вербалізацією своїх почуттів, оскільки через малювання, музичне виконання або інші творчі заняття вони можуть опосередковано передавати свої емоції та переживання.

Важливим компонентом лікування є сімейна терапія, яка передбачає залучення батьків до терапевтичного процесу з метою зміцнення емоційного зв'язку між членами родини та створення сприятливого середовища для психологічного відновлення молодшої людини. Психотерапевтична робота в цьому напрямі спрямована на формування довіри, емпатії та підтримки, що є необхідними умовами для зниження рівня емоційного стресу [7, с. 112].

Превентивні заходи також відіграють важливу роль у подоланні депресивних станів. Освітні установи можуть забезпечувати молодь психологічною підтримкою через організацію тренінгів з розвитку емоційного інтелекту, навчання навичок управління стресом і розвитку позитивного мислення. Крім того, необхідно формувати в молоді розуміння того, що звернення за допомогою є нормальним і важливим кроком до покращення психічного стану.

Одним із ключових аспектів у вивченні депресивних станів у юнацькому віці є визначення їхніх типів і механізмів розвитку. За дослідженнями українських учених, таких як Н.М. Стеценко, можна виділити декілька основних форм депресії в молоді: реактивну, яка виникає внаслідок стресових подій, ендогенну, що пов'язана з біологічними порушеннями, та дистимію, яка є хронічним, але менш вираженим станом. Ці форми мають свої особливості в проявах і вимагають різних підходів до терапії[8, с. 129].

Дослідження В.І. Гриценко вказують на значущість когнітивних викривлень у розвитку депресії в юнаків. Зокрема, у роботах дослідника наголошується, що негативні установки, такі як переконання у власній некомпетентності, почуття безнадійності та очікування невдач, створюють замкнене коло депресивного мислення. Відтак, одним із найефективніших підходів до подолання таких станів є когнітивно-поведінкова терапія, яка допомагає перебудувати деструктивні моделі мислення [9, с. 144].

Проблема депресії серед молоді також пов'язана зі специфікою переживання юнацької кризи, про що писали такі українські психологи, як О.В. Литовченко. Вона зазначає, що процес самовизначення та пошуку сенсу життя може супроводжуватися сильними емоційними коливаннями, які іноді переходять у патологічні стани. Науковець наголошує, що виявлення ранніх ознак депресії (наприклад, втрати інтересу до майбутнього, зниження мотивації до навчання або соціальної активності) має бути основою для профілактичних заходів.

В Україні активно впроваджуються програми, спрямовані на підтримку психічного здоров'я молоді. Наприклад, проекти психологічної підтримки в школах та університетах, які включають тренінги з управління стресом, навчання

технік релаксації та створення груп взаємної підтримки, демонструють свою ефективність. У рамках таких ініціатив учні та студенти можуть отримати консультації кваліфікованих психологів, що значно знижує ризик розвитку важких депресивних станів [10, с. 158].

Ще одним важливим аспектом є використання сучасних технологій. Зокрема, за рекомендаціями Н.М. Лисенко, створення мобільних додатків для моніторингу емоційного стану молоді та забезпечення доступу до онлайн-консультацій може стати важливим інструментом у попередженні депресії.

Превентивні заходи мають охоплювати не лише психологічну, а й освітню та соціальну сфери. За даними досліджень, проведених Л.М. Сидоренко, впровадження програм розвитку емоційного інтелекту у школах і ВНЗ сприяє підвищенню стійкості до стресу та покращенню соціальних навичок у молоді. Важливо, щоб такі програми включали інтерактивні вправи, обговорення проблемних ситуацій і моделювання конструктивних стратегій вирішення конфліктів. Роль сім'ї в профілактиці депресії також є надзвичайно важливою. У своїх роботах О.І. Зайченко підкреслює, що відкриті й підтримувальні стосунки між батьками та дітьми сприяють формуванню довіри, що є фундаментом для своєчасного виявлення проблем. Важливо, щоб батьки вчилися розпізнавати ранні сигнали депресії та не боялися звертатися за допомогою до фахівців.

Висновки. Таким чином, депресивні стани в юнацькому віці є складним явищем, що вимагає системного підходу до їх діагностики, лікування та профілактики. Ефективне подолання цієї проблеми можливе лише за умови інтеграції зусиль батьків, освітніх закладів, медичних фахівців і суспільства загалом, що дозволить створити сприятливі умови для емоційного розвитку та психологічного благополуччя молодих людей.

Депресивні стани в юнацькому віці є багатофакторним явищем, причини якого варіюються від біологічних до соціально-психологічних. Їх вивчення вимагає комплексного підходу. Результати досліджень українських науковців підтверджують, що основними тригерами депресії серед молоді є психологічні кризи, міжособистісні конфлікти та високий рівень стресу. Ефективні методи

подолання депресії включають когнітивно-поведінкову терапію, групові заняття та творчі підходи, а також медикаментозне лікування в тяжких випадках. Превентивні заходи мають бути спрямовані на розвиток емоційного інтелекту, підтримку психічного здоров'я в школах та університетах і зміцнення соціальних зв'язків. Роль сім'ї та суспільства є визначальною у створенні середовища, яке сприяє зниженню ризиків розвитку депресивних станів. Отже, для подолання проблеми депресивних станів у юнацькому віці потрібна взаємодія науковців, практиків, освітян, сімей і громадських організацій. Лише системний підхід може забезпечити ефективну підтримку молоді на етапі її становлення.

Література.

1. Бутенко О.Я. Соціальні чинники виникнення депресивних станів у підлітків. Психологія молоді. 2021. №4. 45–53 с.
2. Коваль Л.М. Роль сімейного середовища у формуванні емоційного благополуччя підлітків. Сучасна психологія: теорія і практика. 2020. Т. 5. № 3. 22–29 с.
3. Слюсаренко В.М. Вплив соціальних медіа на розвиток депресивних станів у юнацькому віці. Інновації у психологічній науці. 2019. Т. 3. № 1. 15–20 с.
4. Суханова О.М. Психосоціальні аспекти депресії серед підлітків: причини та шляхи подолання. Український журнал прикладної психології, 2022. № 7. 50–61 с.
5. Лавриненко Н.Г. Освітнє середовище як фактор психологічного здоров'я молоді. Психологія освіти і науки, 2021. № 8. 35–42 с.
6. Рябцева О.В. Когнітивно-поведінкова терапія у роботі з депресивними станами у підлітків. Психотерапія в Україні: сучасні підходи, 2020. № 2. 18–25 с.
7. Демиденко О.В. Арт-терапія як метод подолання депресії в юнацькому віці: Креативна психологія, 2021. № 6. 12–19 с.
8. Поляков І.В. Біологічні аспекти депресивних станів у юнацькому віці. Нейропсихологія і сучасні дослідження, 2022. Т. 4. № 2. 28–33 с.
9. Гончаренко Н.В. Міждисциплінарний підхід до профілактики депресивних станів у підлітків. Соціальна психологія в дії, 2021. № 3. 40–48 с.
10. Дмитренко Л.С. Ефективність тренінгів емоційної стійкості для підлітків з ознаками депресії. Журнал практичної психології, 2020. № 5. 30–36 с.

1.6. Сексуальні та психосоціальні аспекти сімейного спілкування

Бондар С. С.

Актуальність. Порушення сімейної комунікації є важливою та актуальною проблемою та може стати наслідком різноманітних подій. Важливе місце займає ситуація адюльтеру, як додаткове психоемоційне та психологічне навантаження, що руйнує взаємини між чоловіком і дружиною.

Адюльтер (фр. *adultère*) – подружня зрада, невірність, перелюбство, заздалегідь засуджує поняття незаконної любовний зв'язок. Адюльтер стає чинником, що провокують сімейну агресивність, дратівливість, апатію, зловживання психоактивними речовинами. Руйнуючи функціонування родини [1] адюльтер знижує демонстрування додаткових емпатичних здібностей, співпереживання та співчуття, що виснажує психічний ресурс чоловіка та дружини. Сім'я, яка стикнулася з адюльтером, до певної межі намагається протистояти йому, попередити негативні наслідки. Проте, існують чіткі відмінності щодо того, як різні сім'ї реагують на труднощі [2]. В одних випадках виклик, спровокований адюльтером, здійснює мобілізуючий, інтегруючий вплив. В інших – навпаки послаблює сім'ю та призводить до посилення протиріч у середині неї. Причому, другий варіант є найбільш характерним для молодих сімей, які слабо підготовлені й не випробовувані у сімейних негараздах. Неоднаковість реакції особливо чітко простежується у випадку «нормативного стресу», тобто зіткнення сім'ї із звичними для певного її етапу розвитку труднощами [3, 4]. Сім'я, яка перебуває у стані кризи, не може залишатися незмінною, їй не вдається виконувати необхідні функції адекватно ситуації, що змінилася, оперуючи знайомими, шаблонними поглядами й використовуючи звичні моделі поведінки [5]. До невирішених раніше частин проблеми сімейної взаємодії можна віднести недостатню вивченість психологічних особливості сексуальності та особливостей психологічного реагування чоловіків та жінок на адюльтер.

Мета. Дослідити сексуальні та психосоціальні порушення сімейної комунікації при адюльтері.

Результати дослідження. У проблематиці порушень сімейної комунікації вивчаються етіологічні та патогенетичні чинники руйнування сімей, зміни у взаєминах в родині, індивідуально-психологічні особливості чоловіків та жінок, сімейна взаємодія [6, 1]. Досліджуються психологічного поєднання і сумісності у шлюбних стосунках, відмінності причин і механізмів порушень розвитку родини, дієвості психодіагностичних і психокорекційних методів сімейного консультування й психотерапії [7, 8]. Вивчаються індивідуально-психологічні особливості та психічні стани родин [9], сексуальні та психосоціальні аспекти. Зазначається [10], що чинники благополуччя сімейних взаємин, стабільності шлюбних стосунків, шлюбної сумісності, проблемі схожості–відмінності між подружжям з точки зору особистих характеристик корелюють з чинниками рольових та ціннісних орієнтацій, функції сім'ї та розподілу подружніх ролей, емоційних та міжособистісних відносин та у поєднанні впливають на задоволеність шлюбом. Досліджуються питання впливу психологічного опору у молоді та їх проявів, де відокремлюється їх особистісне значення у сімейної й трудовій сферах [11].

Дослідники [4] надали аналіз та класифікацію конфліктів на ґрунті незадоволених потреб чоловіка й жінки: 1. Конфлікти, що виникають на основі незадоволеної потреби в цінності й значимості свого «Я», порушення почуття поваги з боку іншого партнера; 2. Конфлікти, психічні напруження на базі незадоволених сексуальних потреб одного або обох чоловіка й жінки; 3. Психічні напруження, депресії, конфлікти, сварки через незадоволену потребу одного або обох чоловіка й жінки в позитивних емоціях: відсутність ласки, турботи, уважності, розуміння гумору, подарунків; 4. Конфлікти, сварки, пов'язані із пристрастю одного із подружжя до спиртних напоїв, азартних ігор та інших гіпертрофованих потреб, що призводять до неощадливих і неефективних, а часом і марних витрат коштів сім'ї; 5. Фінансові розбіжності, що виникають на основі перебільшених потреб одного із подружжя в розподілі бюджету, змісту сім'ї, внеску кожного з партнерів у матеріальне забезпечення сім'ї.

6. Конфлікти, сварки, незгоди через незадоволення потреб чоловіка чи жінки в харчуванні, одязі, у будівництві житла тощо.

7. Конфлікти у зв'язку з потребою у взаємодопомозі, підтримці, співробітництві з питань поділу праці в сім'ї, ведення домашнього господарства, догляду за дітьми.

8. Конфлікти, сварки на ґрунті різних потреб та інтересів у проведенні відпочинку й дозвілля, різних хобі. Використання категорії «потреба» в теорії подружньої конфліктності дозволяє перейти до мотивів та інтересів, негативним і позитивним емоціям, до аналізу різних видів депресивних та інших патологічних станів, неврозів, джерелом яких можуть бути сімейні безладдя. Категорії стабільність-нестабільність шлюбу, його конфліктність-безконфліктність також залежать від задоволення потреб чоловіка й жінки, особливо емоційно-психологічних.

Дослідниками вивчаються кризові сім'ї та подружжі зради, де протистояння інтересів і потреб членів сім'ї носить особливо різкий характер і розповсюджується на важливі сфери життєдіяльності сімейного союзу. Члени сім'ї займають непримиренні й навіть ворожі позиції по відношенню один до одного, не погоджуючись ні на які поступки або компромісні рішення. Кризові шлюби розпадаються або перебувають на грані розпаду [12, 13].

Можна зазначити, що подружні зради й сексуальне життя в шлюбі відбиває протиріччя між подружжям, вона є результатом різноманітних психологічних факторів. До зради призводять розчарування шлюбним життям, дисгармонія статевих відносин. На противагу зраді, невірності, вірність – це система зобов'язань перед шлюбним партнером, які регулюються моральними нормами й стандартами. Це переконаність у цінності, значимості прийнятих на себе зобов'язань. По-часту вірність асоціюється з відданістю й пов'язана з бажанням партнерів зміцнювати свій власний шлюб і взаємини. Сексуальна потреба може бути по-справжньому задоволена тільки на тлі позитивних почуттів і емоцій, які можливі за умови задоволення емоційно-психологічних потреб (у любові, у підтримці й збереженні почуття власної гідності, психологічній підтримці, захисту, взаємодопомозі й

взаєморозумінні). Якщо в шлюбі не задовольняються емоційно-психологічні потреби особистості, підсилюється відчуження, накопичуються негативні почуття й емоції, більшої ймовірності набуває шлях до зради. Чоловік і жінка не розуміють один одного, сваряться та рішаються на адюльтер.

Дослідження [14] вказує на чотири кризові періоди життя родини. Перший період припадає на перший рік подружнього життя та характеризується конфліктами адаптації один до одного, коли два «Я» перетворюються в одне «Ми». Другий період пов'язаний з появою дітей: погіршуються можливості професійного зростання; менше часу залишається для захоплень, хобі, можуть виникати протиріччя між батьками з проблем виховання дитини. Третя криза припадає із середнім подружнім віком, який характеризується конфліктами одноманітності. Четвертий період конфліктності у відносинах подружжя настає після 18–24 років спільного життя та пов'язаний з відчуженням від сім'ї дітей. Велика палітра досліджень порушення сімейної комунікації при адюльтері, полягає в значній кількості подружжя, які прагнуть зберегти сімейні стосунки, та звертаються до спеціалістів із сімейного психологічного консультування [7]. Незважаючи на досить значне поширення наукових пошуків питання сексуальних та психосоціальних аспектів порушення сімейної комунікації при адюльтері остаються мало дослідженим.

Сексуальна комунікація чоловіків та жінок, які мають у анамнезі адюльтер, досліджувалася методикою Eysenck, (1971, 1972) у яку автор поклав власну концепцію особистості. Методика оцінює ставлення до сексу, задоволеність шлюбом, відхилення у сексуальній поведінці, співвідношення маскуліності-фемініності. В цілому у респондентів виявлені психологічні особливості сексуальності та співвідношення високого та низького балів у відсотку відображено у КГА (М+Ж) та ГА (М+Ж), які розподілилися не рівномірно, що підтверджує про негативну динаміку впливу віку шлюбу на сімейну кризу.

У КГА (М+Ж) виявлено провідні руйнуючи родину психологічні особливості сексуальності за шкалами: *вседозволеність* – прийнятністю наявних форм сексуальних відносин до сексу як до задоволення та відсутністю стурбовані щодо

дошлюбних та позашлюбних зв'язків (35,0 %, $p<0,05$); задоволення у сексуальному житті (35,0 %, $p<0,05$) залежало від комбінації особистісних чинників у парі, у свою чергу за нереалізованість та розчарування (65,0 %, $p<0,05$) в більшій мірі звинуватили партнерів; *невротичний секс* – конфлікт між внутрішніми переконаннями й потягами з складністю контролювати або пригнічувати внутрішні імпульси (64,0 %, $p<0,05$); *безособовий секс* – ставлення до партнера як до сексуального об'єкту та пошук лише чуттєвого задоволення (65,0 %, $p<0,05$); *порнографія* – не терпимість до вербального опису постільних сцен (60,0 %, $p<0,05$); *сексуальна сором'язливість* – нервозність у присутності осіб протилежної статі (62,0 %, $p<0,05$); *чванливість* – сексуальна пасивність (59,0 %, $p<0,05$); *сексуальна огида* – огида до сексуальних проявів та статевих стосунків зі своїм постійним партнером (55,0 %, $p<0,05$); *сексуальне збудження* – складністю набуття стану сексуального збудження (58,0 %, $p<0,05$); *фізичний секс* – захоплення лише фізичною стороною сексу без її духовної складовій (65,0 %, $p<0,05$); *агресивний секс* – ворожість і агресивність у сексуальних відносинах іноді без згоди партнера (57,0 %, $p<0,05$).

Порівняльний аналіз структури психологічних особливостей сексуальності у респондентів за об'єднувальними шкалами «Статеве лібідо», «Сексуальне задоволення», «Маскуліність–фемініність» виявив відмінності у респондентів КГА (М+Ж).

Шкала «Статеве лібідо» виміряла силу сексуального потягу. Шкала «узагальнює» висновок щодо вседозволеність, сексуальне задоволення, порнографія, безособовий секс і фізичний секс (Eysenck, 1972). За шкалою «Статеве лібідо» у чоловіків КГА1 виявлено високий бал у 53,3 %, низький бал – 46,7 %. У КГА2 відповідно високий бал – 43,3 %, низький бал – 56,7 %, КГА3 – високий бал – 33,3 %, низький бал – 67,6 % ($p<0,05$). Серед жінок: КГА1 виявлено високий бал у 50,0 %, низький бал – 50,0 %. У КГА2 відповідно високий бал – 40,0 %, низький бал – 60,0 %, КГА3 – високий бал – 30,0 %, низький бал – 70,0 % ($p<0,05$). Респонденти, що мали високі бали володіли сильним лібідо й сильним

сексуальним потягом. Й навпаки, у чоловіків та жінок низький бал вказував на слабе лібідо та слабкий сексуальний потяг.

1. Шкала «Сексуальне задоволення» об'єднує в себе показники шкал «невротичний секс», «сексуальна сором'язливість», «розважливість» і «сексуальна огида» (Eysenck, 1972) [15, 16]. За шкалою «Сексуальне задоволення» у чоловіків КГА1 виявлено високий бал у 43,3 %, низький бал – 56,7%. У КГА2 відповідно високий бал – 33,3 %, низький бал – 66,7 %, КГА3 – високий бал – 30,0 %, низький бал – 70,0 % ($p < 0,05$). Серед жінок: КГА1 виявлено високий бал у 40,0 %, низький бал – 60,0 %. У КГА2 відповідно високий бал – 30,0 %, низький бал – 70,0 %, КГА3 – високий бал – 26,7 %, низький бал – 77,3 % ($p < 0,05$). Задоволеність респондентів особистим сексуальним життям не мала залежності від їх сексуального «апетиту». На думку чоловіків та жінок вони мали цілком задовільне сексуальне життя, не переймаючись щодо його активності, енергійності й частою статевих стосунків. У протилежних випадках респонденти, сексуальне життя вважали задовільним при його високої активності, енергійності та частих статевих стосунках що по-часту ставало основною, якщо не єдиною, метою життя.

2. Шкала «Маскулінність–фемінність». Під «маскулінність» розуміється, що респонденти у відповідях набрали високий бал у сексуальних питаннях й відповідає образу типового для суспільства чоловіка і не відповідає типовому жіночому образу. Відповідно під «фемінність» розуміється що респонденти у питаннях сексуальної поведінки погоджувалися з жінками, ніж з чоловіками та набрали низький бал [15, 16]. У чоловіків КГА1 виявлено високий бал у 46,7 %, низький бал – 53,4 %. У КГА2 відповідно високий бал – 50,0 %, низький бал – 50,0 %, КГА3 – високий бал – 53,3 %, низький бал – 46,7 % ($p < 0,05$). Серед жінок: КГА1 виявлено високий бал у 50,0 %, низький бал – 50,0 %. У КГА2 відповідно високий бал – 46,7 %, низький бал – 53,3 %, КГА3 – високий бал – 50,0 %, низький бал – 50,0 % ($p < 0,05$). Треба відмітити, що у структурі відповідей шкали жінки могли отримувати «маскулінність» бали, а чоловіки «фемінність». Проте, це не свідчило про мужність або жіночість респондентів в звичайному розумінні цих якостей й безумовно не мало відношення до гомосексуалізму або лесбійства.

Аналіз відмінностей структури психологічних особливостей сексуальності у респондентів КГ (М+Ж) за шкали «Сексуальне лібідо», «Сексуальне задоволення», «Маскулінність–фемінність» (метод Айзенка Інвентар ставлення до сексу) виявив, що серед респондентів груп КГ (М+Ж) переважали досліджені з високим балом: 1. Шкала «Статеве лібідо». У чоловіків КГ1 виявлено високий бал у 50,0 %, низький бал – 50,0 %. У КГ2 відповідно високий бал – 66,7 %, низький бал – 33,3 %, КГ3 – високий бал – 60,0 %, низький бал – 40,0 % ($p<0,05$). Серед жінок: КГА1 виявлено високий бал у 46,7 %, низький бал – 53,3 %. У КГА2 відповідно високий бал – 67,3 %, низький бал – 33,3 %, КГА3 – високий бал – 56,7 %, низький бал – 43,3 % ($p<0,05$). 2. Шкала «Сексуальне задоволення». У чоловіків КГ1 виявлено високий бал у 73,3 %, низький бал – 36,7%. У КГ2 відповідно високий бал – 60,0 %, низький бал – 40,0 %, КГ3 – високий бал – 53,3 %, низький бал – 46, % ($p<0,05$). Серед жінок: КГ1 виявлено високий бал у 66,7 %, низький бал – 33,3 %. У КГ2 відповідно високий бал – 63,3 %, низький бал – 36,7 %, КГ3 – високий бал – 50,0 %, низький бал – 50,0 % ($p<0,05$). 3. Шкала «Маскулінність–фемінність». У чоловіків КГ1 виявлено високий бал у 53,3 %, низький бал – 46,7 %. У КГ2 відповідно високий бал – 50,0 %, низький бал – 50,0 %, КГ3 – високий бал – 46,7 %, низький бал – 53,3 % ($p<0,05$). Серед жінок: КГ1 високий бал у 50,0 %, низький бал – 50,0 %. У КГ2 відповідно високий бал – 46,7 %, низький бал – 53,3 %, КГ3 – високий бал – 46,7 %, низький бал – 53,3 % ($p<0,05$).

Висновки. За результатами дослідження у групі КГА встановлено руйнуючу дію психологічних особливостей сексуальності на функціонування родини. Виявлено зв'язок між не прийнятністю, не реалізованістю та розчарування партнерів наявними сексуальними відносинами та до бажаними сексом як задоволенням ($p<0,05$). Виявлено конфлікт між внутрішніми переконаннями й внутрішніми імпульсами ($p<0,05$). Встановлено, що ставлення до партнера як до сексуального об'єкту без пошуку чуттєвого задоволення корелює з не терпимістю до вербального опису постільних сцен ($p<0,05$). Статева сором'язливість властива парам з сексуальною пасивністю й огидою до сексуальних проявів ($p<0,05$). У свою чергу складність набуття сексуального збудження корелювала із захопленням лише

фізичного сексу без її духовної складової ($p < 0,05$). За об'єднувальними шкалами у респондентів КГА виявлено наступне: «Статеве лібідо» – особи володіли сильним лібідо й сильним сексуальним потягом ($p < 0,05$); «Сексуальне задоволення» – респонденти стверджували про задовільне сексуальне життя, не переймаючись активністю й частиною статевих стосунків, відмічаючи не задоволеність партнера ($p < 0,05$); «Маскулінність–Жіночність» – респонденти відповідали формі типового для суспільства чоловіка і жінки ($p < 0,05$). Психологічні особливості сексуальності у КГ характеризувалися відкритістю, більш довірливими відносинами, подібністю сексуальних сценаріїв, моральних поглядів, внутрішніх обмежень, щодо питання адюльтеру, ціннісних орієнтирів, тощо). У сукупності із індивідуально-психологічними рисами це формувалися чинники стримування щодо виникнення адюльтеру. Виявлено, що респонденти до статевих зв'язків мали серйозне ставлення як до шлюбу й підкреслювали особливу важливість для них шлюбу не сприймаючи адюльтер як «аморальність». Благополуччя й реалізованість сексуальним життям досягалось комбінацією особистісних та психосоціальних чинників у парі.

Література

1. Eidemiller E.G., Yustitsky, V.V. Psychology and psychotherapy of the family. St. Petersburg, Peter, 2008. 672 p.
2. Kemper J. The practice of sexual psychotherapy: Translation with German, Moscow, Progress-Culture, Yachtsman. 1994. T1, P. 288.
3. Kaprio F.S.. Diversity of sexual behavior: Translation from English, Moscow, Artania. 1995 187 p.
4. Krishtal V.V., Andrukh, G.P. Sexual harmony of a married couple. Kharkov. 1996. Veles, 160 p.
5. Masters W., Johnson V., Kolodny, R. Fundamentals of sexology. Translation from English, Moscow, Mir. 1998. 692 p.
6. Kratochvil S., Vasilchenko, G.S., Danilova T.V. Psychotherapy of marital relations. Translation from Czech, St. Petersburg, Medicine. 2008. 327 p.

7. Rogers K. The Psychology of Friendship. *Mozhlivi alternatives. Seriya Psychology for all*. Translation from English V. Gavrilova. Moscow, Exmo Publishing House, 2002. 288 p. Available at: <http://socio.125mb.com/psihologiya-suprujeskih-otnosheniy-vozmojnyie.html>
8. Ruudestam C. Group psychotherapy: Translation from English, St. Petersburg, Peter, 2000. 384 p.
9. Prib H., Bondar, S. Psychological and psychoemotional disorders of family functioning. *Psychological Prospects Journal*. 2019. 34, pp. 206-218. <https://doi.org/https://doi.org/10.29038/2227-1376-2019-34-206-218>
10. Olifrovich N.I., Zinkevich-Kuzemkina, T.A., Velenta, T.F. Psychology of crisis. St. Petersburg, Speech. 2006. 360 p. Available at: <http://socio.125mb.com/psihologiya-semeynyih-krizisov-spb-rech.html>
11. Prib H., Gromova, Z. Resistance to organizational change as a facet of psychological resistance of an individual. *Journal of Intellectual Disability Diagnosis and Treatment*. 2019. V.7, 4. pp. 170–178. <https://doi.org/10.6000/2292-2598.2019.07.03.15>
12. Brown J., Christensen, D. *Theory Practice of Family Psychotherapy*, St. Petersburg, Peter. 2001. 352 p.
13. Weber G. Crises of love. Systemic psychotherapy of Bert Hellinger. Translation from German Belyakova I, Mikhail Burnyashev (Eds.), Moscow, Publishing House Institute of Psychotherapy. 2002. 304 p. Available at: <https://gigabaza.ru/doc/73403-pall.html>
14. Kratochvil S. Psychotherapy of family-sexual disharmonies. Translation from Czech, Moscow, Medicine. 1991. 332 p.
15. Eysenck H. J. Personality and Sexual Adjustment. *The British Journal of Psychiatry*. 1971. V 118. Issue 547. pp. 593-608. <https://doi.org/10.1192/bjp.118.547.593>
16. Eysenck H. J. Personality and sexual behaviour. *Journal of Psychosomatic Research*. 1972. Vol. 16. pp. 141-152. Persamon Press, Printed in Northern Ireland. Available at: https://hanseysenck.com/wp-content/uploads/1972_eysenck_personality_and_sexual_behaviour_journal_of_psychosomatic_research.pdf

1.7. Соціальні та терапевтичні підходи до роботи з ветеранами з посткомоційним синдромом

Борець О.А.

Актуальність. Повернення до цивільного життя після військової служби є значним викликом для багатьох ветеранів. Це перехід від суворо регламентованого, структурованого середовища до умов, які вимагають самостійності та адаптації до нових соціальних ролей. Особливо складно цей перехід проходять ветерани, які пережили травматичні події на війні. У значної частини цих осіб діагностується посткомоційний синдром (ПКС) – стан, який ускладнює їхню адаптацію через поєднання фізичних, когнітивних та емоційних симптомів.

В Україні проблема психологічної реабілітації ветеранів набула особливої актуальності після початку військових дій на сході країни у 2014 році. За даними Міністерства у справах ветеранів України, понад 500 тисяч осіб є учасниками бойових дій, і цей показник щодня зростає, значна частина з яких потребує психологічної допомоги. ПКС є одним із найпоширеніших синдромів, з яким стикаються ветерани, але через низький рівень обізнаності та обмежений доступ до якісної допомоги цей стан часто залишається невизнаним або недооціненим.

Мета. Надати аналіз ролі практичного психолога у роботі з ветеранами, які мають посткомоційний синдром, з акцентом на ефективні терапевтичні методи, індивідуальний підхід до пацієнта та соціальну підтримку.

Результати дослідження. Теоретичні аспекти ПКС. ПКС у ветеранів виникає як результат впливу комплексу факторів, зокрема травматичного досвіду, фізіологічних змін у роботі мозку та психологічної реакції на стрес. Бойові дії, що супроводжуються втратами, фізичними травмами та постійною загрозою життю, створюють умови для розвитку ПКС, який часто виникає разом із посттравматичним стресовим розладом (ПТСР), ускладнюючи перебіг обох станів [10].

З фізіологічної точки зору, ПКС часто асоціюється з порушеннями у роботі центральної нервової системи. Наприклад, травми головного мозку, які є

поширеними серед ветеранів, можуть викликати порушення функціонування гіпокампу та префронтальної кори. Гіпокамп відповідає за формування пам'яті, тоді як префронтальна кора контролює прийняття рішень та емоції. Пошкодження цих структур поглиблює когнітивні й емоційні симптоми, характерні для ПКС. Крім того, у ветеранів спостерігається підвищена активність мигдалеподібного тіла, що відповідає за реакцію на загрозу, що може призводити до підвищеної тривожності та емоційної нестабільності.

Психосоціальні фактори також мають значний вплив на розвиток ПКС. Соціальна ізоляція, відсутність підтримки з боку сім'ї чи суспільства, труднощі інтеграції в цивільне середовище й економічні проблеми створюють «порочне коло». Ветерани, які не отримують підтримки, частіше стикаються зі зростанням тривожності, депресії та загостренням фізичних симптомів [11]. Нерідко додатковим чинником є відчуття «провини вижившого», яке посилює соціальну ізоляцію ветерана.

Індивідуальні особливості також відіграють важливу роль у розвитку ПКС. Зокрема, дослідження свідчать, що ветерани з високим рівнем резилієнтності (стійкості до стресу) рідше стикаються з тривалими симптомами. Водночас особи з попередніми психологічними травмами чи розладами є більш уразливими до ПКС [10].

Посткомоційний синдром характеризується комплексом симптомів, які можна умовно розділити на когнітивні, емоційні та фізичні. Така багатовимірність ускладнює діагностику ПКС, оскільки його прояви можуть збігатися з іншими психічними розладами, як-от ПТСР чи депресія.

Когнітивні симптоми. Когнітивні порушення є типовими проявами ПКС, особливо у ветеранів, які перенесли черепно-мозкові травми. Найчастіше спостерігаються порушення концентрації уваги, уповільнення мислення та зниження здатності до прийняття рішень. У ветеранів ці труднощі можуть призводити до професійних і соціальних проблем. Частими є також скарги на порушення пам'яті, особливо труднощі із запам'ятовуванням нової інформації в стресових ситуаціях.

Емоційні симптоми. Емоційні прояви ПКС, такі як тривожність, депресія та емоційна нестабільність, мають значний вплив на якість життя ветеранів. Часто ці симптоми загострюються в умовах соціальної ізоляції, що є поширеною проблемою серед військових після повернення до цивільного життя. Ветерани також часто відчують «провину вижившого», що впливає на їхню здатність адаптуватися до мирного середовища [11]. Емоційна нестабільність та дратівливість, характерні для ПКС, часто стають джерелом конфліктів у родинних стосунках.

Фізичні симптоми. До фізичних проявів ПКС належать головні болі, які нерідко класифікуються як хронічна мігрень, порушення сну, включаючи безсоння та кошмари, а також хронічна втома. Ветерани нерідко повідомляють про відчуття виснаження, яке зберігається навіть після тривалого відпочинку. Ці симптоми взаємодіють із когнітивними та емоційними розладами, посилюючи загальний стан ветеранів [10].

Коморбідність посткомоційного синдрому із такими розладами, як посттравматичний стресовий розлад або тривожні розлади, значно ускладнює процес терапевтичного втручання. Наявність множинних розладів погіршує діагностику, підвищує інтенсивність симптомів і впливає на ефективність стандартних підходів до лікування. У таких випадках застосування мультидисциплінарного підходу є необхідністю. Поєднання медикаментозного лікування, спрямованого на корекцію нейрохімічного дисбалансу, із різними формами психотерапії, такими як когнітивно-поведінкова терапія чи EMDR (десенсибілізація та переробка травматичного досвіду за допомогою рухів очей), дозволяє адресувати широкий спектр симптомів. Цей підхід забезпечує індивідуалізацію терапевтичного процесу та сприяє кращим результатам у відновленні психічного стану пацієнтів.

Посткомоційний синдром у ветеранів має низку особливостей, які відрізняють його від аналогічних станів у цивільних осіб. Це обумовлено специфікою травматичного досвіду, соціальними та культурними факторами, а також фізичними ушкодженнями, які є характерними для військових.

Травматичний досвід ветеранів має унікальні риси, які відрізняють його від травм, пов'язаних із нещасними випадками чи стихійними лихами. Участь у бойових діях, втрата товаришів по службі, фізичні поранення та регулярне перебування в умовах загрози життю створюють тривалі стресові фактори. У багатьох випадках ці події мають повторюваний характер, що значно підвищує ризик розвитку ПКС [13].

Соціальні фактори. Після повернення з війни ветерани нерідко стикаються з нерозумінням з боку суспільства. Багато хто відчуває, що їхній бойовий досвід є чужим і не викликає емпатії серед цивільних. Це, разом із труднощами у спілкуванні та побудові довіри, підвищує ризик соціальної ізоляції, яка негативно впливає на психологічний стан ветеранів [12].

Фізичні ушкодження. На відміну від цивільних осіб, ветерани часто мають серйозні фізичні ушкодження, такі як ампутації, порушення слуху чи зору. Ці травми поглиблюють психологічні труднощі та ускладнюють адаптацію ветеранів до мирного життя.

Культурні та професійні аспекти. У військових культурах панує сильна стигматизація психічного здоров'я. Звернення за психологічною допомогою нерідко сприймається як прояв слабкості, що перешкоджає ранньому втручання. Це ускладнює процес діагностики та лікування ПКС, адже багато ветеранів ігнорують симптоми або приховують їх від оточення [12].

Роль психолога у реабілітації ветеранів. Реабілітація ветеранів із посткомоційним синдромом є складним і багатогранним процесом, який вимагає систематичного підходу. Психолог виконує ключову роль на всіх етапах роботи – від первинної оцінки до довготривалого супроводу, сприяючи не лише зниженню симптомів ПКС, але й інтеграції ветеранів у цивільне життя.

Перший етап реабілітації – це оцінка психологічного стану ветерана. Саме на цьому етапі визначаються не лише симптоми ПКС, але й супутні стани, такі як посттравматичний стресовий розлад, тривожність чи депресія. Використання сучасних психодіагностичних інструментів, дає змогу виявити ключові проблеми та визначити стратегії втручання. У міжнародній практиці, зокрема у США, ці

методи широко застосовуються для первинного обстеження ветеранів [10]. В Україні цей процес поки що перебуває на етапі становлення. Обмежена кількість фахівців, низький рівень обізнаності та соціальні стигми залишають значну частину ветеранів поза межами системи допомоги [4].

Наступним етапом є безпосереднє втручання, яке базується на індивідуальних та групових підходах. Найбільш ефективною методикою вважається когнітивно-поведінкова терапія, яка фокусується на зміні негативних переконань, пов'язаних із травматичним досвідом. Дослідження показують, що використання КПТ дозволяє досягти значного зменшення симптомів у понад 70% ветеранів протягом перших шести місяців терапії [11]. Альтернативним або доповнювальним підходом є метод EMDR, який допомагає ветеранам знизити емоційний вплив травматичних спогадів [11].

Завершальний етап реабілітаційного процесу – це супровід ветеранів після завершення терапії. Цей етап спрямований на закріплення результатів лікування, підтримання психологічної стабільності та соціальної адаптації. Ветерани долучаються до груп підтримки, отримують регулярні консультації психологів і, за потреби, інтегруються у професійні чи громадські ініціативи. Такий комплексний підхід забезпечує довготривалий ефект терапії та сприяє повноцінному поверненню ветерана до активного життя [7].

Психоедукація є основним елементом початкового етапу реабілітації ветеранів, що дозволяє знизити тривожність і мотивувати ветеранів до терапії. Однією з ключових проблем ветеранів є нерозуміння причин свого стану, яке часто супроводжується соромом чи страхом бути засудженим. Інформаційні сесії та освітні програми, які проводять психологи, допомагають ветеранам зрозуміти, що їхні симптоми є нормальною реакцією на травматичний досвід. Це дозволяє знизити рівень стигматизації та зробити перший крок до активної участі у лікуванні [11].

У багатьох країнах, зокрема у Великій Британії та Канаді, психоедукація є обов'язковою частиною програм допомоги ветеранам. Ветерани проходять семінари, які допомагають їм зрозуміти, як хронічний стрес впливає на

функціонування мозку та емоційний стан [13]. Такі сесії дають змогу не лише знизити тривожність, але й зміцнити віру у власну здатність подолати проблеми. В Україні подібні практики перебувають на початковому етапі, громадські ініціативи активно впроваджують вебінари та групові зустрічі для ветеранів і їхніх сімей, однак охоплення таких програм є обмеженим, або кількість бажаючих взяти участь у таких заходах є дуже незначною [4].

Індивідуальна терапія є невіддільною частиною роботи з ветеранами, оскільки дозволяє глибше працювати з травматичними спогадами та індивідуальними проблемами. Когнітивно-поведінкова терапія, яка широко застосовується у роботі з ветеранами, дає змогу переосмислити негативні переконання, навчитися управляти емоціями та впоратися з тривожністю. За даними міжнародних досліджень, КПТ показує високу ефективність, зменшуючи симптоми тривоги та депресії у понад 75% ветеранів [10]. У рамках терапії застосовуються також техніки експозиції, які допомагають ветеранам поступово звикнути до травматичних спогадів і знизити їхній емоційний вплив.

Групова терапія, у свою чергу, має свої переваги, адже дозволяє ветеранам знаходити підтримку серед тих, хто пройшов схожий досвід. Ветерани часто відчують, що їхні проблеми незрозумілі оточенню, тому групова терапія створює безпечне середовище, де вони можуть поділитися переживаннями та отримати підтримку. У програмі Veterans' Group Therapy у США близько 80% учасників відзначають зниження рівня соціальної ізоляції вже після кількох сесій. В Україні аналогічні ініціативи активно впроваджуються громадськими організаціями, діяльність яких направлена на підтримку ветеранів [4].

Сімейні стосунки відіграють важливу роль у процесі реабілітації ветеранів. Однак у багатьох випадках саме сім'я стає джерелом додаткового стресу, оскільки ветерани стикаються з нерозумінням з боку близьких або з конфліктами, спричиненими їхнім емоційним станом. Психологи зазначають, що ПКС часто супроводжується дратівливістю, депресією чи емоційною нестабільністю, які впливають на сімейні стосунки. За даними Kaplan & Sadock, понад 50% ветеранів із ПКС стикаються з серйозними проблемами у спілкуванні з партнерами.

Сімейна терапія спрямована на відновлення довіри, покращення комунікації та формування спільних стратегій подолання конфліктів. У рамках програми National Military Family Association у США, яка охоплює ветеранів і їхні сім'ї, проводяться сесії сімейного консультування, спрямовані на навчання партнерів управління емоціями та підтримки ветерана. В Україні подібні підходи активно впроваджуються у рамках програм, як-от «Maximum», які поєднують терапевтичні сесії з активним відпочинком для всіх членів сім'ї [10].

Практичні методики роботи з ПКС. Ефективна реабілітація ветеранів із посткомоційним синдромом ґрунтується на використанні сучасних психотерапевтичних і холістичних підходів, які сприяють відновленню емоційного балансу та покращенню якості життя. У роботі з ПКС застосовуються такі методи, як когнітивно-поведінкова терапія, десенсибілізація за допомогою рухів очей, майндфулнес та релаксація, а також арт-терапія. Ці підходи довели свою ефективність у багатьох країнах світу та активно впроваджуються в програмах підтримки ветеранів в Україні.

Когнітивно-поведінкова терапія є однією з найпоширеніших методик у роботі з ветеранами, які мають ПКС. Цей підхід фокусується на зміні дисфункціональних думок і переконань, що виникають через травматичний досвід, та формуванні нових, більш адаптивних моделей поведінки. Основна увага приділяється автоматичним думкам, які часто викликають тривогу, депресію чи почуття провини.

Наприклад, багато ветеранів з ПКС вважають себе винними у тому, що вижили, або відчують себе нездатними адаптуватися до цивільного життя. КПТ допомагає їм виявити ці хибні переконання й замінити їх більш раціональними та здоровими. Як свідчать результати дослідження Bryant et al. (2019), після 12-тижневого курсу КПТ 75% ветеранів продемонстрували зменшення симптомів тривожності та депресії.

Особливо ефективними є техніки експозиції, які поступово знайомлять ветеранів із травматичними спогадами у контрольованих умовах, дозволяючи їм подолати страх і зменшити емоційне навантаження. Наприклад, у навчальному

курсі «Resilient Warrior» у США ці техніки використовуються для навчання ветеранів долати тригери, пов'язані з травматичним досвідом, що позитивно впливає на їхню здатність функціонувати у повсякденному житті.

Метод десенсибілізації за допомогою рухів очей (EMDR) ґрунтується на теорії про те, що травматичний досвід блокує природну здатність мозку обробляти інформацію, залишаючи емоційні «вузли» у пам'яті. Під час сеансу EMDR терапевт просить ветерана зосередитися на травматичному спогаді, одночасно стежачи за рухами очей або тактильними стимулами. Це стимулює адаптивні нейронні процеси та знижує інтенсивність травматичних переживань.

За даними Shields et al. (2020), близько 60% ветеранів із ПКС демонструють суттєве зниження рівня тривожності вже після восьми сеансів EMDR. Цей метод успішно застосовується у програмах відновлення після травми у США, що допомагає ветеранам переробити болючі спогади без ризику ретравматизації.

Наприклад, у рамках пілотного проекту «EMDR для героїв України» у 2023 році було протестовано цей метод серед ветеранів АТО/ООС, і 70% учасників відзначили покращення сну та зниження тривожності. Це свідчить про перспективність використання EMDR у системі реабілітації ветеранів в Україні.

Майндфулнес – це методика, яка спрямована на розвиток усвідомленості, прийняття теперішнього моменту й управління власними думками та емоціями. Ця техніка вважається особливо корисною для ветеранів, які часто стикаються з емоційною дисрегуляцією, викликану постійною тривогою чи стресом.

Практики майндфулнес, такі як медитація, усвідомлене дихання чи тілесна сканування, сприяють зниженню рівня стресу та покращенню якості сну. Дослідження Smith et al. (2017) показало, що 70% ветеранів, які практикували майндфулнес протягом 10 тижнів, відзначали суттєве покращення свого емоційного стану.

Техніки релаксації, як-от прогресивна м'язова релаксація чи глибоке дихання, допомагають зняти фізичну напругу, що часто супроводжує психологічні стани ветеранів із ПКС. Наприклад, у службі «Veteran Affairs Canada» у Канаді ветерани брали участь у групових заняттях, які включали елементи йоги та

медитації, що дозволило їм краще справлятися зі стресом і покращити концентрацію.

Україна також починає інтегрувати майндфулнес у програми реабілітації. Організуються психологічні тренінги, у яких беруть участь ветерани та їхні сім'ї. Учасники зазначають, що регулярна практика дозволила їм зменшити рівень емоційного напруження та поліпшити взаємини з оточенням.

Арт-терапія є інноваційним методом, який допомагає ветеранам висловлювати емоції через творчість. Малювання, музика, писання або ліплення дозволяють ветеранам працювати з емоціями, які важко передати словами, та знаходити нові способи комунікації.

Дослідження підтверджують, що арт-терапія сприяє зменшенню симптомів депресії, тривожності та підвищенню самооцінки. У рамках британської програми Healing Through Art: Art Therapy Programs for Veterans після шести тижнів занять 80% учасників відзначали покращення емоційного стану.

В Україні арт-терапія активно використовується у реабілітаційних центрах. Ветерани створюють картини, скульптури чи беруть участь у музичних ансамблях, що не лише сприяє емоційному звільненню, але й допомагає знайти нові хобі чи професійний напрямок.

Соціальна адаптація та виклики. Ветерани часто стикаються з посттравматичним стресовим розладом, депресією та підвищеною агресією. За даними дослідження Національного інституту психології НАН України (2023), ПТСР діагностується у 48% військових, які брали участь у бойових діях, і лише 28% з них звертаються по допомогу. Це значно ускладнює їхнє повернення до повсякденного життя, адже симптоми ПТСР включають раптові спалахи гніву, безсоння та нездатність будувати тривалі стосунки.

Пошук роботи після демобілізації часто стає справжнім випробуванням для ветеранів. Згідно з даними Центру зайнятості України (2022), рівень безробіття серед ветеранів становить 23%, що майже вдвічі перевищує середній показник у країні. Причини цього включають нестачу навичок, які є затребуваними на ринку праці, або труднощі у визнанні військового досвіду роботодавцями.

Багато ветеранів стикаються із соціальним упередженням. Наприклад, дослідження Громадської організації «Повернись живим» (2021) показало, що 37% опитаних цивільних вважають ветеранів «проблемними» працівниками через їхній військовий досвід або потенційні емоційні розлади. Це створює бар'єри не лише для працевлаштування, але й для налагодження соціальних зв'язків.

Медичні послуги для ветеранів залишаються недостатніми. За даними Міністерства охорони здоров'я України (2022), лише 22% ветеранів отримують повний спектр реабілітаційних послуг, включаючи фізичну та психологічну допомогу. Довгі черги до фахівців та обмежений доступ до спеціалізованих клінік значно ускладнюють процес реабілітації.

Дослідження Інституту соціальної політики України (2023) підкреслює, що 68% ветеранів, які отримували підтримку від сім'ї, демонстрували значно вищі показники емоційної стабільності. Як зазначає один із учасників дослідження: «Сім'я – це мій тил. Вони завжди поруч, навіть коли я зриваюся». Проте не всі ветерани мають такі умови: розлучення після повернення з війни є поширеним явищем, особливо серед тих, хто не отримав достатньої психологічної підтримки під час служби.

Організації, такі як «Побратими», пропонують ветеранам не лише взаємну підтримку, але й групову терапію. Наприклад, учасники програми «Тренінг психологічної стабільності», організованої цією організацією, відзначали покращення емоційного стану на 45% порівняно з групою, яка не брала участі у подібних заходах (дані Центру ветеранів Києва, 2022).

Програми перекваліфікації, такі як «Career Change for Veterans», є важливим інструментом для забезпечення ветеранів можливістю працевлаштування. Наприклад, за даними Інституту праці України (2022), ветерани, які завершили курси перекваліфікації, отримали роботу у 75% випадків. Найбільш популярними напрямками стали ІТ, інженерія та підприємництво.

Важливим кроком стало створення Міністерства у справах ветеранів України, яке координує низку програм, спрямованих на підтримку ветеранів. За словами міністра у справах ветеранів «ці програми дозволяють створити умови для

стабільного та гідного життя кожного ветерана». У 2023 році понад 45000 ветеранів скористалися послугами, наданими в рамках цієї програми.

Ініціативи, такі як «ВетеранХаб», забезпечують простір для адаптації, взаємодії та професійного зростання. За словами координаторів проекту «...наша мета – не лише допомогти ветерану, але й показати, що їхній досвід може стати важливою частиною розвитку суспільства». У 2022 році понад 7000 ветеранів отримали послуги психологічного консультування, 3500 – юридичну допомогу, а 2000 пройшли тренінги з підприємництва.

Україна також може вивчати досвід інших країн. Наприклад, у Канаді діє програма «Veterans Affairs Canada», яка забезпечує ветеранам комплексну підтримку: від медичного страхування до допомоги у поверненні до цивільної роботи. У 2021 році 85,0 % учасників цієї програми заявили, що почуваються соціально інтегрованими.

В Україні певні елементи цього підходу вже запроваджуються. Зокрема, пілотні проекти, такі як «Дія. Ветеран», успішно забезпечують ветеранів доступом до сучасних технологій та ринку праці. У 2023 році в рамках програми було створено понад 200 стартапів, заснованих ветеранами.

Згідно з даними Міністерства освіти і науки України (2023), у 2022 році понад 10 000 ветеранів зареєструвалися на освітні курси, запропоновані в рамках державних та громадських ініціатив. Це включає онлайн-курси у співпраці з міжнародними платформами, такими як Coursera та EdX. Зокрема, 65,0 % учасників зазначили, що отримані знання допомогли їм відкрити власний бізнес або підвищити свою кваліфікацію.

Висновки. Успішна адаптація ветеранів із посткомоційним синдромом вимагає комплексного підходу, що поєднує психологічну, соціальну та економічну підтримку. Психотерапевтичні методи, зокрема когнітивно-поведінкова терапія, EMDR, майндфулнес і арт-терапія, довели свою ефективність у роботі з травматичними наслідками, зменшенні тривожності та депресії. Разом із цим соціальна підтримка, участь сім'ї та громадські ініціативи сприяють відчуттю прийняття та інтеграції у суспільство.

Держава відіграє важливу роль у забезпеченні доступу до реабілітаційних послуг, професійної перекваліфікації та створенні програм працевлаштування. Позитивний досвід міжнародних моделей реабілітації може стати орієнтиром для вдосконалення української системи. Інвестиції у підтримку ветеранів сприяють не лише їхній інтеграції, але й посиленню соціальної згуртованості та відновленню країни після війни.

Література.

1. Агаєв Н. А., Дикун В. Г., Стасюк В. В. Особливості організації морально-психологічного супроводу в арміях зарубіжних країн : навч. посіб. Бровари : ТОВ-7БЦ. 2020. 136 с.
2. Дідик Н. Ф. Вплив сімейних проблем на психологічний стан військовослужбовців під час АТО. Наукові студії із соціальної та політичної психології. Вип. 41 (44). С. 68–80. Міністерство освіти і науки України. Освітні програми для ветеранів: аналіз ефективності. Київ : МОН України. 2023. 32 с.
3. Кокун О. М., Пішко І. О., Лозінська Н. С. , Олійник В. О., Хоружий С. М., Ларіонов С. О., Сириця М. В. Особливості надання психологічної допомоги військовослужбовцям, ветеранам та членам їхніх сімей цивільними психологами : метод. посіб. Київ : 7БЦ. 2023. 175 с.
4. Міністерство охорони здоров'я України. Річний звіт про стан надання медичних послуг ветеранам АТО/ООС. Київ : МОЗ України. 2022. 52 с.
5. Орловська О. А. Стратегії подолання проблем адаптації у сім'ї учасника бойових дій після повернення до цивільного життя. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Психологія. 2020. Т. 31(70). № 4. С. 127–132.
6. Національна соціологічна служба України. Дослідження соціальної адаптації ветеранів в Україні : звіт. Київ. 2023. 64 с.
7. Національний інститут психології НАН України. Посттравматичний стресовий розлад серед ветеранів: масштаби та способи подолання : дослідницький звіт. Київ : НІП НАНУ. 2023. 48 с.

8. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи : навч. посіб. / Гридковець Л. та ін. ; за заг. ред. Л. Гридковець. Том 3. Київ, 2018. 236 с. <https://www.osce.org/files/f/documents/4/d/430841.pdf>.
9. Ульянов К. Броньований розум. Бойовий стрес та психологія екстремальних ситуацій. Київ : ПП «КП» УкрСІЧ». 2020. 304 с.
10. Brewin CR, Cloitre M, Hyland P, Shevlin M, Maercker A, et al. A review of current evidence regarding the ICD-11 proposals for diagnosing PTSD and complex PTSD. Clin. Psychol. Rev. 2017. №58. P. 1–15.
11. Held, P., Smith, D. L., Bagley, J. M., Kovacevic, M., Steigerwald, V. L., Van Horn, R., & Karnik, N. S. Treatment response trajectories in a three-week CPT-based intensive treatment for veterans with PTSD. Journal of Psychiatric Research. 2021. № 141. P. 226–232.
12. Hollingsworth, W.-G L., Dolbin-MacNab, M. L., & Marek, L. I. Boundary ambiguity and ambivalence in military family reintegration. Family Relations. 2016, №65(4). P. 603–615.
13. Markowitz, F. E., Kintzle, S. M., Castro, C. A., Lancaster, S. L. Effects of perceived public regard on the well-being of military veterans. Society and Mental Health. 2019. № 10(3). P. 291–304.

1.8. Життєстійкість як детермінанта психологічної резильєнтності та адаптаційного потенціалу особистості

*Борець О. А.
Сокоренко М.О.*

Актуальність. Події, які зараз відбуваються на території України, мають травматичний вплив на велику кількість населення країни. Ведення активних бойових дій, воєнний стан, повітряні тривоги з реальною загрозою життю, гібридна війна, руйнування міст, цілеспрямоване знищення населення країни, вимушене переміщення населення, втрати близьких, втрати майна, екологічні катастрофи, погіршення економічних і соціальних умов життя – все це призводить до невідворотних психологічних змін в стані кожної людини. У реаліях сьогодення України сучасна людина має швидко адаптуватись до складних умов життєдіяльності, тому саме питання психологічної резильєнтності особистості, а саме її життєстійкості привертають найбільшу увагу психологів. Важливо зазначити, що життєстійкість вважають відносно новим психологічним феноменом, завдяки якому особистість здатна ефективно вийти зі складних життєвих ситуацій. Життєстійкість особистості досліджують вітчизняні і зарубіжні науковці, але проблема особливостей прояву цього особистісного феномену в сучасному світі залишається недостатньо дослідженою і сьогодні її подальше дослідження є необхідним і дуже важливим.

Мета. Здійснити теоретичний аналіз життєстійкості як детермінанти психологічної резильєнтності та адаптаційного потенціалу особистості.

Результати дослідження. Сучасна психологія виявляє підвищений інтерес до вивчення питання життєстійкості особистості перед розмаїттям складних життєвих обставин і труднощів. Дослідження поняття «стійкість» або англійською «hardiness» почалися на початку 1980-х років, коли американські психологи С. Корбейса, С. Мадді і Д. Хошаб уперше ввели цей термін в концептуальний інструментарій психологічної науки [7]. Термін «життєстійкість» складається з двох слів і поєднує в собі слово «життя» і психологічну властивість «стійкість», що надає йому яскраве

емоційне забарвлення. Цей термін активно використовується у психологічних дослідженнях, оскільки він описує опір життєвим труднощам, подолання складних життєвих ситуацій і відноситься до здатності особистості контролювати та управляти життєвими подіями в невизначених обставинах, сприймати труднощі як цінний досвід і успішно їх долати та використовувати це як можливість особистісного психологічного зростання.. Як зазначає основоположник цього поняття С. Мадді, життєстійкість – особистісна риса, що передбачає певну структуру установок, здібностей та стратегій (що акумульовано у загальному в структуру установок залученості, контролю та прийняття ризику), які сприяють набуттю резильєнтності під впливом життєвих подій завдяки перетворенню складних життєвих обставин, стресових подій на можливості для особистісного зростання (підвищення продуктивності праці, набуття життєвого досвіду) [7]. Починаючи з 2000 р. вітчизняні науковці запропонували український вислів для цього поняття як «життєстійкість», і розглядають його як особистісну стратегію опанування перешкод («coping»), адаптаційний механізм, що дає змогу моделювати життєві цілі, бачити майбутні перспективи у сьогоденні [1], [3], [6]. Так С. Кравчук [3] розглядає життєстійкість не як систему переконань, а як інтегральну характеристику особистості, що дозволяє чинити опір негативним впливам життєвих подій, ефективно долати життєві труднощі, трансформуючи їх у ситуації розвитку. О. Кокун вважає що, життєстійкість – це така якість особистості, що дозволяє їй ефективно функціонувати та досягати своїх цілей, зберігати внутрішню рівновагу в складних ситуаціях життєвого вибору. Життєстійкість тісно пов'язана із суб'єктністю особистості, її благополуччям, здатністю до успішної психологічною адаптації в нових умовах діяльності та життєтворчістю [5]. На думку О. Чиханцової, життєздатність особистості розглядається як енергозберігаючий механізм виживання під час складних життєвих обставин та соціальних змін, який дає можливість особистості зберегти свій особистий потенціал для досягнення мети та цілей; єдину структуру, що складається з різних підсистем, які постійно взаємодіють одна з одною [6]. В дослідженнях С. Кондратюка, життєстійкість особистості розглядається як особистісний ресурс, а також здатність в складних життєвих

ситуаціях скористатися зовнішніми ресурсами. Життєстійкість виступає внутрішнім ресурсом особистості, який допомагає впоратися з військовими, стресовими ситуаціями, важкими життєвими обставинами [2]. Така багаторівнева система виникає через самоорганізацію загальної життєдіяльності особистості. Поняття стійкості охоплює формування особистості, фундаментальних життєвих перспектив, стратегій подолання стресу та екзистенціальної тривоги, представляючи комплексний психологічний феномен. Життєстійкість охоплює набір особистих переконань, які формують погляд людини на себе, світ і їхні зв'язки з ним.

На підставі емпіричних досліджень було встановлено, що життєстійкість складається з трьох ключових компонентів: «залученість», «контроль» і «прийняття виклику», які працюють разом, щоб зменшити внутрішню напругу під час складних ситуацій, ефективно керуючи стресом і сприймаючи його як менш значущий [3]. При цьому треба зауважити, що компоненти життєстійкості мають свою структуру та ієрархію, і розвиваються автономно, окремо один від одного. Розглянемо їх детальніше:

1. Залученість (включеність) – визначається як впевненість у тому, що включеність у те, що відбувається, дає найбільший шанс знайти щось варте і цікаве. Людина з розвиненим компонентом включеності відчуває себе потрібною іншим, отримує задоволення від власної діяльності, має більш високі показники суб'єктивного благополуччя. Відсутність цього компонента породжує почуття відчуженості або самотності, відчуття себе за межами життя.

2. Контроль – переконаність людини у тому, що боротьба дозволяє вплинути на результат того, що відбувається, навіть якщо цей вплив не абсолютний й успіх не гарантований. Людина з розвиненим контролем відчуває, що самостійно обирає свій шлях, переконана, що завдяки ресурсам, які у неї є, може впоратися з проблемами, намагається впливати на події.

3. Прийняття ризику (виклику) – переконаність людини в тому, що усе, що з нею трапляється, завдяки знанням і досвіду (байдуже, позитивному чи негативному) сприяє її розвитку. Людина, яка характеризується ризикованістю, зазвичай сміливіша за інших, є більш вільною у виборі, сприймає проблеми як виклик і випробування

самого себе. Низькі показники прийняття ризику свідчать про ригідність мислення, невміння користуватись отриманим досвідом. Треба зауважити, що С. Мадді наголошує на важливості вираженості усіх трьох компонентів для збереження здоров'я, оптимального рівня працездатності та активності у складних життєвих обставинах і стресогенних умовах [7]. Розвиток компонентів життєстійкості, таких як залученість, контроль і виклик, сприяє позитивному ставленню до себе та життєвих подій [4]. Отже, структура життєвої стійкості являє собою серію стійких позитивних рис, які сприяють успішній психологічній адаптації до зовнішнього середовища, що постійно змінюється, у досягненні особистих прагнень. Під час вивчення психологічних процесів, таких як стрес, боротьба в екстремальних ситуаціях та особистісний розвиток у складних життєвих обставинах, використовуються різні поняття, пов'язані з «життєстійкістю» [7].

Базовими компонентами життєстійкості як інтегральної характеристики особистості О. Купреєва вважає: оптимальну смислову регуляцію, адекватну самооцінку, розвинені волевільні якості, високий рівень соціальної компетентності, розвинені комунікативні здібності та вміння. Внутрішні чинники ефективності психологічної адаптації особистості включають самоконтроль, саморегуляцію, самореалізацію, психодинамічну енергію і пластичність. Адаптивною психодинамічною властивістю є активність, а неадаптивною – емоційність. Успішність адаптації також залежить від психологічного здоров'я та розвитку волі [4]. А. Маклаков вважає, що такі індивідуальні характеристики як: нервово-психічна рівновага, що забезпечує толерантність до стресу; самооцінка особистості, що є ядром саморегуляції і визначає ступінь адекватності умов діяльності і своїх можливостей; відчуття соціальної підтримки, що зумовлює відчуття власної значущості для оточуючих; життєвий досвід та життєтворчі вміння; соціальна активність позитивно впливають на успішність життєстійкості особистості [6]. Дослідники Т. Титаренко та Т. Ларіна [5] наголошують, що життєстійка поведінка часто є для людини способом виживання, особливо в складних життєвих обставинах, коли існує безпосередня загроза життю людини або її близьким. Основними характеристиками такої поведінки виступають:

інтенсивність, динамічність, усвідомленість, різноманітність тощо. М. Логінова вважає, що людина з життєстійкою поведінкою має оптимістичні переконання, позитивне мислення, веде здоровий спосіб життя (підтримує власне фізичне і психічне здоров'я), постійно працює над собою в плані удосконалення самоорганізуючих дій [1], [2]. Результати сучасних досліджень доводять, що компоненти життєстійкості не є вродженими якостями і їх можна розвивати. Результати дослідження психосоціальних факторів, необхідних для зростання життєстійкості особистості в умовах військового стану, показують, що життєстійкість індивіда культивується шляхом поєднання внутрішніх і зовнішніх ресурсів у різних соціоекологічних контекстах. Під час війни, коли особистість стикається з підвищеним інформаційним навантаженням та прискореним темпом життя, з новими та несподіваними ситуаціями, які вимагають швидкої психологічної адаптації, саме ці ресурси відіграють вирішальну роль у збереженні життєстійкості та психічного благополуччя. Розвинена життєстійкість дозволяє адекватно переживати складні життєві обставини і долати їх.

Висновки. Повномасштабний військовий конфлікт в Україні вимагає посилення формування у особистості життєстійкості до подолання впливу життєвих подій і тиску складних життєвих обставин, що зумовило більш активне дослідження проблеми життєстійкості особистості як вітчизняних так і зарубіжних психологів. Феномен життєстійкості розглядається як інтегральна якість особистості, яка ґрунтується на активних життєвих установках, супроводжується здатністю до досягнення мети, забезпечує самодетермінацію та внутрішню збалансованість, сприяє розкриттю ресурсного потенціалу й постає провідною детермінантою психологічної резильєнтності та адаптаційного потенціалу. Дослідження підвищення життєстійкості особистості в сьогоdnішніх умовах війни на всій території України є особливо важливим, оскільки результати таких наукових розвідок будуть сприяти розробці методів підвищення резильєнтності особистості, її стресостійкості та психологічної адаптивності у складних, екстремальних життєвих обставинах. Адже встановлено, що у складних життєвих обставинах наявність і включення ресурсів життєстійкості може запобігти розвитку

наслідків травматичного стресу. Для прояву життєстійкості під час виникнення складних життєвих ситуацій потрібно тренувати свою психологічну гнучкість для того, щоб вистояти викликам долі, адаптуватись до раптових змін в будь-якому місці і вміти ефективно діяти при любых обставинах. Перспективами подальших досліджень є вивчення феномену життєстійкості особистості, яка перебуває у складних життєвих обставинах, визначення структури, показників та чинників життєстійкості, місця життєстійкості у структурі особистості.

Література.

1. Германський І. Ю., Кондратюк С. М. Теоретичні підходи до розуміння сутності життєстійкості особистості. Збірник наукових праць Хмельницького ін-ту соціальних технологій ун-ту «Україна», № 12, 2016. С. 129–132.
2. Кондратюк С. Життєстійкість як ресурс подолання життєвих труднощів в умовах війни. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права, вип. 4. 2022. С. 78–83. <https://chasopys-ppp.dp.ua/index.php/chasopys/article/view/265>
3. Кравчук С. Л. Психологічні особливості життєстійкості особистості зв'язку з її цінностями само актуалізації. Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Кам'янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка, Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, вип. 25. 2014. С. 152–167.
4. Решетник О. А. Екзистенційний та екопсихологічний підходи до дослідження життєстійкості як необхідної якості особистості. III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підв. квал. фах. в умовах трансформації освіти. Київ, 2018. С. 90–93.
5. Титаренко Т. М. Життєві завдання особистості як соціально- психологічний чинник моделювання майбутнього. Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. ст., вип. 16 (19). 2007. С. 304–311.
6. Чиханцова О. А. Особливості прояву компонентів життєстійкості особистості. Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць, № 6, 2018. С. 267–273.
7. Maddi S., Khoshaba D. How to Succeed No Matter What Life Throws at You. Resilience at Work. New York, USA, 2005.

1.9. Теоретичні основи формування самооцінки індивідуума

Борець О. А.

Шаkun В. С.

Актуальність. Самооцінка відіграє вирішальну роль в особистому розвитку індивідуума. Вона впливає на поведінку, діяльність та спілкування людини, визначає емоційне ставлення індивідуума до себе. Самооцінка здійснює суттєвий вплив на те, як особистість себе презентує, комунікує з іншими людьми, визначаючи тим самим рівень професійного та особистого розвитку. Сучасні тенденції розвитку суспільства ставлять все вищі вимоги до індивідуумів. Важливо вміти професійно себе презентувати, випромінювати впевненість у собі, демонструвати стійкість та адекватність. Зазначене свідчить про необхідність дослідження теоретичних основ формування самооцінки індивідуума та виокремлення її різних видів.

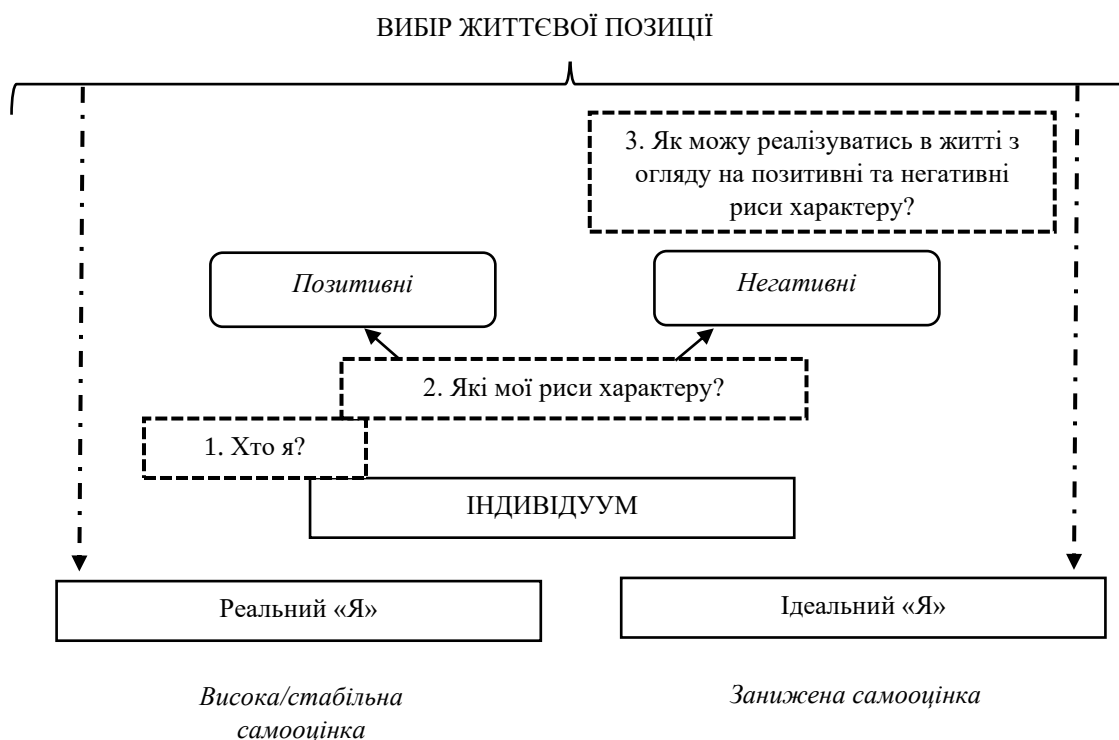
Мета. Вивчити теоретичні основи формування самооцінки індивідуума, систематизація та доповнення класифікаційних ознак її видів. Відповідно до мети вирішено такі завдання: вивчено теоретичні засади сутності поняття «самооцінка»; запропоновано власне трактування досліджуваного поняття; систематизовано та доповнено класифікаційні ознаки видів самооцінки індивідуума.

Результати дослідження. Самооцінка є найбільш вживаним поняттям, яке широко вивчається дослідниками психології та суміжних наук [26]. У 1990-х роках цільова група Департаменту освіти Каліфорнії навіть припустила, що самооцінка є панацеєю від широкого спектру суспільних проблем, включаючи злочинність, насильство, зловживання психоактивними речовинами, підліткову вагітність, жорстоке поводження з дітьми, хронічну залежність, неуспішність [12]. Відомий психолог Абрахам Маслоу визначив різні потреби людей та те, як ці потреби впливають на нашу здатність повністю розкрити свій потенціал. Здорова самооцінка, представлена на четвертому рівні ієрархії Маслоу, є критично важливим чинником фізичного, психічного та духовного здоров'я [24]. Термін

«самооцінка» був введений науковцем У. Джеймсом і він пов'язував його з первинними емоціями, такими як гнів або задоволення [3, с. 390].

Самооцінка – це оцінка переконань і ставлення людини до своїх здібностей та цінностей [25]. В широкому розумінні самооцінка відображає задоволеність або незадоволеність особою щодо самої себе [3, с. 390]. Як базова психологічна структура, самооцінка може бути мотиватором академічної залученості [20]. Самооцінка демонструє зіставлення між «Я-реальним» та «Я-ідеальним». За умови значних відхилень між прагненнями особистості та її реальними можливостями може виникати відчуття невдоволення [6, с. 80]. Наразі в сучасній українській психологічній науці дослідники вивчають формування самооцінки та її розвиток в різних вікових групах, переважно у шкільному, юнацькому і ранньому дорослому віці. Інші вчені приділяють увагу вивченню самооцінки в таких аспектах, як: взаємозв'язок селфі та самооцінки, взаємозв'язок соціальних мереж і самооцінки, вплив самооцінки співробітників на поведінку під час перемовин і т. ін. [17]. Таким чином, самооцінка індивідуума – це оцінка, яка сформувалась згідно життєвих обставин, релігійних переконань індивідуума та згідно якої останній відчуває особисту цінність, значимість та значущість. Огляд наукових досліджень показав, що зміна та формування самооцінки особистості відбувається переважно в дорослому віці. Окремими науковцями було доведено, що самооцінка, яка зазвичай визначається як загальна оцінка, зростає, коли люди переходять у доросле життя [18; 15]. З часом вона досягає відносно стабільного рівня до середнього віку, і зрештою починає знижуватися приблизно у віці 65 років [28]. З огляду на зазначене, розглянемо процес формування самооцінки індивідуума (рис. 1.). Як видно з рис. 1. процес формування самооцінки індивідуума включає в першу чергу відповідь на три питання: Хто я?; Які мої риси характеру?; Як можу реалізуватись в житті з огляду на позитивні та негативні риси характеру? Оцінивши свої реальні можливості індивідуум має змогу обрати бути реальним «Я» або ідеальним «Я». Реальний індивідуум слідує своїм інтересам, цінностям та життєвому досвіду. Ідеальний індивідуум притримується позиції нехтування відповідями на питання, тим самим принижуючи свої цінності та безпосередньо самого себе. Розглянемо

окремі види самооцінки індивідуума, які можуть проявлятися протягом життєвого циклу в тій чи іншій мірі (рис. 2.). Як видно з рис. 2, виокремлюють різні види самооцінки відповідно до яких можна виділити шість класифікаційних ознак.



Розглянемо їх більш детально.

Рис. 1. Схема процесу формування самооцінки індивідуума

Джерело розроблено авторами.

1. За рівнем самооцінки виокремлюють високу, середню та низьку. Висока самооцінка – це самооцінка, яка залежить від стандартів, визначених нашими цінностями і релігійними вподобаннями. Висока самооцінка допомагає людям знайомитись з іншими, бути успішнішими та відчувати більш високий психологічний добробут [26]. Високий рівень самооцінки формує позитивну самооцінку, яка прямопропорційно впливає на академічну та соціальну успішність особистості [27]. Середня самооцінка – це самооцінка індивідуума, який вміє прислухатися до внутрішнього голосу, аналізувати помилки та невдачі, адекватно оцінювати свої можливості. Низька самооцінка – це самооцінка людини, яка постійно негативно думає про себе та про вчинки, які робить.

Фактично, низька самооцінка безпосередньо пов'язана з підвищеним ризиком тривожності, депресії, низькою соціальною підтримкою та неякісними відносинами [13].

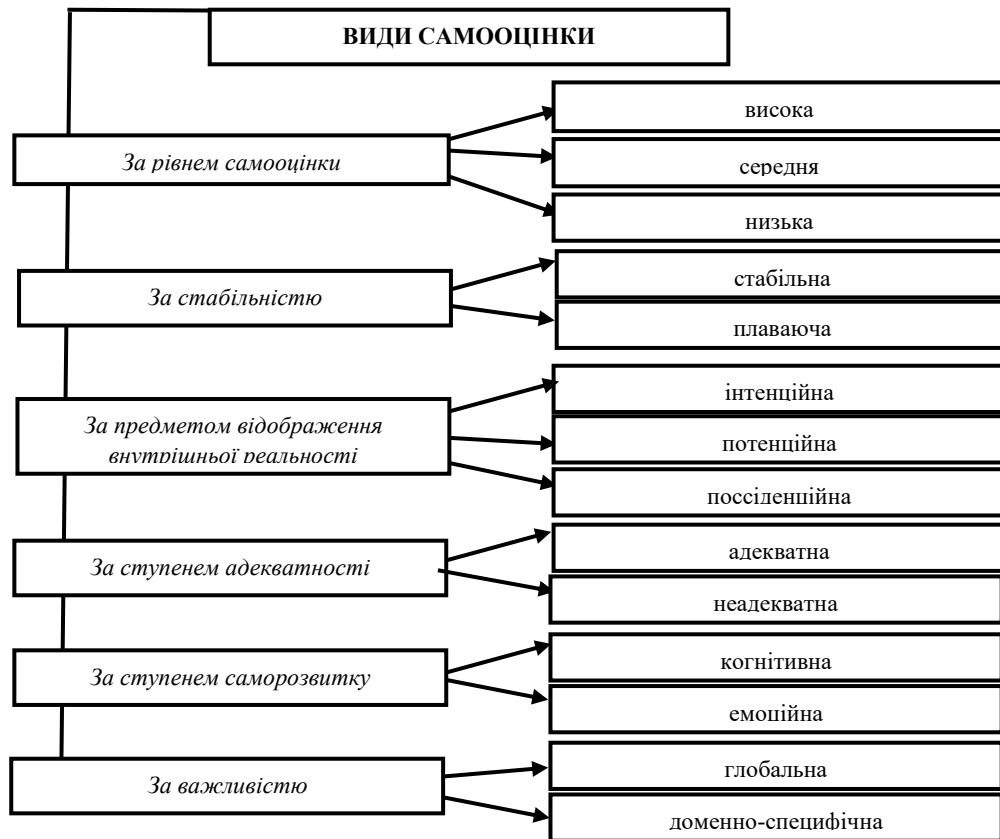


Рис. 2. Класифікаційні ознаки видів самооцінки індивідуума

Джерело розроблено авторами на основі [5; 8; 2; 4;14].

Огляд досліджень показав, що люди з низькою самооцінкою з більшою ймовірністю мають низьку успішність у школі/на роботі, погане психічне та/або фізичне здоров'я, нездорові соціальні відносини в порівнянні з людьми з високою самооцінкою [22]. У Національному звіті про розвиток психічного здоров'я за 2019–2020 рр. повідомляється, що у 24,6% підлітків Китаю, які мали низьку самооцінку, діагностовано депресію, а у 7,4% – важку депресію [16].

2. За стабільністю виділяють стабільну та плаваючу самооцінки. Стабільна самооцінка – це самооцінка, яка є основою психологічного і фізичного здоров'я. Справжня впевненість в собі спирається на особистість, а не на заслуги перед суспільством. І те, що самооцінку можна формувати самостійно, є чудовою

нагодою жити повним і щасливим життям [7]. Плаваюча самооцінка – це самооцінка особистості, яка є незбалансованою та залежить від думок інших людей, а також від власних успіхів і невдач [5]. На мою думку, нарцисичні індивіди характеризуються саме таким видом самооцінки. Нарциси живуть на так званих гойдалках – від я-грандіозний до я-нікчемний. Для того, щоб відчувати себе значущим, вони вимагають від себе надзвичайних звершень. А коли виявляється, що настільки надзвичайні звершення неможливі – неминуче падають в протилежний бік нікчемності [10].

3. За предметом відображення внутрішньої реальності виокремлюють інтенційну, потенційну та посіденційну самооцінки. Іntenційна самооцінка – це самооцінка, яка відображає життєві цілі, наміри та прагнення особистості. Потенційна самооцінка – це самооцінка, яка характеризує пізнавальні та інтелектуальні можливості людини. Посіденційна самооцінка – це самооцінка, яка відображає психофізіологічні, фізичні та характерологічні властивості індивіда [8].

4. За ступенем адекватності розрізняють адекватну та неадекватну самооцінки. Адекватна самооцінка – це самооцінка, яка відображає правильне співвідношення особистості з її можливостями та досягненнями. Вона характеризується критичним ставленням до себе, реалістичним оцінюванням успіхів та невдач і ставленням досяжних цілей [2]. Неадекватна самооцінка – це самооцінка, яка може бути завищеною або заниженою. В цьому випадку у людини виникає неправильне уявлення про себе, ідеалізований образ власної особистості та її можливостей, або ж недооцінка своєї цінності для інших [2].

5. За ступенем саморозвитку виокремлюють когнітивну та емоційну самооцінки. Когнітивна самооцінка – це самооцінка, яка самостійно визначається індивідом з використанням об'єктивних показників [9; 19]. Емоційна самооцінка – це самооцінка, яка характеризує стійкість емоційного збудження та емоційної чутливості індивіда.

6. За важливістю виділяють глобальну та доменно-специфічну самооцінки. Глобальна самооцінка – це самооцінка, яка дає можливість визначити цінність конкретної людини для суспільства в цілому [14]. Доменно-специфічна самооцінка

– це самооцінка, яка дозволяє визначити характеристики та здібності конкретної людини у певній галузі або сфері [14].

Розглянувши різні види самооцінки варто відмітити, що її формування здійснюється під впливом життєвого досвіду та моральних цінностей. Пізнання самого себе – це основа для підняття самооцінки кожного індивідуума. Перш за все важливо зрозуміти, чому властивий той чи інший вид самооцінки, ставлення до нього. Попри поширену думку, знання першопричин, через які особистість не може досягти успіху, аж ніяк не програмує на ще більше знецінення. Воно дає змогу об'єктивно оцінити власний стан та визначити подальші кроки. Але потрібно пам'ятати, що самооцінка за визначенням є суб'єктивною конструкцією та не обов'язково відображає об'єктивні характеристики та компетенції людини. Тому важливо відрізняти самооцінку від нарцисизму, оскільки обидві конструкції включають позитивні самооцінки [16; 23]. У той час як самооцінка відноситься до почуттів самоприйняття та самоповаги, нарцисизм характеризується почуттями переваги, грандіозності, права та егоцентризму [11]. Таким чином, самооцінка є важливим фактором, який відображає впевненість людини в своїх професійних і особистих силах. Формування адекватної самооцінки фахівців дозволяє: вирішити питання соціальної адаптації, подолання внутрішніх конфліктів та особистісних криз громадян, які потребують працевлаштування; допомогти в набутті навичок ефективної взаємодії та спілкування з роботодавцями та керівниками підприємств; розкрити внутрішній потенціал особистості; підвищити рівень психологічної культури [1, с. 10].

Висновки. Самооцінка – це суб'єктивна оцінка індивідуумом своєї цінності як особистості. Вона проявляється як сприйняття людиною своїх здібностей та якостей у різних сферах життя. Самооцінка не обов'язково відображає фактичні здібності чи риси індивідуума, а в основному відноситься до того, як він думає чи відчуває про ці якості та характеристики. Для глибшого розуміння через систематизацію властивостей, запропоновано різні класифікаційні ознаки видів самооцінки індивідуума, зокрема за: рівнем самооцінки (висока, середня та низька); предметом відображення внутрішньої реальності (інтенційна, потенційна, посіденційна); ступенем саморозвитку (когнітивна, емоційна); важливістю

(глобальна, доменно-специфічна); ступенем саморозвитку (когнітивна, емоційна); важливістю (глобальна, доменно-специфічна).

Література.

1. Бегеза Л. Є., Раєвська Я. М., Калюжна Є. М., & Матвієнко Л. І. Компетентнісний підхід у психологічній підтримці фахівців ринку праці в умовах війни // Журнал сучасної психології. 2022. (2). 7–15. https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42984/1/L_Begeza_IA_Raievska_IE_Kaluzhna_L_Matviienko_PSP_2_FPSPSO.pdf
2. Ліпковська Ю. Формування адекватної самооцінки у школярів. // Психологічні виміри культури, економіки, управління. 2016. № 9. С. 61–69
3. Михайлишин У.Б., Гернешій М.В. Поняття самооцінки у вітчизняній та зарубіжній психології. // The XXI International Scientific and Practical Conference «Scientists and methods of using modern technologies», May 30 – June 02, 2023, Melbourne, Australia,. Р. 390–393. <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/51914/1/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%88%D1%96%D0%B9.pdf>
4. Олійник О.О. Самооцінка як передумова професійного становлення студентів. // Теорія і практика сучасної психології. 2018. №1. С. 97–101.
5. Папітченко Л. Теоретичний аналіз проблеми значущості самооцінки в структурі гідності особистості // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки : зб. наук. праць / за наук. редакцією І. С. Булах. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. Вип. 12 (57). 138 с. <https://sj.udu.edu.ua/index.php/pn/article/view/1025/855>
6. Папітченко Л.В. Теоретичний аналіз проблеми значущості самооцінки в структурі гідності особистості. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Психологічні науки. 2020. №12. С. 79–89.
7. Стойко Ю. Стабільна самооцінка: як її сформувати? Інтернет-портал «Колесо Життя». <https://koleso-gizni.com.ua/uk-ua/lichnost/kak-uluchsit-samoocenku>
8. Чорна А. С. Взаємозв'язок структури мотивації та розвитку структури самооцінки. // Проблеми сучасної психології. 2021. С. 11–13.

9. Шмаргун В.М. Освіченість та інтелігентність в освітньому середовищі. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія, 2016. Вип. 233. С. 389–396.
10. Що таке нарцисизм та що з ним робити? Блог про НЛП. <https://bdgpeople.com/blog/shho-take-narcisizm-ta-shho-z-nim-robiti/>
11. Ackerman R.A, Witt E.A, Donnellan M.B, Trzesniewski K.H, Robins R.W, Kashy D.A. What does the Narcissistic Personality Inventory really measure? Assessment. 2011. №18. P. 67–87.
12. Baumeister R.F, Campbell J.D, Krueger JI, Vohs K.D. Does high self-esteem cause better performance, interpersonal success, happiness, or healthier lifestyles? Psychological Science in the Public Interest. 2003. №4. С 1–44.
13. Choi Y., Choi S., Yun J. et al. The relationship between levels of self-esteem and the development of depression in young adults with mild depressive symptoms. Medicine. 2019. №98. 42 p.
14. Donnellan M.B, Trzesniewski K.H, Robins R.W. Self-esteem: Enduring issues and controversies. In Chamorro-Premuzic T, von Stumm S, & Furnham A (Eds.). The Wiley-Blackwell handbook of individual differences. 2011. P. 718–746.
15. Erol R.Y, Orth U. Self-esteem development from age 14 to 30 years: A longitudinal study. Journal of Personality and Social Psychology. 2011. №101. P. 607–619.
16. Gijzen M.W, Rasing S.P, Creemers D.H, Smit F, Engels R.C, De Beurs D. Suicide ideation as a symptom of adolescent depression. A network analysis. J Affect Disord. 2001. № 278. P. 68–77.
17. Greenwald A.G., Banaji M.R., Rudman L.A., Farnham S.D., Nosek B.A., Mellott D.S. A unified theory of implicit attitudes, stereotypes, self-esteem, and self-concept. Psychological Review. 2002. №109. P 3–25.
18. Leary M.R, Baumeister R.F. The nature and function of self-esteem: Sociometer theory. In: Mark PZ, editor. Advances in experimental social psychology. 2000. Vol. 32. Academic Press. P. 1–62.
19. Lee-Flynn S.C., Pomaki G., DeLongis A., Biesanz J.C., Puterman E. Daily Cognitive Appraisals, Daily Affect, and Long-Term Depressive Symptoms: The Role of

Self-Esteem and Self-Concept Clarity in the Stress Process. *Personality & Social Psychology Bulletin*. 2015. № 37. P. 255–268.

20. Lim Y., and Lee O. Relationships between parental maltreatment and adolescents' school adjustment: mediating roles of self-esteem and peer attachment. *J. Child Fam. Stud.* 2017. №26. P. 393–404.

21. Orth U., Robins R., Meier L., Conger R. Refining the vulnerability model of low self-esteem and depression: Disentangling the effects of genuine self-esteem and narcissism. *Journal of Personality and Social Psychology*. 2016. №110. P. 133–149.

22. Orth U, Robins R.W. Orth U, Robins R.W. Is high self-esteem beneficial? Revisiting a classic question. *American Psychologist*. 2022. № 77. P. 1.

23. Paulhus D.L, Robins R.W, Trzesniewski K.H, & Tracy J.L. Two replicable suppressor situations in personality research. *Multivariate Behavioral Research*. 2004. № 39. P. 303–328.

24. Robins R.W, Tracy JL, Trzesniewski K, et al. Personality correlates of self-esteem. *Journal of Research in Personality*. 2001.

25. Rosenberg M. *Society and the Adolescent Self-Image*. Princeton, NJ: Princeton University Press. 1965.

26. Swann W.B, Chang-Schneider C, & McClarty K.L Do people's self-views matter? *American Psychologist*. 2007. №62. P. 84–94.

27. Unguren E. (2020). Exploring the Moderating Effect of Campus Recreation Participation on the Relationship between Education Satisfaction and Self-Esteem. *Polish Journal of Sport and Tourism*. 2020. № 27(3). P. 8-14. <https://doi.org/10.2478/pjst-2020-0014>

28. Wagner J, Lüdtko O, Jonkmann K, Trautwein U. Cherish yourself: Longitudinal patterns and conditions of self-esteem change in the transition to young adulthood. *Journal of Personality and Social Psychology*. 2013. №104. P.148–163.

1.10. Особливості надання психологічної допомоги дружинам військовослужбовцям

Зубченко К.В.

Актуальність. Війна в Україні спричиняє значне психоемоційне напруження в суспільстві. Повномасштабне вторгнення в Україну призвело до потреби надання психологічної допомоги різним верствам населення. Чутливою категорією населення є дружини військовослужбовців та ветеранів бойових дій, які потребують професійної психологічної підтримки [1]. Особливості психоемоційних станів жінок визначається рядом факторів [2-10]:

1. Зниженням психологічної стійкості дружин, яке має ключове значення для збереження власного фізичного і психічного здоров'я, а також для успішної підтримки чоловіків військовослужбовців та родини у цілому. Розвиток психічної стійкості через психологічну підтримку жінок запобігає можливим проблемам їх адаптації та соціальному функціонуванню;

2. Перебудова структурно-функціональних ролей жінки у родині військовослужбовця потребує комплексного супроводу, з урахуванням психологічних реакцій та можливих дезадаптаційних станів при організації підтримки та допомоги.

3. Розвитком розладів адаптації, які можуть виникати внаслідок стресових ситуацій, пов'язаних зі реактивною тривогою.

Палітра психоемоційний станів дружин ветеранів охоплює стани від незначних, легких емоційних коливань та психічного напруження до клінічно окреслених синдромів реактивної тривоги, тривожних та депресивних розладів, нав'язливих станів obsesивно-компульсивного генеза, панічних, дисоціативних розладів. Діагностично об'єднувальним паттерном даних станів є поведінкові реакції у вигляді дратівливості, розгубленості, депривації сну, апатії, життя на «паузі». Психологічним компонентом реагування є виникнення психосоматичних розладів, вторинна травматизація, втрата власної значущості, проблеми із самооцінкою, переживання фаз горя внаслідок втрат.

Дружини військовослужбовців стикаються з проблемами нерозуміння чоловіка, неприйняття змін, що відбулись з ним, не усвідомлення адаптаційного періоду та важливості постійної підтримки, неможливості віднайти власну ідентичність під час постійної тривожності. Дружини часто зазначають на суттєву зміну сімейних відносин, виникнення непорозумінь, конфліктів, безкомпромісності та егоїстичності. Всі ці фактори слугують фоном розвитку емоційного виснаження як дружини військовослужбовця так і родини в цілому.

Дослідження питання надання психологічної підтримки дружинам військовослужбовців є важливим вектором для забезпечення стійкості та налагодження здорових стосунків не тільки в родині, а й в суспільстві взагалі. В цілому дослідниками вивчається широкий спектр [1-10] впливів війни на особистість дружин військовослужбовців. Проте, незважаючи на досить значне поширення наукових пошуків, спрямованих на вивчення факторів порушення сімейних взаємин, мало дослідженим залишаються аспекти особливостей надання психологічної допомоги жінкам.

Мета. Здійснити аналіз особливостей надання психологічної допомоги дружинам військовослужбовців.

Результати дослідження. З дотриманням принципів деонтології (Ethical principles of psychologists and code of conduct) проведено комплексне обстеження 30 дружин військовослужбовців. Базою дослідження став Центр соціальних служб м. Канева. Методологічним апаратом дослідження обрані наступні дослідні інструменти: методика дослідження самопочуття, активності, настрою (САН), «Аналіз сімейної тривоги», Шкала тривоги (А. Спілбергера), методика діагностики рівня емоційного вигорання (В. Бойко). Аналіз, обробка і підрахунок процентних характеристик і коефіцієнтів кореляції здійснювалися за допомогою програми SPSS 10.0.5 for Windows.

За результатами дослідження виявлено, що перебування чоловіка на війні є складною життєвою ситуацією в якій опинилась жінка військовослужбовця. Почасту це травмуюча ситуація, яка вимагає психологічної стійкості, фізичної витримки, переосмислення цінностей, поглядів на себе та суспільства. Виявлено,

що жінці необхідно працювати над збереженням свого внутрішнього ресурсу, який допомагає справлятися з життєвими викликами. Основними сферами життєдіяльності, які надають ресурс відносять: родину, фінансовий добробут, здоров'я, відпочинок, стосунки як із собою так і з іншими, задоволення базових потреб людини. Деякі дослідники, наголошують на підвищеному емоційному навантаженні, що несуть сім'ї військових у період очікування повернення чоловіків з зони бойових дій; а після повернення стикаються з порушеннями психологічного функціонування і психопатологічними проявам, пов'язаними з перенесеним бойовим стресом. Дружини учасників бойових дій, змушені нести підвищене емоційне та фізичне навантаження на всіх етапах, як у період бойової служби чоловіка, так і на етапі його ресоціалізації, вже після повернення до мирного життя. Це навантаження може суттєво ускладнювати емоційне і фізичне самопочуття дружин, викликаючи скарги на напружені відносини, сімейний дискомфорт, конфліктність, емоційне вигорання. Доволі часто дружинам буває важко зрозуміти і прийняти зміни, які сталися з чоловіками, це викликає страх, тривогу, дратівливість, безсоння, втому і переживання за подальшу долю своїх родин [3, 6]. Особливе значення в роботі з дружинами військовослужбовців є розуміння і вміння психолога відгукнутися також на потребу у визнанні мужності і зусиль жінок у період випробувань, що випали на їхню родину: у підтримці чоловіка, коли він воював; у визнанні тривоги за нього під час служби; у визнанні зусиль по турботі про дітей і сім'ю, коли чоловік на фронті; у визнанні того, що вона своєю причетністю до життя чоловіка, також змагалася за благополуччя українців [5].

Узагальнюючі результати власних досліджень, зауважено, що завданням психолога є надання підтримки і розуміння, усвідомлення трансформаційних змін як чоловіка так і жінки, поглянути на можливість перспектив в особистому розвитку для гармонійного життя. В роботі з дружинами військовослужбовців необхідно широко застосовувати комплексні підходи психотерапевтичних напрямків, оскільки головна ціль – допомогти пережити незрозумілі для себе зміни та набути нового досвіду який не буде викликати дистресу. Серед найбільш відомих напрямків виокремлюють: когнітивно-поведінкова терапія, гештальт-

терапія, основи психоаналізу, символ-драма, методи десинсабілізації, схема-терапія, символ-драма, сімейна-терапія та інші.

Зазначмо, що на якість психологічного консультування дружин військовослужбовців впливають наступні аспекти:

- психологічна готовність до консультування;
- життєвий досвід;
- наявність психологічних травм та розладів;
- бажання в отриманні нових знань та умінь;
- зацікавленість і націленість на трансформаційні зміни особистості;
- дисциплінарне дотримання нових навичок.

В процесі консультації психолог навчає жінку приймати і справлятися з життєвими труднощами в розрізі особистої відповідальності за власне життя. Досить часто жінка шукає відповіді на риторичні питання, дратується коли не знаходить їх, перебуває у відчаї в намаганнях щось змінити, відчуває занепад сил і бажань від власного життя і нехтує своїм внутрішнім потенціалом. Інколи жінці необхідно налаштовувати не шукати відповіді на питання, а дозволити собі прожити ситуацію. Винести для себе досвід, відшукати підґрунтя для внутрішнього наповнення ресурсами та вдосконалити свій духовний розвиток.

Основними елементами психологічного консультування дружин військовослужбовців є: довіра; підтримка; емпатія; розуміння; співчуття; відкритість; толерантність; конфіденційність.

Принципами психологічного консультування є: повага, чесність, неоціночне слухання, доброзичливість, порядність та таємність.

За результатами дослідження виявлені труднощі консультування дружин військовослужбовців до яких віднесено те, що почасти жінки скептично відносяться до порад психологів, оскільки звикли контролювати та вирішувати свої питання самостійно. Звичайно виключення становлять залежні та співзалежні стосунки чи наявність різноманітних психічних розладів.

Кінцевим результатом консультування жінок є придбання нового досвіду, віддзеркалення і дистанціювання від проблем, думок, усвідомлення пережитого, рефлексія і дозвіл собі краще розуміти свої потреби.

До цільових напрямків психологічного консультування дружин військовослужбовців необхідно віднести наступні:

- розвиток емоційного інтелекту;
- розвиток емоційної стійкості та пошук точок опори;
- створення та пошук внутрішніх ресурсів;
- опанування навичкам безконфліктної комунікації;
- підтримка при переживанні втрат та змін.

Запити із якими звертаються дружини військових досить різноманітні, а саме:

- побудова гармонійних відносин із собою;
- розуміння чоловіка військового;
- оволодіння навичками комунікації з військовими;
- налагодження стосунків з дітьми;
- поновлення соціальної ролі в родині після повернення чоловіка;
- долаття проблем з адаптацією до нових умов життя;
- побудова толерантних сімейних стосунків;
- вирішення незадоволеності матеріальним становищем, проблем з працевлаштування;
- подолання проблеми в інтимній сфері, відновлення гармонійних відносини з чоловіком після повернення додому;
- позбутись емоційного напруження;
- зрозуміти та навчитись зменшувати тривогу та постійну стурбованість;
- позбутись страхів, нав'язливих думок та панічних атак та ін.

У консультуванні дружин військовослужбовців на наш погляд необхідно використовувати підхід розроблений американським психологом і психотерапевтом, представником екзистенціально-гуманістичної психології Р. Мей [8], якій поділяв консультативний процес на чотири етапи: 1) встановлення довірливих стосунків, які можуть бути реалізовані через елементи віддзеркалення

(відображення жестів, повторення завершення фраз тощо), метою є приєднання та допомога відкритись; 2) складання психологічного портрета за допомогою спостереження за манерами, звичками, тембром голосу тощо; 3) сповідь і тлумачення результатів, через процес активного слухання та інтерпретації психологом почутої інформації, подій, почуттів; 4) трансформація особистості за сприяння та підтримки психолога-консультанта, який має не лише полегшити переживання, але й спрямувати на досягнення бажаної мети особистості.

Консультації з дружинами військовослужбовців може проводитись офлайн або онлайн. Вибір конкретної форми залежить від можливостей клієнта, сутність проблеми, часу. Обидві форми мають свої переваги і недоліки, хоча офлайн консультування набуває більшого поширення через зручність та економічність по затратах. Консультативна робота з дружинами та їх сім'ями полягає у використанні різноманітних методик, технологій, серед яких найпоширенішими можна визначити семінари, тренінги, психотерапевтичні групи, психокорекційну роботу, індивідуальні та групові зустрічі. Також поширеними є гарячі лінії допомоги, групи підтримки на просторах інтернет, спеціально створені мобільні додатки. Дані технології допомагають жінкам в кризових ситуаціях віднайти рівновагу і відчувати стабільний психічний стан, зменшити агресивність, розгубленість, мінімізувати конфліктність, налагодити соціальні зв'язки та сприяє розвитку емоційної впевненості.

Висновки. Узагальнюючи результати дослідження особливостей надання психологічної допомоги дружинам військовослужбовців можна зазначити, що дружини військовослужбовців: мають психоемоційне негативне навантаження та потребують профілактики розвитку явищ тривоги, емоційного вигорання та розладів адаптації; є «чутливо вразливою» категорією, яка піддається психотравмуючому впливу, а тому потребують навичок психологічного захисту, самопомоги, саморегуляції задля запобігання емоційному виснаженню; потребують окремих компетентностей та знань щодо власних емоційних станів, гострих або хронічних станів порушення психічного здоров'я у членів родини; мають потребу у розбудові власної психологічної стійкості задля підтримки членів

родини та власного чоловіка військовослужбовця у психотравмуючих умовах війни; в умовах довготривалої дезадаптації мають симптоми посттравматичного розладу, що потребує психологічної корекції; потребують фахової психологічної підтримки, яка ґрунтується та пов'язана з вже існуючими та постійно наростаючими травмуючими впливами. Терапевтична робота з дружинами військовослужбовців спрямована на розвиток стресостійкості в сімейній, особистій та професійній сферах та проводиться у наступних напрямках: психоедукації з питань ПТСР та вторинної травматизації; підтримка у налагодженні гармонійних стосунків із чоловіком, дітьми, колегами; розвиток нових навичок при комунікації із чоловіком; підтримка у пошуку ресурсів для турботи про себе; розвиток навичок самодопомоги при появі різних емоційних реакцій, технікам емоційного регулювання; підтримка у поясненні причинно-наслідкових зв'язків дітям щодо кожної ситуації, особливо що стосується питань втрати та змін; пропарювання важливих питань щодо минулого травматичного досвіду. Для вирішення кожного конкретного запиту з якими звертаються дружини військовослужбовців психолог обирає певний напрям терапії враховуючи особливості проблеми. Найпоширенішими напрямками в психології виокремлюють: когнітивно-поведінкова терапія, гештальт-терапія, транзакний аналіз, гуманістична терапія, тілесно-орієнтована терапія, психоаналіз тощо.

Література.

1. Богомолець О. В. Поширеність та структура посттравматичних психічних порушень в учасників бойових дій / О. В. Богомолець, І. Я. Пінчук, А. К. Ладик-Бризгалова. *Архів психіатрії*. 2016. Т. 22, № 2. С. 11–15. http://nbuv.gov.ua/UJRN/apsuh_2016_22_2_4.
2. Протокол з діагностики та терапії ПТСР Національного інституту клінічної майстерності Великобританії (NICE). <http://guidance.nice.org.uk/cg26>;
3. Оверченко А. І. Психологія травмуючих ситуацій: навч. посіб. [Текст] / Оверченко А. І. К. : Нац акад. внутр. справ., 2014. 177 с.
4. Синопис діагностичних критеріїв DSM-V та протоколів NICE для діагностики та лікування основних психічних розладів у дітей та підлітків / перекл.

з англійської; упор. та наук. ред. Леся Підлісецька. (Серія «Психологія. Психіатрія. Психотерапія»). Львів: Видавництво Українського католиц. універ., 2014. – 112 с.

5. Росінський Г. С. Порушення здоров'я сім'ї у учасників бойових дій (феноменологія, механізми розвитку, психологічна корекція). – Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за спеціальністю 19. 00. 04 «Медична психологія». Харків, 2019. 184 с.

6. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний посібник. Том 3. Київ, 2018. 236 с.

7. Рекомендації для членів сімей учасників Антитерористичної операції / упорядковано Управлінням по роботі з особовим складом Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України на основі досвіду подолання посттравматичного синдрому, узагальненого В. Арабинським. <http://www.mil.gov.ua>.

8. Маркова М. В. Функціонування сімейної системи і постстресова психологічна дезадаптація учасників бойових дій: взаємодія феноменів, варіанти взаємовпливу, медико-психологічна підтримка. Ментальне здоров'я особистості та організації : колективна монографія. Академія праці, соціальних відносин і туризму / За заг. ред. : Г. А. Приба, Л. Є. Бегези. – Київ : ТОВ «Типографія АМГ». 2024. – С. 270–287 с.

9. Магдисюк Л. І. Основи психологічного консультування : навч. посіб. / Людмила Іванівна Магдисюк, Раїса Петрівна Федоренко. – Луцьк : Вежа-Друк, 2022. – 360 с.

10. Prib H., Beheza L., Markova M., Raievska Y., Lapinska T., Markov A. Psycho-emotional burnout of the personality in the conditions of war // Journal of Intellectual Disability – Diagnosis and Treatment. 2023. V. 11, № 1. P. 36–46.

11. Практикум психологічного консультування військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей. Навчально-методичний посібник Хоружій С. М., Лозинська Н. С., Пішко І. О., Олійник В. О., Сириця М. В. Київ: «Центр учбової літератури». 2023. 90 с.

1.11. Взаємозв'язок психологічних чинників розладів харчової поведінки у дітей та підлітків з методами їх діагностики та корекції

Єнтис Я.І.

Актуальність. Розлади харчової поведінки (РХП) постають серйозним викликом для психічного та фізичного здоров'я дітей і підлітків, демонструючи стрімке зростання захворюваності протягом останніх десятиліть. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, поширеність РХП серед осіб віком 10-19 років сягає 5-7%, причому дівчата страждають втричі частіше за хлопців. Харчова поведінка визначається як сукупність форм поведінки людини, що включають режим, темп споживання їжі, переваги у виборі продуктів харчування, а також поведінкові реакції, які супроводжують прийом їжі. Розлади харчової поведінки характеризуються стійкими порушеннями у споживанні їжі, що призводять до змін у фізичному здоров'ї та психосоціальному функціонуванні особистості.

Психологічні чинники відіграють визначальну роль у формуванні та розвитку РХП, охоплюючи особистісні особливості, сімейну динаміку, травматичний досвід та соціокультурні впливи. Актуальність теми зумовлена необхідністю розробки ефективних методів раннього виявлення та корекції РХП з урахуванням індивідуальних психологічних особливостей дітей та підлітків. Статистика свідчить про зростання випадків анорексії, булімії та компульсивного переїдання серед молоді, що потребує глибокого розуміння взаємозв'язку між психологічними чинниками та методами терапевтичного втручання.

Мета. Визначити та надати аналіз взаємозв'язкам між психологічними чинниками розвитку розладів харчової поведінки у дітей та підлітків та відповідними методами діагностики й корекції. Дослідження спрямоване на розробку рекомендацій щодо вдосконалення діагностичного інструментарію та корекційних програм з урахуванням виявлених психологічних чинників.

Результати досліджень. Психологічні чинники розладів харчової поведінки у дітей та підлітків формують складну багаторівневу систему, де кожен елемент впливає на розвиток та перебіг захворювання. Перфекціонізм, як особистісна риса,

часто виступає тригером для розвитку анорексії, змушуючи підлітків встановлювати нереалістичні стандарти щодо власної зовнішності. Низька самооцінка та негативний образ тіла посилюють тривожність та депресивні стани, що призводить до компульсивного переїдання як способу емоційної регуляції. Сімейні конфлікти та порушення дитячо-батьківських стосунків створюють підґрунтя для формування патологічних харчових патернів, де їжа стає інструментом контролю та самоствердження. Травматичний досвід, включаючи булінг та насильство, може спровокувати розвиток булімії як механізму впоратися з негативними емоціями. Соціальний тиск та культ худорлявості, що активно пропагується через соціальні мережі, посилює ризик розвитку РХП серед молоді [1, с. 23].

Діагностика розладів харчової поведінки потребує інтеграції різних методологічних підходів та інструментів оцінювання. Клінічне інтерв'ю залишається базовим методом первинної діагностики, дозволяючи виявити специфічні особливості харчової поведінки та супутні психологічні проблеми. Психодіагностичне тестування включає застосування стандартизованих опитувальників, таких як EAT-26 (Eating Attitudes Test) та EDI (Eating Disorder Inventory), які оцінюють різні аспекти харчової поведінки та психологічного функціонування. Проективні методики дозволяють дослідити неусвідомлені компоненти образу тіла та самосприйняття. Моніторинг харчового щоденника допомагає відстежувати патерни харчування та тригери дезадаптивної поведінки. Оцінка сімейної системи через генограму та системне інтерв'ю розкриває роль сімейної динаміки у підтримці розладу. Біометричні показники та медичні обстеження доповнюють психологічну діагностику, формуючи цілісну картину стану пацієнта.

Корекційна робота з РХП базується на принципі індивідуалізації терапевтичних втручань з урахуванням виявлених психологічних чинників. Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) допомагає модифікувати дисфункційні переконання щодо їжі, ваги та образу тіла, навчаючи адаптивним стратегіям подолання стресу. Діалектично-поведінкова терапія (ДБТ) фокусується на

розвитку навичок емоційної регуляції та mindfulness, що особливо ефективно при булімії та компульсивному переїданні. Сімейна терапія залучає батьків до процесу одужання, працюючи над покращенням комунікації та встановленням здорових границь. Групова терапія створює середовище взаємної підтримки та можливість відпрацювання соціальних навичок. Арт-терапія та тілесно-орієнтовані практики сприяють відновленню позитивного зв'язку з власним тілом. Психосвітні інтервенції для батьків та педагогів підвищують обізнаність щодо ранніх ознак РХП та способів підтримки дитини [2, с. 45].

Дослідження взаємозв'язку між психологічними чинниками та ефективністю різних терапевтичних підходів демонструє необхідність диференційованого підходу до корекції РХП. Високий рівень перфекціонізму краще піддається корекції через КПТ, тоді як проблеми з емоційною регуляцією ефективніше долаються за допомогою ДБТ. Травматичний досвід вимагає інтеграції технік роботи з травмою в основний терапевтичний протокол. Порушення сімейної динаміки потребує активного залучення сімейної терапії як основного методу втручання. Соціальна тривожність та проблеми з самооцінкою краще коригуються в груповому форматі роботи. Дефіцит усвідомлення тілесного відчуття вимагає включення тілесно-орієнтованих практик в терапевтичний процес.

Прогноз лікування РХП значною мірою залежить від своєчасності діагностики та вибору адекватних методів корекції. Раннє виявлення психологічних чинників ризику через скринінгові програми в школах дозволяє запобігти розвитку повноцінного розладу. Використання модульних терапевтичних програм, які можна адаптувати під індивідуальні потреби пацієнта, підвищує ефективність лікування. Залучення мультидисциплінарної команди фахівців забезпечує комплексний підхід до терапії. Регулярний моніторинг прогресу та готовність модифікувати терапевтичний план відповідно до динаміки стану пацієнта сприяють досягненню стійких результатів. Підтримка терапевтичних досягнень через групи підтримки та періодичні «бустерні» сесії знижує ризик рецидиву [3, с. 46].

Розвиток розладів харчової поведінки часто починається з субклінічних проявів, які поступово трансформуються в повноцінний синдром під впливом множинних психологічних факторів. Підліткова вразливість до оцінок однолітків створює підґрунтя для формування викривленого сприйняття власного тіла, що згодом може перерости в дисморфофобічні прояви. Генетична схильність до перфекціонізму посилюється впливом соціальних очікувань та тиском медіа-стандартів краси. Дослідження патернів сімейної взаємодії виявляють кореляцію між надмірним контролем з боку батьків та розвитком компенсаторних форм харчової поведінки у дітей. Емоційна депривація в ранньому дитинстві формує специфічні механізми психологічного захисту, де їжа стає заміником емоційного контакту. Нейробіологічні дослідження підтверджують зміни в системах винагороди мозку при тривалих порушеннях харчової поведінки.

Стресові події життя виступають каталізаторами розвитку патологічних харчових патернів, особливо в періоди гормональних змін та психосоціальних трансформацій. Копінг-стратегії, сформовані в дитинстві, визначають способи реагування на стрес, де обмеження харчування або переїдання стають деструктивними механізмами саморегуляції. Розлади харчової поведінки часто супроводжуються коморбідними станами, включаючи тривожні розлади, депресію та obsесивно-компульсивний розлад. Дослідження нейрокогнітивних процесів показують порушення виконавчих функцій при тривалих розладах харчування. Порушення інтероцептивної чутливості призводить до втрати зв'язку з природними сигналами голоду та насичення. Соціальна ізоляція та академічні труднощі посилюють психологічний дистрес та закріплюють патологічні харчові патерни [4, с. 167].

Механізми психологічного захисту у підлітків з розладами харчової поведінки характеризуються ригідністю та обмеженим репертуаром адаптивних стратегій. Дисоціативні прояви часто супроводжують епізоди переїдання, створюючи розрив між емоційним переживанням та усвідомленням власної поведінки. Порушення менталізації ускладнює розуміння власних емоційних станів та потреб інших людей. Когнітивні викривлення підтримують дисфункційні

переконання щодо ваги та форми тіла, створюючи замкнене коло негативних думок та компенсаторної поведінки. Алекситимія, характерна для багатьох пацієнтів з РХП, ускладнює процес психотерапевтичної роботи та вимагає специфічних технік емоційної регуляції.

Діагностичний процес повинен враховувати динамічний характер розвитку розладів харчової поведінки та множинність їх проявів. Психометричні інструменти потребують культурної адаптації та врахування вікових особливостей цільової групи. Специфіка підліткового віку вимагає модифікації стандартних діагностичних протоколів та включення проєктивних методик. Оцінка сімейної системи повинна охоплювати трансгенераційні патерни та актуальну сімейну динаміку. Нейропсихологічна діагностика дозволяє виявити специфічні когнітивні дефіцити та планувати відповідні реабілітаційні заходи. Моніторинг фізіологічних показників має здійснюватися паралельно з психологічною діагностикою для забезпечення безпеки терапевтичного процесу.

Психотерапевтична робота з розладами харчової поведінки вимагає інтеграції різних терапевтичних підходів та технік. Психодинамічна терапія дозволяє опрацювати глибинні конфлікти та травматичний досвід, що лежать в основі розладу. Схема-терапія ефективна при роботі з дисфункційними життєвими сценаріями та ранніми дезадаптивними схемами. Емоційно-фокусована терапія допомагає відновити здоровий зв'язок з емоціями та потребами. Системна сімейна терапія працює з патернами взаємодії, що підтримують симптоматику. Майндфулнес-базовані підходи розвивають навички усвідомленої присутності та самоспівчуття [5, с. 90].

Нейропсихологічна реабілітація стає невід'ємною частиною комплексного лікування розладів харчової поведінки. Тренінг виконавчих функцій покращує здатність до планування та самоконтролю. Робота з тілесним образом через психомоторні техніки відновлює адекватне сприйняття власного тіла. Біологічний зворотний зв'язок допомагає розвинути навички саморегуляції. Групові форми роботи створюють простір для соціального навчіння та розвитку комунікативних

навичок. Арт-терапевтичні інтервенції дозволяють виразити невербалізовані переживання та страхи.

Психоосвітній компонент терапії охоплює роботу з сім'єю, школою та найближчим оточенням пацієнта. Навчання батьків навичкам підтримуючої комунікації зменшує ризик рецидивів. Програми профілактики в школах підвищують обізнаність щодо факторів ризику та ранніх ознак розладів. Робота з педагогами спрямована на створення підтримуючого освітнього середовища. Групи підтримки для батьків надають простір для обміну досвідом та взаємодопомоги. Інтеграція психоосвітніх програм у медичні установи підвищує якість міждисциплінарної взаємодії.

Прогностичні фактори одужання включають ранній початок лікування, високу мотивацію до змін та підтримку сімейної системи. Тривалість терапевтичного процесу залежить від важкості симптомів та наявності коморбідних розладів. Етапність терапевтичних інтервенцій забезпечує поступове відновлення нормального функціонування. Критерії одужання охоплюють не лише нормалізацію харчової поведінки, але й психологічне благополуччя. Постерапевтичний супровід включає регулярні підтримуючі сесії та моніторинг стану [6, с. 245].

Терапевтичний альянс виступає ключовим фактором успішності лікування розладів харчової поведінки. Емпатійне ставлення терапевта створює безпечний простір для дослідження травматичного досвіду. Робота з опором та амбівалентністю вимагає специфічних терапевтичних навичок. Підтримка мотивації до змін здійснюється через техніки мотиваційного інтерв'ювання. Гнучкість терапевтичного підходу дозволяє адаптувати інтервенції під індивідуальні потреби пацієнта.

Індивідуалізація терапевтичного плану базується на комплексній оцінці психологічних чинників та механізмів підтримки розладу. Диференційований підхід до вибору терапевтичних технік враховує особистісні особливості пацієнта. Модульний принцип побудови терапевтичних програм забезпечує гнучкість та адаптивність лікування. Інтеграція різних терапевтичних модальностей підвищує

ефективність втручань. Регулярна оцінка прогресу дозволяє своєчасно модифікувати терапевтичний план.

Розвиток резильєнтності виступає важливим компонентом терапевтичного процесу. Формування адаптивних копінг-стратегій підвищує стійкість до стресових ситуацій. Розвиток емоційної компетентності сприяє кращому розумінню власних переживань. Відновлення соціальних зв'язків зміцнює систему підтримки. Розвиток навичок самодопомоги забезпечує довготривалу стабільність результатів [7, с. 45].

Профілактика рецидивів включає розробку індивідуального плану підтримки досягнутих результатів. Ідентифікація тригерів дозволяє розробити стратегії їх попередження. Формування здорових харчових звичок та режиму дня стабілізує психофізіологічний стан. Розвиток навичок самомоніторингу допомагає своєчасно виявляти ознаки погіршення стану. Підтримка терапевтичних досягнень через групи взаємодопомоги зменшує ризик рецидивів.

Міждисциплінарна взаємодія забезпечує комплексний підхід до лікування розладів харчової поведінки. Координація роботи психолога, психіатра та дієтолога оптимізує терапевтичний процес. Регулярні консилиуми дозволяють оцінювати динаміку стану та корегувати план лікування. Взаємодія з педагогами та соціальними працівниками розширює систему підтримки пацієнта. Супервізійний супровід фахівців підвищує якість надання допомоги.

Дослідження катамнезу пацієнтів з розладами харчової поведінки дозволяє оцінити довготривалу ефективність терапевтичних втручань. Аналіз факторів, що впливають на стійкість результатів, допомагає вдосконалювати терапевтичні протоколи. Вивчення випадків рецидивів надає інформацію для покращення профілактичних стратегій. Оцінка якості життя після завершення терапії відображає глибину досягнутих змін. Збір катамнестичних даних сприяє розвитку доказової бази ефективності різних терапевтичних підходів [8, с. 156].

Інтеграція сучасних технологій розширює можливості діагностики та терапії розладів харчової поведінки. Моніторинг фізіологічних показників через мобільні додатки підвищує об'єктивність оцінки стану. Онлайн-платформи підтримки

забезпечують доступність терапевтичної допомоги. Віртуальна реальність використовується для роботи з образом тіла та тривожністю. Телемедичні консультації розширюють географію надання допомоги.

Динаміка розвитку розладів харчової поведінки характеризується складною взаємодією психологічних механізмів та фізіологічних процесів. Когнітивні викривлення щодо образу тіла та самооцінки формують стійкі патерни дезадаптивної поведінки, які підтримуються через механізми позитивного та негативного підкріплення. Порушення інтероцептивної чутливості призводить до втрати природних сигналів голоду та насичення, замінюючи їх ригідними правилами та ритуалами харчування. Емоційна регуляція через їжу стає домінуючим способом боротьби зі стресом, тривогою та іншими негативними переживаннями. Формування компенсаторних механізмів захисту через контроль харчування створює ілюзію безпеки та передбачуваності у нестабільному емоційному світі підлітку.

Травматичний досвід та порушення прив'язаності в ранньому дитинстві формують підґрунтя для розвитку патологічних харчових патернів. Дисфункційні сімейні системи, характеризовані емоційною холодністю, надмірним контролем або хаотичністю границь, створюють умови для формування порушеного відношення до їжі та власного тіла. Трансгенераційна передача патологічних патернів харчової поведінки через моделювання батьківської поведінки та неусвідомлені сімейні послання закріплює дезадаптивні способи емоційної регуляції. Травматичні події, включаючи фізичне, емоційне або сексуальне насильство, можуть провокувати розвиток розладів харчової поведінки як спроби відновити контроль над власним життям та тілом. Порушення сепарації-індивідуації в підлітковому віці часто виражається через симптоми розладів харчової поведінки [9, с. 76].

Нейробіологічні дослідження розладів харчової поведінки виявляють специфічні зміни у функціонуванні мозкових структур, відповідальних за регуляцію харчування та емоційних станів. Порушення балансу нейромедіаторів, особливо серотоніну та дофаміну, впливає на механізми винагороди та насичення.

Хронічний стрес та травматичний досвід призводять до змін у роботі гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової осі, що впливає на метаболічні процеси та харчову поведінку. Дисрегуляція інсуліну та лептину порушує природні механізми контролю ваги та апетиту. Нейропластичні зміни в структурах мозку, пов'язаних з образом тіла та самосприйняттям, підтримують патологічні когнітивні схеми.

Соціокультурні фактори відіграють значну роль у формуванні та підтримці розладів харчової поведінки через створення нереалістичних стандартів краси та успішності. Медіа-контент, насичений ідеалізованими образами тіла, підвищує ризик розвитку дисморфобічних проявів та патологічного прагнення до худорлявості. Соціальні мережі створюють платформу для порівняння та самокритики, посилюючи негативне самосприйняття та тривогу щодо зовнішності. Культурні норми, що пов'язують контроль над харчуванням з моральними якостями та силою волі, формують дисфункційні переконання щодо їжі та ваги. Гендерні стереотипи та очікування суспільства щодо зовнішнього вигляду створюють додатковий тиск на формування образу тіла [10, с. 86].

Генетичні дослідження розладів харчової поведінки вказують на спадкову схильність до розвитку певних форм патологічного харчування. Поліморфізм генів, пов'язаних з регуляцією нейромедіаторних систем, впливає на ризик розвитку анорексії та булімії. Епігенетичні модифікації під впливом стресу та травматичного досвіду можуть активувати генетичну схильність до розладів харчової поведінки. Взаємодія генетичних та середовищних факторів створює унікальний профіль вразливості для кожного індивіда. Розуміння генетичних механізмів дозволяє розробляти більш таргетовані терапевтичні втручання та профілактичні стратегії.

Висновки розлади харчової поведінки у дітей та підлітків демонструють тісний взаємозв'язок між психологічними чинниками їх виникнення та ефективністю діагностично-корекційних заходів. Комплексне розуміння особистісних, сімейних та соціальних факторів ризику дозволяє розробляти індивідуалізовані терапевтичні програми, що враховують унікальний патерн психологічних проблем кожного пацієнта. Перфекціонізм, низька самооцінка, порушення образу тіла та проблеми емоційної регуляції виступають ключовими

мішенями психотерапевтичної роботи, визначаючи вибір специфічних методів та технік втручання. Діагностичний процес вимагає інтеграції різних методологічних підходів, включаючи стандартизовані опитувальники, проєктивні методики, клінічне інтерв'ю та оцінку сімейної системи.

Ефективність корекційної роботи базується на диференційованому підході до вибору терапевтичних інтервенцій відповідно до виявлених психологічних чинників. Когнітивно-поведінкова терапія, діалектично-поведінкова терапія, сімейна терапія та тілесно-орієнтовані практики демонструють найбільшу ефективність при роботі з різними аспектами розладів харчової поведінки. Інтеграція психоосвітнього компоненту та залучення батьків до терапевтичного процесу підвищують стійкість досягнутих результатів. Міждисциплінарний підхід до лікування розладів харчової поведінки забезпечує комплексність терапевтичних втручань та підвищує їх ефективність. Профілактика рецидивів потребує розробки індивідуальних планів підтримки досягнутих результатів та розвитку навичок самомоніторингу. Ідентифікація тригерів, формування здорових харчових звичок та розвиток адаптивних копінг-стратегій забезпечують довготривалу стабільність терапевтичних досягнень. Групи взаємодопомоги та періодичні підтримуючі сесії створюють додатковий ресурс для підтримки ремісії. Впровадження сучасних технологій, включаючи мобільні додатки для моніторингу стану та онлайн-платформи підтримки, підвищує доступність та ефективність терапевтичної допомоги. Катамнестичні дослідження підтверджують ефективність комплексного підходу до лікування розладів харчової поведінки, що базується на розумінні взаємозв'язку між психологічними чинниками та методами терапевтичного втручання. Аналіз довготривалих результатів терапії дозволяє вдосконалювати існуючі протоколи лікування та розробляти нові підходи до профілактики та корекції розладів харчової поведінки у дітей та підлітків. Координація роботи психологів, психіатрів, дієтологів та інших фахівців забезпечує оптимальні умови для відновлення нормального функціонування пацієнтів та підтримки досягнутих результатів.

Література.

1. Дягилева А. Вплив харчової поведінки на психологічне благополуччя молоді : кваліфікаційна робота. Київ, 2024. 89 с.
2. Левченко О. І. Соціальні чинники розвитку розладів харчової поведінки в підлітків : монографія. Харків : НПУ ім. Г. С. Сковороди. 2023. 156 с.
3. Мохаммад-Драчук К. З. Психологічні чинники психосоматичних захворювань у дітей під час війни. Київ. 2023. 198 с.
4. Писаренко Д. Психологічні особливості жінок з порушенням харчової поведінки та їх корекція. Одеса. 2022. 20 с.
5. Ремесник Н. Ю. Особливості психологічної корекції самоприйняття людей з надмірною вагою / Інститут психології імені Г. С. Костюка. Київ. 2023. 215 с.
6. Рибалка С. Г. Взаємозв'язок структурних параметрів сім'ї з проявами девіацій у підлітків. Харків. 2023. 395 с.
7. Романець Н. О. Вплив тривожності на харчову поведінку студентів : магістерська робота / Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк. 2024. 112 с.
8. Сирбу М. М. Психологічні особливості деструктивної поведінки сучасних школярів : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07. Київ. 2024. 203 с.
9. Танасієнко А. Є. Розлади харчової поведінки в юнацькому віці: психологічний аспект : магістерська робота. Вінниця. 2023. 95 с.
10. Чубарова Н. Психологічні чинники харчової поведінки у юнацькому віці. Психологічний журнал. 2020. № 6. С. 84-93.

1.12. Необхідність дослідження і розвитку стресостійкості особистості як позитивного ресурсу особистості

Ковальчук М.С.

Актуальність. Війна, яка триває в Україні, непередбачуваність змін і шалений темп життя вказують кожному із нас, що бути стійким, стресостійким, берегти своє фізичне і ментальне здоров'я зараз дуже важливо. У сучасних умовах це набуває особливого значення. Дослідження стресостійкості стає все більш важливим у сучасному світі через зростання впливу стресогенних факторів на людину, збільшення їх кількості і накопиченні загальної втоми суспільства. Накопичення відомостей і дослідження у цій сфері знань дає нові перспективи її вивчення. Особливе значення поняттю стресостійкості особистості надає триваючий воєнний стан в Україні. Це має сильний вплив на всі сфери життєдіяльності людини, привносить зміни до її діяльності, світогляду, фізичного та ментального здоров'я кожної особистості. Однак, існують досить різні та навіть протилежні прояви такого навантаження на психіку та поведінку людей. Для однієї частини людей такий фактор стресу несе руйнівні наслідки, призводячи до депресії, погіршення стану здоров'я, хвороби, зниження життєвої мотивації. Водночас для іншої частини людей бойові дії стають поштовхом для пошуку необхідності змін, вдосконалення стресостійкості, зміни свого образу життя, виявлення та укріплення життєстійкості і резильєнтності. Психологічні ресурси особистості визначають подальшу поведінку людини у кризових ситуаціях. Так, постає проблема вивчення діяльності людини в умовах, що швидко змінюються, а також з'являється необхідність дослідження ресурсів стресостійкості особистості, виявлення здатності особистості адаптуватися до складних життєвих обставин і відновлення після подолання труднощів.

Мета. Провести теоретичний аналіз чинників, умов формування та розвитку стресостійкості особистості.

Результати дослідження. Дослідження в царині стресу і стресостійкості проводили такі іноземні вчені, як: Р. Лазарус, Г. Сельє, Б. Сіворд, Ш. Тейлор, С.

Фолкман та ін. Серед українських дослідників, які мають наукові досягнення у вивченні питань стресу і стресостійкості є Л. Наугольник, Л. Карамушка, О. Кравцова, В. Крайнюк, О. Когут, В. Корольчук, Т. Титаренко, О. Чабан та інші. За класичною теорією стресу Г. Сельє, стрес – це стан фізіологічної або психологічної напруги, зумовлений різноманітними чинниками (соматичними, розумовими, емоційними, зовнішніми або внутрішніми, частіше – їх сукупністю), які спрямовані на порушення функцій організму, та яких організм намагається уникнути. Залежно від сили або дози та тривалості дії стресорних чинників стрес-реакція у своєму розвитку може проходити або три послідовні стадії – тривоги, резистентності й виснаження, коли загальний адаптаційний синдром набуває характеру руйнівного процесу (дистресу), або тільки дві перші (тривоги й резистентності), коли формується так званий еустрес (позитивний стрес), що, як стверджував Г. Сельє, сприяє підтриманню та збереженню здоров'я. Стресові навантаження – це повсякденна реальність сучасної людини. Однак, на переконання Г. Сельє уникнути стресових ситуацій не лише не можливо, а й не потрібно, оскільки «стрес – це і є життя, а його відсутність означає смерть» [14].

Стрес може впливати на організм людини як позитивно, так і негативно, у залежності від того, як застосовує «адаптаційний потенціал» та «адаптаційні стратегії». Термін «стрес» у фізіологію та психологію вперше ввів у 1932 році Волтер Бредфорд Кеннон у своїх класичних роботах з універсальної реакції «боротись чи втікати» (англ. *fight-or-flight response*) [9]. Досить часто авторство терміну передають відомому канадському фізіологу Гансу Сельє, проте використовувати саме поняття стрес він почав лише у 1946 році для пояснення загального адаптаційного напруження [11]. Адаптація, як позитивний результат впливу стресу, є його фізіологічною функцією. Стрес, як особливий психофізіологічний стан, забезпечує захист організму від загрозливих та руйнівних фізичних і психічних впливів. Так в організмі розвивається функціональний стан, який характеризується комплексом реакцій гормональної, нервової та інших систем організму. Таким чином, стрес – це нормальна реакція здорової людини, захисний механізм біологічної системи. Окрім цього, стрес є невід'ємною частиною професійної діяльності, і його вплив на робочу діяльність

людини може бути як позитивним, так і негативним, залежно від інтенсивності стресових факторів та здатності особи їх подолати. Надмірний або хронічний стрес, який виникає в умовах безперервних викликів і змін, може значно знизити ефективність особистості, призводячи до емоційного вигорання, зниження мотивації та продуктивності в діяльності, а також погіршення фізичного і психічного здоров'я. Тому для життя людини, її психічного та фізичного здоров'я актуальним і важливим є вміння долати стреси і проявляти життєстійкість. Окрім цього, підвищенню практичної ефективності особи, а також загальній здатності виживання в екстремальних умовах сприяє вивчення та використання засобів активізації мотиваційних ресурсів стресостійкості. Вдосконалення здатності долати стресові ситуації можливе на основі виявлення психологічних ресурсів стресостійкості особистості.

Згідно визначень більшості науковців, стресостійкість розглядається як процес адаптації, тому її пов'язують із емоційною стабільністю та емоційною стійкістю. Так, Р. Шевченко визначає стресостійкість як комплексну властивість особистості, що вирізняється необхідною мірою адаптації до дій в екстремальних ситуаціях, сприяє перенесенню інтелектуальних, вольових й емоційних навантажень, зумовлених особливостями професійної діяльності, без відчуття несприятливих наслідків для роботи, свого здоров'я та здоров'я оточення [7, с. 283]. М. Шпак розглядає стресостійкість як здатність особистості протистояти стресу, чинити опір. Стійкість організму до стресу є корисною захисною функцією, яка дозволяє людині успішно адаптуватися до умов навколишнього середовища, протидіяти негативному впливу зовнішніх і внутрішніх стресогенних чинників [8, с. 201]. Стресостійкість особистості на соціально-психологічному рівні розглядають як збереження здатності до соціальної адаптації; збереження значущих міжособистісних зв'язків; забезпечення успішної самореалізації, досягнення життєвих цілей; збереження працездатності; збереження здоров'я. Основним критерієм стресостійкості людини є рівень її спроможності до пристосування у складному і вимогливому світі [5, с. 56]. Багато психологів вважають, що виникнення і переживання стресу залежить не так від об'єктивних, як від суб'єктивних чинників, від внутрішніх особливостей самої людини: її мотивації, настанов, очікувань, пам'яті про події, оцінки нею ситуації,

порівняння своїх сил і вимог, що висуваються до неї та ін. Тому певна ситуація одними може сприйматися як стресова, а в інших не викликати жодних стресових проявів [2, с. 29].

Довготривала стресова ситуація виснажує та руйнує адаптивні можливості людини, після чого відбувається так званий злам адаптаційного бар'єра. Згідно існуючих нині наукових поглядів, саме стресові механізми лежать в основі виникнення більшості захворювань, при цьому час появи хвороби розподілений не рівномірно, а накопичується навколо певних подій, коли вони сприймаються як такі, що загрожують, надмірно напружують, навантажують, непосильні або такі, що викликають конфлікти. В результаті знижується рівень психологічного здоров'я людини, загострюються хронічні захворювання, знижується працездатність тощо.

Для збереження ментального та соматичного здоров'я важливо з'ясувати об'єм, кількість та види наявних у індивіда ресурсів, що дозволяють зберігати адаптаційні можливості організму. Ресурси – це все те, що людина використовує, щоб задовольнити вимоги середовища (фізичні, психологічні, соціальні ресурси тощо). Успішність подолання складних життєвих ситуацій безпосередньо залежить від розуміння власних ресурсів, вміння їх виявляти, від різноманітності, характеру і міри використання наявних і доступних ресурсів людини. Побачити, розвинути та навчитися ефективно використовувати власні ресурси може допомогти розроблена професором Мулі Лахадом (Mooli Lahad – директор Ізраїльського Центру попередження стресу) та його колегами модель стресодолання «*BASIC Ph*». З погляду авторів цієї моделі потенціал виходу з кризи є у кожного з нас, для цього пропонується відкрити весь спектр особистісних можливостей людини. Ця модель ґрунтується на глибоких теоретичних та емпіричних дослідженнях, а також широко адаптована у психологічній практиці, охоплює весь спектр стилів, шляхів того, як людина може впоратися із стресом і/чи кризою.

Модель «*BASIC Ph*». В 90-х рр. 20 ст. під час роботи з людьми, які живуть в ситуації постійної загрози для життя, М. Лахад та його колеги встановили, що у 20% досліджуваних проявляється ПТСР (Посттравматичний стресовий розлад), інші ж 80

% якимось чином долають травму, зберігаючи при цьому своє здоров'я. Провівши аналіз провідних психологічних теорій «зустрічі людини зі світом», а також здійснивши власний багаторічний емпіричний аналіз, зберігаючи фокус дослідження на цих здорових способах подолання людиною кризових ситуацій, М. Лахад запропонував власну багатовимірну модель «зустрічі зі світом» – модель подолання стресу та пошуку внутрішньої стабільності для людини. Модель «BASIC Ph» – це деякий «міст над прірвою», що допомагає людині «вирости» з кризової ситуації, «з'єднати» її внутрішнє «Я» та зовнішній «Світ» [12]. Було виявлено, що в кожного є своє власне унікальне поєднання ресурсів подолання. Ідея моделі полягає в тому, що в людини існує свій потенціал, досвід у подоланні стресової події в шести модальностях: 1. B – Belief & values – віра, переконання, цінності, філософія життя. 2. A – Affect – вираження емоцій та почуттів. 3. S – Socialization – соціальні зв'язки, соціальна підтримка, соціальна приналежність, спілкування. 4. I – Imagination – уява, мрії, спогади, творчість. 5. C – Cognition, thought – розум, пізнання, когнітивні стратегії. 6. Ph – Physical – фізична активність, тілесні ресурси.

Belief & values – цей спосіб подолання кризи базується на вмінні вірити: це може бути віра в Бога, в людей чи в самого себе. Існування в нашому житті сенсовної наповненості, системи життєвих цінностей, місії, віри є джерелом, з якого людина може почерпнути сили у складних ситуаціях.

Affect – цей спосіб подолання стресу вимагає від нас, перш за все, навчитися розуміти власні почуття, називати їх своїми власними іменами. Після цього з'являється можливість висловити розпізнані почуття найбільш прийнятними для кожної людини способами: словесно – в особистій розмові, письмово – в листі, без слів – в танці, малюнку, музиці чи драмі. Йдеться про пряме чи опосередковане вираження почуттів: наприклад, записувати в щоденник свої почуття, висловлювати їх у будь-який арт-спосіб (малюнок, спів, інструментальна музика) тощо.

Socialization – даному способу стресодолавання притаманне прагнення до спілкування, звернення за підтримкою до сім'ї, близьких людей чи до кваліфікованих спеціалістів. Суть способу полягає у соціальній включеності,

можливості бути серед людей, бути чимось корисним, почувати себе частиною системи, організації тощо.

Imagination – цей спосіб подолання стресу апелює до наших творчих здібностей, креативної сторони нашої особистості. Завдяки уяві ми можемо мріяти, розвивати інтуїцію та пластичність, шукати і знаходити рішення у світі гри та фантазії, уявляти собі змінене майбутнє та минуле, навіть спогади про щасливі моменти здатні зменшити інтенсивність переживань у складних ситуаціях «тут і тепер». Сюди також відноситься почуття гумору, імпровізація, мистецтво та різного роду ремесла.

Cognition – спосіб подолання кризи через звернення до наших ментальних здібностей, до нашого вміння логічно та критично мислити, оцінювати ситуацію, пізнавати та осягати нові ідеї, планувати, навчатися, збирати достовірну інформацію, аналізувати проблеми та вирішувати їх. Сюди ж належить пріоритетність, альтернатива, делегування та саморефлексія (розмова з самим собою).

Physical – спосіб стресодолавання, що передбачає звернення до фізичної активності нашого тіла. Цей спосіб пов'язаний із такими можливостями нашого фізичного тіла, як здатність відчувати себе завдяки слуху, зору, нюху, дотику, смаку, відчуттю тепла та холоду, болі та задоволення, орієнтації на місцевості, внутрішньої напруги чи розслаблення. Він також включає в себе різного роду фізичні навантаження (зарядка чи виконання фізкультурних комплексів, ходьба, прогулянка на природі, походи в гори тощо) та тілесні практики (релаксаційні техніки, дихальні вправи тощо).

Так, у кожної людини є шість каналів подолання стресу, при цьому, з них домінуючими є лише кілька. Важливо пам'ятати, що немає правильного чи неправильного з вищеописаних, кожен має свої переваги та недоліки. З огляду на це, важливо розуміти свої сильні сторони і розвивати слабкі (пасивні) канали, тим самим посилюючи і збагачуючи свої ресурси. При цьому, щоб поновити та збільшити сили та ресурси в ситуаціях, коли людина «вибита з колії» та втратила ґрунт під ногами, варто осмислити вже ті частини наших ресурсів, що є в наявності

та зосередитися на ефективному їх використанні. Якщо ж людина відчуває себе у «глухому куті», варто звернутися до тих частин, які поки що не проявлені чи дуже слабкі [4]. Відповідно, основною умовою збереження психологічного здоров'я є готовність особистості до творчого конструювання власного життя. Засобом відновлення психологічного здоров'я має стати соціально-психологічна реабілітація як комплексний процес активізації життєтворення та підвищення суб'єктивного благополуччя. Здатність особистості керувати власним життям базується на відновленні її готовності до самотрансформацій та реалізації оновлених проєктів майбутнього в сімейній, особистій, професійній сферах. Реабілітація передбачає варіативність інтервенцій з урахуванням життєвої історії особистості, її ресурсів та характеру травми, можливостей відновлення частково втрачених функцій, запобігання ускладненням [6, с. 60].

Висновки. Аналіз наукової літератури про форми проблем стресу та їх вплив на життя і діяльність людини показує, що існують різноманітні наукові методи та моделі феномену стресу, а також регуляції його виникнення об'єктивними та суб'єктивними причинами (стресорами). Позитивний або негативний вплив на функціонування різних структур людського організму, впливаючи на особистість, поведінку, інтелектуальний та емоційний розвиток індивіда, а в довготривалих ситуаціях – призводячи до необоротного погіршення здоров'я. Хоча встановлено, що ступінь реакції на стресори може коливатися від слабкої до сильної, зокрема в залежності від індивідуальних і типових якостей, ми вважаємо за доцільне продовжити пошук ефективних методів профілактики та стратегій зниження стресу. і успішно долати реакцію на стрес для підтримки розумової, психологічної та фізичної стабільності організму.

Формування та розвиток стресостійкості сприяє розвитку адаптаційних реакцій, що, у свою чергу, підвищує індивідуальну працездатність і сприяє зниженню ризику психосоціальних проблем. Стійкість до стресу включає такі навички, як емоційний інтелект, планування, гнучке прийняття рішень та ефективне спілкування. Ці навички допомагають людям адаптуватися до складних обставин і підтримувати продуктивне життя. Крім того, стресостійкість також

можна тренувати та покращувати. Ми бачимо перспективу для подальших досліджень щодо розробки корекційних підходів, спрямованих на розвиток особистих ресурсів подолання негативних наслідків стресу.

Стресостійкість, як здатність особистості ефективно реагувати на стресові ситуації, зберігаючи при цьому психічне та фізичне здоров'я, є критично важливою у контексті триваючого війни в Україні, швидко змінюваного соціального середовища, чисельних викликів суспільства.

Основною умовою збереження психічного здоров'я є бажання особистості творчо будувати власне життя. Засобом виходу із складних стресових ситуацій є реабілітаційний процес, який сприяє активізації життєтворчості та підвищує рівень суб'єктивного щастя та успішності особистості, сім'ї, а також у професійній діяльності. Забезпечити ефективність відновлення стає можливим завдяки поетапному включенню ресурсних надбань, реабілітаційних заходів, залученням спільнот та експертів різного профілю.

Література.

1. Кокун О. М. Психологія професійного становлення сучасного фахівця: монографія. К.: ДП «Інформ.- аналіт. Агентство. 2012. 200 с.
2. Наугольник Л.Б. Психологія стресу: підручник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ. 2015. 324 с.
3. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Том 2, Видавець Organization for Security and Co-operation in Europe <https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/430829>
4. Ресурсоорієнтована модель стресодолання BASIC Ph. <https://arpp.com.ua/blog/resursooriyentovana-model-stresodolannya-basic-ph/>
5. Титаренко Т. М. Профілактика порушень адаптації молоді до повсякденних стресів і кризових життєвих ситуацій: навч. посіб. / Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології; за наук. ред. Т. М. Титаренко. К.: Міленіум. 2011. 272 с.
6. Титаренко Т. М. Технології відновлення психологічного здоров'я особистості в умовах війни: комплексний підхід. Наукові студії із соціальної та

політичної психології. 2019. Вип. 43. С. 54–62.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nsspp_2019_43_8.

7. Шевченко Р. М. Стресостійкість як чинник професійної діяльності жінок-управлінців: структурнокомпонентний аналіз. Актуальні проблеми психології. Т. IX, вип.10. 3б. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 2020. С. 280–287.

8. Шпак М. М. Стресостійкість особистості в дискурсі сучасних психологічних досліджень. Габітус. Гельветика, 2022. Вип. 39. С. 199–203. DOI : <https://doi.org/10.32843/2663-5208>.
<http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27825>.

9. Cannon, W. B., The wisdom of the body. New York: W. W. Norton, 1932.

10. Folkman, S., Moskowitz, J. Tedlie Stress, Positive Emotion, and CopingView. Current Directions in Psychological Science. 2000. Volume 9, Issue 4, P.115– 118. <https://doi.org/10.1111/1467-8721.00073>

11. Jerry Kennard, Ph.D. (A Brief History of the Term «Stress». 2018.

12. Lahad, M., &Leykin, D. (2013). The Integrative Model of Resiliency –The «BASIC Ph» Model, or What Do We Know about Survival? The «BASIC Ph» Model of Coping and Resiliency Theory, Research and Cross-Cultural. London, UK and Philadelphia, USA: Jessica Kingsley, 11–32.
https://books.google.com.ua/books/about/The_BASIC_Ph_Model_of_Coping_and_Resilience.html?hl=uk&id=bo8jLOiNL3sC&redir_esc=y

13. Lazarus, Richard S., Folkman, S. Stress, Appraisal, and Coping. Springer Publishing Company NY, 1984. 456 p.
<https://www.scirp.org/reference/ReferencesPapers?ReferenceID=1927117>

14. Selye, H. Stress without Distress. Philadelphia, PA: Lippincott. 1974. 178 p.
<https://www.scribd.com/document/442108406/Hans-Selye-Stress-Without-Distress-Lippincott-Williams-Wilkins-1974-pdf>

1.13. Психічне здоров'я працівників організації в умовах війни

Лозовська О. В.

Актуальність. Війна та збройні конфлікти завжди залишають глибокий слід на людському житті, впливаючи не тільки на фізичний стан, але й на психічне здоров'я. В умовах збройного конфлікту значні психоемоційні стреси переживають не тільки військовослужбовці, але й цивільні особи, включаючи працівників різних організацій. Військові дії суттєво змінюють умови роботи, посилюють тиск та вимоги до психоемоційної стійкості працівників.

Працівники організацій під час війни можуть стикатися з багатьма викликами: від нестабільності на робочому місці до загрози власному життю та життю своїх близьких. Постійний стрес, тривога за безпеку, необхідність адаптації до нових умов роботи та соціальні обставини створюють додатковий тиск, який може призводити до психічних розладів.

Термін «психічне здоров'я» було вперше використано у 1979 році на засіданні Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Відповідно до термінології ВООЗ «психічне здоров'я – це такий стан добробуту, що визначається здатністю людини реалізовувати власні здібності, долати щоденні стреси, плідно працювати та робити внесок у життя суспільства»[13].

Також ВООЗ визначає основні критерії психічного здоров'я, особистості, серед яких [1]: постійність переживань своєї ідентичності; постійність реакцій в схожих ситуаціях; можливість адаптуватися до стресу та адекватно реагувати відповідно до інтенсивності зовнішніх обставин, стимулів та подразників; здатність планувати свою діяльність та втілювати плани в життя; здатність керувати своєю поведінкою та слідувати соціальним нормам; можливість адекватної критичної оцінки себе та своєї діяльності.

Тобто, коли говорять про психічне здоров'я, йдеться не лише про відсутність психічних захворювань, психічних розладів та межових станів, які суттєво впливають на життєдіяльність особистості і те, як вона почувається, думає та

поводиться, а й про оптимальний рівень перебігу психічних процесів, за якого людина може бути повноцінно включеною в суспільство.

Мета. Дослідити теоретичні аспекти психічного здоров'я працівників організації в умовах війни

Результати дослідження. У науковій літературі поряд із дефініцією «психічне здоров'я» використовують такий термін як «ментальне здоров'я». Щоб зрозуміти відмінність чи схожість понять, слід проаналізувати семантичне наповнення слова «ментальний». Енциклопедія сучасної психології визначає досліджуваний нами термін як «поняття, що належить до сфери мислення, способу світосприйняття, духовної настроєності, притаманний індивіду або групі; означає душевний або психічний» [3]. Практичні психологи визначають ментальне здоров'я як стан організму людини, що дозволяє повноцінно виконувати всі його функції. Це відчуття рівноваги всередині себе, а також між собою та фізичним і соціальним середовищем, коли людина може ефективно давати раду стресовим ситуаціям, продуктивно працювати, робити внесок в громадське життя, а також розуміти власний емоційний стан і керувати ним, усвідомлювати інших та розвивати з ними стосунки, бути відкритою до навчання та розвитку. Тобто психічне і ментальне здоров'я фактично є словами синонімами.

Втім, варто зазначити, що заміна поняття «психічне здоров'я» на термін «ментальне здоров'я» може сприяти стигматизації людей, що зіштовхнулися з психічними розладами або хворобами. Не зважаючи на той факт, що в останні десятиліття у світі та в останні роки в Україні увага до проблем психічного благополуччя значно підвищилася, втім все ще існує стигматизія тих, хто переживає психічні порушення здоров'я. Це пояснюється низькою психоедукацією пересічних громадян, які не розрізняють значення понять «психічний розлад», «психічна хвороба», «психічний стан», «психологічне здоров'я», а термін «психічне» пов'язують виключно зі значними відхиленнями та небезпекою. Таким чином, замінюючи поняття «психічне здоров'я» на «ментальне здоров'я», що зокрема є запозиченим з іноземної літератури (*mental health*), відбувається зсув у бік стигматизації всього, що пов'язане із терміном «психіка».

Вітчизняні психологи Карамушка Л. і Дзюба Т. визначають психічне здоров'я як «інтегральну характеристику повноцінного функціонування всіх психічних структур індивіда (рівень і якість мислення, розвиток пам'яті й уваги, ступінь емоційної стійкості, розвиток вольових якостей), що забезпечують відчуття суб'єктивного психічного комфорту, здатність до осмисленої діяльності та адекватні форми поведінки» [8, с. 26].

Цілісний підхід до психічного здоров'я особистості також пропонує біопсихосоціальна модель, в якій біологічні, психологічні та соціальні чинники перебувають в постійному взаємозв'язку. Таку модель часто застосовують для роботи з людьми, які зіштовхнулися з психічними розладами, з метою виявлення тих факторів, які могли слугувати причиною виникнення розладу, а також задля пошуку ресурсу для його подолання.

Науковці виокремлюють три сфери впливу на психічне здоров'я [10]: – біологічну (фізіологічне та психічне здоров'я з точки зору функціонування мозку та нервової системи – цим займаються лікарі); – психологічну (індивідуальні психічні особливості – сфера роботи психологів та психотерапевтів); – соціальну (взаємовідносини особистості з іншими людьми – залежить як від факторів соціальної групи, до якої відноситься людина, так і від індивідуальних здібностей будувати стосунки).

Державний вісник з питань ментального здоров'я США [14] підкреслює, що психічне здоров'я поєднує в собі емоційну, психологічну та соціальну складові. Тобто добре психологічне самопочуття (*psychological well-being*) людини безпосередньо залежить від функціонування її психіки.

Сьогодні у психологічній науці поняття «психологічне здоров'я» активно використовується поряд із терміном «психічне здоров'я». Тому є необхідність розмежування основних характеристик цих визначень.

У західній парадигмі термін «хороше психологічне самопочуття» (*psychological well-being*) характеризує міжособові та внутрішньоособові рівні позитивного психологічного функціонування, які можуть включати в себе близькі відносини з іншими людьми, адекватну самооцінку, визначену систему ціннісних

орієнтирів та установок, діючи у відповідності до яких людина зберігає внутрішню гармонію та здатна до особистісного росту.

У східній парадигмі еквівалентом терміну «хороше психологічне самопочуття» слугує введене Дубровіною І. поняття «психологічне здоров'я» [2]. За її визначенням психологічне здоров'я є більш ширшим поняттям, ніж психічне здоров'я, та характеризується не тільки оптимальним рівнем психічного здоров'я, але й характеризує людину у її цілісності. Вона зазначає, що «психологічне здоров'я передбачає інтерес людини до життя, свободу думок та ініціативу, активність і самостійність, відповідальність і здатність до ризику, віру в себе та повагу до іншого, здатність до сильних почуттів і переживань, усвідомлення своєї індивідуальності, творчість у самих різних сферах життя і діяльності» [2].

Ряд вчених (Іщук І., Кузьмінський В. Нікіфоров Г., Приходько В.) у своїх напрацюваннях оперують поняттям «психологічне здоров'я» та наводять наступні його характеристики: 1. Гармонійне поєднання та здатність до інтеграції особистістю своїх різних рис та якостей. 2. «Включеність» в життя та здатність переживати життєві події тут і зараз. 3. Здатність до адекватної оцінки навколишньої дійсності та прийняття рішень відповідно до неї. 4. Конгруентні реакції на зовнішні події. 5. Ефективні механізми психологічних захистів задля збереження власної цілісності.

Сучасні українські дослідники (Серьогін С. , Соколовський С.) доходять думки, що психологічне здоров'я особистості ґрунтується на двох основних здатностях [12]: – дотримання діалектичного (серединного) шляху у різних сферах діяльності, що припускає наявність психічної рівноваги та стійкості. При цьому, така «золота середина» є індивідуальною для кожної людини в залежності від її типу нервової системи, темпераменту, характеру тощо; – можливості адаптації – соціальної, соціально-психологічної та інтрапсихічної. Це означає, що людина здатна успішно пристосовуватися до зовнішніх умов, людей та власних особливостей.

Карамушка Л. зазначає, що у вітчизняній психологічній науці та практиці дефініцію «психічне здоров'я» здебільшого використовують під час вивчення

індивідуумів, які мають різні психічні захворювання, а термін «психологічне здоров'я» – до характеристики практично здорових осіб [11, с. 56].

Як було зазначено вище, фізіологічне та емоційне самопочуття, задоволеність соціальними стосунками є складовими психічного здоров'я особистості. Окрім цього, ці складові як впливають на стан психічного здоров'я, так і залежать від нього. Такий взаємозв'язок може бути накладений і на робочу сферу: від того як людина почувається залежать її продуктивність, ефективність та мотивація до праці. Наприклад, стресове навантаження, робота в екстремальних умовах, в понаднормовий час будуть створювати психологічний дискомфорт, який за умови постійності та перманентності може вплинути на психічне здоров'я. І, навпаки, з субоптимальним рівнем психічного здоров'я пов'язують виникнення таких істотних проблем для бізнесу як [4]: 1) Вигорання працівників – інтелектуальне, фізичне та емоційне виснаження. 2) Презентеїзм – фактична присутність на роботі, проте невиконання працівником своїх безпосередніх робочих задач у зв'язку з поганим самопочуттям, зокрема, пов'язаним зі станом психічного здоров'я. 3) Абсентеїзм – відсутність на роботі з причин захворювань, у тому числі, – психічних розладів. 4) Лівеїзм – використання вільного від роботи часу, вихідних та відпусток для вирішення робочих задач, що з часом призводить до вигорання. 5) Втрата працездатності чи навіть самогубство у зв'язку з робочими питаннями.

Осмислення проблеми психічного здоров'я та пошук шляхів її вирішення є однією із важливих завдань для психологів. Так, згідно з даними Bureau of Labor of Statistics on occupational fatalities (США), 304 особи у 2018 році скоїли суїцид через проблеми на роботі, що на 11% більше ніж у 2017 році та на 26% більше ніж у 1995, коли цей показник вперше почали вимірювати. Причинами накладення на себе рук в ході розслідувань були названі невтримуване робоче навантаження, булінг на робочому місці, сексуальні домагання тощо.

В Україні, згідно з офіційними документами, ця проблема є вкрай загостреною. В «Концепції розвитку охорони психічного здоров'я в Україні на період до 2030 року» (схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України в

2017 р.) зазначається, що станом на 1 січня 2017 р. 1,7 млн. жителів України перебували на обліку у зв'язку з розладами психіки та поведінки, зокрема 694 928 жителів (або 3,9 відсотка населення) – внаслідок розладів, пов'язаних із вживанням алкоголю та наркотиків. За 2016 рік до закладів з надання психіатричної допомоги було госпіталізовано 182 415 хворих, які перебували в середньому 53,4 дня у стаціонарі. На кінець 2016 року в Україні 261 240 хворих на психічні розлади мали групу інвалідності, з них 8,5 % є дітьми у віці до 17 років. Смертність населення України від навмисного самоушкодження у 2015 році становила 17,7 на 100 тис. населення [11, с. 32].

Так, можна зробити висновок, що психічне здоров'я є основою для функціонування людини, зокрема, її реалізації у соціумі та діяльності, а наведені вище критерії психічного здоров'я вказують на прямий зв'язок між станом особистості та її здатністю до самореалізації, до якої безпосередньо відноситься можливість ефективно та продуктивно працювати [4].

ВООЗ також зазначає, що зокрема психічне здоров'я залежить від низки соціально-економічних та таких, що відносяться до оточуючого середовища, факторів, при цьому, одним з напрямків захисту ментального здоров'я вважається розробка програм по зміцненню психічного здоров'я на робочих місцях [13].

Отже, не тільки стан психічного здоров'я кожного окремого індивіда впливає на його здатність продуктивно та ефективно працювати, а правильною є також зворотна констатація – створені умови роботи є одним з факторів впливу на індивідуальне психічне здоров'я.

Проблематика профілактики психічного здоров'я працівників організації залишається сьогодні однією із актуальних як в діяльності окремих організацій, так і у функціонуванні суспільних інститутів загалом. Адже стрес та психічні розлади, які потенційно можуть бути викликані виконанням низки професійних завдань, мають прямий вплив на зниження продуктивності та ефективності праці спеціаліста, зменшення його мотивації до трудової діяльності, а також опосередковано впливають на підвищення плинності кадрів в межах однієї організації, зниження лояльності до компанії, передчасний вихід на пенсію та ін.

Стандарти психічного здоров'я за міжнародними нормами поєднують в собі такі елементи: інтелект, соціальна поведінка, культура харчування, виважений рівень емоційності, відповідальне ставлення до свого фізичного та психічного здоров'я, достатній набір моральних якостей, гнучкість, логічність мислення, сексуальність, цілеспрямованість.

На державному рівні виділяють низку проблем психічного здоров'я в Україні. Серед них наступні: низький рівень поінформованості суспільства щодо культури збереження психічного здоров'я людини; недосконалість національного законодавства; відсутність дієвої системи профілактики психічних розладів людини; недосконалість регулювання діяльності у сфері охорони психічного здоров'я; низький рівень кадрового забезпечення галузі; надмірна зосередженість допомоги у сфері психічного здоров'я у спеціалізованих закладах охорони здоров'я та інтернатних закладах системи соціального захисту; низька доступність психологічної та психотерапевтичної допомоги; дефіцит служб, які б базувалися на рівні територіальних громад, реабілітаційних і соціальних послуг; відсутність ефективного адміністрування та моніторингу та ін. [9].

Все вище викладене дає підстави до визначення низки соціально-психологічних чинників, що мають опосередкований вплив на стан психічного здоров'я працівника в організації в умовах війни. Психологи визначають ключові фактори, які можуть впливати на психічне здоров'я працівників в умовах війни та невизначеності [5, 6, 7]: 1) стрес від перевантаження та стислих строків: постійний тиск через велику кількість завдань та брак часу на їх виконання може призводити до хронічного стресу; 2) стрес і тривога: постійна загроза та нестабільність можуть викликати тривогу, депресію та посттравматичний стрес; 3) втрата близьких: втрата рідних та друзів може призвести до глибокого емоційного болю та депресії; 4) втрата житла та звичних умов життя: небезпечні умови життя та недостатнє житло можуть погіршити психічне здоров'я; 5) недостатня підтримка та брак зворотного зв'язку від керівництва: відсутність емоційної підтримки та оцінки роботи працівника може призвести до почуття ізольованості та зниження мотивації; 6) незбалансованість роботи та особистого життя: сучасні технології

дозволяють бути на зв'язку 24/7, що часто розмиває межу між робочим часом та особистим життям; 7) недоступність медичних послуг: Відсутність доступу до медичних послуг та психологічної підтримки може призвести до погіршення психічного здоров'я; 8) проблеми з економічною безпекою: втрата роботи та економічна нестабільність можуть призвести до стресу та депресії.

Усі, перераховані вище фактори можуть впливати на психічне здоров'я працівників різними способами. А, отже, важливо забезпечити працівникам необхідну підтримку та допомогу. Наведені нижче рекомендації зможуть допомогти покращити психічне здоров'я працівників під час війни.

Слід приділяти значну увагу підтримці емоційного здоров'я своїх працівників. Бажано запровадити регулярні сеанси психологічної підтримки, індивідуальні та групові консультації. Також, можна організувати роботу груп підтримки, де працівники можуть обговорювати свої почуття та переживання.

Однією з ключових потреб особистості є потреба у безпеці. Тому керівництву як країни в цілому, так і конкретного підприємства у першу чергу слід потурбуватися про забезпечення зовнішньої та внутрішньої безпеки працюючих. На підприємствах має бути у працівників доступ до надійних джерел інформації про безпеку. Також розроблені і впроваджені чіткі інструкції щодо дій у випадку небезпеки. Забезпечить доступ до ресурсів з психічного здоров'я гарячі лінії та інші онлайн-ресурси.

Висновки. Сьогодні важливим є дотримання гнучкого графіку роботи працівників підприємства. Це теж один із засобів профілактики вигорання та забезпечення психічного здоров'я особистості. Бажано, якщо є така можливість на підприємстві, дозволити працівникам працювати дистанційно або за гнучким графіком. Така практика дозволить працівникам збалансувати роботу та особисте життя. Важливо створити підтримуючу та безпечну робочу атмосферу, де працівники відчують, що їхні потреби та благополуччя враховуються. Це допоможе зберегти мотивацію та підвищити продуктивність навіть у складних умовах війни.

Не слід нехтувати й фізичною активністю та активним відпочинком. Бажано заохочувати працівників брати перерви для фізичних вправ та релаксації, організовувати спортивні або релаксаційні заходи, такі як йога або медитація тощо. Насамкінець, гасло «навчання впродовж життя» й в умовах війни не втратило своєї актуальності. Запровадження тренінгів з управління стресом та розвитку навичок адаптації, стимулювання професійного розвитку і навчання новим навичкам, – все це з рештою буде мати позитивний вплив не лише на психічне здоров'я працівників, а й посприє формуванню їх конкурентоспроможності особистості на ринку праці. Варто підкреслити, що підтримка психічного здоров'я працівників під час війни є надзвичайно важливою. Впровадження заходів для зменшення стресу, забезпечення емоційної підтримки, створення безпечних умов роботи та забезпечення доступу до необхідних ресурсів допоможуть зберегти мотивацію та працездатність працівників. Організації мають бути гнучкими та чуйними до потреб своїх співробітників, щоб забезпечити їхнє благополуччя в умовах надзвичайних ситуацій.

Література.

1. Василевська О. І. Психічне здоров'я особистості. Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету : зб. наук. пр. зв.-наук. конф. (9–10 лютого 2013 року) / укл. Волинка Г. І., Уваркіна О. В., Ємельянова О. П. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. С. 289–291.
2. Дубровіна І. В. Психічне та психологічне здоров'я у контексті психологічної культури особистості. Вісник практичної психології освіти. 2009. № 3. С. 17–21.
3. Енциклопедія практичної психології. <http://psychologis.com.ua/>
4. Євтушенко І. В., Лозовська О. В. Методологічні підходи до вивчення проблеми психічного здоров'я особистості в організаційній психології. Особистість у сучасному соціопсихологічному вимірі : монографія / за заг. ред. Г. А. Пріба, Є. М. Калюжної; колектив авторів. Херсон : Олді+, 2022. С. 35–49.
5. Карамушка Л. М. Психічне здоров'я особистості під час війни: як його зберегти та підтримати: Метод. рекомендації. Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2022. 52 с.

6. Карамушка Л.М. Психічне здоров'я особистості в умовах війни: як його зберегти та підтримати: методичні рекомендації. Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2024. 48 с.

7. Карамушка Л.М. Психічне здоров'я персоналу організацій в умовах війни : Навч.-методичний посібник. К.: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2023. 125 с.

8. Карамушка, Л., Дзюба, Т. Феномен «здоров'я» як актуальний напрям досліджень в організаційній психології. Організаційна психологія. Економічна психологія. 2019. № 1(16). С. 22–33. <https://doi.org/10.31108/2.2019.1.16.2>.

9. Концепція розвитку охорони психічного здоров'я в Україні на період до 2030 року. Схвалено розпорядженням Кабінет Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1018-р. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1018-2017-p#n8>.

10. Не діагнозом єдиним або що означає біопсихосоціальна модель допомоги для українців? Mental Health For Ukraine. <https://www.mh4u.in.ua/shukayu-dopomogu/ne-diagnozomyedynym-abo-shho-oznachaye-biopsyhosoczialna-model-dopomogydlya-ukrayincziv/>

11. Психолого-організаційні детермінанти забезпечення психологічного здоров'я персоналу освітніх організацій в умовах соціальної напруженості: монографія / Л. М. Карамушка, О. В. Креденцер, К. В. Терещенко та ін.; за ред. Л. М. Карамушки. Київ – Львів : Видавець Вікторія Кундельська, 2021. 278 с.

12. Серьогін С. М., Соколовський С. І., Шипко А. Ф. Психічне здоров'я як фактор ефективності професійної діяльності державного службовця: зарубіжний досвід. <http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2009-02/09ssmszd.pdf>

13. Mental Health: Strengthening Our Response: 30 March 2018. World Health Organization. <https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/mental-health-strengthening-our-response>.

14. What is Mental Health? 28 May 2020. <https://www.mentalhealth.gov/basics/what-is-mental-health>.

1.14. Здолання дезадаптації як чинник професійного розвитку осіб, які працюють в умовах підвищеної стресогенності

Ланінська Т.В.

Актуальність. Вивчення проблеми професійної дезадаптації та розвитку синдрому професійного вигорання серед середнього медичного персоналу (СМП), які працюють в умовах підвищеної професійної стресогенності з військовослужбовцями та ветеранами набуває підвищеної актуальності. Питання професійної дезадаптації та питання професійного вигорання особистості досліджували В.В. Бойко, Дж. Грінберг, Т.В. Зайчикова, Л.М. Карамушка, С. Д. Максименко, А. Хартман, Н.В. Чепелева та інші. Відомо, що дезадаптація людини це деструктивний руйнівний патологічний процес, який породжує та змінює поведінку людини у суспільстві. Дезадаптуючим є такий перебіг внутрішньопсихічних процесів і поведінки особи, що призводить до її поглиблення, а не розв'язує проблемну ситуацію, посилює труднощі і ті неприємні переживання, які вона викликає. Науковці зазначають, що стан дезадаптації виникає внаслідок дії стресів на особистість. Внаслідок дії стрес-факторів на особистість порушуються її адаптивні структури та виникає стан дезадаптації. Основними проявами дезадаптації будуть – порушення фізичного та психічного здоров'я індивіду, що відобразиться на зниженні його працездатності та робочій ефективності, погіршенні взаємозв'язків з робочим та близьким оточенням, зниженні загальної самооцінки та власне сприйняття себе як особистості [1-3]. Доведено, що дезадаптація має фізіологічний і патологічний характер. Фізіологічна проявляється відхиленою поведінкою, суб'єктивними хвилюваннями, які пов'язані з слабкою соціалізацією, різкою зміною умов існування, руйнуванням інтерперсональних зв'язків. Дезадаптація може мати і патологічний характер.

Психічна адаптація має безпосереднє відношення до аналізу особливостей функціонального стану осіб, що здійснюють діяльність у надзвичайних ситуаціях, а також осіб, які переживають їх наслідки [1, 2]. Проведені за останні десятиліття дослідження довели реальність існування такого явища, як «синдром

професійного вигорання». По суті своїй прояви професійного вигорання дуже схожі на стан хронічного стресу і психічного перевантаження, і його ядром є емоційне виснаження особистості. Термін «професійне вигорання» вперше використав американський психіатр Х. Дж. Фрейденбергер для позначення психічного стану здорових людей, які постійно перебувають у емоційно перенавантаженій атмосфері зв'язку з тим, що їх професійна діяльність вимагає інтенсивного спілкування [4]. Можна зазначити про відсутність достатньої кількості досліджень у вітчизняній психології з питань професійної дезадаптації, синдрому професійного вигорання в умовах підвищеної професійної стресогенності серед середніх медичних працівників.

Мета. Дослідити окремі закономірності професійної дезадаптації та синдрому професійного / емоційного вигорання у середнього медичного персоналу, які працюють в умовах підвищеної професійної стресогенності.

Результати дослідження. На сьогодні СМП це самостійна галузь охорони здоров'я, з досить вираженими функціональними обов'язками як з реабілітації хворих, так і з підвищенням якості їх лікування. Робочий день середнього медичного працівника це спілкування з людьми, загалом, хворими, які потребують щохвилинної уваги і турботи. СМП стають свідками постійних страждань людей, прагнуть зрозуміти кожного, як унікальну особистість. Стикаючись з негативними емоціями медичний працівник мимоволі втягується в них, в силу чого починає відчувати і переживати підвищену емоційну напругу.

Саме напруженість праці, перевантаження являються основними компонентами розвитку та формуванню професійної дезадаптації та синдрому професійного вигорання: професійна вибірковість сприйняття у процесі виконання професійної діяльності, що виділяє з навколишнього світу значущі, з точки зору професіонала, властивості і сторони. Удосконалення та розвиток професійно важливих якостей: формується компенсаторне професійне пристосування, що дозволяє успішно виконувати роботу навіть при зниженні показників деяких функцій (наприклад, якого-небудь аналізатора); відбувається усвідомлення і оцінка тих психічних особливостей, які необхідні для успішної роботи; психічні

властивості і процеси набувають «парціальність» і по-різному проявляються при вирішенні професійних і непрофесійних завдань; оволодіння саморегуляцією професійної діяльності впливає на прояв властивостей нервової системи і темпераменту; рішення типових завдань протягом багатьох років не тільки вдосконалює професійні знання, вміння та навички, а й формує професійні звички, певний склад мислення і стиль спілкування, професійні стереотипи; розвиток професійних деформацій (може відбуватися на різній стадії професіоналізації), як зміна сформованої структури діяльності й особистості, які чинять негативний вплив на продуктивність праці, а також на розвиток самої особистості [5]. Професійна деформація розвивається поступово, виростаючи з професійної адаптації, яка є необхідною для медичного працівника. Адаптація до нових, а тим більше до екстремальних умов, досягається ціною витрат функціональних резервів організму за рахунок так званої біосоціальної плати (Жукова, 1990). Реакція організму на зовнішні і внутрішні впливи протікає залежно від сили чинника, часу його впливу і адаптаційного потенціалу організму, який визначається наявністю функціональних резервів. Порушення регуляторних процесів призводить спочатку до функціональних, а потім і до морфологічних змін в організмі, що свідчить про розвиток хвороби [6, 7].

Середній медичний персонал постійно має справу зі смертю і стражданнями інших людей, і в багатьох інших випадках для нього існує проблема «невключення» своїх почуттів в ситуацію, що йому далеко не завжди вдається [8]. Природно, що тільки емоційно зріла, цілісна особистість в змозі вирішувати ці завдання і справлятися з подібними труднощами. Існує індивідуальна межа можливостей емоційного «Я» протистояти виснаженню, протидіяти «згорянню» та професійній деформації.

Медпрацівник середньої ланки, на початку своєї професійної кар'єри дуже бурхливо переживає професійні події, (страждання, операції, смерть), поступово розвивається певна емоційна опірність. Професійна дезадаптація найчастіше стає «поведінковою моделлю» під впливом звички та проявляється як черствість по відношенню до хворих в такій мірі, що у оточуючих створюється враження

бездушності і цинізму. Різні стресові впливи, які чинять негативний вплив на психофізичне здоров'я і ефективність діяльності фахівців медичної сфери, неможливо розглядати без синдрому вигорання.

Згідно з визначенням ВООЗ, синдром вигорання (burnout syndrome) – це фізичне, емоційне або мотиваційне виснаження, що характеризується порушенням продуктивності в роботі і втому, безсонням, підвищеною схильністю соматичних захворювань, а також вживанням алкоголю або інших психоактивних речовин і (в багатьох випадках) суїцидальною поведінкою. Цей синдром розглядається як довготривала стресова реакція, яка виникає в результаті впливу на людину хронічних професійних стресів середньої інтенсивності. В даний час існує кілька моделей вигорання. Згідно однофакторній моделі, вигорання – це стан фізичного, емоційного і когнітивного виснаження, викликаного тривалим перебуванням в емоційно перевантажених ситуаціях. Фактор виснаження розглядається тут в якості головної причини (компоненту), а інші прояви дисгармонії переживань і поведінки вважаються наслідками [9]. Поняття «вигорання» зазвичай використовується для позначення пережитого людиною стану фізичного, емоційного та психічного виснаження, що викликається його тривалим знаходженням в професійній ситуації, пов'язані з особливими емоційними навантаженнями. Враховуючи мультикомпонентність такого стану, діагностується як синдром вигорання і розглядається як відповідна реакція на тривалі професійні стреси міжособистісних комунікацій, що включає в себе три компоненти: емоційне виснаження; деперсоналізацію; редукцію персональних досягнень.

Професійне вигорання це синдром, що розвивається на фоні хронічного стресу і призводить до виснаження емоційноенергетичних і особистісних ресурсів працюючої людини. Синдром професійного вигорання – найнебезпечніший стан для тих, хто працює з людьми: медичних працівників, вчителів, соціальних працівників, психологів, менеджерів, журналістів, бізнесменів і політиків, всіх, чия діяльність неможлива без спілкування. Професійне вигорання виникає в результаті внутрішнього накопичення негативних емоцій без відповідної «розрядки» або «звільнення» від них. Щоденна робота з постійним фізичним та психічним

навантаженням, ускладнена напруженими емоційними контактами, призводить до життя в стані постійного стресу, накопичення його наслідків, виснаження запасів життєвої енергії, як наслідок до серйозних фізичних захворювань і ранньої смерті [10].

У двофакторній моделі (Dierendonck, 1994) синдром вигорання представлений емоційним виснаженням і деперсоналізацією. Перший компонент відноситься до сфери скарг на своє здоров'я, нервову напругу, емоційне виснаження. Другий – деперсоналізація – проявляється у зміні відносин або до пацієнтів, або до себе [11]. Відповідно до трифазної моделі С. Maslach, S. E. Jackson СЕВ розглядається як відповідна реакція на професійні тривалі стреси, що включає в себе три компоненти: симптоми емоційного дефіциту, симптом особистісної відстороненості або деперсоналізації і синдром психосоматичних і психовегетативних порушень [12]. Шість фаз розвитку СЕВ виділяє М. Burisch, кожна з яких має специфічні психологічні, психопатологічні, поведінкові та психосоматичні особливості. За даними С. Maslach і співавт., цей синдром включає три основні компоненти: 1) інтрапсихічний (емоційне виснаження) – відчуття спустошеності, вичерпаності власних емоційних ресурсів; 2) міжособистісний (деперсоналізація) – бездушне, цинічне, формальне чи надзвичайно відсторонене ставлення до інших людей на роботі; 3) самооціночний (зниження особистісної успішності, редукція професійних досягнень) – тенденція бачити свою роботу виключно в негативному ракурсі, незадоволеність професійними досягненнями, відчуття зниження своєї компетентності, продуктивності та самоефективності [13].

Інші автори у формуванні цього синдрому виділяють чотири фази: деперсоналізацію (втрату індивідуальності); недооцінку особистого внеску; ізоляцію; емоційне і фізичне знесилення [9]. Найбільш практично використовуваною є класифікація стадій вигорання: 1-я стадія – «напруга» – симптоми: незадоволеність собою, «загнаність в клітку», переживання психотравмуючих ситуацій, тривожність і депресія; 2-я стадія – «резистенція» – симптоми: неадекватне, виборче емоційне реагування, емоційно-моральна дезорієнтація, розширення сфери економії емоцій, редукція професійних

обов'язків; 3-я стадія – «виснаження» – симптоми: емоційний дефіцит, емоційна відстороненість, особистісна відстороненість, психосоматичні та психовегетативні порушення [14].

Важливу роль у виникненні ПД, синдрому емоційного вигорання в умовах підвищеної професійної стресогенності серед середніх медичних працівників відіграє наступне:: хронічно напружений характер діяльності, інтенсивне спілкування і великий обсяг діагностичних і терапевтичних заходів, які фахівець зобов'язаний провести; психологічно важкий контингент – вкладання в роботу великих особистісних ресурсів при недостатньо ефективних результатах (особливо при роботі з безнадійними пацієнтами), ризик прийняття на себе проблем пацієнта; у осіб, які тривалий час працюють психіатричними пацієнтами, психічні процеси можуть іноді міняти темп і підлаштовуватися під темп пацієнта; відзначаються також випадки некритичності до порушень в емоційній і розумовій сферах хворих; недостатня винагорода, яка сприймається, як порушення соціальної справедливості; ризик адміністративних санкцій у зв'язку з помилками у професійній діяльності неправильним заповненням медичної документації; неблагополучна психологічна атмосфера професійної діяльності – напруженість і конфлікти у професійній сфері (в першу чергу, з керівництвом), недостатня підтримка з боку колег, недостатні повноваження в роботі; дестабілізуюча організація діяльності – монотонний характер роботи, суворе регламентування часу і порядку її виконання, велика кількість бюрократичних процедур, неможливість самостійно приймати рішення; нечітка організація і планування праці, нестача обладнання, відсутність умов для самовираження особистості, професійного зростання; невідповідність обсягів фінансування охорони здоров'я вимогам до обсягу діагностичних та лікувальних заходів, які зобов'язаний провести медичний працівник; відсутність комфортних умов на робочому місці; сімейні проблеми, а також відсутність психологічної підтримки в сім'ї, недостатнє розуміння близькими людьми специфіки професії медичного працівника [15].

Згідно даним І. К. Сосіна і співавтори, основним чинником, що викликає професійний стрес у медичних працівників, є економічний фактор – мізерна

зарплата, яка не відповідає тій величезній інтелектуальній та емоційній енергії, що витрачається при виконанні професійних обов'язків. Крім того, багатьом медичним працівникам притаманні негативні стратегії подолання стресу, які можуть зробити його некерованим і трансформуватися в СЕВ. В якості основних передумов до цього 69,0 % опитаних медичних працівників відзначали часте вживання спиртних напоїв, 65,0 % – порушення сну, 50,0 % – наростаючу дратівливість, 35,0 % – бажання усамітнитися [16].

Як показано І. Харді, медичні сестри мають різні типи емоційності. Так звана «сестра-рутинер», не співпереживає хворим, не співчуває їм. Тип «нервової сестри» схильний до емоційної нестабільності і невротичних реакцій. Вони дратівливі, запальні, виглядають похмурими, як би ображеними на ні в чому не винних хворих. І тільки сестра «материнського» типу відповідає вимогам своєї професії: вона емпатична і турботлива. Виявлено деякі відмінності в емоційній сфері медичних сестер, які працюють у відділеннях реанімації, і сестер, що працюють в поліклініці або терапевтичному відділенні. Хоча у більшості СМП рівень тривожності середній, у перших він дещо вищий, що можна пов'язати зі специфікою їх роботи в екстремальних ситуаціях. У сестер реанімаційних відділень вище здатність до емоційної ідентифікації з хворими, але нижче емоційна стійкість [17].

Висновки. У найбільш загальному вигляді щодо проблем дезадаптації та деяких аспектів синдрому професійного / емоційного вигорання в умовах підвищеної професійної стресогенності серед середніх медичних працівників, можна узагальнити наступним: *професійна дезадаптація* у діяльності медичної сестри пов'язана з підвищеними психоемоційними навантаженнями в поєднанні з відповідальністю в прийнятті рішень при різних екстремальних ситуаціях. Найбільше психоемоційне напруження викликають взаємини з пацієнтами, котрі відчувають біль, тих, хто боїться лікарського втручання, є стурбованими і напруженими, іноді агресивно налаштованими, недовірливими і їх родичами; *запобіжником* професійної дезадаптації, а саме таких негативних почуттів, як фрустрація, гнів, цинізм, почуття невпевненості в собі перед обличчям страждань і

непереборних болів пацієнтів, які є дійсною реальністю професійної атмосфери медичної сестри, вважається розвиток емоційноінтелектуального боку медичної практики, творчий і особистісний ріст професіонала; *синдром професійного / емоційного вигорання* у медичних сестер частіше проявляється «неадекватним реагуванням» щодо пацієнтів, слабкістю емоційного реагування, зниженням здатності до співчуття до хворих, втомою, що призводить до негативного впливу роботи на особисте життя; *для середнього медичного персоналу* необхідне усвідомлення того, що, врештірешт, звертатися до себе може бути не так вже і погано. Беручи на себе відповідальність за характер переживання стресу, фахівець знаходить контроль над собою, і при цьому переходить з положення «жертви» до стану «уцілілого» і тим самим знижує рівень професійного / емоційного вигорання.

Література.

1. Максименко С. Д., Карамушка Л. М., Зайчикова Т. В. та ін. Синдром «професійного вигорання» та професійна кар'єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти. Київ: Міленіум. 2024. 368 с.
2. Максименко С. Д., Коваль І. А., Максименко К. С., Папуча М. В. Медична психологія. Вінниця: Нова Книга. 2008. 520 с.
3. Богданова, Н. Дезадаптація суб'єкта та її зв'язок об'єктивними відношеннями / Н. Богданова. Психологія і суспільство. 2008.
4. Freudenberg, H. J. Вигорання персоналу. соціальних наук. 1974. №30. С. 159–165.
5. Чепелева, Н. О. Психологічні особливості емоційного вигорання викладачів вищих навчальних закладів : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 19.00.01. Загальна психологія, історія психології. Одеса. 2010. 20 с.
6. Волинець Н.В. Психологічні особливості особистісного благополуччя в професійній сфері життєдіяльності: монографія, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. Хмельницький, НАДПСУ. 2019. 619 с.
7. Омелянович В.Ю. Структурована характеристика стратегій копінг-повідінки та синдрому емоційного вигоряння у спільних органів внутрішніх справ,

які страждають на психосоматичні розлади / О.В. Синдром у працівників органів внутрішніх справ, які страждають на психосоматичні розлади. Журнал психіатрії і медичної психології. 2009. №1 (21). С. 84–89.

8. Маркова М. В., Козіра П. В. Постстресові дезадаптивні стани на тлі соціальних змін: аналіз проблеми / М. В. Маркова, П. В. Козіра. Медична психологія. 2015. №1. С. 8-13.

9. Дроздова, А. Р. Синдром «емоційного вигоряння» як один із видів психологічних механізмів захисту особистості / А. Р. Дроздова. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. 2010. №9. С. 54–58.

10. Карамушка Л. М. Особливості прояву синдрому «професійного вигорання» у вчителів / Л. М. Карамушка. Психологія управління. 2012. №1. С. 57–65.

11. Dierendonck, D. V. (1994) Вигорання серед лікарів загальної практики: відповідна теорія справедливості. соц. клін. психол. 1994. №139(1). С. 54–57.

12. Maslach, C. Burnout: a multidimensional perspective // Professional burnout: recent developments in the theory and research. Washington D. C : Taylor & Trances, 1993. С. 19–32I <https://doi.org/10.31108/1.2019.5.11>

13. Maslach, C. The Maslach Burnout inventory manual. Пало-Альто, Каліфорнія: Consulting Psychologist Press. 1986.

14. Городовіченко В. М. Емоційне вигорання плата за співчуття / В. М. Городовіченко. Медсестринство. 2013. № 3.

15. Лапінська Т. В. Психологічні особливості медичних працівників в умовах емоційного виснаження. Монографія. Академія праці, соціальних відносин і туризму / За заг. ред.: Г.А. Пріба, Л.Є. Бегеза. Київ : АПСВТ. 2024. 416 с.

16. Сосін І. К., Слабунов О. С. , Кулікова В. Д. Синдром емоційного вигорання» як наслідок професійної діяльності в наркології / Арх. психіатрії. 2004. №10. 2 (37). С. 149–151.

17. Cubrilo-Turek, M. Синдром вигорання – оцінка стресової роботи серед персоналу інтенсивної терапії. Зб. праць. 2007. Т. 30. №1, С. 131–135.

1.15. Особливості психічних станів жінок часто хворіючих дітей

Мазур Н.В.

Актуальність. Психічні стани жінок, чий діти належать до категорії часто хворіючих, на нашу думку, є важливим об'єктом уваги сучасної психології. Хвороби дітей є стресогенним фактором, що впливає на емоційний фон, психічний стан та адаптивні можливості жінки (матері). Зважаючи на важливу роль материнської фігури у розвитку дитини, дослідження особливостей психічних станів таких жінок набуває не лише теоретичного, але й практичного значення, яке потребуватиме програм психологічної підтримки жінок часто хворіючих дітей.

Незважаючи на значний обсяг досліджень, присвячених психологічним станам батьків дітей з хронічними хворобами, аспекти впливу повторюваних захворювань у дитини на психічний стан жінок залишаються недостатньо вивченими. Особливо актуально це в контексті українських реалій, коли майже третій рік поспіль Україна протистоїть військовій агресії де соціально-економічні та культурні особливості формують специфічне середовище для прояву цих станів. Це є величезним навантаженням на психіку жінки. Всі ці фактори виснажують жінку, залишаючи значно менше ресурсу, від яких турбота про дітей вимагала багато ресурсу і в мирному житті.

Мета: дослідити особливості прояву психічних станів жінок часто хворіючих дітей та факторів, що впливають на психічне здоров'я жінок.

Результати дослідження. Для кожної людини позитивний психічний стан визначається як стан психічного благополуччя, душевного комфорту, переживання щастя. Це базові складові, що ґрунтуються на переживаннях особистості досягнень та успіхів у різних сферах життя, гармонії у особистому житті, самопізнанні тощо. Така гармонія ґрунтується на чітких ритмах, певних законах, відповідних кількісних та якісних співвідношеннях. За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), психічне здоров'я – це стан добробуту, при якому кожна людина може реалізувати свій власний потенціал та впоратися із життєвими

стресами, продуктивно і плідно працювати, а також робити внесок у життя своєї спільноти.

Психічне здоров'я не обмежується лише відсутністю психічних захворювань, але також включає в себе широкий спектр факторів, що впливають на загальний стан емоційного, соціального та фізичного благополуччя людини та є ключовим компонентом загального її благополуччя та важливою складовою якісного життя. Його підтримка та збереження вимагає уваги до різних аспектів життя, включаючи фізичне здоров'я, соціальне середовище, емоційний стан та психічний добробут.

Незважаючи на значний обсяг досліджень, присвячених психологічним станам батьків дітей з хронічними хворобами, аспекти впливу повторюваних захворювань у дитини на психічний стан жінок залишаються недостатньо вивченими. Особливо актуально це в контексті українських реалій, де соціально-економічні та культурні особливості формують специфічне середовище для прояву цих станів.

За визначенням науковця М.Д. Левітова «психічні стани, як складне явище, єдністю психічних процесів, їхнім підсумком. Але психічні процеси, що виникли, «накладаються» на психічні властивості особистості, які залежно від свого психоенергетичного потенціалу, тобто ступеня розвинутості й міцності, гальмують, стримують їх або сприяють розвитку, тобто підсилюють» [1, с. 681].

Зокрема, психічний стан є комплексною характеристикою тимчасового функціонального стану психіки, який визначає специфіку переживання людиною себе та зовнішнього середовища у певний момент часу.

Науковець О. Степанов, визначає психічний стан як «форма прояву психіки індивіда, яка разом із психічними процесами і психічними властивостями умовно виділяє в психіці статичний момент. Психічні процеси підкреслюють динамічні аспекти психіки, а психічні властивості вказують на стійкість проявів психіки індивіда в структурі особистості. Психічний стан є психологічною характеристикою особистості, що відображає її порівняно тривалі переживання» та як «прояви почуттів (настрій, тривога, афект), уваги (зосередженість, розсіяність), мислення (сумніви, впевненість), уяви (мрії) тощо [2, с. 340].

О. Степанов і М. Фіцула у своїх роботах зазначають, що психічні стани – це «емоційно забарвлені мінливі стани людини, які виникають під впливом різних обставин життя, стану здоров'я та інших факторів» [3, с. 509].

Професор М. Савчин до «психічних станів людини з вираженою емоційною складовою відносить такі стани як тривога, стрес, страх, радість, фрустрація, гнів, зневіра, горе, тощо» [4, с. 383]. Серед них власне емоційними станами М. Савчин називає тривогу, страх, гнів і стрес.

За словами академіка С. Максименка «багатство емоційних станів виявляється у формі настроїв, афектів, стресів, фрустрацій, пристрастей» [5, с. 217].

Якщо розглядати психічний стан особистості з позицій функціонування можна побачити наскільки швидко чи повільно відбуваються в ньому реакції і процеси, як виявляються наявні психічні властивості.

Так, науковці М. Прищак та Л. Мацко звертають нашу увагу на тому, що психічні стани впливають на протікання психічних процесів, а повторюючись часто, набувши стійкості, можуть стати властивістю особистості, розділяючи їх на види у залежності від таких параметрів:

- вплив на особистість (позитивні і негативні, стенічні й астеничні);
- переважні форми психіки (емоційні, вольові, інтелектуальні);
- глибина (глибокі, поверхневі);
- час протікання (короткочасні, тривалі та ін.);
- ступінь усвідомленості та до психічних станів відносять: стрес, настрої, афект, страх, гнів, сором, фрустрацію, радість, агресію та інші.

Науковці підкреслюють, що психічний стан є проміжною ланкою між миттєвими емоційними реакціями та стабільними особистісними рисами та визначають його як психологічну характеристику людини, що відображає її тривалі, статичні душевні переживання [6, с. 53].

- У психологічній науці психічні стани класифікуються як вияви певних психічних процесів:

- мотиваційні (бажання, прагнення, інтереси, потяги, пристрасті);

- емоційні (емоційний тон відчуттів, емоційний відгук на явища дійсності, настрої, конфліктні емоційні стани – стрес, афект, тривога тощо);
- -вольові стани ініціативності, цілеспрямованості, рішучості, наполегливості (їхня класифікація пов'язана зі структурою складної вольової дії – рішучість, розгубленість тощо);
- стани різних рівнів організованості свідомості (вони виявляються в різних рівнях уважності).

Отже, кожний психічний стан ототожнюється із переживанням особистості й водночас діяльністю його різних систем, він має зовнішнє вираження і виявляється у зміні ефекту діяльності, яку виконують. Тільки за сукупністю певних ознак, що відображають кожний з цих рівнів, можна зробити висновок про наявність у людини того чи іншого стану. Ні поведінка, ні різні психофізіологічні показники, взяті окремо, не можуть достовірно диференціювати один стан від іншого. Провідне місце в діагностиці станів належить переживанням, пов'язаним зі ставленням особистості. Виокремлення останнього як чільного чинника психічного стану особистості дає змогу розглядати психічний стан саме як якісну характеристику психіки особистості, що об'єднує у собі психічні процеси та властивості особистості та здійснює вплив на них.

За роллю в структурі особистості стани можуть бути ситуативними, особистісними й груповими. Ситуативні стани виражають особливості ситуації, котра спричинила в особистості нехарактерні для її психічної діяльності реакції.

Особистісні й колективні (групові) – стани, які є типовими для конкретної людини чи колективу (групи).

За глибиною переживань розрізняють стани глибокі й поверхові.

За характером впливу на особистість, колектив (групу) стани поділяють на позитивні й негативні.

За тривалістю стани бувають тривалими й короткими.

За ступенем усвідомленості стани можуть бути більш-менш усвідомленими й неусвідомленими.

Складність розрізнення типів психічних станів у тому, що їх майже неможливо розмістити в межах однієї шкали, класифікувати за однією ознакою. Кожен зі станів має свій континуум виявів і набір ознак (рівень усвідомленості, домінування психічних процесів, тривалість, адекватність чи неадекватність ситуації тощо) [1, с. 684]. Слід зазначити, що існують певні особливості психічних станів, які характеризуються наступними властивостями:

- цілісність як психічна діяльність загалом за певний проміжок часу;
- рухливість і відносна стійкість як психічні стани мінливі, що мають початок, кінець, динаміку, більш стійкі, ніж психічні процеси.
- прямий і безпосередній як взаємозв'язок із психічними процесами і властивостями особистості.
- індивідуальна своєрідність і типовість як нерозривно пов'язаний зв'язок з індивідуальними особливостями особистості, її моральними та іншими рисами.

- крайнє різноманіття психічних станів.
- полярність, кожному психічному стану відповідає протилежний стан.

За динамікою психічних станів людини можна виокремити три істотні періоди [1, с. 688–689]:

- підготовка до розв'язання завдань;
- процес розв'язання завдання;
- завершення розв'язання завдань.

Отже, зважаючи на вищезазначене, можна дійти висновку, що психічний стан визначається як відносно стійка характеристика психіки, що проявляється у конкретний період часу через когнітивні, емоційні та поведінкові особливості.

Нашу увагу було зосереджено на дослідженні певних психічних станів, які притаманні жінкам часто хворіючих дітей, таких як: стрес, тривога, тривожність, депресія, емоційне вигорання, які мають свої симптоми й особливості проявів.

Для жінок, які знаходяться в особливих життєвих обставинах – мають часто хворіючих дітей, особливий психічний стан формується під впливом специфічних стресових умов, що зумовлює їхню унікальність та варіативність.

Психічний стан жінок часто хворіючих дітей визначається різними компонентами, серед яких особливо важливими є стан здоров'я дитини та сприйняття матір'ю здоров'я своєї дитини.

Зокрема, психічні стани жінок, які стикаються з хронічними чи повторюваними проблемами здоров'я у дітей, мають динамічний характер і залежать від рівня особистісних ресурсів, адаптивних механізмів та соціальної підтримки.

Психічний стан конкретної особистості залежить від багатьох чинників.

Стрес – це наші особисті відчуття. Цей стан індивідуальний і породжується нами. Він безпосередньо не пов'язаний з тим, що нас оточує; зовнішні фактори лише запускають нашу внутрішню дзеркальну реакцію – суто індивідуальну [7, с. 50].

На нашу думку, джерелом стресу у жінок можуть стати такі ситуації:

1. Надмірна робота вдома або на роботі.
2. Запізнення з виконанням завдань та термінів.
3. Фінансові проблеми.
4. Сімейні проблеми або конфлікти.
5. Хронічне перевантаження.
6. Здоров'я дітей або рідних.
7. Нездатність досягти мети або успіху в житті.

Стан стресу у жінки нерідко може супроводжуватися таким складним психічним станом, як неспокій, страх, тривога, тривожність.

Тривога пов'язана з тривожністю і може бути її причиною.

Тривога виступає однією із компонентів сигнальних систем організму людини щодо мобілізаційних ресурсів організму та функціонального його адаптування в екстремальних умовах.

Тривогу можна розглядати як неспокій.

Тривога – це стан та схильність до емоційних розладів, який рано чи пізно вражає майже кожного в житті. Причиною може будь-які обставини: проблеми в житті, сімейні проблеми, проблеми на роботі чи навчанні, розбіжності з близькими людьми, нестабільна політична чи економічна ситуація в країні. Відносини між колегами також можуть викликати тривогу: несправедливі соціальні ролі та ситуації, порушення початкових очікувань та багато інших аспектів. Люди, які працюють у великих групах стрес, депресія і тривога.

Тривога може виникати при наявності невизначеного ризику очікуваної події і виражається в оцінці його шкідливих наслідків. Перш за все, слід зазначити, що існує дві схожі емоції, які часто плутають – це тривога і страх, але вони різні. Страх – це те, що ми відчуваємо у відповідь на події, тоді як тривога стосується минулих або майбутніх подій, які ми зараз переживаємо.

Страх, гнів, тривога тощо, які ми відчуваємо це негативні емоції, щось погане. Але насправді це нормальні емоції, важливі й корисні жінок. Коли жінка повністю поглинена цими турботами, коли вона справді в безпеці й нічого не загрожує, їй важко перейти від думок про минуле чи майбутнє до сьогодення. Так виникає тривога. Когнітивна та гуманістична психотерапія оперують різними концептуальними рамками та однаково підходять до питання про природу тривоги – тривога викликається новим досвідом і загрозами, несумісними з мисленням людини. Ці уявлення різні: в когнітивній психології – про весь світ, в гуманітарних науках – про себе [8].

Тривожність визначається як індивідуально-психологічна особливість, яка проявляється у схильності людини до частих та інтенсивних переживань стану тривоги.

Тривожність – постійне відчуття небезпеки для здоров'я чи життя дитини. Це може супроводжуватися соматичними проявами (тремор, серцебиття) та когнітивними спотвореннями (надмірне очікування гіршого).

З'ясовано, що тривожність є поєднанням домінуючої емоції страху з однією або кількома іншими фундаментальними емоціями, а також – конструйованою

людиною категорією. Хороше психічне здоров'я є важливою складовою здоров'я, людського духу і його загальних вимірів [9].

Депресія – тривалий біохімічний розлад психічного здоров'я людини, один із найбільш поширених у світі, пов'язаний із зовнішніми умовами (навколишнім середовищем), що характеризується зниженням настрою, тривалої апатії та загальної активності індивіда. Психологічний словник надає наступне визначення депресії: «це афективний стан, для якого притаманним є наявність негативного емоційного фону, а також змін у когнітивній та мотиваційній сферах з ознаками пасивної поведінки» [10, с. 88–89].

Депресивні стани – почуття безвиході, виснаження, зниження самооцінки. Такі стани особливо небезпечні, оскільки вони можуть призводити до емоційного дистанціювання матері від дитини.

Емоційне вигорання – результат тривалого фізичного й емоційного навантаження. Характеризується апатією, втратою інтересу до життя та неможливістю ефективно реагувати на потреби дитини.

Інтернальність чи екстернальність у стресових ситуаціях – деякі жінки схильні звинувачувати себе за те, що дитина часто хворіє (інтернальність), інші – перекладати провину на зовнішні обставини (екстернальність).

Поряд із негативними станами, важливо враховувати потенціал позитивних психічних станів жінок, таких як радість і вдячність, які можуть формуватися у процесі спільного подолання труднощів із дитиною.

Як бачимо, що визначення та класифікація психічних станів жінок часто хворіючих дітей, є важливим кроком для розуміння психологічних механізмів їхньої адаптації.

Досліджуючи стан психічного здоров'я жінок, які мають дітей з хронічними захворюваннями або часто хворіючих, можна спостерігати, що їх психічний стан значною мірою залежить від сукупності багатьох факторів, які можна умовно поділити на гендерні, соціально-економічні, культурні, медичні та психологічні фактори тощо.

Висновки. Отже, розуміння того, як жінки (матері), чиї діти часто хворіють, здатні вистояти, відновитися і навіть психологічно зміцніти після важких життєвих подій, є викликом для психологічної спільноти, і суспільства в цілому. Дослідження життєстійкості та факторів, що визначають умови її цілеспрямованого формування та розуміння здатності жінки до позитивної психологічної адаптації в несприятливих обставинах може допомогти психологам розробити програми психологічної підтримки, розвитку стресостійкості, рекомендації щодо формування у них резильєнтності, що включає в себе не тільки подолання труднощів і повернення до попереднього стану, але і рух через труднощі до нового етапу життя тощо.

Література.

1. Варій М. Й. Загальна психологія : підр. 3-тє вид. Київ : Центр учбової літератури. 2009. 1007 с.
2. Психологічна енциклопедія / упоряд. О. М. Степанов Київ : Академвидав, 2006. 424 с.
3. Степанов О. М., Фіцула М. М. Основи психології і педагогіки : навч. посіб. Київ : Академвидав. 2006. 520 с.
4. Савчин М.В. Загальна психологія : навч. посіб. Київ : Академвидав. 2011. 464 с.
5. Максименко С. Д. Загальна психологія : навч. посіб. 2-ге вид., доп. Київ : Центр навчальної літератури. 2004. 272 с.
6. Прищак М. Д., Мацко Л. А. Психологія: навч. посіб. Вінниця : ВНТУ. 2013. 98 с.
7. Бардин Н. М., Жидецький Ю. Ц., Кіржецький Ю. І. та ін. Стресостійкість : навч. посіб. / за ред. Я. М. Когута. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ. 2021. 2014 с.
8. Томчук С. М., Томчук М. І. Психологія тривоги, страху та агресії особистості в освітньому процесі : [монографія] / С. М. Томчук, М. І. Томчук – Вінниця : КВНЗ «ВАНО». 2018. 200 с.

9. Галієва О. М. Диференціація понять «тривога» та «тривожність» / Психологія та соціальна робота. Київ. 2019. Т. 24. № 1 (49). С. 32–48.
10. Шакар В. Б. Сучасний тлумачний психологічний словник. Харків : Прапор, 2005. 640 с.

1.16. Психологічна готовність до материнства

Мілютіна К. Л.

Гаврилюк Л.А.

Актуальність. Аналіз психологічної літератури дає нам розуміння, що поняття «психологічна готовність до материнства» на сьогодні не має чіткого визначення, неоднозначно розуміється його сутність, структура та критерії. Проблематика материнства розглядається у різних аспектах. Можна виокремити наступні: культурно-історичний, психофізіологічний, феноменологічний та психотерапевтичний. Як історично зумовлений процес материнство розглядається з позиції культурно-історичного підходу, у рамках якого материнська поведінка та емоційні переживання і уявлення матері про розвиток дитини і свою материнську роль різноманітні у різних культурах і залежать від конкретної культурної моделі материнства і дитинства. Психофізіологічними аспектами материнства є розгляд позиції матері з точки зору організації її фізіологічного і стимульного середовища для розвитку дитини. Розвиток материнства і динаміка стану вагітності вивчаються, виходячи із формування фізіологічної «домінанти материнства». Успішність виношування вагітності та народження дитини пов'язують із психофізіологічними особливостями емоційної сфери жінки і її особистісними характеристиками. У феноменологічному напрямку виділяються й описуються функції матері, особливості її поведінки, переживань і установок.

У дослідженнях, пов'язаних із вивченням успішності адаптації жінки до материнства, враховуються різноманітні чинники: особистісні особливості, історія життя, адаптація до подружнього життя, досвід взаємодії із власною матір'ю, особливості сімейної моделі материнства, можливості взаємодії із немовлятами і поява інтересу до них у дитинстві.

Материнство традиційно продовжує бути однією з найвизначніших подій у життя жінки, і її готовність до цього повинна визначатися не лише на фізіологічному рівні, що стосується здатності до зачаття, винесення та народження дитини, а й на психологічному, що передбачає усвідомлення взаємозв'язку діади

матір–дитина, формування адекватної материнської поведінки та компетентності, та на соціальному, що потребує усвідомлення та прийняття материнської ролі та відповідальності за частку своєї дитини. *Актуальність проблеми* зумовлює формування теми психологічна готовність до материнства, де об'єктом визначено готовність до материнства, як психологічний феномен.

Мета. Виявити параметри психологічної готовності до материнства на основі аналізу структури психологічної готовності до материнства.

Результати дослідження. Поняття «свідоме материнство» визначається як інтегрована життєва позиція жінки, що охоплює : почуття та емоції, пов'язані з бажанням і готовністю стати матір'ю; біологічну та фізичну здатність виносити та народити дитину; готовність взяти на себе відповідальність за народження та виховання дитини; здатність об'єктивно оцінювати реальну життєву ситуацію і створювати оптимальні умови для гармонійного розвитку дитини; формування самосприйняття материнства та Я-образу матері, що включає усвідомлення себе в ролі матері та інтеграцію цієї ролі у власну ідентичність.

Таким чином, свідоме материнство є багатогранною концепцією, яка об'єднує емоційні, фізичні, психологічні, аналітичні та ідентифікаційні аспекти готовності жінки до материнства. Відповідно до цієї позиції, свідоме вагітність визначається як стан вагітності, що виникає внаслідок усвідомленої життєвої позиції та материнської орієнтації жінки. Процес свідомої вагітності включає кілька ключових аспектів: цілеспрямована підготовка до вагітності, планування вагітності, усвідомлення змін під час вагітності, відповідальне ставлення до народження дитини та робота над відновленням психологічної рівноваги після пологів. Відмінною рисою свідомої вагітності є прийняття рішення про вагітність, а умовою її виникнення є суб'єктивна психологічна готовність до материнства, що передбачає формування нового набору ролей для жінки, зокрема ролі матері [1].

А. Кулик визначає материнство складним явищем, яке є результатом взаємодії багатьох факторів: генетичних, біологічних, впливу сім'ї та соціального середовища. Материнство є унікальним психологічним феноменом із

фізіологічними механізмами, еволюційною історією, культурними та індивідуальними особливостями [3, с. 282].

За визначенням С. Куца, материнство є основною соціальною роллю жінки, яка сформувалася в процесі історичного розвитку жіночої природи, інстинктів і цінностей, визначених суспільством. Це поняття відображає глибоке коріння соціальних, культурних і біологічних аспектів, які разом визначають роль і значення материнства. Історично роль жінки як матері формувалася в контексті еволюційного розвитку, де материнство було необхідним для виживання і процвітання людських спільнот. Це включає в себе фізичні і психологічні аспекти, такі як здатність до виношування і народження дітей, а також виховання і догляд за ними. Материнські інстинкти є біологічними та психологічними характеристиками, що спонукають жінку до захисту, турботи і виховання своїх дітей. Ці інстинкти включають в себе здатність до емоційного зв'язку з дитиною, бажання забезпечити їй безпеку і комфорт, а також інтуїтивне розуміння потреб малюка. Суспільні цінності відіграють важливу роль у визначенні і підтримці ролі материнства. Культура, традиції і соціальні норми впливають на те, як жінки сприймають і виконують свою материнську роль. В різних суспільствах і культурах материнство може мати різні прояви, але загалом воно залишається центральним елементом жіночої ідентичності. Як соціальна роль, материнство включає в себе набір очікувань і обов'язків, які суспільство покладає на жінок. Це може включати відповідальність за фізичний і емоційний розвиток дитини, її освіту, соціалізацію, а також забезпечення її матеріальних потреб. Материнство має значний вплив на жіночу ідентичність, формуючи самосприйняття жінки і її місце в суспільстві. Воно може стати джерелом особистого задоволення і самореалізації, але також може включати виклики і стреси, пов'язані з виконанням цієї ролі.

Таким чином, визначення С. Куца підкреслює комплексність і багатовимірність материнства, яке є не тільки біологічною функцією, але й важливою соціальною роллю, глибоко вкоріненою в історичному і культурному контексті [4, с. 114].

За словами М. Гомонюк, при вивченні материнства важливим фактором є вивчення фізіологічної готовності до материнства, яка визначається як стан організму жінки, що означає готовність до вагітності та пологів. Цей стан охоплює різні аспекти фізіології, такі як стан репродуктивної системи, а також здоров'я та функціонування інших органів і систем [2, с. 24].

В. Вишньовський описує психологічну готовність до материнства як здатність матері забезпечити належні умови для здорового розвитку дитини і виявляється у певній типовій материнській установці. Він описує п'ять основних блоків [1, с. 301].

1. Особиста підготовка: загальна особистісна зрілість (відповідна гендерна ідентифікація; здатність приймати рішення та брати на себе відповідальність; сильна відданість справі; відсутність залежності) та особистісні якості, необхідні для ефективного материнства (емпатія; вміння працювати разом; здатність бути «тут і зараз»).

2. Адекватна батьківська модель: адекватність материнської та батьківської моделей, що сформувалися в сім'ї; оптимальне ставлення батьків, виховних установок і стратегій, материнського ставлення до народження та виховання дитини.

3. Мотиваційна готовність: зрілість мотивації до народження дитини, при якій дитина не стає засобом гендерної ролі, віку та особистісного сприйняття жінки; як засіб утримання партнера або зміцнення сім'ї; як спосіб компенсації стосунків між дитиною та батьком; засіб досягнення певного соціального статусу тощо.

4. Формування материнської компетентності: ставлення до дитини як до суб'єкта не лише фізичних потреб, а й психічних потреб і суб'єктивних переживань; вміння розуміти стан дитини, особливості її поведінки; необхідні знання про фізичний та розумовий розвиток дитини; вміння працювати з дитиною.

5. Формування материнської сфери. Материнство як частина особистісної сфери жінки.

Т. Щербак охарактеризувала декілька груп показників психологічної готовності до материнства. До першої групи належать особливості жіночого досвіду спілкування з раннього дитинства. Якщо досвід спілкування з близькими позитивний, це означає, що початкові умови для побудови автономних стосунків з оточуючими були сприятливими і основи для побудови автономних стосунків з дитиною закладені [7, с. 251].

До показників другої групи відноситься досвід жінки у відносинах з плодом. Найбільш сприятливою ситуацією для поведінки майбутньої матері є бажаність дитини, наявність суб'єктивних стосунків матері з ненародженою дитиною, що виявляється в любові до неї, образному чи словесному зверненні, прагненні інтерпретувати ворухіння плода як акти спілкування.

Третя група показників стосується ставлення до стратегії виховання дітей. Те, як майбутня мати має намір доглядати за нею, з точки зору автора, також свідчить про перевагу об'єктивних чи предметних стосунків з дитиною.

Материнство вивчається у руслі різних наук: історії, культурології, медицини, фізіології, соціології, психології. Кожна наука вивчає та визначає материнство, виходячи зі своїх цілей та завдань. Інтерес до комплексного вивчення материнства виник порівняно недавно. Але сьогодні єдиного визначення поняття «материнство» немає.

Психологічна готовність до материнства трактується як здатність матері забезпечити адекватні умови для розвитку дитини та виявляється в певному типі материнського ставлення. Виділяють п'ять основних блоків готовності до материнства :

1. Особистісна готовність: загальна особистісна зрілість (адекватна статеві ідентифікація; здатність до ухвалення рішень і відповідальності; міцна прихильність; відсутність залежностей) та особистісні якості, необхідні для ефективного материнства (емпатія; здатність до спільної діяльності; здатність бути «тут і тепер»; творчі здібності; інтерес до діяльності вирощування та виховання; культура тіла).

2. Адекватна модель батьківства: адекватність моделей материнської і батьківської ролей, сформованих в своїй сім'ї; оптимальні для народження і виховання дитини батьківські установки, позиції, виховні стратегії, материнське ставлення.

3. Мотиваційна готовність: зрілість мотивації народження дитини, при якій малюк не стає: засобом статевого ролевого, вікової та особистісної самореалізації жінки; засобом утримання партнера або зміцнення сім'ї; засобом компенсації своїх дитячобатьківських стосунків; засобом досягнення певного соціального статусу тощо.

4. Сформованість материнської компетентності: ставлення до дитини як до суб'єкта не лише фізичних, але й психічних потреб і суб'єктивних переживань; здатність розуміти стани дитини, особливості її поведінки; необхідні знання про фізичний і психічний розвиток дитини; здатність до спільної діяльності з дитиною.

5. Сформованість материнської сфери. Материнство як частина особистісної сфери жінки (материнська потребово-мотиваційна сфера) включає три блоки (емоційно-потребовий; операційний; ціннісно-смысловий).

Психологічна готовність до материнства проявляється у вольових зусиллях та здатності до саморегуляції під час виконання цієї ролі. Жінка, яка володіє високим рівнем психологічної готовності до материнства, виявляє відповідальність, терпіння та вміння адаптуватися до змінних ситуацій. Оскільки комплексність та зміст психологічної готовності до материнства визначаються задовго до вагітності, у процесі онтогенезу материнської сфери виділяються шість стадій [2, с. 27].:

1. Взаємодія з власною матір'ю до трьох років.

2. Ігровий період, що включає сюжетно-рольові ігри з ляльками.

3. Період няньчення (від 5-6 років до початку статевого дозрівання), коли формуються основи «потреби у материнстві» через власний досвід взаємодії з маленькою дитиною або спостереження за іншими дорослими та дітьми.

4. Диференціація мотиваційних основ материнської та статевої сфер.

5. Взаємодія з власною дитиною під час вагітності, пологів, післяпологового періоду та дитинства.

6. Формування у матері емоційної зв'язаності з дитиною, особистісного прийняття та інтересу до її внутрішнього світу.

Психологічна готовність до материнства базується на особистому ставленні жінки до своєї майбутньої дитини, яке відображається у її стилі материнської поведінки. Цей стиль визначається рядом факторів, включаючи сприйняття вагітності, акцент на завданнях виховання та догляду за малюком, а також вплив раннього досвіду дитинства на майбутню матір. Сприйняття вагітності може варіюватися від радісних очікувань до тривоги та невпевненості. Важливо, щоб жінка відчувала підтримку та знала, як ефективно впоратися з емоційними та фізичними змінами, пов'язаними з цим періодом. Фокус на завданнях виховання та догляду за малюком означає здатність до вирішення проблем, встановлення гармонійних відносин з дитиною та виконання різноманітних батьківських обов'язків. Багато жінок також відчують вплив свого раннього досвіду дитинства на їхню психологічну готовність до материнства. Позитивні досвіди можуть стимулювати впевненість та самоствердження, тоді як негативні досвіди можуть викликати тривогу та невпевненість у власних здібностях [1, с. 302].

Крім того, у структурі готовності до материнства виокремлюються такі складові [4, с. 116]:

1. Компонент когнітивний. Включає уявлення про себе як про відповідальну особу та про дітей як про рівноправних членів сім'ї. Виховання розглядається як позитивний процес розвитку, а не просто система покарань та заохочень.

2. Компонент емоційний. Передбачає відкрите, безумовне прийняття дитини без оцінок, можливість вираження своїх почуттів за допомогою словесних та невербальних засобів. Щирість у виявах особистості та прагнення до побудови тісних довірчих зв'язків.

3. Компонент поведінковий. Відображає діяльність матері, спрямовану на догляд за дитиною, забезпечення її безпеки та задоволення потреб. Також

передбачає наявність навичок співпраці, вирішення конфліктів та здатність вільно висловлювати свої почуття.

Отже, готовність до материнства виявляється не тільки у бажанні зачати і народити дитину, але й у готовності до подальшого виховання і розвитку дитини. Подорож бути матір'ю пов'язана з різними викликами, оскільки народження дитини приносить значні зміни. Жінка повинна свідомо прийняти на себе материнські обов'язки і бути готовою пройти через цей процес з усіма його труднощами. У структурі психологічної готовності до материнства важливі навички виховання, знання, саморегуляція, стійкість до стресу, мотивація та бажання мати дитину. Рівень готовності до материнства визначається загальним впливом цих факторів на момент, коли жінка стає матір'ю [7, с. 253].

Українська дослідниця, психолог Л.І. Магдисюк стверджує у своїй статті «Психологічна готовність української молоді до материнства»: [4] «Система освіти в Україні не передбачає виховання молоді у двох життєво важливих сферах – статевому житті та підготовці до материнства і батьківства. Через це, на нашу думку, ситуація у державі стосовно реалізації материнської ролі стикається з такими проблемами, як зниження статусу матері, зменшення потреби у жінок народжувати, що спричинене не характерною слов'янським народам трансформацією батьківських установок та позицій, психологічна не готовність до виконання нової ролі при активній її реалізації, що спричиняє нездорове виховання нових поколінь».

Також вона робить висновки, що в юнацькому віці відбувається усвідомлення накопиченого досвіду взаємодії з власною матір'ю, формування образу своєї моделі материнства, з'являється бажання мати сім'ю, дітей, що є показником гармонійного формування материнської сфери жінки. Онтогенез розвитку материнської сфери в юнацькому віці вступає в один зі своїх основних етапів, коли психологічна готовність до материнства, наповнена певним досвідом, як особистісне новоутворення починає оформлятися в усвідомлені уявлення, образи свого майбутнього материнства. У зв'язку з цим дуже важливо, щоб ці уявлення про материнство не приймали деформований характер.

Материнство – це складний та відповідальний етап у житті жінки, що обумовлений множиною факторів. Готовність до цієї ролі визначається не лише внутрішнім бажанням мати дитину, а й залежить від різноманітних обставин. Досвід взаємин з батьками у дитинстві може впливати на уявлення про батьківство та власні здібності. Реакція на емоційний аспект материнства також має велике значення: вміння розуміти свої почуття та емоції допомагає жінці впоратися з важливими випробуваннями, що супроводжують материнство. Набуття виховних стратегій, здоров'я та фізичного стану також є важливими аспектами. Індивідуальні особливості, такі як вік, освіта, культурний фон, моральні якості, допомагають сформувати свідоме ставлення до батьківства та власної готовності до нього. Важливою є підтримка партнера, який ділить бажання матері та готовий поділитися відповідальністю за виховання дитини. Отже, готовність до материнства є комплексним поняттям, що включає в себе психологічні, фізичні та соціокультурні аспекти. Лише з урахуванням всіх цих факторів жінка може почувати себе впевнено та готовою до важливої ролі матері.

Запорізький психолог Світлана Райдужка [5], яка є перинатальним психологом, сімейним арт-терапевтом, та дитячим психологом, виділяє наступні чинники формування психологічної готовності до материнства:

1. Особистісна готовність.
2. Адекватна модель батьківства.
3. Мотиваційна готовність.
4. Сформованість материнської компетентності.
5. Сформованість материнської сфери.

Особистісна готовність:

Загальна особистісна зрілість (адекватна віково-статева ідентифікація)

- здатність до прийняття рішень та відповідальності;
- відсутність залежності;
- здатність усвідомлювати та регулювати власні дії;
- особисті якості, необхідні для ефектного материнства;
- здатність до спільної діяльності;

- здатність бути «тут і зараз» (тепер);
- творчі здібності;
- інтерес до розвитку іншої особи;
- інтерес до діяльності вирощування та виховання;
- вміння отримувати задоволення від плодів своєї діяльності;
- культура тіла та здоров'я.

Адекватна модель батьківства:

- адекватність моделі материнської та батьківської ролей, сформованих у своїй сім'ї, по відношенню до моделі особистості сім'ї та батьківства своєї культури;

– оптимальні для народження та виховання дитини батьківські настанови, позиція, виховні стратегії, материнське ставлення.

Мотиваційна готовність: зрілість мотивації народження дитини, при якій дитина не стає засобом полерольової, вікової та особистісної самореалізації жінки; засобом утримання партнера чи зміцнення сім'ї; засобом компенсації своїх дитячо-батьківських відносин; засобом досягнення певного соціального статусу тощо.

Сформованість материнської компетентності [3, с. 284]:

- ставлення до дитини, як до суб'єкта не тільки фізичних а й психологічних потреб та суб'єктивних переживань;
- чутливість до сигналів від дитини (плач, дихання, рухи);
- здатність до адекватного реагування на прояви потреб дитини;
- здатність орієнтуватися для розуміння стану дитини на особливості її поведінки та свій стан;
- гнучке ставлення до режиму та встановлення на орієнтацію на індивідуальний ритм життєдіяльності дитини в ранній період її розвитку;
- необхідні знання про психічний та фізичний розвиток дитини, вікові особливості її взаємодії зі світом;
- здатність до спільної діяльності з дитиною;

– навички виховання та навчання, адекватні віковим особливостям дитини.

Сформованість материнської сфери складається із 3х блоків: 1. емоційно-потребовий (здатність відчувати і розуміти свої емоції та емоції іншого); 2. операційний (здібності та навички з догляду за дитиною та спілкування з нею); 3. ціннісно-смысловий (наявність та сенс у потребі материнства, адекватна цінність дитини та материнства, баланс цінностей материнської та інших потреб жінки). Зміст цих трьох блоків послідовно формується в онтогенезі жінки:

- у взаємодії з власною матір'ю та іншими носіями материнської функції;
- в сюжетно-рольовій грі ляльки та в сім'ю;
- у взаємодії з немовлятами до народження своєї дитини;
- у період статевого дозрівання;
- у взаємодії із власними дітьми.

Висновки. Аналізуючи сутність психологічної готовності до материнства та її структуру, виявлено, що цей процес має складну природу, що включає в себе різноманітні аспекти психіки та психосоціального контексту. Особливу увагу приділено формуванню компонентів психологічної готовності жінок до материнства, що відображається в їхніх переконаннях, цінностях та психологічних реакціях. Крім того, виявлено, що психологічна готовність жінок до материнства відрізняється в залежності від їхнього віку, що підкреслює необхідність розуміння та врахування вікових особливостей у психологічній підготовці до материнства. Проаналізувавши теоретичні аспекти психологічної готовності до материнства ми дійшли висновку, що на психологічну готовність до материнства впливає ряд чинників як біологічних, так і особистісних і соціальних. Велику роль грають знання жінки про особливості психічного та фізичного розвитку дитини. На готовність до материнства так само впливають мотивація жінки стати матір'ю, її потреби та пізнання в материнстві, усвідомлення важливості своєї ролі як матері, її емоційне ставлення до материнства. Рівень психологічної готовності до материнства визначається сумарним ефектом дії позитивних і негативних чинників до того моменту, коли жінка стає матір'ю. Отже, чим більше позитивних чинників,

що впливають на розвиток суб'єктного ставлення до майбутньої дитини, діяло на жінку протягом її життя, чим яскравіше виражено суб'єктне ставлення до ненародженої дитини, тим вище буде рівень її психологічної готовності до материнства. Поруч з цим, значний вплив на рівень психологічної готовності до материнства має вік майбутньої матері, індивідуальні особливості характеру, мотиви материнства та наявність і розвиток у неї зазначених складових психологічної готовності до материнства.

Література.

1. Вишньовський, В.В. Формування психологічної готовності жінки до материнства – 2016: Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів. Актуальні задачі сучасних технологій, С. 301-302.
2. Гомонюк, О. М. Особливості психологічної готовності до материнства. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Психологія : електрон. наук. фахове вид. 2017, С. 24-28.
3. Кулик, А. В. Вивчення материнства в історичному аспекті. Філософія в сучасному світі – Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Харків, 20-21 листопада), 2020, С. 282–285.
4. Куц, С. В. Формування особистісної готовності жінки до материнства. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017. С. 114-117.
5. Магдисюк Л.І. Психологічна готовність української молоді до материнства. Електронний ресурс. Режим доступу: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/20886/1/mahdysiuk_demchuk.pdf
6. Райдужка С. Вебінар Психологічна готовність до материнства. Електронний ресурс. Режим доступу: <https://www.youtube.com/watch?v=QbiHx7udCd4>
7. Щербак, Т. І. Психологічна готовність жінки до материнства. Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць, 2019, С. 251-254.

1.17. Ставлення внутрішньо переміщених осіб до життєвої кризи та її подолання

*Мілютіна К.Л.
Мозгун С. А.*

Актуальність. Усвідомлення життєвої кризи, особливо у контексті внутрішньо переміщених осіб, є складним процесом, який охоплює різноманітні аспекти їхнього емоційного, соціального та культурного досвіду. Цей процес пов'язаний із глибокими особистими трансформаціями, що впливають на всі рівні існування людини. Людина, яка стикається з кризою такого масштабу, як втрата дому, переміщення чи зміна звичного середовища, опиняється перед необхідністю переосмислити власну ідентичність, роль у суспільстві, а також знайти новий сенс життя. Життєва криза, спричинена цими обставинами, спонукає до активізації внутрішніх ресурсів і, водночас, викликає значний дистрес, що може мати як руйнівні, так і конструктивні наслідки [3, с. 17].

Психологічний стан внутрішньо переміщених осіб зазвичай характеризується інтенсивними емоційними переживаннями, серед яких домінують тривога, стрес, страх перед невідомістю, відчуття втрати та безсилля. Втрата стабільності, що супроводжується вимушеним переселенням, створює велику емоційну напругу, оскільки люди стикаються з неможливістю контролювати своє життя в нових умовах. Умови, в яких опиняються переселенці, сприяють формуванню почуття невизначеності, яке може перерости у хронічний стрес, особливо якщо людина довгий час не може адаптуватися до нового середовища або знайти підтримку. У таких випадках психічне здоров'я може зазнавати значних негативних змін, включно з розвитком депресії, посттравматичного стресового розладу або інших психосоматичних розладів.

Емоційний стан внутрішньо переміщених осіб часто супроводжується глибоким переживанням втрати. Ця втрата може стосуватися не лише фізичного місця проживання, а й соціальних зв'язків, професійної діяльності, відчуття безпеки та звичного способу життя. У таких умовах людині важко зберегти

відчуття власної значущості, особливо якщо вона опиняється в середовищі, де їй доводиться постійно доводити свою спроможність інтегруватися, працювати чи взаємодіяти з новими соціальними групами. Ці фактори сприяють посиленню внутрішнього конфлікту, який впливає на здатність приймати важливі рішення, відновлювати мотивацію чи планувати майбутнє [7, с. 28].

Мета. Дослідити ставлення внутрішньо переміщених осіб до життєвої кризи та її подолання.

Результати дослідження. Соціальні та культурні фактори відіграють значну роль у формуванні ставлення внутрішньо переміщених осіб до життєвої кризи. Середовище, в якому опиняються переселенці, впливає на їхнє сприйняття себе та своєї ролі у новому контексті. Якщо середовище проявляє ворожість або байдужість, це може посилювати відчуття ізольованості, яке стає бар'єром для адаптації. Однак якщо людина стикається з підтримкою з боку громад, соціальних інститутів або близьких, це може значно полегшити процес інтеграції та сприяти формуванню почуття приналежності. У такому випадку переселенці сприймають кризу не як загрозу, а як можливість переосмислити своє життя, створити нові соціальні зв'язки та адаптуватися до змін.

Культурний контекст також має визначальний вплив на сприйняття кризи. Люди з різних культурних середовищ можуть по-різному реагувати на виклики. Наприклад, культура, яка підкреслює важливість колективної підтримки та спільної відповідальності, може забезпечувати сильнішу мережу підтримки для переселенців. Навпаки, культури, орієнтовані на індивідуалізм, можуть стимулювати самостійний пошук рішень, що часто супроводжується більшою ізоляцією. Крім того, культурні уявлення про кризу та її подолання впливають на способи адаптації. У деяких випадках криза сприймається як природна частина життя, що спонукає до духовного зростання, тоді як в інших контекстах вона може бути джерелом сорому або відчуття провини.

Інтерпретація життєвої кризи як можливості чи загрози залежить від багатьох факторів, включно з особистісними рисами, попереднім досвідом, рівнем підтримки та об'єктивними умовами. Деякі внутрішньо переміщені особи

сприймають кризу як виклик, який може мотивувати до розвитку нових навичок, створення альтернативних сценаріїв життя чи переосмислення цінностей. У таких випадках криза стає каталізатором для змін, сприяючи особистісному зростанню та підвищенню стійкості. Інші, навпаки, відчують кризу як загрозу, яка підриває основи їхнього існування та спричиняє емоційне виснаження. Такі особи можуть опинитися в пастці власних страхів, уникати змін і зосереджуватися на втраті, що знижує їхню здатність до адаптації [8, с. 16].

Ставлення до кризи також визначається рівнем розвитку механізмів копіngu, які застосовують переселенці. Адаптивні механізми, такі як пошук соціальної підтримки, конструктивне вирішення проблем, рефлексія та розвиток внутрішніх ресурсів, дозволяють більш ефективно справлятися з викликами. У той час як дезадаптивні стратегії, такі як уникання проблем, звинувачення себе або інших, можуть ускладнювати подолання кризи та збільшувати ризики розвитку психологічних розладів. Таким чином, успішне подолання життєвої кризи значною мірою залежить від того, наскільки людина здатна мобілізувати свої внутрішні та зовнішні ресурси для адаптації до нових умов. Процес переосмислення життєвої кризи може бути не лінійним і залежати від багатьох змінних. Зокрема, фактори часу, стабільності нових умов проживання, доступу до ресурсів та послуг, а також рівень інтеграції у нове середовище можуть визначати, чи буде криза сприйматися як тимчасова перешкода чи як хронічна проблема. Ті особи, які отримують можливість відновити своє соціальне та економічне становище, швидше інтерпретують кризу як етап, що веде до нових можливостей. Водночас люди, які стикаються з постійними труднощами, можуть зберігати негативне ставлення до свого досвіду, що ускладнює їхню інтеграцію.

Стратегії подолання життєвої кризи, особливо в контексті внутрішньо переміщених осіб, формуються на перетині багатьох факторів, які визначають поведінку, емоційні реакції та соціальну інтеграцію індивіда. Однією з ключових стратегій є пошук ресурсів, що забезпечують можливість адаптації до нових умов життя. Ресурси, які використовуються для подолання кризи, поділяються на внутрішні та зовнішні. Внутрішні психологічні резерви включають такі якості, як

стійкість, здатність до саморегуляції, оптимізм та віра у власні сили. Ці риси є основою для формування позитивного ставлення до кризи як до виклику, який можна подолати. Зовнішні ресурси охоплюють соціальну підтримку з боку родини, друзів, громади, а також доступ до матеріальних і фінансових засобів, які допомагають забезпечити базові потреби.

Роль соціальної підтримки у подоланні кризи є незаперечною. Соціальні зв'язки виступають не лише джерелом емоційної підтримки, але й засобом отримання інформації, практичної допомоги та мотивації. Переміщені особи, які мають доступ до підтримки з боку соціальних мереж, демонструють більшу здатність до інтеграції у нове середовище, оскільки підтримка сприяє зниженню рівня стресу та тривожності. Проте соціальна підтримка має бути ефективною, тобто адекватно відповідати потребам людини. У випадку недостатньої чи неадекватної підтримки, це може призводити до зростання емоційного виснаження та поглиблення почуття ізоляції [2, с. 65].

Внутрішні резерви особистості визначають здатність долати кризові ситуації. Психологічна стійкість, як основна характеристика, дозволяє людині не лише справлятися з труднощами, а й отримувати з них досвід, який сприяє розвитку особистості. Внутрішні ресурси формуються під впливом багатьох факторів, зокрема попереднього досвіду подолання криз, наявності навичок саморефлексії та здатності до саморегуляції. Люди, які володіють розвиненою емоційною компетентністю, здатні краще розуміти свої почуття та управляти ними, що зменшує ризик виникнення хронічного стресу.

Іншою важливою стратегією є розвиток адаптивних навичок, які дозволяють людині ефективно реагувати на нові виклики. Зміна способу мислення є ключовим елементом цього процесу. Когнітивна реструктуризація, як метод роботи з думками, спрямована на перетворення деструктивних уявлень про кризу у конструктивні. Людина, яка здатна переосмислювати негативний досвід як можливість для змін, значно підвищує свою здатність до адаптації. Навчання новим умінням, таким як управління ресурсами, планування або комунікація, сприяє

кращій орієнтації у нових умовах. Крім того, важливу роль відіграє поведінкова гнучкість, яка дозволяє змінювати стратегії дій залежно від ситуації.

Зміна поведінкових стратегій передбачає перехід від реактивного до проактивного підходу до вирішення проблем. Людина, яка активно шукає шляхи вирішення проблеми, має більше шансів на успіх, ніж та, яка зосереджена на уникненні труднощів. Проактивність сприяє розвитку самостійності, формуванню впевненості у власних силах і зниженню залежності від зовнішніх обставин. У цьому контексті велику роль відіграє навчання нових способів вирішення проблем, що дозволяє більш раціонально використовувати наявні ресурси.

Застосування механізмів психологічного захисту є ще одним засобом подолання кризи. До основних механізмів належать когнітивна реструктуризація та емоційне саморегулювання. Когнітивна реструктуризація дозволяє змінити спосіб інтерпретації ситуації, знижуючи рівень дистресу та посилюючи відчуття контролю. Цей процес включає усвідомлення автоматичних думок, аналіз їхньої реалістичності та заміну деструктивних переконань більш конструктивними. Емоційне саморегулювання, у свою чергу, спрямоване на зниження інтенсивності негативних емоцій, таких як страх, тривога чи злість, що сприяє збереженню психологічного балансу. Ефективне використання механізмів саморегулювання можливе за умови розвитку усвідомленості та емоційної гнучкості. Усвідомленість, або здатність зосереджувати увагу на теперішньому моменті без оцінок, дозволяє уникнути катастрофізації майбутніх подій і зосередитися на актуальних діях. Емоційна гнучкість допомагає змінювати емоційну реакцію залежно від контексту, що забезпечує краще пристосування до нових умов. Досягнення емоційної рівноваги потребує активного використання таких технік, як релаксація, дихальні практики чи медитація, які сприяють зниженню рівня стресу [6, с. 8].

У процесі подолання кризи людина стикається з необхідністю гармонізувати свої когнітивні, емоційні та поведінкові стратегії. Це потребує інтегрованого підходу, який враховує всі аспекти особистості. Такий підхід передбачає використання всіх доступних ресурсів, розвиток адаптивних навичок та

застосування механізмів психологічного захисту. Лише за умови поєднання цих складових можна досягти стійкого результату у подоланні кризи.

Подолання життєвої кризи для внутрішньо переміщених осіб має глибокі наслідки, які трансформують їхню особистість, цінності та спосіб взаємодії із зовнішнім світом. Одним із найсуттєвіших результатів цього процесу є формування стійкості. Стійкість визначається як здатність людини адаптуватися до змін, долати труднощі й зберігати психічну рівновагу навіть у несприятливих умовах. Вона розвивається на основі досвіду, отриманого під час подолання кризи, і сприяє зростанню впевненості у власних силах. Людина, яка пройшла через складні обставини, зазвичай демонструє кращу здатність до саморегуляції, підвищену толерантність до стресу і більше довіряє своїм ресурсам для вирішення майбутніх викликів. Цей досвід також сприяє розвитку самопізнання, допомагаючи усвідомити власні межі і можливості, що має вирішальне значення для подальшого зростання.

Формування стійкості в умовах кризи включає кілька етапів. Спершу людина стикається із шоком і розгубленістю, що супроводжуються відчуттям втрати контролю. Згодом, через пошук ресурсів і адаптацію до нових умов, формується нове ставлення до себе і свого середовища. Цей процес сприяє зміцненню психологічного захисту та закладає основу для конструктивного реагування на труднощі в майбутньому. Стійкість стає не лише індивідуальною рисою, а й колективною якістю, якщо людина отримує підтримку від спільноти чи родини. Взаємодія з іншими людьми в умовах кризи розвиває відчуття співпричетності, яке відіграє роль каталізатора для подолання ізоляції і відновлення соціальної активності [4, с. 37].

Одним із результатів переживання кризи є також переосмислення життєвих цінностей і пріоритетів. Цей процес нерідко включає кардинальні зміни в уявленнях про майбутнє, особисті цілі та важливість певних аспектів життя. Люди, які долають кризу, починають більше уваги приділяти аспектам, які раніше здавалися другорядними, таким як сімейні стосунки, здоров'я чи самореалізація. Водночас деякі зовнішні цілі, пов'язані з матеріальним добробутом або

професійними досягненнями, можуть втратити свою значущість на тлі нового розуміння сенсу життя. Це не лише змінює спосіб мислення, а й сприяє перегляду поведінкових стратегій, що впливають на якість життя.

Зміна цінностей багатовимірним процесом, який формується під впливом багатьох факторів, зокрема характеру кризи, інтенсивності її переживання та рівня доступної підтримки. У ситуаціях, коли людина вимушена змінити місце проживання, вона зустрічається з численними викликами, серед яких адаптація до нового соціального, культурного та емоційного середовища. Ця адаптація супроводжується необхідністю перегляду звичних переконань і моделей поведінки, що створює умови для розвитку відкритості до незнайомих ідей, підходів і досвідів. Такі обставини стимулюють гнучкість мислення, яка стає основою для пошуку нових рішень і способів існування у змінній реальності. Процес переоцінки цінностей часто пов'язаний із переживанням втрати, яка може бути як матеріальною, так і психологічною. Втрата старого «я», сформованого в попередніх умовах, може викликати почуття розгубленості або навіть болю. Проте, саме це відчуття втрати дає простір для переосмислення себе, своїх потреб і прагнень, а також для усвідомленого вибору нових життєвих орієнтирів. Такий перехід сприяє формуванню нової ідентичності, яка часто ґрунтується на особистій рішучості та прагненні досягти гармонії в новому середовищі. Це не лише дає змогу адаптуватися до змін, але й відкриває шляхи до самореалізації у нових умовах.

Для людей, які зазнали переміщення, подібні трансформації мають особливе значення, адже саме вони стають фундаментом для інтеграції у нову спільноту. Здатність приймати зміни, будувати нові зв'язки та встановлювати нові пріоритети дозволяє не лише зберігати внутрішню рівновагу, але й забезпечувати стійкість у складних обставинах. Це допомагає не тільки пристосуватися до нового середовища, але й знайти в ньому можливості для зростання та розвитку, що в перспективі може сприяти створенню нового, більш гармонійного образу життя [1, с. 10].

Соціальна інтеграція є ще одним наслідком подолання життєвої кризи. Переміщені особи часто опиняються у середовищі, яке суттєво відрізняється від

їхнього звичного соціокультурного контексту. Це створює додаткові виклики для відновлення стабільності. Успішна інтеграція залежить від здатності формувати нові зв'язки, налагоджувати стосунки і включатися в життя спільноти. Соціальна інтеграція забезпечує людині доступ до підтримки, інформації та ресурсів, які необхідні для подолання кризи. Вона також створює відчуття належності, що є критичним для відновлення емоційного комфорту і довіри до зовнішнього світу. Процес соціальної інтеграції включає кілька рівнів. На індивідуальному рівні це здатність до міжособистісної комунікації, відкритість до нових соціальних норм і готовність до взаємодії. На колективному рівні це підтримка з боку громади, створення умов для участі в соціальному житті і визнання внеску переселенців у спільноту. Формування нових соціальних зв'язків сприяє зменшенню відчуття ізоляції та стимулює подальший розвиток адаптивних навичок, які забезпечують успішну інтеграцію.

Висновки. Узагальнюючи викладений матеріал, можна зробити висновок, що ставлення внутрішньо переміщених осіб до життєвої кризи визначається як індивідуальними, так і зовнішніми чинниками. Ця група людей часто стикається зі значними емоційними, соціальними та економічними викликами, що змушують їх переосмислювати свої життєві цінності, адаптуватися до нових умов та шукати шляхи подолання труднощів. Ефективні стратегії подолання кризи включають мобілізацію внутрішніх і зовнішніх ресурсів, розвиток адаптивних навичок та механізмів саморегуляції, що дозволяють справлятися зі стресом і зберігати баланс.

Подолання кризи має значні наслідки, які трансформують особистість. Формується стійкість, переглядаються життєві пріоритети, відбувається соціальна інтеграція, яка є необхідною умовою відновлення стабільності. Таким чином, криза може бути не лише джерелом труднощів, а й платформою для особистісного розвитку, створюючи нові можливості для зміцнення ідентичності та соціального включення.

Література.

1. Вимушені переселенці та приймаючі громади. Наук. доп. Київ. 2016. 140 с.
2. Горобченко А.С. Особливості психологічної допомоги внутрішньо переміщеним особам з подолання криз зміни способу життя. Запоріжжя. ЗНУ. 2023. 65 с.
3. Кисельова О.І. Війна в Україні та вимушена міграція як чинники впливу на міграційну політику ЄС. Scientific notes of Lviv University of Business and Law. 2023. № 6. С. 137–144.
4. Лібанова Е. Цимбал О. Масштаби та наслідки вимушеної міграції населення України внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Demography and social economy. 2022. № 48.2. С. 37–57.
5. Павлів-Самоїл Н.П. Вимушена міграція. Міжнародні стандарти внутрішньо переміщених осіб у національному законодавстві. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2019. № 24. С. 35–40.
6. Садова У.Я. Інтереси внутрішньо переміщених осіб в епіцентрі інституційних зусиль української держави. Регіональна економіка. 2016. № 1. С. 8–12.
7. Сафін О. Кузьменко Ю. Особливі умови життєдіяльності та адаптаційний потенціал особистості. Хмельницький. Видавництво НАДПСУ. 2016. № 1 (3). 268 с.
8. Соловійов Є.В. Внутрішньо вимушена міграція як об'єкт державного регулювання. Теорія та практика державного управління. 2016. № 3. С. 146–150.
9. Afanasieva N. Bosniuk V. Deinychenko L. Kholodnyi O. Mykhliuk E. Ostopolets I. Quality of life of internally displaced persons in Ukraine. International Relations 2017. Bratislava. 2017. P. 44–57.

1.18. Психологічні чинники виникнення агресивно-девіантної поведінки у учасників навчально-виховного процесу та шляхи їх подолання

Могилко Т. Р.

Актуальність. Агресія та девіантність вивчається з різних сторін психологами, соціологами, педагогами, філософами і т. ін. Проте «інтегруючим центром» вивчення цієї проблеми є психологія. На сьогоднішній день існує велика кількість теорій, які визначають чинники агресії та девіації, що дає можливість їхнього широкого використання на практиці. Агресія – індивідуальна поведінка людей, яка є інстинктивною, вона спрямована на пошкодження або руйнування. Агресивність як риса особистості може зумовлюватися несприятливим соціальним і психологічним досвідом [7, с. 10]. Девіація – поведінка особистості, яка не відповідає загальному стандарту. Тобто, це такий вид поведінки, який суперечить прийнятим у суспільстві правовим, моральним, соціальним нормам та стереотипам. Проблеми проявів агресії привертали увагу багатьох вчених. Т. Хоббс вважав, що агресія закладена у підсвідомості. З. Фрейд написав «теорію двох інстинктів». Л. Берковіц вивчав значення слова «агресія». А. Бандура розглядав агресію як поведінку. Д. Доллард, Н. Міллер, Л. Берковіц розглядали агресивність як наслідок розбіжностей між рівнем потреб і рівнем можливостей особи. Н. Костенко досліджував вплив статевих та індивідуально-психологічних відмінностей на прояв агресії у підлітків. Агресивність як стан має такі складники: когнітивний, що забезпечує орієнтування суб'єкта в ситуації; емоційний, що виявляється в емоційних станах суб'єкта; вольовий, що забезпечує агресивно налаштованому суб'єкту досягнення його мети.

Мета. Виявлення чинників, які спричиняють появу агресивно-девіантної поведінки у учасників навчально-виховного процесу, а також екологічні способи їх подолання.

Результати дослідження. На сьогодні існує величезна кількість визначень агресії. Ряд вчених, таких як: Ф. Аллан, А. Адлер, Л. Бендер, під агресією розуміли невід'ємну та позитивну якість свідомості, живої матерії, яка здатна спрямувати

активність, діяльність, а також внутрішню силу до виживання. Все це дає людині можливість протистояти зовнішньому впливові, змагатися, боротися за першість, відчувати себе не об'єктом, а суб'єктом. Ряд інших вчених, таких як: Д. Річардсон, Р. Берон, Ф. Зімбардо, Х. Дельгадо розуміють її, як дію суто негативну, навіть ворожу, це погрози та атаки, які здатні викликати руйнування, заподіяння шкоди та страждань жертві, мається на увазі особі, та навіть суспільству в цілому.

Більшість вчених переконана у тому, що явище агресії є нелінійним. Це значить, що агресія має гнучкий перебіг і може змінювати свою спрямованість та зміст в залежності від соціальних та психологічних умов та факторів. Агресія є, на думку О. Кернберга, Х. Кауфма, О. Шваб та Е. Фромма, інструментом підтримки гомеостазу, психічної саморегуляції та цілісності організму. У тематичному психологічному словникові, укладеному О. Коваль, знаходимо визначення агресії як поведінки деструктивної та мотивованої, що суперечить правилам та нормам існування людей у суспільстві, агресія завдає руйнівної шкоди живим та неживим об'єктам нападу, і результатом агресії слід вважати нанесення людям психологічного і фізичного збитку чи дискомфорту [3, с. 13].

Розглянемо спочатку зовнішні причини агресивності: сім'я, у якій росте дитина. На жаль, багато батьків схильні до подвійних стандартів: на словах вони негативно ставляться до прояву агресії у дітей, бажають виховати дитину доброю, але в той же час заохочують прагнення дитини вирішити проблеми, що виникають, за допомогою сили. У дитячому колективі часто сила є значущою, особливо серед хлопчиків. Якщо дитина потрапляє в «бійцівський» клас або групу, вона підлаштовується під загальний «настрій», переймає поведінку лідера та має значні проблеми в спілкуванні з однолітками. В такому випадку необхідно поміняти дитячий колектив, тоді і поведінка дитини зміниться.

В сучасному світі діти часто споживають інформаційний контент, призначений для дорослої аудиторії: дивляться передачі, фільми, для дорослих – бойовики, випуски новин, основні теми яких – шантаж, насильство, вбивства, катастрофи, тероризм. Ті ж теми мусуються в газетах, в книгах, в комп'ютерних іграх. Психіка юнаків не захищена від згубного впливу агресії зовнішнього світу,

дитині необхідно підрости, зміцніти, до підліткового віку, коли він уже зможе адекватно оцінювати те, що відбувається навколо нього і захищатися від тиску навколишньої дійсності.

Внутрішні причини агресивності: агресивність – прояв внутрішнього дискомфорту, невпевненості; невміння адекватно висловлювати негативні емоції, контролювати себе; висока тривожність, відчуття знедоленої людини; неадекватна самооцінка (частіше занижена); прагнення привернути увагу дорослих.

Агресивність як властивість особистості відрізняється від ситуативної агресії, що виникає при небезпеці і проходить, коли людині нічого не загрожує. Ситуативна агресія абсолютно нормальна і навіть необхідна, її не варто коригувати. У подібних випадках важливо, щоб людина вміла висловлювати свої негативні емоції адекватно. Але буває так, що агресивність стає властивістю особистості. Причинами агресивної поведінки може служити особиста неприязнь, завищена або занижена самооцінка, особистісні якості, психологічна несумісність з певною людиною або групою людей, неузгодженість бажаного і реального результату. Крім того також агресивна поведінка може бути реакцією на стрес, викликаний змінами в житті у юнацькому віці, як наслідок адаптації або захисної реакції на вигадану загрозу.

Вчені розділяють комплекс демографічних, індивідуально-психологічних та соціально-психологічних факторів, які прямо чи опосередковано впливають на появу та особливості форми проявів агресії. Слід зазначити, що переважна більшість цих форм збігається з уже відомими факторами агресивної поведінки (насильство в сім'ї, вплив асоціальних субкультур однолітків, характерологічні особливості тощо).

Одним із основних чинників набуття особистістю підвищеної агресивності вважаються недоліки сімейного виховання, спостереження за моделями агресивної поведінки інших у реальному житті, на кіно- і телеекранах чи комп'ютерних іграх. Істотна роль у зародженні і формуванні готовності людини до агресії, а також у її реалізації відводиться і ситуативним чинникам, таким як вплив кліматичних умов, температури навколишнього середовища, підвищений шум, велике скупчення

людей, неприємний запах та тіснота у приміщенні, дискомфорт, зазіхання на особистий простір, вороже соціальне середовище, біль, виникнення стресової ситуації, очікування помсти за власні агресивні дії, вживання алкоголю, сексуальне збудження [1, с. 22].

Як особистісні фактори, які зумовлюють підвищення рівня агресивності, розглядають підвищену ворожість та дратівливість, підвищений рівень тривожності та депресії, підвищену емоційну реактивність, негативну афективність, перевищену самооцінку, певні особливості мотиваційної сфери, низький рівень розвитку інтелекту, антисоціальну спрямованість особистості, заздрісність, схильність приписувати оточуючим агресивні наміри тощо.

Серед чинників, які перешкоджають прояву агресивності, називають можливість покарання за агресію, любов, дружні стосунки, а також такі особистісні якості, як поміркованість, толерантність, завбачливість, безконфліктність, високий самоконтроль.

За даними дослідників, на процес розподілу ролей в агресивній ситуації впливають такі фактори: а) самооцінка власної поведінки в ситуаціях агресії; б) соціальне прийняття або неприйняття (ролі); в) соціальний статус. Також було виявлено, що існують гендерні відмінності у розподілі ролей в даних ситуаціях (чоловіки частіше виступають у ролі агресора, вони більше схильні до проявів агресії фізичного типу, а дівчата – до вербальної та соціальної).

Одним із найпоширених проявів агресивної поведінки є третирування інших людей.

Головною рисою феномена третирування, яке відрізняє його від окремого агресивного вчинку, є систематичність, регулярний характер прояву. В основі відносин між жертвою та агресором лежить нерівність фізичних або соціальних можливостей (різниця в силі чи в соціальному статусі); інакше кажучи, це насильство сильної людини над слабкою, взаємовідносини переслідувача і жертви.

Агресія призводить до збільшення форм девіантної поведінки серед молоді (вандалізм, крадіжки, вживання алкоголю, наркотиків); погіршенню соціально-психологічного клімату в закладах освіти. Оскільки агресивна ситуація за своїми

характеристиками є різновидом інтенсивної тривалої стресової ситуації, то вона має серозні психологічні наслідки. Як жертви, так і самі агресори схильні до нервово-психічних розладів (різні розлади поведінки, депресії), що може призвести до скоєння кримінальних злочинів.

Форми прояву агресивності наступні: фізична агресія, непряма агресія, роздратованість, негативізм, образа, вербальна агресія.

Усі форми агресивності мають одну спільну рису: вони викликані спробами контролювати ситуацію, впливати на неї з метою вдосконалення або себе, або свого оточення, включаючи близьких людей. Реакція у вигляді агресивної поведінки приводиться в дію вродженими і набутими механізмами, певною внутрішньою мотивуючою силою.

Таким чином, причини агресивності ми знаходимо як в особливостях самої особистості, так і у впливі навколишньої дійсності, тому ця властивість часто визначається як амбівалентний феномен: з одного боку, як негативний прояв людини, з іншого – як пристосувальна функція особистості, спрямована на адаптацію людини до умов життя. У науковій літературі існує думка, що розумна агресивність є необхідністю для гармонійного розвитку особистості, умовою її успішної соціальної адаптації та здатністю долати перешкоди на своєму шляху, сприяє формуванню наполегливості, ініціативності та лідерства, вміння відстоювати свої ідеали і боротися за них. Зарубіжні психологи вказують на те, що відсутність у людини певного рівня агресивності може привести до пасивності і конформності її поведінки і, як наслідок, до зниження її соціального статусу і становища в суспільстві.

Організовуючи навчально-виховну роботу з неповнолітніми, необхідно враховувати, що на їхню поведінку й діяльність вагомий вплив має думка однолітків. У всіх своїх діях і вчинках вони орієнтуються перш за все на неї.

На сьогоднішній день гостро постає проблема вербальної агресії як з боку вчителів, так і з боку учнів та їхніх батьків. Вербальна агресія – це слова, які завдають болю і змушують людину повірити в те, що він чи вона позбавлений здібностей, що він або вона невірно сприймає оточуючий світ. Така агресія руйнує

людину зсередини. Наприклад, учень відчуває агресію, але його відчуття не сприймаються, його думка не береться до уваги, йому стає ще болючіше від відчуття самотності, покинутості й розчарування. Педагогу варто пам'ятати, що вербальна агресія наносить удар по самооцінці і здібностях дитини. В гіршому випадку така агресія може призвести до жахливих подій. Проте з вербальною агресією стикаються й самі вчителі під час розмов із учнями та їхніми батьками.

Така агресія може бути відкритою або прихованою. Відкрита агресія – це звинувачення в чомусь, чого дитина або педагог ніколи не робив і навіть не думав робити. Прихована агресія має більшу руйнівну силу, бо вона скерована на те, щоб підпорядкувати людину в такий спосіб, щоб вона сама не здогадувалася про це [2, с. 9].

Для того щоб налагодити контакт з людиною, потрібно навчитися слухати її та приймати, зважати на її думку. Наприклад, вчитель може долучати учнів до обговорення тем, які бентежать учнів, викликають емоційну зацікавленість. Такий спосіб допоможе зняти напругу та вирішити конфлікт, який тільки починає зароджуватися.

Отже, для того щоб уникнути вербальної агресії в навчально-виховному процесі необхідно навчитися слухати не тільки своїх колег, а й дітей та їхніх батьків. Давати можливість учням знаходити складові проблеми та шляхи її вирішення. Вчитель в такому випадку виступає виключно як провідник та спостерігач. Що стосується емоційного стану вчителів, потрібно пам'ятати про професійну деформацію, яка визначається як емоційне, розумове і фізичне виснаження (особливо під час повномасштабної агресії проти України). Такий стан стає небезпечним не тільки для вчителя, але й для його учнів.

Фундаментальними потребами неповнолітніх були і залишаються: потреба у спілкуванні з ровесниками в умовах спільної діяльності, потреба у самоактуалізації та соціальному статусі у групі ровесників. Система ціннісних орієнтацій неповнолітнього перебуває на стадії активного формування. Уявлення про цінності закладаються ще в дитинстві, та з віком відбувається їх трансформація. В учнів підліткової вікової категорії більш сформована ієрархія життєвих цілей за

недостатньої сформованості засобів їх досягнення, а це уповільнює проходження процесу інтеграції стереотипів соціально-цінної поведінки.

Працюючи з учнями, в першу чергу потрібно виявити страхи та сподівання підлітків. Саме в них приховані ті підказки, які допоможуть зрозуміти причини появи агресивно-девіантної поведінки в тій чи іншій групі людей. Вчитель таким чином може розвіяти певні страхи дітей та вивести їх на відверту розмову тим самим побудувавши відносини між учнем та вчителем, якому можна довіряти. Оскільки підлітковий вік – це період бунтарства та недовіри до оточуючого світу, наявність такого наставника, якому можна довіряти, зменшує ризик розвитку та погіршення агресивно-девіантної поведінки.

Варто також звернути увагу на коучингові практики «КОЛО» (їх різновидів існує велика кількість). Головна мета та перевага практики «КОЛО» полягає в тому, що кожен з учнів може висловити свою точку зору і може бути почутим. Така практика корисна для всіх учасників навчально-виховного процесу, оскільки саме завдяки їй люди можуть висловити все, що вони вважають за потрібне і не боятись осуду. Якщо підліткам в групі важко висловити свої власні емоції, то тут варто застосувати іграшку, за допомогою якої учні могли б розповісти про хвилюючі їх теми. Таким чином учень розповідає про свою проблему, але не напямую, а за допомогою іграшки-помічника, передаючи таким чином частину своїх хвилювань їй. Такі заняття допомагають зняти внутрішню напругу, а також мотивувати учнів. Тренінгові заняття варто проводити щонайменше 1 раз на місяць, при цьому до таких заходів потрібно залучати й самих батьків. Така злагоджена робота допоможе знизити ризики формування агресивно-девіантної поведінки у учнів, а також допоможе батькам краще зрозуміти своїх дітей, які перебувають в підлітковому перехідному віці. Що стосується інших учасників навчально-виховного процесу, то їм варто раз на 3-6 місяців проходити тренінги та отримувати психологічну консультацію, щоб запобігти вигорянню на робочому місці. Семінари та тренінги мають бути спрямовані на вирішення нагальних потреб вчителів та учнів, а не на загальні питання.

Висновки. Необхідно відзначити, що агресивність та девіантність виявляється у всіх людей, але у кожної людини вона характеризується різним рівнем і певними особливостями. Сила агресивно-девіантних реакцій, їхня частота, а також спрямованість і тривалість залежать від безлічі різних причин. Тому в кожному окремому випадку агресивність та девіантність повинна аналізуватися з точки зору впливу на людину фізіологічних, психологічних, соціальних та ситуаційних чинників. Однак, незважаючи на наявність психологічних, фізіологічних, соціальних факторів, основні причини та умови прояву агресивно-девіантності – це конфлікти (міжособистісні або внутрішньоособистісні, усвідомлювані або неусвідомлювані) [4, с. 86]. Таким чином, будь-який прояв агресивної-девіантності є наслідком невдоволення людини навколишньою дійсністю, рівнем свого життя, іншими людьми або ж самим собою.

Література.

1. Бернацька, І. Школа без агресії. Формування ненасильницького простору в НУШ. Соціальний педагог. 2019. № 5. С. 22–24.
2. Демощук, М. На словах. Вербальна агресія як форма психологічного насильства. Психолог. 2020. № 6. С. 8–19.
3. Коваль О. Тематичний словник-довідник з психології та педагогіки. Тернопіль: ТНЕУ, 2013. 138 с.
4. Нев'якіна, Н. Профілактика насильства та агресії. Семінар-тренінг для педагогів. Психолог. 2019. № 12. С. 84–96.
5. Павелків В.Р. Психологічні засоби корекції міжособистісних стосунків у підлітків з агресивною поведінкою : автореф. дис ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Віталій Романович Павелків. Київ : Б.в., 2006. 20 с.
6. Поліщук, М. Стоп агресії. Практичне заняття для педагогів. Соціальний педагог. 2019. № 10. С. 37–47.
7. Психологічна енциклопедія / Автор-упорядник О.М. Степанов. К.: «Академвидав», 2006. – 424 с.

1.19. Теоретична генеза поняття «віктимна поведінка» у психологічній літературі

*Морозова О. В.
Шпаляренко Т. О.*

Актуальність. Віктимність людей у сучасному світі, у світі панування соціальних мереж, набуває особливої актуальності. Але, чим більше стає таких контактів, тим більше з'являється невизначеності, складності та інформаційного різноманіття, що стають джерелами різних зіткнень між індивідами, що значно знижують поріг їхньої віктимогенної уразливості [6, с. 5]. Серед кримінологів з точки зору віктимології поняття «жертва» трактувалося як «потерпілий від злочину». Цікавим спостерігається той факт, що за одних й тих самих обставин люди поводять себе по-різному, а тому одні із них відчують себе «жертвами», а інші – шукають шляхи вирішення ситуації та не мають відповідної особистісної позиції. У літературі учення про жертву, віктимологія, визначається як наука, що досліджує людей, які стали жертвами внаслідок здійснення дій, що заподіяли їм значної шкоди. Даний підхід вивчає особистість та поведінку потерпілого в якості суб'єктивних ознак, що сприяють вчинення відносно неї злочину або потраплянні її у віктимогенно-небезпечну ситуацію [6, с. 7]. Дослідження кримінологів, соціологів, психологів показали, що віктимність є складним явищем не лише суб'єктивного, а значною мірою і об'єктивного характеру. На думку С. Пальчевського віктимологія це: «галузь знань, яка, будучи складовою частиною соціальної педагогіки, вивчає на міждисциплінарному рівні різноманітні категорії реальних та потенційних жертв несприятливих умов соціалізації...» [6, с. 173]. Метою віктимологічних досліджень є виявлення причин і умов, при яких індивід виявляється або перетворюється на жертву злочину. Значна кількість закордонних розглядали та продовжують розглядати віктимологію як складову частину кримінологічної науки й наполягають на вживанні терміну «кримінальна віктимологія» [6, с. 7].

Аналіз психологічної літератури дає підстави стверджувати, що підлітковий вік є достатньо інтенсивним періодом життя, що висуває особливі вимоги до особистості та її активності, адаптації у соціумі. Зазначений віковий період відрізняється високою інтенсивністю процесів соціалізації, у той же час характеризується відстоюванням підлітками власних кордонів. Період підліткового дорослішання характеризується інтенсивними пошуками свого місця у суспільстві, світі, системі соціальних стосунків, а також розширенням усвідомлення власних особливостей, здібностей з точки зору відповідності вимогам соціуму. Тому, почасти, підлітку необхідно погоджувати свої потреби з очікуваннями оточуючих та вимогами соціальних норм. Необхідність такого погоджування часто пов'язана із значними труднощами, котрі й стають причиною виникнення суперечностей у розвитку підлітка. Ці суперечності можуть бути в гострій формі, зумовлюючи сильні емоційні переживання, порушення у поведінці та взаєминах із дорослими та ровесниками [2; 3; 5; 17].

Мета. Проаналізувати теоретичні підходи та тлумачення поняття «віктимна поведінка» у психологічній літературі; розглянути чинники виникнення віктимної поведінки у підлітків на різних вікових етапах.

Результати дослідження. Поведінка є процесом взаємодії особистості разом з оточенням, яка вміщує у собі всі варіанти активності. Поведінка, як показник сутності людини, залежить від ситуації, у якій опиняється особистість. Практично кожна особистість проживає своє життя, так як від неї цього прагне система, в якій вона знаходиться. Вона виконує ті ролі, що представляють їй потрібні позиції і статуси. Вид стосунків підлітка з оточенням формує самотність його характеру, а саме від норм, цінностей, рольових приписів. Слід зазначити, що поведінка, що відноситься до норм безпеки, розуміють як нормативно-схвальну, а поведінку, в якій прослідковуються різні відхилення – як аномальну.

Д. Рівман твердить, що уперше термін «віктимна поведінка» виник на теренах кримінальної віктимології. Віктимологія (viktima – жертва, logos – вчення) у буквальному перекладі означає «вчення про жертву». Це загальна теорія, предметом дослідження якої є жертва будь-якого походження, як кримінального, так і не

пов'язаного зі злочинами: жертви нещасних випадків, природних і техногенних катастроф, епідемій, воєн та інших збройних конфліктів, політичних протистоянь, а також різних видів насилля, зокрема сексуального, та адиктивної поведінки [2; 3; 5].

Науковці-психологи до базових понять віктимології відносять поняття «віктимність або віктимогенність» – це набуті людиною фізичні, психічні та соціальні риси й ознаки, які можуть зробити її схильною до перетворення на жертву різних обставин, груп осіб, організацій тощо та віктимізація – процес набуття віктимності [9]. Акцентуємо увагу на тому, що вперше поняття «віктимність» увійшло до наукового вжитку завдяки Л. Франку і його праці «Віктимологія та віктимність». На думку науковця, поведінка особи може бути не лише злочинною, а й віктимною – легковажною, ризикованою, необачною, тобто небезпечною для себе. Дослідник розглядав її як певне явище та спосіб дії певного індивіда – жертви злочину, потенційну чи актуальну здатність людини індивідуально чи колективно ставати жертвою соціально небезпечної поведінки. Він наголошував, що віктимність існує у двох формах – потенційній та реалізованій – і може бути зменшена або збільшена (процес віктимізації) [10]. Звернемо увагу, що єдиного визначення поняття «віктимність» та «віктимна поведінка» не існує (табл.1).

Таблиця 1

Трактування поняття «віктимності та віктимної поведінки»*

Автор	Суть поняття
Л. Франк	визначає віктимність як реалізовану або потенційну здатність особистості стати за певних обставин жертвою злочину (або нездатність уникнути небезпеки там, де це об'єктивно можна було зробити)
В. Голіна, Б. М. Головкін	«У широкому змісті віктимологія – це комплексне вчення про осіб, які перебувають у кризовому стані (жертва злочину, стихійних лих, епідемій, катастроф, геноциду, озброєних конфліктів, економічного і соціального відчуження, політичних протистоянь, біженець, соціальні організації та ін.), і заходах допомоги їм» [4, с. 11.].
Д. Рівман	виділяє «нормальну», «середню» і «потенційну» віктимність, роблячи акцент на тому, що за певної життєвої ситуації будь-хто може стати жертвою, тобто не набуває віктимності, а просто не є невіктимним
А. Репецька	виокремлює чотири різновиди віктимності: віктимогенна деформація як сукупність соціально-психологічних властивостей, пов'язаних з несприятливими обставинами соціалізації та незадоволеністю соціальною адаптацією; професійна або рольова; вікова – як біофізична властивість (сюди ж відносять людей з інвалідністю); віктимність-патологія тобто наявність патологічних станів

У психологічному сенсі трактування поняття «віктимність» містить сенси емоційно-вольових властивостей особистості, пізнавальні та мотиваційні фактори; а також залежать від психічних станів, які домінують у момент конкретної загрози; від рівня спеціальної підготовки до дій у ситуаціях, що загрожують життю людини.

До чинників віктимізації людини можна віднести фактори соціалізації: мікрочинники – сім'я, групи однолітків і субкультура, мікросоціум, релігійні організації; мезофактори і етнокультурні умови, регіональні умови, засоби масової комунікації; макрофактори: світ, країна, суспільство [6].

Віктимність можна охарактеризувати як схильність індивіда стати жертвою несприятливих обставин або інших людей. У буквальному розумінні віктимність – це жертвовність, а віктимними є особи, які через об'єктивні чи суб'єктивні чинники можуть стати жертвами чого-небудь. Проявами цього може бути відсутність в індивіда бажання відстоювати свою позицію та нести відповідальність за власні вчинки, що спричиняє підкорення більш сильним особам [1; 5; 7;].

Інші дослідники (Бовт О. Б., Гарькавець С. О., Докторович М. О., Мойсєєва О. Є. та ін.) викладають думку, що негативні дії індивіда обумовлюються соціальним оточенням: віктимність – це особливості особистості та поведінки індивіда (покірність, навіюваність, невміння постояти за себе, необережність, довірливість, легковажність, недиференційована товариськість, психічні розлади), що накликають на неї агресію з боку інших людей. Слід зазначити, що проблема людини як жертви несприятливих умов соціалізації не так давно постала в соціально-педагогічному контексті, але не є новою для деяких галузей людинознавства, і тим більше для соціальної практики [5].

Зародившись на теренах кримінології, дослідження проблеми віктимності вийшло з її вузьких меж і, як зазначає М. Докторович, «гостро постає проблема зміщення акцентів вивчення цього явища в площину психології і соціальної педагогіки» [7]. Окрім того, С. О. Гарькавець [6, с. 37] стверджує, що віктимологія як наука включає в себе не тільки кримінологічні аспекти, а і відбиває соціально-психологічні особливості індивіда, який став жертвою злочину, тому буде

небезпідставним наполягати саме на міждисциплінарному, інтегративному характері даної науки.

Для системного розгляду в руслі соціальної педагогіки такого фундаментального соціального явища, як людина-жертва несприятливих умов соціалізації, необхідна розробка самостійної галузі знання – соціально-педагогічної віктимології. Одним із перших у соціально-педагогічній науці до питань віктимології звернувся А. Мудрик [11]. Зокрема, він визначає, що соціально-педагогічна віктимологія – це галузь знання, що входить як складова частина в соціальну педагогіку, вивчає різні категорії людей – реальних чи потенційних жертв несприятливих умов соціалізації, їхній розвиток і виховання.

Конкретизуючи запропоноване визначення, дослідник визначає соціально-педагогічну віктимологію як галузь знань, в якій: а) на міждисциплінарному рівні вивчається розвиток людей з фізичними, психічними, соціальними і особистісними відхиленнями, а також тих, чий статус (соціально-економічний, правовий, соціально-психологічний) в умовах конкретного суспільства зумовлює або створює передумови для нерівності або дефіциту можливостей для «життєвого старту» і (або) фізичного, емоційного, психічного, культурного, соціального розвитку та самореалізації; б) розробляються загальні та спеціальні принципи, цілі, зміст, форми і методи профілактики, мінімізації, компенсації та корекції тих обставин, унаслідок яких людина стає жертвою несприятливих умов соціалізації [12].

В «Енциклопедії для фахівців соціальної сфери» визначено, що предметом соціально-педагогічної віктимології є вивчення дітей і дорослих, які опинилися у складних життєвих обставинах і потребують спеціальної соціальної та педагогічної допомоги (люди з особливими потребами, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з сімей, де є прояви насильства, низький економічний рівень, біженців та ін.) [8, с. 22]. Тобто з точки зору соціальної педагогіки термін «віктимність» розглядається через призму складних життєвих обставин, у яких опинився індивід, детермінованих соціальним середовищем, і які спричиняють його позицію жертви.

О. Шишко [16] вказує, що у кримінології поняття «жертва» може розглядатися у двох аспектах: у вузькому тлумаченні під поняттям «жертва» розуміють особу, що постраждала внаслідок злочинних діянь; у широкому – будь-яку особу, яка зазнала страждань від насилля, нещастя, невдачі, або навіть «внаслідок відданості чомусь».

На думку психологів, люди свідомо або несвідомо обирають «роль жертви» у соціальному середовищі (установка на безпорадність, небажання змінювати власне становище без втручання ззовні, низька самооцінка, заляканість, засвоєння віктимних стереотипів з боку суспільства), постійно втягуються у різні криміногенні кризові ситуації з підсвідомою метою одержання підтримки, виправданості рольової позиції жертви.

«Аналіз літератури свідчить про те, що в багатьох роботах виокремлюють три основні типи віктимної поведінки: 1) активна – поведінка жертви, яка спровокувала злочин; 2) інтенсивна – здійснення жертвою позитивних дій, які тим не менше призвели до злочину; 3) пасивна – бездіяльна, коли жертва не чинила супротив [1]». «У якості таксономічної ознаки, на підставі якої розробив систематизацію Д. В. Рівман [5], обрано характер і ступінь прояву особистісних якостей людини, які окреслюють особистісну віктимну приналежність. У результаті дослідником були описані наступні типи віктимної поведінки: універсальний тип – із чіткими особистісними прикметами, які є передумовами високої потенційної вразливості по відношенню до різноманітних злочинів; вибіркового типу – особи із високою віктимною чутливістю; ситуативний тип – особи, яким властивий середній рівень віктимності та які можуть стати жертвою за умови певного збігу обставин; випадковий тип – особи, які можуть стати жертвами випадково; професійний тип – віктимізація даних людей пов'язана з їх фахом» [5].

Особливої уваги у контексті соціально-педагогічної діяльності потребують діти підліткового віку. Як відомо, підлітковий вік є перехідним у біологічному (статеве дозрівання і досягнення зрілості інших біологічних систем організму) та соціальному (зміна соціальних ролей, місця у системі соціальних стосунків) плані. Цей віковий період є важливою фазою у загальному процесі становлення

особистості, оскільки у ході вироблення нової структури та складу діяльності дитини закладається базис усвідомленої поведінки, формується загальна спрямованість у формуванні моральних і соціальних установок [5].

Підлітковий вік визначають періодом кризи, особистісної травмуючої адаптації та соціалізації. Це зумовлено, насамперед, численними зрушеннями, що відбуваються у цей час і спричиняють зміну попередніх інтересів, ставлень дитини. Ці зміни нерідко супроводжуються появою у підлітка значних суб'єктивних труднощів, посткризовий період (14-15 років), формування нових психологічних утворень (вибір професії, способу поведінки, самостійне прийняття рішень). Зважаючи на ці особливості, для підлітків важливо навчитися робити свій конструктивний життєвий вибір (у різних сферах життя) в умовах наявних соціальних, психологічних можливостей, що зменшить ризик виникнення віктимної поведінки [5]. На кожному віковому етапі існують бар'єри, зіткнення з якими може привести до того, що людина стає жертвою несприятливих умов соціалізації [5; 15] (табл. 2.).

Таблиця 2

Віковий етап та чинники виникнення віктимної поведінки

Віковий період	Вік	Чинники
молодший шкільний вік	6-10 років	спосіб життя батьків (особи, що їх замінюють: вітчим мачуха), матеріальне становище сім'ї; взаємодія в учнівському середовищі; негативний вплив однолітків або старших хлопців (залучення до куріння, до випивки, розкраданню); пригнічення; психічні та фізичні травми.
підлітковий вік	11-14 років	пияцтво, алкоголізм, аморальність батьків; куріння, токсикоманія; зґвалтування, розбещення; самотність; фізичні травми; цькування однолітків; залучення в антисоціальні і злочинні групи; часті переїзди родини.
старший підлітковий вік	15-17 років	антисоціальна сім'я, злидні сім'ї; пияцтво, наркоманія, проституція; залучення в злочинні групи; зґвалтування; фізичні травми; втрата перспективи, нерозуміння оточуючими, самотність; цькування однолітків, романтичні невдачі; суїцидальні устремління.

Розроблено автором на основі джерела [3; 11; 12; 16; 17].

Віктимогенність позначає наявність у певних об'єктивних обставинах соціалізації характеристик, рис, небезпек, вплив яких може зробити дитину

жертвою цих обставин. М. Шакурова [16; 17] вирізняє деякі механізми віктимогенності підлітків: вербальний принцип побудови навчального процесу, книжне вивчення життя. Некритичне сприйняття готової інформації приводить до того, що діти не можуть реалізувати природне прагнення пізнавати самостійно, втрачають здатність мислити самостійно; позбавлене взаємозв'язку поетапне оволодіння знаннями, уміннями й навичками руйнують цілісність сприйняття світу; надмірне захоплення методами інтелектуального розвитку на шкоду почуттєвому, емоційно-образному, що веде до роз'єднання інтелектуального й емоційного, до розпаду найважливішої функції психіки – уяви, і, як наслідок – до раннього формування шизоїдної психічної конституції; негативний вплив на дітей шкільних традицій: загальноприйнята поза дітей під час уроку (учень згорблений, напружений, тривале нерухоме сидіння на уроці та ін.); збіднене природне середовище, тобто закриті приміщення, обмежений простір, заповнений однотипними стендами, що не сприяє емоційно-почуттєвому сприйняттю світу, звуження зорових горизонтів, пригнічення емоційної сфери [16; 17].

Викладені вище механізми стосуються у першу чергу навчання як одного з головних видів діяльності для дітей підліткового віку. Разом з тим, віктимогенна група однолітків, спілкування з якою домінує, також створює механізми віктимізації конкретного підлітка. Варто зазначити, що віктимність у підлітковому віці формується під впливом середовища, у якому перебуває дитина. І таким середовищем є, перш за все, родина. Віктимна активність є формою дезадаптивної поведінки підлітка, за допомогою якої вона намагається опанувати тривогу, формується, виникає, розвивається і закріплюється саме в родинній системі, де підліток виконує певну специфічну роль. Ця роль завжди спрямована на збереження засад і нормативів цієї системи, а також на продовження її існування [2].

Віктимні підлітки – це діти, що жертвують своїм «Я» для того, щоб бути прийнятими родинною системою або такою, що її може замінити. Таким чином, на процес дезадаптації і формування віктимності впливають особливості психологічних захисних механізмів батьків, причому існують відмінності у впливі захисних механізмів батьків та матерів або людей, які їх замінюють і виконують

відповідні функції. Захисні механізми батьківської психіки разом з обраним стилем виховання формують тривожність, навіюваність і агресивність як базові особистісні риси підлітка, його захисні механізми і, тим самим, тип особистісної організації підлітка та поведінкові форми його боротьби з тривогою. Віктимна поведінка – це будь-яка форма поведінки, якщо її можна визначити як провокативну [3; 14]. С. О. Гаркавець [6] переконує в тому, що небезпека віктимності підлітків пов'язана з тим, що вони мають труднощі у взаємовідносинах з близькими людьми, поверховість почуттів, звичку жити за вказівкою, прояви грубого порушення дисципліни (провокативна поведінка, безвідповідальне ставлення до себе та оточуючих, необдуманість вчинків, недостатня зайнятість, що може спричинити крадіжки, бродяжництво та ін.). Віктимні учні повільно реагують на зауваження дорослих, менше гнучкі щодо позитивного та більше до негативного впливу довколишнього середовища, ризиковані, недостатньо критичні, мають низький рівень самоконтролю, складно засвоюють позитивний досвід поведінки і дій, позаяк не мали його у своєму житті. Такі підлітки є потенційними учасниками асоціальних угруповань, що є серйозною перешкодою для конструктивного розвитку суспільства [6]. Існують чинники віктимізації підлітків, які аналізуються за змістом і сутністю. У табл. 3. наведено класифікації цих чинників (факторів) з погляду різних авторів.

Таблиця 3

Класифікація чинників віктимізації підлітків

Науковець	Чинники віктимізації підлітків
Аналіз наукової літератури	внутрішні чинники: біопсихологічні, психологічні та соціально-психологічні; зовнішні чинники: диференціація суспільства, частота стресових ситуацій, проблеми в родині підлітка та низький рівень просвітницької діяльності з профілактики віктимізації.
В. Карамушка	фактори виникнення віктимної поведінки: індивідуально-психологічні, соціально-психологічні, фактори психолого-фізіологічного походження
О. Андроннікова	неблагополучна сім'я (відсутність підтримки зі сторони батька чи матері підлітка, досвід переживання підлітком факту насильства в родині); – індивідуально-психологічні якості підлітків;
В. Терпелюк	віктимність особистості підлітка, віктимогенність його сім'ї.

Розроблено автором на основі теоретичного аналізу літератури

Висновки. Віктимність – це індивідуальна схильність особистості, зумовлена певними особистісними рисами та соціальними чинниками, що можуть спричинити віктимну поведінку і потрапляння у соціально небезпечні ситуації. Віктимна поведінка є формою дезадаптивної поведінки, що проявляється у комплексі стійких властивостей, які обумовлюють схильність підлітка стати жертвою несприятливих умов соціалізації. Факторами віктимної поведінки підлітків можуть бути індивідуально-психологічні якості (емоційна нестійкість, тривожність, низька самооцінка), відсутність комунікативних навичок у взаємодії із членами родини та соціальним середовищем.

Література.

1. Бовт О.Б. Віктимна поведінка як психологічна проблема. Соціальна психологія. 2004. № 4 (6). С. 14–22.
2. Вакулич Т. В. Вивчення віктимності особистості неповнолітніх у психологічній літературі. <http://vuzlib.com/content/view/780/94/>.
3. Вакулич Т. М. Вивчення віктимності особистості неповнолітніх у психологічній літературі / Т. М. Вакулич // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка Акад. пед. наук України / за ред. С. Д. Максименка. Київ. 2009. Т. 11. Ч. 6. С. 46–52.
4. Віктимологія : навч. посіб. / В. В. Голіна, Б. М. Головкін, М. Ю. Валуйська та ін. ; за ред. В. В. Голіни і Б. М. Головкіна. Харків : Право, 2017. 308 с. <https://you-book.com.ua/wp-content/uploads/2023/10/viktymologiya.pdf>.
5. Гарькавець С. О. Психологія підліткової віктимності : монографія. Луганськ. «Ноулідж». 2013. 175 с.
6. Гарькавець С. О. Психологічні основи віктимології. Навчально-методичний посібник. Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля. 2023. 170 с.
7. Докторович М. О. Віктимність особистості : етіологія та генеза : Соціальна педагогіка : теорія та практика. 2009. №2. С. 51–57.
8. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / за ред. І.Д. Зверєвої. Київ, Сімферополь : Універсум, 2012. 536 с.

9. Коць М. Психологічні детермінанти конфліктної поведінки підлітків : Соціальна психологія. 2007. № 1. С. 162–169.
10. Ломова Т. О. Особливості взаємозв'язку стратегії поведінки у конфлікті та соціальних очікувань особистості в малій соціальній групі. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер.: Педагогіка. 2007. № 1. С. 217–223.
11. Мойсеєва О. Є. Психологія агресії: вікові та генетичні виміри: навч.–метод. посіб. Київ. 2010. 128 с.
12. Папуша В. В. Вплив батьківсько-сімейного виховання на віктимну поведінку підлітків : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім'я». Тернопіль, 2014. С. 357–359.
13. Рівман Д. В., Устинов В. С. Віктимологія. 2004. 332 с.
14. Терпелюк В. В., Заблоцький А. Р. Психологія віктимної особистості в сучасному соціальному середовищі. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка Педагогічні науки. Випуск 15. 2022. № 15 С. 146–152.
<http://journals.kogpa.te.ua/index.php/pedagogy/issue/view/17>
15. Ткаля О. В. Заходи щодо запобігання віктимності неповнолітніх. <http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/11032/TKALIA%20O%20V.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
16. Шишко О. Я. Деякі особливості віктимної поведінки підлітків : Соціальна робота в Україні : теорія і практика. 2010. №3. С. 41–48.
17. Шкарлатюк К. І. Агресія та здатність до прогнозування в підлітковому віці : Психологічні перспективи. Вип. 17. Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2010. С. 273–280.

1.20. Методи психологічної реабілітації військовослужбовців, які зазнали бойової психічної травми

Келин Д.О.

Актуальність. Повномасштабне вторгнення на територію України призвело до гострої необхідності вивчення психоемоційних станів військовослужбовців. Тривале перебування в зоні бойових дій має значний вплив на психічний стан захисників і захисниць та на їхню здатність ефективно виконувати бойові накази та протистояти ворогу. Дослідження емоційних станів військових дозволить підбирати ефективні методики для покращення навичок саморегуляції, підвищення рівня стресостійкості та допоможе подолати наслідки негативного впливу бойових факторів на психічне здоров'я воїнів.

Бойовий стрес – це процес мобілізації всіх наявних можливостей організму, імунної та нервової систем, психічних функцій для подолання загрозової для життя ситуації. Бойовий стрес виникає ще до прямого контакту із загрозою життю і продовжується аж до виходу із зони військових дій. Кожен учасник бойових дій піддається його впливу [7].

Питанням висвітлення бойового стресу та його впливу на психоемоційний стан військовослужбовців присвячено роботи таких авторів, як Агаєв Н. А., Кокун О. М, Лозінська Н. С. , Приходько І.І., Кравченко К.О. та ін.

Кравченко К.О. розуміє бойовий стрес як переживання, що виникають у військовослужбовця при опосередкованому чи безпосередньому впливі на нього стрес-факторів бойової діяльності та проявляються у вигляді емоційних, інтелектуальних, фізичних та поведінкових реакцій [9].

Тютюнник Л.Л. описує бойовий стрес як наслідок потужної дії зовнішніх і внутрішніх стресорів на організм людини в екстремальних бойових умовах, що спричиняє серйозні порушення психічного, психологічного та фізичного здоров'я особистості [11].

Наказом Міністерства оборони України «Про затвердження Положення про психологічну реабілітацію військовослужбовців Збройних Сил України (ЗСУ), які

брали участь в антитерористичній операції, під час відновлення боєздатності військових частин (підрозділів) від 09.12.2015 №702», поняття «бойовий стрес» визначається як багаторівневий процес адаптаційної активності організму людини в умовах екстремальної бойової обстановки, що супроводжується напруженням механізмів реактивної саморегуляції та закріпленням специфічних пристосувальних психофізіологічних змін [6].

Мета. Дослідити методи психологічної реабілітації військовослужбовців, які зазнали бойової психічної травми.

Результати дослідження. Наслідки бойового стресу мають велику травматичність для організму. Вони можуть проявлятися у вигляді підвищеної збудливості нервової системи, емоційної напруженості, агресивності, істотного порушення сну з жахливими сновидіннями, перевтоми, нав'язливих і депресивних станів, втрати сенсу життя тощо [11].

На інтенсивність бойового стресу впливають такі фактори:

- 1) ступінь бойової активності конкретного військовослужбовця, що визначається, як правило, за кількістю бойових операцій, в яких військовослужбовець брав безпосередню участь і які супроводжувалися реальною загрозою його життю;
- 2) значущість бойових дій, в яких брав участь військовослужбовець, для виконання більш масштабних бойових завдань;
- 3) ступінь напруженості та характер бойових дій військовослужбовця (при цьому особливе значення надається участі військовослужбовця в бойових діях з противником, який значно переважає за силою, в умовах вимушеного відступу, в оточенні);
- 4) кількість бойових втрат у частині, підрозділі, де проходив службу військовослужбовець, а також сприйняття цим військовослужбовцем їх доцільності та зумовленості об'єктивними умовами бойової діяльності [2].

Одним з ключових понять, які використовуються у контексті розгляду психологічних наслідків впливу на особовий склад стрес-факторів бойової обстановки, є бойова психічна травма. Наказом Міністерства оборони України

«Про затвердження Положення про психологічну реабілітацію військовослужбовців Збройних Сил України, які брали участь в антитерористичній операції, під час відновлення боєздатності військових частин (підрозділів) від 09.12.2015 № 702», поняття бойової психічної травми визначається як наслідок впливу бойових стрес-факторів, патологічний стан центральної нервової системи (ЦНС), що обумовлює регулювання поведінки постраждалого за допомогою патофізіологічних механізмів. В результаті психотравмування відбувається накопичення змін в структурах ЦНС, наростання специфічної особистісної дисгармонії і готовності до психопатологічного синдромуутворення [6].

Бойова психічна травма може три ступеня тяжкості, кожен з яких характеризується певними ознаками:

1) легкі прояви (I ст.) характеризуються надмірним збудженням і дратівливістю, бажанням «закритися в собі», втратою апетиту, швидкою стомлюваністю та наявністю головного болю;

2) середнім (II ст.) властиві легкі істеричні реакції та прояви агресії, тимчасова амнезія, депресія, гіперестезія (підвищена чутливість до яскравого світла, гучних звуків і запахів) та страх;

3) тяжкі (III ст.) характеризуються порушенням слухових і зорових функцій, розбалансуванням рухових навичок та координації рухів, наявністю психомоторних розладів від безглузвих вчинків до стану ступору [11].

Тривалі наслідки бойового стресу можуть трансформуватись у посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), що проявляється у вигляді повторюваних спогадів про травматичну ситуацію; раптових яскравих образних уявлень (flash-backs), що тривають від декількох секунд до кількох годин і супроводжуються пригніченням, страхом; погіршення пам'яті, уваги, нервового і психічного виснаження та зниження працездатності [8]. На фізичному рівні можуть проявлятися такі симптоми, як безсоння, нічні кошмари, часті головні болі, запаморочення, больові відчуття в області серця [4].

Враховуючи вищезазначене, слід відзначити нагальність потреби в проведенні заходів психологічної реабілітації військовослужбовців, які повертаються із зони бойових дій.

Законодавчо психологічна реабілітація військовослужбовців в Україні визначається як комплекс заходів, що здійснюються з метою збереження, відновлення або компенсації порушених психічних функцій, якостей, особистого та соціального статусу особи, сприяння психосоціальній адаптації до зміненої життєвої ситуації, осмислення досвіду, отриманого в екстремальній ситуації, та застосування його в житті [6].

Основними завданнями психологічної реабілітації є діагностика та нормалізація психічних функцій отримувача послуг; відновлення порушених (втрачених) психічних функцій до оптимального рівня їх вираженості; корекція особистості отримувача послуг для забезпечення ефективного функціонування його в соціумі; надання допомоги в установленні (відновленні) конструктивних відносин у сім'ї та суспільстві; відновлення адаптивних механізмів до екстремальних (бойових) дій; опанування методів саморегуляції та керування стресом (заспокоєння); запобігання психологічному травмуванню та психічним розладам; проведення психопрофілактичної та психокорекційної роботи із сім'єю отримувача послуг; формування позитивних реакцій, мотивації, соціальних установок на життя та професійну діяльність [6].

До методів психологічної реабілітації військовослужбовців відносять психологічне консультування, психотерапію та психологічні втручання малої інтенсивності, що включають в себе арттерапію, зоотерапію, музикотерапію та ін. [3].

Використання методів арттерапії у процесі реабілітації допомагає військовослужбовцям дати вихід негативним відчуттям та агресії, опрацювати травмувальний досвід, отриманий під час перебування в зоні бойових дій. Метод арттерапії є дієвим та ефективним, оскільки забезпечує зменшення надмірного збудження; допомагає невербально відтворити образи та емоції, які складно

висловити словами; допомагає опанувати нав'язливі спогади та сприяє емоційній стабільності [14].

Великого поширення в Україні набуває зоотерапія, де в процесі лікування задіюється спілкування з тваринами. Цей метод спрямований на зменшення рівня тривоги, стресу, покращення емоційного стану, а також сприяє покращенню комунікації між усіма учасниками процесу [3].

За даними досліджень, присутність тварин та взаємодія з ними дозволяють знизити симптоматику та тяжкість ПТСР серед ветеранів. Під час взаємодії з тваринами організм виробляє серотонін, окситоцин та пролактин, що сприяє зниженню рівня стресу, тривоги, депресії, смутку, самотності. Також серед військовослужбовців та ветеранів, що взаємодіяли з тваринами відзначалось зниження рівня агресивності, гніву, тривоги, зловживання алкоголем. Метод зоотерапії також допомагає в створенні атмосфери довіри та спокою, що сприяє покращенню комунікації між учасниками [17, 18].

Однією з додаткових форм лікування ПТСР є музична терапія. Цей метод спрямований на досягнення таких результатів, як покращення навичок керування стресом, полегшення болю, допомагає виразити свої почуття та сприяє покращенню пам'яті та налагодженню комунікації.

Процес музичної терапії включає в себе використання музичних інструментів для створення мелодій, спів, дихання, дихальні вправи, написання пісень, терапевтичні виступи, прослуховування музичних творів, релаксування під музику, підбір і використання вже знайомої музики для залучення приємних спогадів та інше [19].

Також у процесі психологічної реабілітації військовослужбовців в груповому та індивідуальному форматах можуть використовуватись такі методи, як когнітивно-поведінкова терапія; EMDR, тілесно-орієнтована терапія; наративно-експозиційна терапія [16].

Когнітивно-поведінкова терапія спрямована на виявлення та зміну негативних думок, які сприяють виникненню емоційних труднощів, депресії та занепокоєння.

КПТ допомагає виявити, ідентифікувати та змінити ці думки на більш реалістичні та об'єктивні [12].

Когнітивно-поведінкова терапія ґрунтується на наступних принципах:

- 1) когнітивний принцип – думки клієнта безпосередньо впливають на його поведінку, його бачення проблеми визначає його подальші дії;
- 2) поведінковий принцип – думки впливають на поведінку, а поведінка таким же чином підтримує спосіб мислення, що подібно до ходіння по колу, адже клієнт лише підживлює існуючу проблему;
- 3) принцип співробітництва – клієнт є активним учасником терапевтичного процесу, виконує завдання та ініціює обговорення проблем;
- 4) принцип планування – КПТ терапевт намічає конкретні завдання та цілі терапії, визначає план та аналізує результат;
- 5) принцип емпіричності – психотерапевт перевіряє наскільки ефективні методи КПТ для пацієнта на практиці і, у разі чого, коригує перебіг терапії;
- 6) принцип «тут і зараз» – КПТ терапія фокусується на конкретній актуальній проблемі, а не на аналізі всього внутрішнього життя клієнта [5].

EMDR використовується для лікування ПТРС, депресивних, тривожних та травматичних розладів. Цей метод передбачає рух очима певним чином під час обробки травматичних спогадів та має на меті допомогтивилікуватися від травми чи іншого неприємного життєвого досвіду. EMDR-терапія не вимагає детальної розмови про хвилюючу проблему. Натомість EMDR зосереджується на зміні емоцій, думок або поведінки, які є результатом важкого досвіду (травми). Це дозволяє мозку відновити природний процес опрацювання [13].

Терапія EMDR використовує структурований 8-фазний підхід, який включає:

- 1) фаза 1: збирання анамнезу;
- 2) фаза 2: підготовка клієнта;
- 3) фаза 3: оцінка цільової пам'яті;
- 4) фази 4-7: обробка пам'яті до адаптивної роздільної здатності;
- 5) фаза 8: оцінка результатів лікування.

Обробка конкретного спогаду зазвичай завершується протягом одного-трьох сеансів. Терапія EMDR відрізняється від інших методів лікування, орієнтованих на травму, тим, що вона не включає тривалий вплив на тривожну пам'ять, детальний опис травми, виклик дисфункціональних переконань або виконання домашніх завдань [15].

Тілесно-орієнтована терапія базується на тому, що тіло і розум взаємодіють і впливають один на одного. Цей метод психотерапії допомагає у врегулюванні емоцій, подоланні травм, роботі з психосоматичними проблемами, встановленні гармонії між тілом та розумом. Тілесно-орієнтована терапія включає в себе дихальні вправи, рухову терапію, усвідомлення тілесних відчуттів, біодинамічну терапію та сенсорну інтеграцію [10].

Наративна експозиційна терапія (NET) базується на теорії подвійного пред'явлення травматичних спогадів, де за допомогою терапевта клієнт складає хронологічну розповідь про свою життєву історію та фокусується на травмуючих переживаннях, що дозволяє інтегрувати фрагменти травмивного досвіду в життєву історію клієнта. Метод NET спрямований на аналіз всього життя людини та не потребує вибору однієї травматичної події. Даний метод дозволяє повторно переглянути травматичний досвід, переосмислити його, що дає змогу клієнту побачити проблему в контексті його життя в цілому, а не переживати її заново [1].

Висновки. Під час перебування в зоні бойових дій військовослужбовці зазнають постійного впливу на них стрес-факторів, що має негативні наслідки для психоемоційного та фізичного стану воїнів. Своєю чергою це має негативний вплив на здатність військовослужбовців ефективно виконувати службові обов'язки та бойові задачі. Процес психологічної реабілітації військовослужбовців, що повернулись з зони бойових дій, спрямований на покращення їх психоемоційного стану, опрацювання травмувального досвіду, отриманого у зоні бойових дій, а також на полегшення процесу адаптації до умов цивільного життя. Психологічна реабілітація охоплює значну кількість методів психологічного консультування та психотерапії, зокрема, КПТ, арттерапію, зоотерапію, музичну терапію, тілесно-орієнтовану терапію тощо.

Література.

1. Абаніна Г.В. Стратегії опанування психотравматичного досвіду в контексті наративного підходу. Правничий вісник Університету «КРОК». – К.: Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 27. 2017. С. 140–144.
2. Агаєв Н.А., Кокун О.М., Пішко І.О., Лозінська Н.С. , Остапчук В.В., Ткаченко В.В. Збірник методик для діагностики негативних психічних станів військовослужбовців: Методичний посібник. К.: НДЦ ГП ЗСУ. 2016. 234 с.
3. Васильєва Г.В., Колєсник Н.В. ЕМОЦІЙНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ ПОРУШЕННЯ ВНАСЛІДОК ПТСР. Habitus. 2021. № 30. С. 65–69. <https://doi.org/10.32843/2663-5208.2021.30.10>
4. Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Наукове видання – К.: КНУ ім.. Тараса Шевченка. – Київ: ВИДАВНИЦТВО. 2016. 124 с.
5. Когнітивно-поведінкова терапія. Rozmova.me. <https://www.rozmova.me/vydy-psykhoterapiyi/kohnityvno-povedinkova-terapiya>
6. Наказ Міністерства оборони України «Про затвердження Положення про психологічну реабілітацію військовослужбовців Збройних Сил України, які брали участь в антитерористичній операції, під час відновлення боєздатності військових частин (підрозділів)» від 09.12.2015 №. 702. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0237-16>
7. Подолання бойового стресу і його психологічних наслідків. <https://psychologdcpp.in.ua/wp-content/uploads/2019/10/biblioteka/file42.pdf>
8. Пузирьов Є. В. Бойовий стрес та його наслідки для військовослужбовців / Є. В. Пузирьов, В. В. Ізвеков. // Психологія національної безпеки та безпеки життєдіяльності. 2023. С. 203–209.
9. Соціально-психологічні детермінанти виникнення бойового стресу у військовослужбовців – учасників антитерористичної операції : монографія / К.О. Краченко, О.В. Тімченко, Ю.М. Широбоков. Х.: Вид-во НУЦЗУ. 2017. 256 с.

10. Тілесно-орієнтована психотерапія. Rozmova.me.
<https://www.rozmova.me/vydy-psykhoterapiyi/tilesno-oriientovana-psihoterapiya>
11. Тютюнник Л. Л. Бойовий стрес та шляхи подолання його психотравмуючих наслідків. Вісник Національного університету оборони України. 36-к наук. праць. 2020. №2 (55). С. 106–115.
12. Що таке когнітивно-поведінкова терапія. Київський Центр КПТ.
<https://uccbt.com.ua/blog/bez-kategoriyi/shho-take-kognityvno-povedinkova-terapiya/>
13. Cleveland Clinic medical professional. EMDR Therapy: What It Is, Procedure & Effectiveness. Cleveland Clinic. <https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/22641-emdr-therapy>
14. Collie Kate, Backos Amy, Malchiodi Cathy, Spiegel David. Art Therapy for Combat-Related PTSD: Recommendations for Research and Practice. Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association. 2006. № 23(4). P. 157–164.
15. Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy.
<https://www.apa.org>. <https://www.apa.org/ptsd-guideline/treatments/eye-movement-reprocessing>
16. Glade Forest. <https://www.lisovapoliana.com.ua/methods/yunit-psiichnogo-zdorovya>
17. O'Haire, M. E., & Rodriguez, K. E. Preliminary efficacy of service dogs as a complementary treatment for posttraumatic stress disorder in military members and veterans. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 2018. №86(2). P. 179-188.
<https://doi.org/10.1037/ccp0000267>
18. The Healing Power of Animals: Benefits of Animal-Assisted Therapy. Husson University. <https://www.husson.edu/online/blog/2022/07/benefits-of-animal-assisted-therapy>
19. What is Music Therapy? American Music Therapy Association.
<https://www.musictherapy.org/about/musictherapy/>

1.21. Теоретичні аспекти визначення дисгармонійної родини в сучасній психології

Сулима О.А.

Актуальність. Теоретичні аспекти визначення дисгармонійної родини в сучасній психології зумовлені важливістю сім'ї як базової соціальної інституції, яка формує фундаментальні особистісні якості, впливає на психологічний добробут і соціальну адаптацію індивідів, а також визначає рівень гармонії у взаємодії між поколіннями. У сучасному світі, що характеризується швидкими соціально-економічними змінами, глобалізацією, урбанізацією, нестабільністю та зростанням рівня стресу, сім'я стикається з численними викликами, які можуть порушувати її функціонування та гармонійність.

Зростання кількості конфліктів, збільшення рівня розлучень, емоційне відчуження між членами сім'ї, а також поширення таких явищ, як міжпоколінні травми, гендерна нерівність і насильство в сім'ї, свідчать про необхідність глибокого аналізу причин і механізмів виникнення дисгармонії в сімейних системах.

Мета. Теоретичне вивчення дисгармонійної родини як складного соціально-психологічного явища через аналіз емоційних, когнітивних, поведінкових і соціокультурних аспектів її функціонування, визначення ключових чинників, що сприяють виникненню дисгармонії, а також розробка рекомендацій для покращення психологічного клімату та гармонізації взаємодії між членами родини.

Результати дослідження. Досягнення цієї мети передбачає інтеграцію сучасних психологічних теорій, таких як системна теорія, теорія прив'язаності та концепції сімейної динаміки, для побудови комплексної моделі, яка пояснює природу та наслідки дисгармонії в сім'ї. Результати теоретичного аналізу показали, що дисгармонійність родини є багатовимірним феноменом, який зумовлений поєднанням внутрішніх і зовнішніх факторів, таких як відсутність емоційної підтримки, низький рівень ефективної комунікації, нерівномірний розподіл ролей, економічна нестабільність та соціальний тиск.

Одним із ключових висновків є те, що порушення гармонії в сімейних системах часто має своїм корінням між поколіннями конфлікти та травматичний досвід, який передається через рольові моделі, когнітивні установки або емоційні взаємодії.

Необхідності здорового та сприятливого середовища у родині для розвитку індивіда присвятила своє дослідження Люсі Мфафулі. У 2023 році у збірці «Parenting in Modern Societies» авторка опублікувала главу «The Impact of Dysfunctional Families on the Mental Health of Children» [4] («Вплив неблагополучних сімей на психічне здоров'я дітей»).

Виявлено, що діти, які піддаються зневазі, домашньому насильству, постійним конфліктам, агресії, жорстокому поводженню та розлучі через розлучення, або мають батьків, які багато працюють поза домом, швидше за все, матимуть поведінкові та емоційні проблеми. Авторка прийшла до висновку, що батьки, незалежно від того, самотні, одружені чи розлучені, несуть відповідальність за захист психічного здоров'я своїх дітей [4].

Дослідження також підтвердили, що сім'ї з дисгармонійною динамікою характеризуються підвищеним рівнем стресу, що негативно впливає на дітей, знижуючи їхню самооцінку, формуючи тривожність і схильність до міжособистісних конфліктів у майбутньому [5, с. 12].

Сучасні дослідження підтвердили, що розлади харчової поведінки тісно пов'язані з кількістю отриманої батьківської уваги. Дефіцит батьківської прихильності з раннього дитинства погіршує у людини розвиток емоційного контролю, що внаслідок призводить до нездатності самостійно справлятися з негативними емоціями. Це породжує механізми подолання проблем, які тісно пов'язані з розладом переїдання та ожирінням. Відзначається тісний зв'язок фізичного та психологічного насильства в родині з розвитком ожиріння в дорослому віці [3].

Окрім того, науковці стверджують, що батьківський алкоголізм є значущим фактором, що визначає психологічну неблагополучність сім'ї. Згідно з результатами останніх досліджень, дійсно, діти алкоголіків імовірноше матимуть складнощі як у

дитинстві, так і в дорослому віці. Цим дітям та їхнім сім'ям необхідна система підтримуючих послуг. Підхід до цієї проблеми в рамках лікування алкоголізму є важливим фактором запобігання проблем, які ним спричинені [1].

Довгострокове дослідження показало, що емоційний зв'язок між матір'ю та дітьми дійсно є захисним фактором для психічного здоров'я людини. Теоретична модель дослідження визначає, що діти та матері дотримуються конгруентних або неконгруентних поглядів на своє відчуття згуртованості. Це відображає функціонування сім'ї та є показником майбутніх наслідків психічного здоров'я членів сім'ї [2].

Крім того, було встановлено, що соціальні й культурні контексти значно впливають на рівень гармонійності сім'ї, причому традиційні моделі виховання або гендерної нерівності часто поглиблюють конфлікти.

Важливим результатом дослідження є виявлення ключових елементів, які сприяють відновленню гармонії в родині, зокрема розвиток емоційної грамотності, підвищення рівня емпатії, навичок конструктивної комунікації та побудова справедливого розподілу відповідальності між членами сім'ї.

Це дослідження підкреслює важливість системного підходу до аналізу дисгармонійної родини, а також необхідність інтеграції наукових знань у практичну психологію з метою розробки ефективних інструментів для діагностики, профілактики та терапії.

Отримані результати сприятимуть поглибленню розуміння природи дисгармонії в родині та створенню умов для гармонізації сімейного життя, що є важливим кроком для поліпшення психологічного добробуту суспільства в цілому [6, с. 25].

Для забезпечення глибокого аналізу теоретичних аспектів визначення дисгармонійної родини в сучасній психології, необхідно врахувати багатовимірний підхід до цього феномену, який включає соціальні, психологічні, емоційні та поведінкові аспекти. Дисгармонійна родина, з одного боку, є соціальною системою, в якій порушена внутрішня рівновага через низку факторів, що можуть включати емоційний членів сім'ї, конфлікти, які не вирішуються належним чином, або

відсутність ефективної комунікації, а з іншого боку – є полем для складної взаємодії індивідуальних особливостей кожного члена сім'ї, їхніх соціальних ролей і очікувань. У цьому контексті важливим є теоретичне розуміння як особистісних, так і міжособистісних аспектів, які визначають функціонування такої родини.

Згідно з сучасними підходами в психології, родина розглядається як система, елементи якої перебувають у постійній взаємодії, а дисгармонійність виникає тоді, коли ця взаємодія не сприяє досягненню гармонії і задоволення базових потреб її членів.

Теоретичні концепції, що розглядають дисгармонійну родину, часто базуються на системному підході, який стверджує, що порушення в одній частині системи (наприклад, у взаєминах між батьками чи у вихованні дітей) впливає на всю систему в цілому. На думку дослідників, таких як Мюррей Боуен, Джей Хейлі і Сальвадор Мінухін, родинна дисгармонія може бути спричинена дисфункціональними комунікаційними схемами, які стають причиною стресу і відчуження між членами сім'ї [7, с. 37].

Одним із ключових критеріїв визначення дисгармонійної родини є рівень емоційної підтримки, яку надають її члени одне одному. У гармонійній родині емоційна підтримка є важливим чинником, що сприяє розвитку кожного індивіда, тоді як у дисгармонійній родині її відсутність чи недостатність може призвести до психологічного дистресу, низької самооцінки, тривожності та депресії.

Відсутність підтримки може бути пов'язана з токсичними моделями взаємодії, такими як критика, звинувачення, ігнорування або насильство (як фізичне, так і психологічне). Згідно з теорією прив'язаності Джона Боулбі, саме ранні взаємодії в родинній системі закладають основи для формування патернів поведінки, що згодом визначають взаємодію індивіда з оточуючим світом.

Ще одним важливим теоретичним аспектом визначення дисгармонійної родини є аналіз її ролей і структур, що ґрунтується на концепції сімейної динаміки. У дисгармонійних сім'ях часто спостерігаються явища, такі як рольова інверсія, коли дитина змушена брати на себе функції, притаманні дорослим, або явище «козла відпущення», коли на одного з членів сім'ї покладаються всі труднощі і

невдачі. Такі явища викликають порушення нормального розвитку особистості і створюють конфлікти, які можуть передаватися з покоління в покоління, формуючи так звані міжпоколінні травми [8, с. 45].

Крім того, важливим аспектом є соціокультурний контекст, у якому існує сім'я. Сучасна психологія наголошує, що на дисгармонійність родинного середовища впливають такі фактори, як економічна нестабільність, соціальна ізоляція, стереотипи і гендерні ролі, а також культурні уявлення про шлюб і виховання дітей.

Зокрема, економічна нестабільність може викликати хронічний стрес, який підриває здатність сім'ї адаптуватися до змін. Водночас культурні уявлення можуть або сприяти гармонізації стосунків у сім'ї, або, навпаки, закріплювати конфліктні моделі поведінки, наприклад, через авторитарний стиль виховання чи патріархальні структури влади.

Сучасні психологічні дослідження також приділяють увагу впливу зовнішніх чинників, таких як медіа, школа та однолітки, які можуть посилювати дисгармонійність у сім'ї, створюючи додатковий тиск на її членів. Наприклад, дослідження впливу соціальних мереж показують, що надмірна залученість у віртуальну реальність може призводити до послаблення міжособистісних зв'язків і зростання відчуження, особливо серед підлітків [9, с. 52].

Таким чином, дисгармонійна родина є складним явищем, яке вимагає міждисциплінарного аналізу і врахування широкого спектра чинників. Її визначення в психології базується на аналізі емоційного стану членів родини, рівня їхньої взаємодії, виконання соціальних ролей, а також врахуванні зовнішніх соціокультурних і економічних умов.

Сучасна психологія прагне не лише ідентифікувати проблеми в таких родинах, але й розробити стратегії їхнього подолання через терапевтичні методи, які спрямовані на покращення комунікації, підвищення рівня підтримки і створення сприятливих умов для розвитку кожного з її членів.

Розглядаючи дисгармонійність у родинах із точки зору індивідуальних особливостей її членів, сучасна психологія також акцентує увагу на ролі

особистісних рис, таких як рівень емпатії, стресостійкості та здатності до саморегуляції. Наприклад, якщо один із батьків має низький рівень емоційної саморегуляції, це може проявлятися у формі дратівливості, агресивності або емоційної нестабільності, що, у свою чергу, створює напруження в родинній системі [10, с. 67].

Діти в такій сім'ї часто стають «барометром» родинного клімату, демонструючи поведінкові чи емоційні проблеми як реакцію на загальну дисгармонію. Важливим напрямом досліджень є також вплив травматичного досвіду членів родини, що може проявлятися у формі посттравматичного стресового розладу, який суттєво ускладнює налагодження здорових стосунків між членами сім'ї.

Ще одним аспектом, що розглядається в теоретичному аналізі дисгармонійної родини, є питання прив'язаності і довіри, які є фундаментальними для гармонійного функціонування будь-якої родини.

Наукові дослідження свідчать, що порушення прив'язаності в ранньому дитинстві – через емоційне нехтування, відсутність теплих взаємин із батьками або насильство – може створити основу для хронічної недовіри, тривожності і емоційної віддаленості, які часто стають головними ознаками дисгармонійної родини. У цьому контексті важливим є вклад теорії прив'язаності Джона Боулбі, яка підкреслює, що якість прив'язаності між дитиною і її первинним опікуном має ключове значення для формування здатності до побудови близьких і гармонійних стосунків у дорослому житті.

Крім емоційних та особистісних аспектів, важливу роль у визначенні дисгармонійної родини відіграють також когнітивні фактори. Висновки, які члени родини роблять про власну цінність, свої обов'язки чи права в родині, формують те, як вони взаємодіють одне з одним.

Наприклад, у сім'ях із порушеннями гармонії часто зустрічається когнітивне спотворення у вигляді звинувачення іншого члена родини у всіх проблемах або перебільшення власних зусиль і недооцінки внеску інших. Такі когнітивні установки сприяють зростанню конфліктів і відчуження.

Слід також зазначити, що дисгармонійна родина, як правило, характеризується слабкою або нерівномірною структурою владних ієрархій. Наприклад, у деяких сім'ях батьки можуть демонструвати авторитарний стиль виховання, що пригнічує ініціативу та автономію дітей, у той час як інші сім'ї можуть бути надмірно ліберальними, де відсутність меж і правил створює хаос і почуття небезпеки. Теоретичні моделі, такі як модель балансу влади, стверджують, що ефективне функціонування родини можливе лише тоді, коли влада та відповідальність у ній розподілені справедливо й прозоро [11, с. 79].

Дисгармонійна родина в сучасній психології розглядається як складний соціально-психологічний феномен, що характеризується порушенням гармонії у взаєминах між членами сім'ї, що виникає через неузгодженість їхніх потреб, цінностей, установок, ролей і очікувань, а також через наявність деструктивних моделей комунікації, які перешкоджають формуванню сприятливого емоційного середовища для кожного члена сімейної системи.

Така родина може демонструвати дисфункціональну поведінку в контексті як внутрішньосімейної, так і соціальної взаємодії, що призводить до емоційної напруги, конфліктів і зниження психологічного благополуччя як окремих індивідів, так і сім'ї загалом [12, с. 85].

Психологи відзначають, що одним із ключових критеріїв визначення дисгармонійності є відсутність ефективного вирішення конфліктів, що супроводжується систематичною нездатністю до емоційної підтримки та задоволення базових психологічних потреб, таких як визнання, безпека та любов, що в свою чергу спричиняє формування негативних установок і поведінкових патернів, які можуть передаватися від одного покоління до іншого. Теоретичні моделі акцентують увагу на впливі різних факторів, таких як соціальні, економічні, культурні, психологічні та особистісні характеристики, які визначають складність і багатогранність проявів дисгармонійності в родині.

Таким чином, аналіз дисгармонійної родини вимагає інтегративного підходу, який поєднує теоретичні концепції системної сімейної терапії, теорії прив'язаності та когнітивно-поведінкові підходи для глибшого розуміння динаміки сімейних

взаємин, що сприяє розробці ефективних методів діагностики та психокорекції, орієнтованих на відновлення гармонії в родині та зміцнення її емоційного фундаменту.

Соціокультурний контекст також відіграє важливу роль у формуванні дисгармонійних сімейних моделей. Зокрема, у суспільствах із жорсткими патріархальними традиціями жінки та діти можуть піддаватися маргіналізації, що посилює нерівність і породжує психологічні проблеми, такі як почуття безпорадності чи депресія [13, с. 99].

З іншого боку, сучасні глобалізаційні процеси і зростаючий вплив медіа сприяють поширенню західних ідей про індивідуалізм, які, хоча й мають позитивні аспекти, можуть руйнувати традиційні форми сімейної солідарності, що створює нові виклики для гармонізації стосунків у сім'ї.

Важливою складовою аналізу є вплив зовнішніх стресорів, таких як соціально-економічні труднощі, війни, епідемії, міграція, які можуть значно загострити внутрішньо-сімейні конфлікти та зруйнувати механізми психологічної підтримки. Наприклад, дослідження, проведені в період глобальної пандемії COVID-19, продемонстрували, що ізоляція, економічні труднощі та невизначеність майбутнього призвели до зростання рівня тривожності і напруження в багатьох сім'ях, що посилює прояви дисгармонійності.

Таким чином, аналіз дисгармонійної родини в сучасній психології є багатограним і включає дослідження емоційних, когнітивних, соціокультурних і економічних аспектів. Усі ці фактори взаємодіють між собою, створюючи унікальні моделі, які потребують індивідуального підходу в діагностиці та терапії. Тому одним із ключових завдань сучасної психології є не лише ідентифікація проблемних зон у родинному житті, але й розробка ефективних стратегій їх вирішення для створення умов, які сприяють розвитку та благополуччю всіх членів родини.

Висновки. Отже, аналізу теоретичних аспектів дисгармонійної родини в сучасній психології підкреслює багатогранність цього явища, яке вимагає системного підходу та врахування різноманітних факторів. Дисгармонійна родина

– це не просто осередок ізольованих конфліктів чи проблем, а складна система, в якій емоційні, когнітивні, соціальні, економічні та культурні аспекти взаємодіють, створюючи умови для порушення гармонії та благополуччя її членів.

Сучасні теоретичні моделі акцентують увагу на важливості емоційної підтримки, ефективної комунікації та збалансованого розподілу ролей і відповідальності в родині. Водночас дослідники наголошують, що зовнішні стресори, такі як соціально-економічні труднощі, культурні особливості та вплив глобалізації, також значно впливають на динаміку сімейного життя, посилюючи дисгармонію в складних умовах.

Визначення дисгармонійної родини вимагає врахування не лише внутрішньо-сімейних проблем, але й між поколінних факторів, таких як передача травматичного досвіду або рольові моделі. Важливим завданням сучасної психології є розробка інструментів, які допомагають сім'ям виходити з кризових ситуацій, усувати джерела дисгармонії та створювати здоровий емоційний клімат для розвитку особистості кожного з її членів.

Таким чином, дисгармонійна родина є складним соціально-психологічним явищем, яке потребує глибокого аналізу, індивідуального підходу в терапії та інтеграції мультидисциплінарних знань для створення стійких і гармонійних сімейних систем.

Література.

1. Associations between parental alcohol problems in childhood and adversities during childhood and later adulthood: a cross-sectional study of 28047 adults from the general population. S. H. Haugland et al. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy. 2021. Vol. 16, no. 1. <https://doi.org/10.1186/s13011-021-00384-9>.

2. (In)Congruence in Perceived Mother-child Cohesion and Informants' Depressive Symptoms: A Dyadic Response Surface Analysis. Fang Y., Chen Z., Han B. Journal of Youth and Adolescence. 2023. <https://doi.org/10.1007/s10964-023-01905-4>.

3. Parental Care and Binge-Eating Disorder. In: Patel, V.B., Preedy, V.R. (eds) Eating Disorders. Amianto, F., Vitiello, B. 2023. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-16691-4_53.

4. The Impact of Dysfunctional Families on the Mental Health of Children. Parenting in Modern Societies. Kganyago Mphaphuli, L. 2023. IntechOpen. <http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.110565>.
5. Киричук, О. В. Психологія сімейних стосунків. – Київ: Наукова думка, 2015. – 320 с.
6. Максименко, С. Д. Основи загальної та сімейної психології. Київ: Генеза, 2014. 256 с.
7. Титаренко, Т. М. Особистість у кризових ситуаціях: стратегії подолання. – Київ: Либідь. 2016. 304 с.
8. Гавриленко, Т. О. Соціальна адаптація родини в умовах соціально-економічних змін. – Харків: Основа. 2018. 220 с.
9. Романець, В. А. Психологія сім'ї та шлюбних стосунків. – Львів: Світ, 2017. 312 с.
10. Ельріх, Е. Психологічні чинники встановлення гармонійних сімейних взаємин у консультативному процесі / Е. Ельріх // Графіати. – 2020. – <https://www.grafiati.com>.
11. Єременко, О. Бінарний комплекс автор-реципієнт у художньому тексті крізь призму його емпатійного компонента / О. Єременко // Academia. 2022. <https://www.academia.edu>.
12. Харкавець, С. Психологія правослукняної та протиправної поведінки особистості в умовах трансформації українського суспільства: монографія / С. Харкавець. – Academia. 2019. – <https://www.academia.edu>.
13. Мушкевич, М. І. Психологічний супровід сімей, що мають проблемних дітей / М. І. Мушкевич. – Мій Дисер, 2018. – <https://mydisser.com>.

ЧАСТИНА 2.

МЕНТАЛЬНЕ ЗДОРОВ'Я ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА РЕЗИЛЬЄНТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ

РОЗДІЛИ:

2.1. Психологічні особливості професійної діяльності іт-фахівців у комерційних організаціях

*Бегеза Л. Є.
Чугай О. В.*

Актуальність. У статті розглянуто психологічні особливості професійної діяльності ІТ-фахівців у комерційних організаціях. Визначено основні чинники, що впливають на їхню професійну ефективність та емоційний стан, зокрема когнітивне навантаження, стресові фактори і ризики емоційного вигорання. Окреслено перспективи подальших досліджень у цьому напрямі. Пропонуються рекомендації для профілактики вигорання та покращення діяльності ІТ-фахівців. Сучасний розвиток інформаційних технологій зумовлює зростання попиту на ІТ-фахівців у комерційних організаціях. Їхня професійна діяльність характеризується високим рівнем інтелектуального навантаження, необхідністю постійного оновлення знань, виконання складних когнітивних завдань та адаптації до швидких технологічних змін. Такі особливості висувають підвищені вимоги до психологічних характеристик ІТ-спеціалістів, впливаючи на їхню професійну ефективність та емоційний стан. Дослідження показують, що професійна діяльність ІТ-фахівців пов'язана з низкою психологічних викликів. Зокрема, високий рівень когнітивного навантаження, монотонність роботи та обмежені соціальні контакти можуть призводити до емоційного вигорання. Крім того, недостатня комунікативна компетентність може ускладнювати взаємодію з колегами та клієнтами, що негативно впливає на якість виконуваних завдань.

Мета. Визначити психологічні особливості професійної діяльності ІТ-фахівців у комерційних організаціях, та їх впливу на професійну ефективність й

емоційний стан, а також обґрунтування заходів для підтримки їхнього професійного та емоційного благополуччя.

Результати досліджень. Сучасні комерційні організації орієнтовані на максимальну ефективність і конкурентноспроможність. ІТ-фахівці, як одна з ключових професійних груп, відіграють важливу роль у досягненні цих цілей. Їх діяльність пов'язана з впровадженням інновацій, автоматизацією процесів і забезпеченням цифрової трансформації бізнесу. Крім того, їхня діяльність часто включає: розробку та підтримку програмного забезпечення; вирішення технічних проблем у режимі реального часу; аналіз даних для стратегічного планування; адаптацію нових технологій до потреб бізнесу;

Паралельно з позитивними аспектами, таким, як інтелектуальний розвиток, професійний ріст, спостерігаються негативні наслідки, серед яких найбільш поширеним є емоційне вигорання. Професійна діяльність ІТ-фахівців характеризується специфічними психологічними особливостями, серед яких:

1. Високий рівень когнітивного навантаження. Робота ІТ-спеціалістів вимагає інтенсивної розумової діяльності, що може призводити до психічного перенасичення та монотонії.

2. Обмежені соціальні контакти. Зосередженість на технічних завданнях часто супроводжується зниженим рівнем комунікації, що може впливати на розвиток комунікативної компетентності та емоційного інтелекту.

3. Необхідність постійного навчання. Швидкий розвиток технологій вимагає від ІТ-фахівців безперервного професійного розвитку, що може стати додатковим стресовим фактором.

4. Ризик емоційного вигорання. Поєднання вищезазначених факторів може призводити до розвитку синдрому емоційного вигорання, що негативно впливає на професійну ефективність та загальний стан здоров'я.

У сучасних комерційних організаціях, де високі очікування щодо ініціативності, креативності, відповідальності, жорстких дедлайнів та здатності працювати в умовах невизначеності та підвищеного стресу створюють умови для емоційного виснаження та втрати мотивації. Це є особливо актуальним у період

військового стану через значний вплив зовнішніх чинників, таких як економічна нестабільність, ризики для безпеки життя, психологічний тиск.

Крім цього слід враховувати психологічні чинники, які впливають на емоційний стан спеціалістів ІТ-галузі: підвищений рівень тривожності та стресу. воєнний стан створює атмосферу невизначеності та постійної загрози, що призводить до зростання рівня тривожності; постійний інформаційний потік про військові події та можливі небезпеки посилює емоційне напруження.

Особливої уваги заслуговує вплив стресу на здатність приймати рішення, а також підтримання мотивації в умовах підвищеної загрози. Дискусійними питанням залишається, які саме чинники впливають на професійне вигорання.

Робота в бізнес-середовищі супроводжується високим темпом, вимогою до результативності, та значним психологічним навантаженням. Основна увага зосереджена на досягненні фінансових та стратегічних цілей, що може призводити до перевантаження персоналу та підвищення ризиків стресу, що зумовлює необхідність забезпечення ефективного використання ресурсів, головним з яких є людський капітал.

У сучасній українській науковій літературі науковці роблять акцент на психологічних особливостях особистості. Зокрема, це стосується таких особливостей як цінності, мотивація, спосіб прийняття рішень, вміння адаптуватися до змін, ризикувати. Тобто підкреслюється не лише виконання своїх робочих функцій, а й наявність певного набору соціально-психологічних та індивідуально-психологічних характеристик. Оскільки це напряду впливає на ініціативність, відповідальність, цілеспрямованість спосіб мислення працівників та їх поведінкові прояви. А значить, це впливає на успішність роботи організації, створення атмосфери розвитку та довіри, комфортних взаємовідносин, можливостях самореалізації, що позначається на ефективності, якості роботи. Таким чином, персонал розглядається, як головний актив комерційної організації. Отже, важливо звернути увагу на чинники, які можуть призвести професіоналів до того, що вони втрачають інтерес до своєї праці, швидко виснажуються, втрачають мотивацію та відмовляються від своїх посад, від рішення задач в

найвідповідальніші моменти. Синдром вигорання, як зазначається в роботах Гнускіної Г.В., Карамушка Л.М., К. Маслач та ін. пов'язаний з фізичним, емоційним та мотиваційним виснаженням. Тому, важливо визначити показники цих чинників, щоб підтвердити або спростувати інформацію.

У статті проаналізовано найбільш розповсюджені в сфері комерційної діяльності чинники, які на думку спеціалістів HR-сфери, керівників та власників бізнесу могли найбільше впливати на рівень професійного вигорання. До індивідуально-психологічних чинників зараховують: вік, темперамент (сангвінік, холерик, флегматик, меланхолік), характер та стресостійкість, компетенції (hard/soft skills), самооцінка, спосіб мислення, емоційний інтелект (eq), персональні характеристики людини (песиміст, оптиміст, перфекціоніст, рівень емпатії, недовіра, тривожність, конфліктність та ін.), виховання, освіта, рівень бажання до саморозвитку, відсутність покликання до своєї професії (відсутність здібностей). До соціально-психологічних чинників належать: нерегламентована тривалість робочого дня, стиль керівництва, соціально-психологічний клімат в колективі, сфера діяльності організації, неналежне забезпечення умов праці, не задовільнена потреба в безпеці (невпевненість в тому, що працівник не втратить своє робоче місце, не отримає штрафні санкції за прогалини або помилки і т.ін.), нереалістичні очікування керівника та вимоги, дисбаланс між роботою та персональним життям, жорстка внутрішня конкуренція (особистісна, посадова, між відділами), неналежні фінансові умови, зміст роботи, незрозумілий зміст трудової діяльності, зокрема відсутність необхідності посадових інструкцій чи їх формальний характер, адміністративна політика (примус до виконання обов'язків, не передбачених посадою, відсутність або незрозумілий зміст посадових інструкцій, відсутність підтримки, заохочень, схвалення), корпоративна культура.

Слід зазначити, що реакцію на стрес та здатність адаптуватися до викликів суттєво визначає тип особистості. Наприклад, екстраверти зазвичай ефективно працюють у команді та знаходять підтримку в соціальній взаємодії, тоді, як інтроверти краще зосереджуються на завданнях, що не потребують комунікації, але

можуть страждати від ізоляції. Перфекціоністи, хоча і забезпечують високу якість роботи, часто зазнають стресу через прагнення до ідеалу.

Не менш важливим фактором для збереження ефективності в умовах високих навантажень є резильєнтність, або психологічна стійкість. Працівники з високою резильєнтністю швидше відновлюються після стресу, зберігають мотивацію та здатність приймати раціональні рішення.

Як зазначалось вище, комерційні організації потребують високої результативності від персоналу. Отже, роль працівника у бізнесі не обмежується лише виконанням завдань, але включає творчий підхід, ініціативність та здатність адаптуватися до змін.

Особливість роботи спеціалістів ІТ-сфери в нинішніх умовах полягають у тому, що саме цей професійний сектор є тим, що дуже підтримує економіку, разом з тим страждає від військових дій як і решта галузей. Це й втрата клієнтів, перебої із електроенергією, що ускладнюють робочий процес, та проблеми з фінансуванням. До того ж існує також відтік робочих кадрів через причини, котрі ми зазначили вище, що створює додаткове навантаження на залишковий персонал. Крім того, існує фактор постійної фонові загрози життю, що демотивує. При цьому фахівець, що працює з цифровими технологіями повинен бути стресостійкий, мати змогу працювати в стресових умовах тривалий час, внаслідок потреби в обороні кіберпростору, мати високу працездатність, креативність, здатність до швидкого навчання та постійного розвитку, вміння працювати як самотійно так і в команді. Все вищезазначене може сприяти емоційному та професійному вигоранню.

Будь яке з цих видів вигорання призведе до неможливості спеціалістів виконувати свої обов'язки чи то тимчасово чи на постійній основі, тому важливими є проведення заходів, які забезпечують вчасне попередження вигорання спеціалістів та ресурсне відновлення фахівців: постійна діагностика за допомогою сучасних методик та тестів; просвітницька діяльність (семінари, лекції); баланс відпочинку та роботи (організація для співробітників командних заходів для відпочинку таких, як відвідування театрів, спортивних залів, сумісних обідів чи

походів в парк, відвідування майстер-класів та ін.); забезпечення базових потреб (їжа, вода, сон); забезпечення раціонального розподілу робочого часу та оптимізація робочого навантаження (забезпечення збалансованого розподілу завдань та часу на їх виконання допоможе уникнути перенапруження та знизити ризик вигорання); забезпечення робочим обладнанням та створення максимально безпечних умов праці, гідної оплати, постійної мотивації, здорового клімату в колективі та доступності керівництва.

Для запобігання емоційному вигоранню рекомендується розвивати стресостійкість кожного працівника за допомогою навчання методам психологічної самопомоги, рефлексії, забезпечити умови для професійного розвитку та згуртовувати колектив. Однією з ключових компетенцій, що потребує особливої уваги у контексті профілактики емоційного вигорання, є розвиток емоційного інтелекту. Емоційний інтелект включає здатність усвідомлювати, розуміти та ефективно управляти власними емоціями, а також емоціями інших людей. Дослідження свідчать, що високий рівень емоційного інтелекту сприяє зниженню рівня стресу, підвищенню адаптивності до змін і формуванню позитивного соціально-психологічного клімату в колективі. Таким чином, розвиток емоційного інтелекту є важливим компонентом психологічної стійкості працівників, що дозволяє не лише зменшити ризик вигорання, але й підвищити ефективність професійної діяльності. Крім того, особливо важливим в профілактиці як професійного так і емоційного вигорання є можливість проговорити свої робочі труднощі та проблеми і, відповідно, отримати підтримку та допомогу чи то від інших спеціалістів чи то на спеціально організованих тренінгах. Метою даних тренінгів як правило є як профілактика професійного вигорання так і допомога в особистісному, професійному розвитку.

Впровадження програм підтримки працівників, спрямованих на зниження рівня стресу, формування навичок стресостійкості та емоційного саморегулювання, може суттєво сприяти профілактиці емоційного вигорання. Такі програми можуть включати тренінги з управління стресом, психологічне консультування, створення комфортного робочого середовища, а також заходи, спрямовані на поліпшення

балансу між професійним та особистим життям. Комплексний підхід до підтримки працівників дозволяє не лише зменшити ризик емоційного виснаження, але й підвищити загальну мотивацію та ефективність команди.

Висновки. Враховуючи вищезазначене, перед спеціалістами в галузі психології та психологічного консультування постають наступні задачі: проведення просвітницьких заходів, семінарів, тренінгів щодо інформування про показники емоційного вигорання та його вчасного розпізнавання; індивідуальна психологічна підтримка, коучинг щодо попередження емоційного вигорання (індивідуальний, командний); допомога в створенні умов для попередження емоційного вигорання, розвитку компетенції управління емоційним вигоранням та завчасної профілактики, щоб співробітники могли розуміти, контролювати та відстежувати свої стани та завчасно запобігати вигоранню. Тобто, в компаніях потрібно проводити систему заходів, спрямованих на предмет менеджменту своїх станів, формувати вміння повертати себе до нормального стану. Розуміння психологічних особливостей професійної діяльності ІТ-фахівців є ключовим для розробки ефективних стратегій підтримки їхнього емоційного та професійного благополуччя. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на вивчення впливу організаційної культури на психологічний стан ІТ-спеціалістів, а також на розробку програм профілактики емоційного вигорання в комерційних організаціях.

Література.

1. Гнускіна Г. В. Психологічні чинники професійного вигорання у підприємців : дисертація канд. психолог. наук / Національна академія педагогічних наук України, Інститут психології імені Г. С. Костюка Київ. 2016. 267 с.
2. Гончаренко Я. В. Психологічні чинники орієнтації на клієнта персоналу комерційних організацій : дисертація канд. психолог. наук / Національна академія педагогічних наук України, Інститут психології імені Г. С. Костюка Київ. 2018. 324 с.
3. Жолошко Т. В. Особливості мотивації персоналу ІТ компаній у воєнний час : матеріали ІІ Між. Наук. Конф., м.Луцьк, 03.03.23 р. Комплексний підхід до модернізації науки: методи, моделі та мультидисциплінарність: /

Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа. 2023. 240 с. <https://ksada.org/repozitarij/dizseredov/dizseredov-repozitarij-naucovi-publikaczii-30.pdf#page=43>

4. Ринок праці: досягнення, виклики та перспективи у національному та європейському просторі : тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 16 травня 2024 р.). Академія праці, соціальних відносин і туризму / За заг. ред.: В.Б. Сухомлина, Г.А. Приба. К. : ФОП Ямчинський О.В. 2024. 572 с.

5. Карамушка Л. М., Гнускіна Г.В. Психологія професійного вигорання підприємців : монографія. Київ. Логос. 2018. 198 с.

6. Кудряшов В. П, Курс фінансів : навч. посіб. / Бібліотека українських підручників. 2020. https://westudents.com.ua/knigi/647-kurs-fnansv-kudryashov-vp.html#google_vignette

7. Лихолобов Е. А. , Ночка М. П. Еволюція поглядів на роль персоналу в діяльності підприємства. Ефективна економіка : електронний журнал. 2015. № 11. с. 32.

8. Моначин І. Л., Кутузова Н. В. Психологічні особливості професійного вигорання ІТ-спеціалістів // Матеріали VIII Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», 16-17.2011. 2019 р., м. Тернопіль. С. 136-138. https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31091/2/MNTKv3_2019v3_Monachyn_I_L-Psychological_features_of_136.pdf

9. Сазонова Т. О., Васюха О. В., Вплив емоційного вигорання на поведінку персоналу. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2024. Том 9. No 3. С. 241–245.

10. Якимчук О. Психологічні особливості професійного вигорання особистості, 2021, Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2021. №16 (61).

2.2. Емоційний інтелект як чинник соціалізації особистості

Бегеза Л.Є.

Канафоцька Л. М.

Актуальність. Проблема емоційного інтелекту (ЕІ) та уміння соціалізуватися збільшує свою актуальність з кожним днем та спрямована зайняти окрему нішу у психології як метод, спрямований на реалізацію індивіда та його можливість перебувати та функціонувати у суспільстві. Як правило, ЕІ формується протягом життя, однак, враховуючи те, що підлітковий вік являє собою період переходу від дитинства до дорослості та від незрілості до зрілості, соціальні навички та уміння комунікувати починають відігравати неабияку роль [1, С. 52]. Вплив ЕІ окремої особи водночас має безпосередній вплив на соціальне середовище та індивідів, які у ньому перебувають.

Мета. Розглянути емоційний інтелект як чинник соціалізації особистості, який сприяє можливості створення позитивного емоційного клімату в колективі, формуючи при цьому індивіда як свідомого члена не лише колективу, в якому він перебуває, але й суспільства загалом, не нехтуючи при цьому власними та чужими емоційними потребами.

Результати дослідження. Поведінка та дії будь-якого індивіда є детермінованими, що означає те, що вони обумовлені та обмежені внутрішнім механізмом мотивації, інтересами та цінностями індивіда, а також його умінням взаємодіяти з потребами не лише своїми, але й інших. На діяльність та поведінкові реакції впливають як самі люди та оточення загалом, так і вже існуючі суспільні норми та правила. Ідентифікація соціальної поведінки особистості формується за характеризується як: альтруїстична чи егоїстична, законослухняна або ж на протипагу їй протизаконна, серйозна або легковажна, виважена чи груба і т. д. Варто було б зазначити те, що спрямованість поведінки у соціумі може бути розглянута як з позитивного, так і з негативного боків, що вказує на унікальність кожного індивіда та має певний зв'язок з його рівнем емоційного інтелекту та соціальної обізнаності.

Внаслідок різних причин економічного, політичного та психологічного напряму у соціумі формуються як люди з девіантною поведінкою та низьким рівнем ЕІ, так і ті, які є адекватними та проактивними учасниками соціуму чи колективу та дуже часто відзначаються високим рівнем емоційного інтелекту, що часто можна спостерігати як у компаніях друзів чи колег, так і у шкільному колективі. Емоційний інтелект вважається групою ментальних здібностей, що беруть участь в розумінні та усвідомленні як власних емоцій, так й емоцій оточуючих. Тобто це здатність, яка допомагає успішно діяти за будь-яких, навіть критичних обставин. Вперше поняття емоційного інтелекту ввели та сформулювали П. Саловей та Дж. Майер.

Дослідження рівня ЕІ свідчать про те, що особа з високим рівнем емоційного інтелекту здатна добре розуміти почуття як свої, так і інших людей, а також має здатність ефективного керування емоційною сферою свого життя. Тому поведінка особи описується як така, яка при взаємодії з суспільством являється більш адаптивною. При цьому вона легше знаходить та йде на компроміс у різних ситуаціях, або ж набуває здатність взагалі уникати конфліктів в принципі.

У результаті становлення у людини високого показника ЕІ набувається здатність якісної комунікації з оточуючим світом на інтуїтивному та свідомому рівні з врахування власних почуттів та емоцій, а також почуттів та емоцій інших людей. Уміння комунікувати має важливе значення при досягненні життєвих цілей та реалізації амбіцій.

Вченими (Д. Гоулманом, А. Здоймою, Д. Карузо, Д. Мейєром, В. Пейном) виділено 5 основних компонентів, що характеризують існуючу структуру емоційного інтелекту: розуміння самого себе (власне саме усвідомлення власних емоцій, впевненість у собі, самоповага); потенціал до уміння комунікувати (емпатія, соціальна відповідальність); уміння адаптуватись (вміння розв'язувати проблеми, долати труднощі, емоційна гнучкість); антистресовий потенціал (самоконтроль та уміння зосередитись в умовах стресових ситуацій); загальний настрій (оптимізм).

До найбільш значущих якостей емоційного інтелекту вченими було віднесено співчуття та емпатію, усвідомлення та розуміння власних почуттів, уміння зберігати баланс між емоціями та раціональним мисленням, а також ознаки високої самоповаги та самосприйняття людини.

Актуальність та популярність дослідження феномену емоційного інтелекту у психології формувалися протягом тривалого проміжку часу, починаючи з кінця 20 століття. З самого початку окремо досліджували розвиток інтелекту й емоцій такі вчені як: А. Брушлінський, Д. Векслер, Дж. Гілфорд, Дж.Зінгер, К. Ізард, Є. Ільїн, О. Сімонова, Дж. Тернер, Л. Терстоун та інші. Пізніше взаємовплив та взаємозв'язок когнітивних та емоційних процесів був досліджений такими науковцями як: Е. Айзен, Б. Ананьєв, Х. Вайсбах, Л. Виготський, У. Дакс, Л. Засекіна, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, Р. Торндайк, О.Тихомиров, Ч. Хант, С. Шехтер та інші. Поняття та феномен в науці ЕІ почав популяризуватися Д. Гоулманом, А. Здоймою, Д. Карузо, Д. Мейєром, В. Пейном, П. Селовеєм, К. Стайнером. З розвитком психології як науки ЕІ продовжують досліджувати: І. Андрєєва, І. Аршава, Р. Бар-Он, Т. Березовська, П. Воронкін, О. Власова, Г. Горськова, М.Девіс, С. Дерев'янка, Н. Коврига, Ю. Коноплицька, О. Лобанов, Д. Люсін, М. Манойлова, І. Мещерякова, Е. Носенко, А. Савєнков, О. Ставицька, А. Садокова, Г. Юсупова.

Аналіз сучасних досліджень показує, що автори визначають та тлумачать феномен емоційного інтелекту через призму різних психологічних категорій. В основному його розглядають як: емоційну реакцію; процес; стан; інтегральну властивість особи; компетенції (знання, уміння, навички); здібність; здатність; стратегію; діяльність; функцію регуляції психіки.

Варто звернути увагу на наукові роботи вчених, які досліджували ЕІ у підлітків (тут виокремлено тих, які досліджували та спостерігали за підлітками з проявом девіантної поведінки). На даний момент виявлено розбіжності прояву ЕІ девіантних і недевіантних підлітків (О. Пасмор); проаналізовано зв'язок ЕІ з особливостями соціально-психологічної адаптації (А. Дегтярьов); встановлено особливості ЕІ підлітків, схильних до інтернет-залежності (В. Густодимова).

Аргументом до розгляду робіт науковців, які займалися саме підлітками з девіантною поведінкою є те, що соціалізація напряду впливає як на прояв адиктивної поведінки, так і в подальшому на формування ЕІ та становлення особистості в колективі та соціумі.

Деякими науковцями в процесі досліджень було отримано суперечливі результати. Як приклад можна навести дослідження Е. Гарсія-Санчо та його колег, яке було спрямовано на аналіз вже наявних досліджень, які стосувалися вивчення взаємозв'язку агресивної поведінки та ЕІ. В результаті цих досліджень було виявлено негативний зв'язок ЕІ з агресією різних форм, до яких можна віднести її фізичні прояви, девіантність, маніпулятивність та жорстокі жарту.

Водночас не треба виключати дослідження, за допомогою яких не було виявлено негативної кореляції ЕІ, вербальної агресії та сексуального насильства. Суперечливі результати були пояснені тим, що методи, які діагностують ЕІ як риси та як здібності, і розглядають цей вид інтелекту та його функцію як модератора зв'язку макіавеллізму й агресії, не являються точними у дослідженні та несуть за собою значну похибку, оскільки вибірка включає у себе більшість дорослих людей і лише невелику частину інших вікових категорій, зокрема підлітків. Тобто ми помічаємо пряму залежність між віком, ЕІ та соціалізацією. А також вбачаємо те, що особливу увагу треба звернути саме на підліткову вікову категорію.

Питаннями проблеми соціалізації особистості, які завжди є актуальними, займалися такі вчені, як: Л. Виготський, Л. Буєв, І. Конер, А. Макаренко, В. Сухомлинський, Л. Рубінштейн. Основною їхніх досліджень була вказівка на прямий зв'язок між умовами соціального середовища та безпосередньо самим розвитком особистості. Важливість соціальних зв'язків та соціалізації неодноразово підкреслювалась у якості необхідного активного процесу розвитку та формування особистості.

У ХХІ столітті особливу увагу почали приділяти аспектам рольових конфліктів, рольової взаємодії, рольових ігор, рольової соціалізації та проблемам рольової ідентичності. Цими питаннями детально займалися такі вчені як П.

Еростей, А. Кронік, А. Кочарян, Н. Корра Блава, Д. Кіпер, Е. Левенталь та А. Лебедєв.

Такі вчені як Р. Баярд, А. Біне, О. Ніл та С. Френе вивели дослідження питань соціалізації на міжнародний рівень.

З українських вчених, які здійснили цінний внесок у дослідження проблеми соціалізації особистості варто виділити таких як І. Зязюн, Л. Коваль, О. Кононко, Г. Костюк, М. Лукашук, Л. Максименко, В. Москаленко, В. Оржеховська та інші. Основи створення цілісного виховного середовища детально було описано І. Бехом, Е. Кацинською, О. Кузьменком та О. Щербань.

Особливості соціалізації підлітків та механізми їхнього виховання розглянули у своїх наукових роботах Б. Ананьєв, М. Боришевський, Л. Виготський, О. Запорожець, А. Коваленко, С. Ельконін та Д. Фельдштейн.

Процес соціалізації спрямований на охоплення різних етапів життя людини та пов'язаний із засвоєнням та застосуванням індивідом культурних цінностей. Переважно, з часом, кількість засвоєних цінностей має властивість трансформуватися в нову, вищого рівня, якість, що впливає на подальше формування структури та спрямованості особистості [2, С. 98-102].

Людина як суб'єкт, сформований соціумом, являє собою одночасно результат взаємовпливу середовища й системи виховання, являючись при цьому активним учасником соціальних відносин. Якщо розглядати індивіда з двох боків, то з одного буде засвоєння соціального досвіду, цінностей, установок та норм, властивих суспільству чи певній соціальній групі, а з іншого – активна участь у соціальних відносинах, яка має на меті отримання нового досвіду.

Процес соціалізації може відбуватися як стихійно, так і цілеспрямовано. Це залежить від впливу різних соціальних структур та інститутів. Якщо ж розглядати конкретно виховний вплив, то він змінюється в залежності від етапу життя.

Вченими виділено наступні домінуючі чинники соціалізації:

- гомогенність: являє собою інтеграцію особистості в сімейне середовище, засвоєння нею мови, жестів, уміння сприймати морально-психологічні стереотипи, ролі та їх соціальний характер, формування єдиних цінностей.

– трансформація: являє уміння засвоювати класичну культуру спадщини та спрямована на збагачення власного духовного світу.

– особистісна інтеграція: розглядається як розвиток певного рівня мотивації, цінностей та інтересів, формування почуття власної ідентичності, узгодження особистих психологічних процесів і станів (Ю. А. Соколов).

Процеси інтерналізації (внутрішньої інтерпретації соціальних норм) також були розглянуті такими вченими як Е. Белінська, О. Тихомандрицька та І. Клетіна, вказуючи на важливу роль у формуванні особистості та її емоційної обізнаності й відповідно емоційного інтелекту [7].

Підґрунтям до розуміння процесів становлення та утвердження особистості як складової системи суспільних відносин є категорія соціалізації (від лат. *socialis*, що означає суспільний). До даної категорії все частіше звертаються філософи, соціологи, психологи, педагоги, політологи та інші науковці. Дослідження процесу соціалізації охоплює різні аспекти, основні з яких можна звести до двох основних напрямів: вивчення соціалізації в контексті системного розвитку (зародження і становлення загальної природи людини) та в контексті онтогенетичного розвитку (процес формування певного типу особистості).

У психології існує багато трактувань процесу соціалізації. Якщо брати найрозповсюдженіше визначення «соціалізація», то це «багатогранний процес засвоєння людиною досвіду суспільного життя, що перетворює її з природної істоти на соціальну, з індивіда на особистість». Системою можливостей, вимог та очікувань, які відіграють спрямовуючі функції в процесі соціалізації варто розглядати соціальне середовище. Цей комплекс вимог та очікувань складним чином відображається у функціональній структурі свідомості та самосвідомості індивіда, його мотиваційній та когнітивній сферах, а також у сукупності алгоритмів, норм і правил поведінки та діяльності. У міру того, як індивід стає більш інтегрованим у своє середовище, зростає сила, різноманітність, складність і глибина впливу середовища на формування особистості. Таким чином, процес соціалізації стає реальним. Водночас індивід через свою діяльність у вільний час і творчість також здійснює формуючий вплив на середовище. Формування і

розвиток особистості та її становлення як соціальної, духовної і моральної істоти є практично тотожними. Однак це два полюси взаємодії, що перебувають у постійній динамічній трансформації внутрішнього потенціалу індивіда та його соціальних самореалізаційних завдань і просторів. Різноманітність і складність процесу соціалізації зумовлює існування різних підходів, теорій і визначень процесу соціалізації. На думку Ф. Гіддінса та Г. Тарда, соціалізація має позитивний характер і головним критерієм її успішності є свобода індивіда функціонувати в суспільстві за умови його активності в процесі соціалізації, а на думку Т. Парсонса, соціальна теорія пояснює процес інтеграції індивідів у соціальну систему через інтерналізацію загальноприйнятих норм. На його думку, соціалізація – це динамічний процес, пов'язаний з організацією соціальних структур. Індивіди «вбирають» спільні цінності в процесі спілкування зі «значущими» іншими. Результатом соціалізації є включення нормативних стандартів у мотиваційну структуру індивіда. Соціалізація відбувається через психологічний механізм оцінки, розпізнавання та засвоєння цінностей. Цей механізм діє на основі принципу задоволення-болю, ініціюється заохоченнями та покараннями і поєднує в собі процеси гальмування (подібно до «витіснення» за Фрейдом) та заміщення (або «перенесення»). Когнітивні механізми включають процеси наслідування та розпізнавання, засновані на почуттях поваги та любові. Засвоєння цінностей пов'язане з процесом формування супер-его, яке вбудовується в структуру особистості в результаті визнання фігури батька або інтерналізації сімейної структури як цілісної системи [5].

Для дослідження саме емоційного інтелекту, як однієї з можливостей покращення соціалізації можна розглянути «Тест емоційного інтелекту EQ» (Н. Холл). Він призначений для визначення здатності людини розуміти взаємозв'язки, представлені емоціями, і керувати своєю емоційною сферою на основі прийняття рішень. Складається з 30 тверджень, що включають п'ять шкал:

- перша шкала – «Емоційна обізнаність»;
- друга шкала – «Уміння керувати власними емоціями» (прояв емоційної чутливості, уміння зберігати емоційний баланс);

- третя шкала – «Уміння самотивуватись» (добровільний контроль над власними емоціями);
- четверта шкала – «Емпатія» (відповідає за уміння співпереживати як собі, так і іншим);
- п'ята шкала – «Усвідомлення емоційного стану інших людей» (здатність впливати та оцінювати емоційні стани інших людей).

Існує багато досліджених та розглянутих теорій, що пояснюють те, який вплив має емоційний інтелект на адаптаційний успіх. Наприклад, К. Брез припускає, що люди з високим ЕІ ефективніше діють у ситуаціях, коли їх агресивно провокують. Люди з низьким ЕІ вороже ставляться до навколишнього світу та рідко погоджуються на компроміс. Група випробовуваних індивідів з низьким ЕІ виявила досить високий рівень агресії. З іншого боку, не зрозуміло, як здатність розпізнавати емоції на фотографіях дозволяє будувати ефективні соціальні відносини. Дослідження, проведені на сьогоднішній день, не дають відповідей для розуміння цього процесу. Однією з важливих складових адаптації, яка активно вивчається, є копінг (копінг-стратегії). Як форма саморегуляції, психологічна мета копіngu полягає в тому, щоб дати можливість людині якнайкраще пристосуватися до вимог ситуації шляхом їх опанування, послаблення або пом'якшення. На думку С. Нартової-Бочавер [6, С. 25], поняття «копінг» охоплює широкий спектр людської діяльності, враховуючи всі види взаємодії суб'єкта з внутрішніми та зовнішніми завданнями. Підхід р. Бар-Она ґрунтується на ідеї, що емоційний інтелект має допомагати людині адаптуватися до реального життя. Дослідження показали, що його опитувальник EQ (неформальне скорочення емоційного інтелекту) позитивно корелює з адаптивністю, суб'єктивним благополуччям і соціальним успіхом. Високі показники EQ пов'язані з найбільш адаптивними копінг-стратегіями, спрямованими на вирішення проблем. Однак ці результати ставлять і інші питання. Наприклад, негативна кореляція між EQ та шкалами, що оцінюють вираженість психопатологічних симптомів, може свідчити про те, що EQ вимірює не здатність долати життєві труднощі, а радше наслідки протистояння цим життєвим труднощам [6, С. 4]. Варто також зазначити, що досліджуючи процеси

соціалізації, значну частку опитуваних становлять саме підлітки, так як вони являються найменш стабільною та водночас найбільш вразливою (зокрема емоційно) складовою суспільства [3, 4].

Висновок: Емоційний інтелект (ЕІ) являється важливим та невід'ємним чинником соціалізації особистості та становлення її у соціумі, а також є його здатністю ефективної взаємодії з оточуючим середовищем та адаптації до нього. Високий показник ЕІ сприяє кращому та глибшому розумінню як власних почуттів та емоцій, так і емоцій та почуттів інших людей, що допомагає в подальшому уникнути конфліктів та знаходити компроміси навіть у критичних ситуаціях. На основі вже існуючих досліджень було зазначено, що наявність високого ЕІ має прямий взаємозв'язок схильності до адаптивної поведінки та здатності ефективного керування емоціями. Також варто зазначити, що низький рівень ЕІ корелює з високим рівнем агресії, однак треба також враховувати існуючу похибку при цих дослідженнях, яка не виявляє цього моменту. Соціалізацію варто розглядати як процес інтеграції індивіда в соціальну групу і в соціум загалом, що залежить від багатьох факторів, включно з соціальним середовищем, культурними цінностями та умовами виховання. В основі досліджень соціалізації лежить її спрямування на розвиток соціальних навичок та їх формування під впливом існуючих соціальних норм та правил. У всіх дослідженнях прослідковується взаємозв'язок ЕІ з впливом на процес соціалізації, оскільки при цьому відбувається процес забезпечення ефективної комунікації та розуміння дій у різних соціальних ситуаціях. Значна частина досліджень, пов'язаних з емоційним інтелектом та його розвитком у підлітковому віці, показує, що саме у цій віковій категорії він є критичною та вирішальною складовою, яка сприятиме формуванню їхньої особистісної та міжособистісної поведінки. Навчання умінню керувати власними емоціями та розрізненню чужих емоцій є важливими компонентами у підвищенні рівня ЕІ, які впливають на формування самосвідомості, розвитку та умінню емпатії, умінню адаптуватися, самоконтролю та оптимізму, що в цілому сприятимуть вибудові позитивного емоційного клімату та гармонійному розвитку не лише однієї особи, але і всього колективу, в якому перебуває індивід. Таким чином,

емоційний інтелект являється одним з ключових чинників успішної соціалізації підлітків та забезпечує здатність до ефективної взаємодії в суспільстві, підтримуючи при цьому позитивні емоційні стосунки. Вивчення та впровадження програм по розвитку ЕІ повинні стати важливим напрямком психологічної підтримки підлітків, а також у допомозі їхнього становлення в соціумі та досягнення ними успіху в житті. Підлітки як були, так і залишаються найбільш вразливою віковою категорією, так як у цей час відбувається перехід від дитинства до дорослості, Тому саме у цей вік варто зацентувати увагу на емоційному становленні та розвитку ЕІ, що в кінцевому результаті дозволить сприяти розвитку не лише однієї особи, але і соціуму загалом.

Література.

1. Бондарчук О. І. Психологія девіантної поведінки: Курс лекцій. МАУП, 2006. 88 с.
2. Василенко І. В. Організація системи соціального виховання учнів. Педагогіка і психологія. 1996. 103 с.
3. Діяльнісні засади підготовки майбутніх компетентних фахівців в умовах сучасних викликів: монографія / за ред. О.А.Дубасенюк. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2024. 366 с.
4. Енциклопедія освіти. Акад. пед. наук України. за ред. Кремень. В.: Юрінком Інтер, 2008. Івано-Франківськ. 2007. 41 с.
5. Лялюк Г. М. Психологічні особливості соціалізації підлітків в умовах родинної депривації: дис: ... канд. психол. наук: спец. 19.00.07. Дрогобицький державний педагогічний ун-т імені Івана Франка. Дрогобич. 2007. 211 с.
6. Міхно О. П. Організація дослідницької діяльності старшокласників у процесі вивчення новели М.Коцюбинського «Цвіт яблуні». Українська мова й література в школі. 2007. №2. С. 25–30.
7. Філіппова І. Ю. Рольова соціалізація підлітка як засвоєння соціального досвіду. Збірник статей «Актуальні проблеми сучасної психології». Луцьк, 2014. С. 204-215.

2.3. Ціннісні орієнтації майбутнього психолога в координаті психічного здоров'я

*Бондар С. І.
Тетерук С. П.*

Актуальність. Після початку повномасштабної агресивної війни проти України надзвичайно гострою постала проблема захисту ментального здоров'я. Війна у всіх її проявах є потужним стресовим фактором, що впливає на психіку людини навіть через кілька років після закінчення воєнних дій. Щоб запобігти серйозним і віддаленим психологічним ускладненням, дуже важливо вже зараз окреслити цю проблему і перевести її в русло забезпечення психологічної підтримки. Такі непередбачувані чинники, як участь у бойових діях або перебування в прифронтовій зоні та навіть і в тилівій з постійними ракетними та артилерійськими обстрілами, бомбовими ударами, перебування в окупації, значно підвищують уразливість українців до психосоціального стресу, сприяють поширенню певних психічних розладів, а саме: тривожності, постстресовим розладам, депресії тощо. До цього переліку можна додати втрату почуття безпеки внаслідок вразливості практично всієї території країни для ракетних обстрілів та атак БПЛА, тривогу за рідних та близьких, втрату роботи й звичного, комфортного середовища; побутові негаразди, фінансові труднощі, соціальну ізоляцію, невпевненість у майбутньому. За оцінками експертів, 40–50 % населення потребуватимуть психологічної допомоги [3]. У певних групах населення кількість таких людей буде становити: з-поміж військових та ветеранів – 1,8 млн; серед людей старшого віку – 7млн; близько 4 млн – дітей та підлітків. Прогнозована потреба в допомозі з питань психічного здоров'я на первинній ланці медицини – 27 млн звернень [9] 3–4 млн українців матимуть певний розлад психічного здоров'я – помірної або тяжкої форми».

Мета. Дослідити ціннісні орієнтації майбутнього психолога в координаті психічного здоров'я.

Результати дослідження. Перед урядом України, перед усією українською спільнотою постали непересічні питання збереження психічного здоров'я нації в цілому і кожної окремої особистості. Для вирішення цього питання на рівні урядових та громадських організацій, відбуваються численні дискурси, зустрічі, конференції, семінари. Окреме і важливе місце у вирішенні цієї проблеми відводиться освіті, а саме: формуванню фахівців з психології, психологів-реабілітологів, психологів-клініцистів, психотерапевтів, щоб у майбутньому уникнути кадрового голоду. Цей надважливий запит суспільства вимагає специфічної траєкторії навчання і виховання майбутніх психологів в атмосфері вибору відповідних цінностей і ціннісних орієнтацій, які б сприяли збереженню психічного здоров'я і резильєнтності. Складність побудови навчальної стратегії полягає в тому, що учасники навчального процесу – це особистості, які самі переживають зазначені вище стресові ситуації. На нашу думку визначення пріоритетності цінностей і ціннісних орієнтацій має допомогти кожному здобувачу психологічної освіти у закладі вищої освіти формувати власну систему цінностей, на підґрунті якої виникне архітектура захисту психологічного здоров'я.

Для цього майбутній фахівець в галузі психології повинен опанувати поняттями цінностей і ціннісних орієнтацій та орієнтуватися в теоріях цінностей і ціннісних орієнтацій. «В галузі психології роль і вплив цінностей та ціннісних орієнтацій на становлення особистості розкрито в працях у працях вітчизняних науковців, серед яких В. Андрущенко, І. Бех, О. Бондаренко, О. Бондарчук, М. Головатий, Л. Долинська, Г. Дубчак, І. Зязюн, З. Карпенко, П. Таланчук, В. Хмелько, та інші. Закордонними авторами вагомих наукових досліджень є А. Бандура, А. Маслоу, М. Рокіч, К. Рокіч, К. Роджерс, Ш. Шварц, які приділяли значну увагу формуванню ціннісних орієнтацій особистості» [2, с. 1244]. Цінності можуть бути детермінантами трансформацій у суспільстві. Трансформація політичних цінностей може відбутися в розвинених індустріальних суспільствах. Ця трансформація може змінювати основні пріоритети цінностей для поколінь в результаті зміни умов при яких відбувалась соціалізація індивіда, а в свою чергу зміни цінностей та пріоритетів у представників нових поколінь може призвести до

зміни довгострокових тенденцій у політичних партіях. Люди переслідують різні цілі в ієрархічному порядку, приділяючи максимум уваги тим речам, які, на їхню думку, є найважливішими незадоволеними потребами на даний момент, іншими словами – гіпотеза ціннісної значущості того, чого не вистачає.

У психології ХХ-го століття було розроблено низку теорій, які активно включали поняття цінностей та ціннісних орієнтацій. Однією з найвідоміших таких теорій є теорія особистості американського психолога Абрахама Маслоу, який ввів поняття «ієрархії потреб», що в подальшому наочно відображалося у вигляді піраміди (хоча сам науковець не створював піраміду). Піраміда Маслоу має свою інтерпретацію: чим нижчий рівень потреб, тим менш забезпечений рівень життя людини. Якщо особистість прагне задовольнити мінімальні потреби, лише фізіологічні, це означає що людина зазнала харчової, матеріальної, економічної депривації. Згідно з Маслоу, у індивіда мета може уособлювати і матеріальне, і символічне, від бажання володіти певним фізичним об'єктом як символом певного статусу до бажання бути визнаним або коханим.

В дитинстві кожна дитина переживає ситуації, які стосуються обмежень різних видів її потреб. В книзі «Мотивація та особистість» американський психолог говорить про те, що діти, які постійно відчують любов і турботу батьків, у яких сформовано базове почуття довіри до світу, легко переносять випадки депривації, дисциплінуючий режим, покарання і тощо, вони не сприймають це як фундаментальну загрозу своїм головним, базовим потребам і цілям. Пріоритет матеріальної складової, фінансового збагачення буде проявлятися у тих поколіннях, які переживали злидні, були обмежені в речах першої необхідності [7; 8].

Іншою теорією, пов'язаною з цінностями, є теорія когнітивного дисонансу Леона Фестінгера, яка розглядає конфлікт між цінностями та діями людини. В 50-х роках ХХ століття Леон створив свою теорію, яка отримала назву когнітивного дисонансу (з латинської когніто – «пізнання») або словосполучення «когнітивний дисонанс» походить від англійських термінів: «cognition» – знання + «dissonance» – невідповідність, розбіжність. Теорія когнітивного дисонансу – одна з «теорій відповідності», що ґрунтуються на приписуванні особистості прагнення до

зв'язного і впорядкованого сприйняття свого ставлення до світу. А саме теорія когнітивного дисонансу була сформульована Л. Фестінгером у 1957 році на базі теорії польової поведінки К. Левіна та теорії структурного балансу Ф. Хадера. Поштовхом до неї послужило вивчення чуток, що поширилися внаслідок землетрусу в одному з північноамериканських штатів. Пояснюючи походження цих чуток та причини повсюдної віри в них, учений зробив висновок, що люди прагнуть до внутрішньої рівноваги між інформацією, яку вони отримують та особистими мотивами їх поведінки.

У даній теорії реалізовується основний принцип гештальтпсихології: «динаміка розвитку» визначається досягненням позитивного гештальту. Стверджується, що індивід прагне до гармонії когнітивних репрезентацій будь-яких знань, думок, переконань про навколишній світ, про себе, про поведінку будь-кого. Дисонанс цих репрезентацій переживається як щось неприємне, що потрібно максимально зменшити. Тому якщо індивід зустрічається з суперечливими уявленнями, то у нього з'являється особлива мотивація, яка веде до зміни поведінки – або одне з уявлень переглядається, або знаходиться нова інформація. Вважається, що існує комплекс знань про об'єкти та людей, названий когнітивною системою, який може бути різного ступеня складності, узгодженості та взаємозв'язку. При цьому складність когнітивної системи залежить від кількості і різноманітності включених до неї знань. За класичним визначенням Л. Фестінгера, когнітивний дисонанс – це невідповідність між двома когнітивними елементами – думками, досвідом, інформацією, тощо, при якому заперечення одного елемента впливає з існування іншого, і викликає відчуття дискомфорту, інакше кажучи, відчуття дискомфорту виникає при зіткненні в свідомості логічно суперечливих знань про одне й те ж явище, подію, об'єкти. Теорія когнітивного дисонансу характеризує способи усунення або згладжування цих протиріч і описує те, як це робить людина в типових випадках.

Положення теорії можна викласти в трьох основних пунктах: а) між когнітивними елементами може виникнути дисонанс; б) існування дисонансу

викликає прагнення зменшити його або запобігти його зростанню; в) прояв цього прагнення включає: або зміну поведінки, або зміну знань, або обережне, вибіркове ставлення до нової інформації.

Як ілюстрація наводиться загальновідомий приклад з курцем: людина курить, але разом з тим знає, що куріння шкідливе; у нього виникає дисонанс, вийти з якого можна трьома шляхами: а) змінити поведінку, тобто кинути курити; б) змінити знання, в даному випадку – переконати себе, що всі міркування про шкоду куріння, щонайменше перебільшують небезпеку, а то і зовсім недостовірні; в) обережно сприймати нову інформацію про шкоду куріння, тобто просто ігнорувати її [10]. Отже, Л. Фестінгер вважав, що людина прагне позбутися такого дисонансу. Наприклад індивід може ігнорувати нову інформацію, щоб не створювати протиріч. Адже можна переконати себе, що протиріччя не існує. У своїй роботі він наводить приклад виключення конфлікту. Якщо людина змушує себе посміхатись, коли їй сумно (тобто знаходиться у когнітивному дисонансі), то вона в якийсь момент певним чином відреагує: або припинить прикидатись, або щиро повеселішає.

Теорія когнітивного дисонансу швидко знайшла застосування у педагогіці. З її допомогою можна виробити у дитини певне ставлення, наприклад, до агресії або чесності й чуйності. Створюючи ситуацію дисгармонії, педагог тим самим підштовхує учня до породження певної думки. Ця «когнітивна» педагогіка стала своєрідною протипагою педагогіці біхевіористів, які вважали, що всі аспекти поведінки можна побудувати за допомогою простої системи «стимул-реакція». Л. Фестінгер зовсім не відкидав досягнення біхевіористів, він лише стверджував, що далеко не всьому можна навчити таким способом.

На думку вченого прості елементи поведінки можуть бути закріплені за допомогою різних стимулів, і при цьому зміна думки може бути досягнута тільки за допомогою когнітивних методів. Застосовуючи когнітивний дисонанс можна «достукатися» до людини, вплинути на зроблений нею вибір. Явище когнітивного дисонансу може мати не тільки позитивні, але і негативні наслідки. Дослідження, проведені Л. Фестінгером, є надзвичайно важливими для багатьох наук, зокрема

для педагогіки та соціології [10]. Теорія Л. Фестінгера є дотичною до формування цінностей особистості, особливо у середовищі, яке може вимагати гнучкості в поведінці та вироблення адекватного ставлення до різних життєвих ситуацій.

Теорія ідентичності Дж. Еріксона встановлює, що формування ідентичності особистості відбувається протягом життя і переживає різні стадії. Однією з ключових стадій є стадія «ідентичність проти рольової конфузії», яка зазвичай настає в підлітковому віці. На цій стадії особистість спробує зрозуміти, хто вона є, і які цінності та переконання їй важливі. Цей процес включає в себе внутрішній вибір і взаємодію з навколишнім світом. Теорія ідентичності Л. Кольберга, відомого своїми дослідженнями морального розвитку, розглядає ідентичність як результуючий продукт морального розвитку. Л. Кольберг виділяє шість рівнів морального розвитку, які охоплюють різні стадії морального мислення. На вищих рівнях розвитку морального мислення особистість більш схильна до усвідомлення власних цінностей і переконань, які можуть впливати на формування її ідентичності. Важливо відзначити, що теорії ідентичності Дж. Еріксона і Л. Кольберга не розглядають ідентичність в ізоляції від інших аспектів особистості. Вони враховують вплив зовнішніх факторів та соціального середовища на формування ідентичності і, відповідно, цінностей особистості [10]. Крім того, ідентичність може впливати на вибір професійної діяльності. Люди, які чітко усвідомлюють свої цінності і переконання, схильні обирати професії, які відповідають їхній ідентичності та дозволяють реалізувати їхні цілі [4].

Теорія соціального когнітивного навчання, розроблена Альбертом Бандурою, є важливою в соціальній психології і має значний вплив на розуміння формування ціннісних орієнтацій особистості. в тому числі і в умовах професійної діяльності. Ця теорія висуває ідею, що люди навчаються не тільки через прямий досвід, але й через спостереження за іншими людьми та їхніми діями. Отже, теорія має важливий вплив на формування ціннісних орієнтацій, оскільки ці орієнтації можуть зазнати впливу навколишнього середовища та моделей поведінки інших людей, за якими особистість спостерігає. Згідно з теорією А. Бандури, одним із ключових аспектів є поняття «соціального моделювання». Це означає, що люди вчаться,

спостерігаючи імітацію поведінки інших осіб, які є для них авторитетними, або які мають великий вплив. В умовах професійної діяльності, це може означати, що працівники можуть спостерігати за своїми керівниками, колегами або іншими фахівцями в своїй області і моделювати їхню поведінку та ціннісні установки.

Крім того, важливою концепцією в теорії Бандури є «саморегуляція». Це означає, що люди можуть контролювати і регулювати свою поведінку, враховуючи цінності та цілі, які вони визначили для себе [1; 2]. Теорія А. Бандури надає підґрунтя для розуміння впливу моделювання на формування ціннісних орієнтацій. Якщо студент спостерігає за успішними однокурсниками, які дотримуються певних моральних цінностей, то це може спонукати його до прийняття аналогічних цінностей і стилю діяльності. З іншого боку, якщо особистість спостерігає негативні приклади це також може вплинути на її ціннісні орієнтації [1].

Однією з ключових психологічних теорій ціннісних орієнтацій є теорія ціннісного конфлікту Кріса Т. Клегторна. Згідно з цією теорією, ціннісні орієнтації можуть викликати конфлікт, якщо вони суперечать одна одній або, якщо вони не узгоджені з реальною поведінкою особистості. Це може призвести до стресу та психологічних труднощів. Теорія ціннісного конфлікту надає інструмент для розуміння, чому люди можуть відчувати внутрішній конфлікт між різними цінностями та яким чином цей конфлікт впливає на їхні рішення та поведінку [4].

Ще однією важливою психологічною теорією є теорія ціннісних орієнтацій Шаллонда Шварца. Він виділяє 10 основних ціннісних орієнтацій, які можна поділити на чотири основні категорії: трансцендентні цінності (які включають в себе гармонію, універсалізм, доброту), самосамостійність (що включає в себе стимуляцію, самофективність, інноваційність), бажання (які включають в себе досягнення, владу, славу) і традиція (яка включає в себе безпечність, конформізм, впевненість). Шварц розглядає ціннісні орієнтації як структуровану систему, що впливає на спосіб сприйняття та взаємодії особистості зі світом навколо неї [6].

Психологічні теорії ціннісних орієнтацій відіграють важливу роль у розумінні та вивченні процесу формування ціннісних орієнтацій у житті особистості. Різні теоретичні підходи пропонують різні пояснення та моделі для розуміння, як і чому

ціннісні орієнтації розвиваються та впливають на поведінку та рішення особистості. Аналіз літературних джерел дозволяє нам продовжити перелік зазначеного вище за рахунок теорій розвитку цінностей і ціннісних орієнтацій, а саме: 1. Теорія розвитку цінностей Дж. Гарднера представляє модель розвитку цінностей, яка включає стадії формування цінностей від дитинства до дорослості [11]. 2. Теорія Леонарда Інглхарта. Леонард Інглхарт розробив теорію «зміни цінностей», яка вказує на зміну цінностей у суспільстві через покоління і відзначає роль культурного контексту [11]. 3. Теорія розвитку цінностей Мілтона Рокіча включає у себе концепцію розвитку цінностей у відповідь на життєві події та досвід особистості, що змінюються з часом [5]. 4. Теорія Лавра Стрейкера. Лавр Стрейкер розробив модель розвитку цінностей, яка включає п'ять етапів від ранньої дитини до дорослості, де цінності еволюціонують [11]. 5. Теорія розвитку цінностей Моріса Рокіча. Моріс Рокіч розглядає розвиток цінностей на різних етапах життя, включаючи ранню дитину, підлітка, дорослого та старість, і виділяє ключові цінності на кожному етапі [5]. Зв'язок між цими теоріями і формуванням ціннісних орієнтацій полягає в тому, що ідентичність особистості і її цінності взаємопов'язані. Під час процесу формування ідентичності особистість розмірковує про свої цінності, переконання і життєві цілі. Ці роздуми та пошук власного «я» можуть призвести до більшого усвідомлення і внутрішнього прийняття певних цінностей [2].

Висновки. Отже, в умовах що склалися в результаті подій війни, яка, нажалює все ще триває, першочерговим у переліку цінностей майбутнього фахівця галузі психології, має бути збереження власного психічного здоров'я і власної резильєнтності та надання психологічної допомоги з метою підтримки і захисту психічного здоров'я найбільш вразливих членів суспільства. А завданням вищого закладу освіти є вибір стратегій формування ціннісних орієнтацій студентів для застосування знань в системі збереження психічного здоров'я.

Література.

1. Бандура, Альберт. «Механізм самоефективності в людському функціонуванні». Психологія і суспільство. 2024. № 90. Р. 63–94, <https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/1289>

2. Бондар С. І., Тетерук С. П. Саморегуляція і система ціннісних орієнтацій особистості студента в умовах університетської освіти. Наукові перспективи. Серія «Психологія». 2024. № 11(53). С. 1244–1257.

3. Зеленська про програму ментального здоров'я: Виявилося, що «сильні не ходять до психологів» <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3703135-zelenska-pro-programu-m...>

4. Зима О. Г., Полубєдова А.О. Діагностика ціннісних орієнтацій студентів. Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів, м. Харків, 22.04. 2016. Харків: Видавництво «НТМТ». 2016. 128 с.

5. Методика «Ціннісні орієнтації Рокіча» <https://studfile.net/preview/5258514/page:36/>

6. Нагорняк К. М. Уточнена теорія базових цінностей Ш.Шварца: Попередні результати адаптації методики PVQ-57 в Україні/ Наукові записки НаУКМА. 2017. Том 196. Соціологічні науки.с. 24-31.

7. Павленко Т.В. Розуміння конструкту «бажання» в структурі особистості відповідно методу психотерапії «Я-реконструкція» / Т. Павленко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. К. : Національний авіаційний університет, 2023. Вип. 1(22). С. 118–125

8. Піраміда потреб Маслоу: що таке ієрархія потреб і як вона працює? <https://www.gasformind.com/piramida-potreb-maslou>

9. У межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я визначили пріоритетні проекти. <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3695613-u-mezah-vseukrainskoi-p...>

10. Cognitive Dissonance Theory(Festinger). The Blackwell Encyclopedia of Sociology. Publisher: John Wiley & Sons. 2015. Editors: George Ritzer https://www.researchgate.net/publication/291356571_Cognitive_Dissonance_Theory_Festinger

11. Encyclopedia of Psychology / Ed. by R. J. Corsini. Vol. 1–4. New York, 1994.

P. 166–170. https://www.researchgate.net/publication/229850733_Corsini_Encyclopedia_of_Psychology

2.4. Психолого-педагогічні засади навчання особистості протягом життя як складова європейської соціальної моделі неперервної освіти

Гончаренко Н.М.

Актуальність. При підрахунку Індексу Людського Розвитку враховуються три показники: очікувана тривалість життя; рівень грамотності населення країни (середня кількість років, витрачених на навчання) та очікувана тривалість навчання; рівень життя, оцінений через валовий національний дохід на душу населення. Таким чином, очікувана тривалість навчання визнається одним із ключових індикаторів рівня людського розвитку. Важливо звернути увагу на те, що з 2010 року враховується не просто рівень освіченості, а й тривалість навчання [9]. Це свідчить про акцентування уваги на продовженому навчанні (continuing education), або, у більш вживаному в останні роки терміні, на навчанні протягом життя (lifelong learning). Лісабонський саміт Ради Європи у березні 2000 року прийняв «Меморандум освіти протягом життя» (A Memorandum of Lifelong Learning) [10]. У Меморандумі підкреслюється, що безперервна освіта повинна стати головною політичною програмою громадянського суспільства, соціальної єдності й зайнятості. Визначення безперервної освіти охоплює своїм змістом: отримання ступенів та дипломів у вільний час; професійні курси, в тому числі з метою підвищення кваліфікації персоналу; освіту для дорослих; другу освіту та інше. У Меморандумі визначено шість принципів безперервної освіти.

1. Нові базові знання і навички для всіх. Мета: гарантувати загальний неперервний доступ до освіти для отримання й оновлення навичок, необхідних для включення людини в інформаційне суспільство. Підсумкові документи Лісабонського саміту відносять до таких навичок комп'ютерну грамотність, володіння іноземною мовою, технологічну культуру, підприємництво та соціальні навички.

2. Збільшення інвестицій в людські ресурси. Мета: значно збільшити інвестиції в людські ресурси для підняття пріоритету найважливішого надбання Європи – її людей. В останніх документах ЄС пропонується підвищувати

капіталовкладення в людські ресурси, діючи на основі соціального партнерства і поширюючи досвід передових компаній.

3. Інноваційні методики викладання й навчання. Мета: Розробити нові методології навчання для системи безперервної освіти. З розвитком інформаційного суспільства освітні технології стають усе більше орієнтованими на користувача. Методи навчання як у формальній, так і в неформальній системі освіти повинні орієнтуватися на користувача, змінюватися в напрямку особистісної мотивації, критичного мислення й уміння навчатись.

4. Нова система оцінки отриманої освіти. Мета: Докорінно змінити підходи до розуміння і визнання навчальної діяльності та її результатів, особливо у сфері неформальної та інформальної освіти. Визнання такої освіти допоможе підвищити мотивацію до безперервної освіти. Актуалізується потреба у розробці якісної системи «Акредитації попередньої і неформальної освіти» (Accreditation of Prior and Experiential Learning – APEL).

5. Розвиток наставництва й консультування. Мета: забезпечити кожній людині протягом усього життя вільний доступ до інформації про освітні можливості та до необхідних консультацій і рекомендацій. Має бути створена постійна консультаційна служба, яка надаватиме рекомендації в сфері освітнього, професійного та особистісного розвитку і буде орієнтована на інтереси та потреби активного користувача.

6. Наближення освіти до місця проживання. Мета: наблизити освітні можливості до місця проживання споживачів за допомогою мережі навчальних та консультаційних пунктів і використання інформаційних технологій. Маючи свободу пересування, люди не повинні, однак, бути змушеними залишати своє рідне місто чи село для отримання якісної освіти [10].

Мета. Дослідити психолого-педагогічні засади навчання особистості протягом життя як складова європейської соціальної моделі неперервної освіти.

Результати досліджень. Основним вектором змін повинен стати пріоритет співпраці (синергії) і взаємодопомоги у реалізації глобального культурного проекту «цивілізації безпеки». Активним і діючим фактором сучасного

багатоманітного бачення міжнародних освітніх та соціальних систем є новий гуманізм, націлений на ноосферний розвиток людини і цивілізації, який враховує як цінності традиційних релігійних спільнот, так і індивідуалістичну аксіологію індустріальної і постіндустріальної цивілізації [8].

Головним обмеженням на шляху економічного зростання та інноваційної трансформації економіки України є скорочення чисельності і погіршення якості трудових ресурсів, вища та професійна освіта не забезпечують країну кадрами інноваторів – талановитими молодими вченими, конструкторами, інженерами, техніками, кваліфікованими робітниками, менеджерами, тому для базових інновацій відсутні кваліфіковані інноваційні кадри. Не акцентуючи уваги на демографічних викликах, сценарій інноваційного прориву однозначно орієнтує на багатократне підвищення продуктивності праці зайнятих на основі освоєння високоефективних технологій, зсувів у структурі зайнятих на користь оброблювальних виробництв за рахунок скорочення надзвичайно розгалужених, паразитуючих сфер обігу і управління. З огляду на це, професійна і вища освіта має здійснити рішучий поворот до підготовки якісно нового покоління інноваторів на основі компетентнісного підходу [6].

Але, вже акцентуючи на демографічних викликах, саме розвиток системи освіти протягом життя як європейської соціальної моделі неперервної освіти в умовах цивілізаційної кризи є не тільки умовою, але й активним чинником прогресивних змін елементів продуктивних сил, прискорення науково-технічного прогресу і розвитку виробництва країни.

Ми є свідками потужної хвилі енергоекологічної, демографічної, технологічної, фінансово-економічної, геополітичної і соціокультурної криз, що охопили весь глобальний простір і загрожують усьому людству. Ці кризи можуть бути подолані у другій третині XXI століття на основі високих індексів епохальних і базових інновацій, результатом яких буде становлення гуманістично-ноосферної постіндустріальної цивілізації, нової моделі глобалізації, багатопольного світовлаштування, що базується на діалозі і партнерстві цивілізацій [8].

Специфічною формою існування цивілізації є її нестійкість, яка у повній мірі проявилась і в Україні. Субординованими елементами загальноцивілізаційної нестійкості за окремими сферами є наступні: 1) екологічна нестійкість, що є рушійним елементом загальної нестійкості; 2) соціальна нестійкість, яка виражається в крайній бідності і злиднях, посиленні соціальних протиріч; 3) демографічна нестійкість (за даними Інституту демографії і соціальних досліджень ім. Птухи населення України за 24 роки скоротилося на 9,5 млн. людей) [7], [9]; 4) фінансово-економічна нестійкість, яка проявляється у виключній хиткості світових фінансових, фондових, кредитних ринків, курсів акцій, валют; гігантському зовнішньому боргу; 5) міжцивілізаційна нестійкість, яка загострилась, як своєрідне протиставлення між носіями західних ліберальних і традиційних східних традицій; 6) моральна нестійкість, яка загострилась до масштабного падіння цінностей, що проявляється у зростанні корупції та інших деструктивних явищ; 8) нестійкість особистого життя, що виражається в порушенні конституційних прав людини на державному рівні, зростанні злочинності проти особистості, збільшенні терористичних актів [8].

У справі об'єднання людства перед очевидними загрозами на основі певних ціннісних і цільових орієнтирів, безумовно, одним із пріоритетних чинників стає навчання протягом життя як компонент європейської соціальної моделі неперервної освіти в умовах цивілізаційної кризи. Неперервність виступає у сучасному культурно-освітньому контексті як ідея, принцип навчання, якість освітнього процесу, умова становлення людини, один із ключових чинників формування якісного людського капіталу. За останні десятиліття кардинально змінилася система генерування й передачі знань, а їх обсяг і спектр багатократно зросли.

Вирішення проблеми забезпечення якості трудових ресурсів, забезпечення країни кадрами інноваторів полягає в переході до навчання протягом життя, де базова освіта періодично повинна доповнюватися програмами додаткової, післядипломної освіти й організовуватись не як кінцева, завершена, а лише як основа, фундамент, що доповнюється іншими програмами. Це вимагає від

випускника вищого навчального закладу, крім отриманих знань у вузькій професії, ще на студентській лаві розвинути свої здатності до навчання протягом усього професійного життя, розвинути навички комунікації, адаптивності, самовдосконалення, організаційної й групової ефективності та низку інших якостей [6].

Для реалізації інноваційного прориву у галузі освіти протягом життя як складової європейської соціальної моделі неперервної освіти в умовах цивілізаційної кризи необхідне інноваційне оновлення державної політики, що має бути реалізоване через:

- створення ефективного інноваційного євроінтегрованого законодавства;
- формування програми довгострокового прогнозування соціально-економічного, науково-технологічного і територіального розвитку України;
- розробку і утвердження на високому рівні системи національних інноваційних освітніх програм і проектів, у повній мірі, на засадах випереджувального підходу забезпечених ресурсами;
- дієві стимули залучення інвестицій до інноваційних наукових і освітніх проектів шляхом приватно-державного партнерства, податкових і митних преференцій для корпорацій, які беруть у них участь, створення міжнародної методично-інноваційно-технологічної біржі і державного страхування інноваційних ризиків та наукових програм;
- цільову підготовку адміністративних менеджерів освіти, вчених, державних службовців для реалізації інноваційних наукових та освітніх програм і проектів;
- створення цільових оргструктур для реалізації стратегії інноваційного прориву по національним інноваційним програмам і проектам, консорціумів, холдингів, стратегічних альянсів;
- створення об'єднаної освітньо-наукової ради з прогнозування, стратегічного планування, інноваційних програм і проектів під керівництвом Національної академії педагогічних наук України [8].

Концепція інноваційної системи освіти протягом життя як складової європейської соціальної моделі неперервної освіти в умовах цивілізаційної кризи потребує підтримки за рахунок комплексної інституціоналізації на мікро- мезо- і макрорівнях, міжнародної інноваційної стратегії, а також заходів системної освітньої політики, направлених на стійке інноваційне позиціонування України у світі, вирішення тактичних і стратегічних завдань у сфері міжнародної наукової інноваційної співпраці на основі інтернаціоналізації та мобілізації ресурсів, реалізації міжнародних проектів і програм.

Міжнародна співпраця. Наразі, у рамках реалізації освітніх проектів у межах програми співробітництва з ЄС – країни Східного партнерства (Темпус та Еразмус Мундус), вищими навчальними закладами України реалізується більше ніж 60 спільних з європейськими університетами проектів, що фінансуються Європейською Комісією. Серед основних пріоритетних напрямів проектів – модернізація програм підготовки фахівців, впровадження механізмів забезпечення якості вищої освіти відповідно до європейських стандартів та рекомендацій, відновлення тісного співробітництва між університетами, промисловістю та структурами, що здійснюють інноваційну діяльність, з метою надати більше можливостей для підвищення якості викладання та навчання. Основні види діяльності за напрямками: 1) викладання (викладацьке відрядження): розроблення інноваційних методів викладання, мобільність відкрита для країн-партнерів в обох напрямках; 2) професійний розвиток: удосконалення навичок і компетентностей у викладацького складу та адміністративного персоналу, відкритий для країн-партнерів в обох напрямках.

Крім того, існують фінансові інструменти, які сприяють започаткуванню та розвитку міжнародної співпраці між державами в обраних пріоритетах політики ЄС шляхом реалізації довготермінових міжнародних проектів, таких як програми в сфері науки та освіти: Еразмус Плюс (Erasmus +), Горизонт (Horizon) [9]. Нова Міжнародна програма Еразмус Плюс об'єднує кілька програм, таких як: навчання впродовж життя (LLP), молодь в дії (Youth in Action), Еразмус Мундус, Темпус.

За час її дії за програмою мобільності працівників системи освіти пройшли навчання 1 млн викладачів, вчителів, тренерів, волонтерів і адміністративних працівників системи освіти та менеджменту освіти із країн учасниць і країн-партнерів. Міжнародний обмін студентами і працівниками в рамках країн ЄС, а також за участі партнерських країн (у т. ч. України) у сфері вищої освіти, а також мобільність, організовану на підставі спільних навчальних програм і проектів. Пропонуються різноманітні сфери реалізації Програми: Мобільність студентів і працівників навчальних закладів (країни програми); Мобільність студентів і працівників навчальних закладів (партнерські країни); Спільні магістерські програми Еразмус Мундус; Позики на навчання та здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра в іншій європейській країні [9].

За умовами Програми педагогічні і науково-педагогічні працівники навчальних закладів можуть виїздити з метою проведення навчальних занять до закордонних університетів, з якими їх базові університети (факультети) підписали угоди про таку співпрацю; інші працівники ВНЗ можуть здійснювати поїздки до іноземних інституцій (підприємств, фірм, освітніх організацій, в тому числі університетів) з метою вдосконалення фахових компетенцій, обміну досвідом, розширення своїх знань в обраній сфері (участь в стажуваннях, семінарах, практичних заняттях з елементами навчання, тощо). Діють спільні магістерські програми, такі як освіта другого рівня міжнародного характеру; створено Консорціуми навчальних закладів з різних країн, учасниками яких є щонайменше три ВНЗ з різних країн програми, рідше – з партнерських країн. Сфера реалізації Програми – стратегічні партнерства (Strategic Partnerships) між вищими навчальними закладами; об'єднання задля знань (Knowledge Alliances) між вищими навчальними закладами та бізнесом; формування потенціалу у сфері вищої освіти в партнерських країнах (Capacity Building) між вищими навчальними закладами країн програми та партнерських країн. Цілі програм спрямовані на упровадження і поширення інноваційних рішень у вищих навчальних закладах з метою модернізації освітньої пропозиції, її наближення до суспільних та економічних потреб та покращення якості навчання як відповідь цивілізаційним викликам [9].

Програмою передбачені інші освітні заходи, такі як короткі навчальні програми для працівників; короткотермінові поїздки студентів (до двох місяців) поєднані з віртуальною мобільністю (участю у заняттях в іноземних ВНЗ за допомогою мережі Інтернет); довготермінові поїздки викладачів з метою ведення лекційних занять в партнерських навчальних закладах, в межах яких проводяться адміністративні заходи: зустрічі, тощо).

У межах цієї співпраці діють:

1. Програма «Об'єднання задля знань», основною метою якої є підтримка інноваційності в освітній сфері і бізнесі, а також в соціально-економічному середовищі, розвиток в суспільстві вмінь, пов'язаних з підприємництвом, стимулювання трансферу знань між ВНЗ та бізнесом.

2. Програма «Формування потенціалу»: допомога і підтримка інституцій у сфері вищої освіти та систем вищої освіти в партнерських країнах.

Головними завданнями на найближчий період для ВНЗ України є пошук партнерів, укладання договорів про співпрацю з ВНЗ країн-членів ЄС, запровадження викладання спільних програм (курсів) навчання іноземними мовами та вивчення викладачами іноземних мов – англійської, французької, німецької. Реалізація цієї програми здійснюється за двома типами: 1) Спільні проекти (Joint Projects) – зміну ВНЗ: опрацювання навчальних програм; модернізація системи управління закладом освіти і його функціонування; зміцнення зв'язків з оточенням; 2) Структурні проекти (Structural Projects) – зміна системи (участь міністерств): модернізація політики, управління і керування системами у сфері вищої і професійної освіти; зміцнення зв'язків з оточенням.

Висновки. В умовах цивілізаційної кризи навчання стає не лише засобом отримання знань, але й важливим інструментом психологічної адаптації та особистісного розвитку. Підтримка психологічного благополуччя через навчання може допомогти людям не лише вижити, але й знайти нові шляхи для розвитку у складні часи. Навчання протягом життя позиціонується як повноправне освітнє поле з відповідною увагою до контролю й перевірки якості та забезпеченням визнання різноманітних форм освіти. Зростаюче різноманіття пізнавально-

інформаційних запитів різних верств населення неможливо задовольнити в рамках існуючих дотепер форм традиційної освіти. Загострюється проблема невідповідності сформованої системи освіти новим потребам суспільства й людини. Це породжує вимогу новітнього підходу до організації масової освітньої діяльності дорослих – навчання повинне відповідати різнорівневим інтересам і можливостям громадян, органічно вписуватися в їхній спосіб життя, враховувати специфіку запитів того чи іншого контингенту й навіть окремих груп населення. Освіта протягом життя покликана підвищувати рівень загальних знань і розширювати можливості участі громадян у культурній, соціальній і політичній діяльності країни. Вона повинна внести вклад у подальшу демократизацію суспільства, а також сприяти посиленню позиції людини в професійній діяльності.

Література.

1. Андрущенко В. Австрія і Україна в структурі європейських освітніх стратегій: проблеми взаємодії. Австрія й Україна у контексті європейської інтеграції й співробітництва. Збірник наукових праць. К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. 2005. 160 с.
2. Освіта протягом життя: світовий досвід і українська практика. Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. <http://www.niss.gov.ua/articles/252//>
3. Освіта протягом життя як чинник людського розвитку. / Аналітична записка. / Національний інститут стратегічних досліджень. <http://www.niss.gov.ua/articles/1865/>
4. Польсько-українські академічні стосунки. / Аналітичний центр СЕДОС. <http://www.cedos.org.ua/uk/osvita/polsko-ukrainski-akademichni-stosunky>.
5. Із матеріалів Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України <http://rian.com.ua/analytics/20151118/1000510531.html>.
6. Соснін О.В., Воронкова В.Г., Постол О.Є. Сучасні міжнародні системи та глобальний розвиток (соціально-політичні, соціально-економічні, соціально-

антропологічні виміри): Навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2015. 556 с.

7. Чи потрібен післядипломній педагогічній освіті відкритий університет європейського типу / В. Олійник, В. Гравіт. // Післядипломна освіта в Україні. Вигот. ТОВ «Дорадо-Друк». К. 2015. №1(36). С. 3–10.

8. Шпак В. Історія як система взаємодії потоків людської діяльності. Філософська думка. №1. С. 55-62.

9. European Employment Strategy.
<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=en>.

10. UNESCO institute for Statistics.
<http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/default.aspx>.

11. Why did the Report change the indicators for measuring education and income in 2010 // United Nations Development Programme.
<http://hdr.undp.org/en/content/why-did-report-change-indicators-measuring-education-and-income-2010>.

2.5. Роль сучасних інтернет-технологій у наданні психологічної підтримки особистості

Житинська М.О.

Актуальність. Можливостей використання Інтернет-технологій у наданні психологічної підтримки в сучасних умовах є надзвичайно високою оскільки суспільство активно використовує Інтернет для комунікації, навчання, розваг та здобуття інформації. В умовах війни, економічної нестабільності та соціальних змін, психоемоційний стан населення України зазнає значного впливу. Війна в Україні має безпосередній та опосередкований вплив на психічне здоров'я людей. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), близько 22% осіб, які проживають у зонах конфлікту, протягом останніх 10 років можуть зазнати різних психічних розладів, починаючи від легких форм депресії та тривожності до важких психозів. Приблизно 9% населення може страждати від помірних або тяжких психічних розладів. Якщо ці дані перевести на населення України (43,7 мільйона осіб), то можна припустити, що близько 9,6 мільйона людей мають психічні проблеми, а 3,9 мільйона – серйозні або середні розлади [7].

Українці під час війни, очевидно, переживають стрес, який проявляється у вигляді тривожності, смутку, відчутті безнадії, порушень сну, втоми, дратівливості або невиразних фізичних симптомів, таких як біль. Однак це природні реакції на екстремальні умови. У більшості випадків ці симптоми зникнуть з часом, якщо будуть задоволені основні потреби і надана необхідна соціальна та психологічна підтримка. Однак, вже, зараз, в умовах повномаштабної війни, інтернет-ресурси можуть стати дієвим інструментом для надання психологічної підтримки, поширення корисної інформації та сприяння інтеграції в суспільство. Завдяки доступу до Інтернету навіть у віддалених регіонах країни, психологи мають змогу охопити більшу кількість людей, зокрема тих, хто проживає в сільській місцевості чи є внутрішньо переміщеними особами. Використання Інтернет ресурсів дає можливість впроваджувати новітні форми взаємодії з тими, хто потребує підтримки, у форматі онлайн-консультацій, тренінгів, форумів та платформ для

психологічних проєктів. Це робить психологічну допомогу в умовах військової агресії більш ефективною, інтерактивною та адаптованою до реальних потреб суспільства. Для ефективної роботи онлайн з людьми, що перебувають в кризовій ситуації та потребують психологічної підтримки психологи повинні мати належні навички користування цифровими технологіями, тож це питання є важливим і у сфері підготовки фахівців до дистантної психологічної підтримки.

Сучасні українські вчені активно досліджують використання інтернет-технологій для надання соціально-психологічної підтримки, зважаючи на зростання попиту на такі послуги в умовах економічних і соціальних криз, а також через вплив війни. Однією з головних тем є використання онлайн-платформ для психологічної реабілітації військових, які повернулися з зони бойових дій, та членів їх сімей. Дослідження зосереджуються на тому, як інтернет-технології можуть сприяти подоланню посттравматичного стресового розладу (ПТСР), депресії та тривожних станів у цих груп населення. Зокрема, розробляються спеціалізовані програми, які включають відеоконсультації та онлайн-групи підтримки. Так, до прикладу, Гречанюк І. С. розглядає вплив новітніх інтернет-технологій на психологічну допомогу, зокрема в контексті онлайн-консультування та самопомоги [1]. Демченко О. В., Шевченко Н. С. представляють аналіз проблем та можливостей використання інтернет-технологій в психотерапевтичній практиці, а також прогнозування тенденцій розвитку цієї сфери [2]. Шевченко І. В. виокремлює переваги та недоліки використання інтернет-ресурсів для надання психологічної допомоги, а також етичні питання, що виникають при цьому [9]. Науковці Калініченко Т. С. , Черняк О. В. вивчають переваги інтернет-терапії як новітнього напрямку у психологічній допомозі, з акцентом на психотерапевтичні методи, що застосовуються через онлайн-ресурси [3]. Тищенко І. М. розглядає сучасні інтернет-ресурси, що використовуються для корекції психічного здоров'я, зокрема для лікування депресії, тривоги та стресових розладів [8].

Аналізуючи сучасні українські дослідження помічаємо, що науковці приділяють велику увагу питанням ментального здоров'я й надання дистанційної підтримки дітям і підліткам, які відчувають стрес через військову агресію,

соціальну нестабільність або міграцію. Зокрема, платформи для онлайн-консультацій із психологами та програми, що підтримують емоційний інтелект і стресостійкість, допомагають молоді легше адаптуватися до життєвих змін. Так, Козлова Т. В. вивчає роль інтернет-консультування в наданні психологічної допомоги молоді в умовах сучасних викликів [4]. Рибак М. О., Чернявська О. П. в дослідженнях представляють особливості онлайн-консультування через соціальні мережі, його ефективність та специфіка роботи з клієнтами в таких умовах [5]. Також вітчизняні дослідники вивчають роль інтернет-технологій у наданні психологічної допомоги ВПО, які через війну змушені покидати свої домівки та адаптуватися до нових умов. В таких дослідженнях часто аналізуються групи підтримки у соціальних мережах, де люди можуть обмінюватися досвідом і відчувати підтримку, а також онлайн-консультації з психологами.

Варто відмітити, що популярним напрямом є дослідження ефективності мобільних додатків, які допомагають людям самостійно працювати з емоціями та покращувати психологічний стан. Такі додатки часто пропонують вправи для релаксації, медитацію, трекінг настрою тощо. Українські дослідники також створюють власні програми для мобільних пристроїв, адаптовані до національних особливостей, мови та культурного контексту. Так, Смірнова Т. О., Новикова Н. А. розглядають використання мобільних додатків та онлайн-платформ для надання психологічної допомоги та консультацій, а також їх вплив на ефективність роботи психологів [7]. Через зростаючий рівень стресу та тривоги серед населення, українські вчені вивчають ефективність анонімних платформ для кризової підтримки (гарячих ліній та чатів), особливо для людей, які мають труднощі з відкритим зверненням за допомогою. Важливим напрямком тут є дослідження з розробки та впровадження чат-ботів і платформ з мінімальним впливом на особисту конфіденційність. Зокрема Семенець О. О., Лаврентьева О. В. висвітлюють перспективи та бар'єри використання інформаційно-комунікаційних технологій у психологічній допомозі, з акцентом на проблеми доступності та конфіденційності [6]. Викликають інтерес дослідження, присвячені онлайн-тренінгам для фахівців соціально-психологічної підтримки. У зв'язку зі

збільшенням кількості запитів на допомогу, в дослідженнях акцентовано увагу на створенні навчальних платформ для підвищення кваліфікації психологів та соціальних працівників. Такі програми дозволяють підготувати фахівців до роботи з різними категоріями населення в умовах кризи.

Серед сучасних зарубіжних дослідників, які активно вивчають можливості використання інтернет-технологій для надання соціально-психологічної підтримки, можемо згадати канадську дослідницю Мішель Фукс (Michelle Fuks). В своїх наукових розвідках вона досліджує питання використання онлайн-технологій для підтримки ментального здоров'я підлітків та молоді. Її дослідження зосереджені на можливостях платформ для онлайн-консультацій, чатах і мобільних додатках, спрямованих на покращення емоційного благополуччя молоді. Ширин Гохарі (Shirin Gohari), американська вчена досліджує роль мобільних додатків та цифрових інтервенцій у підтримці людей із депресією та тривожними розладами. Вона аналізує, як цифрові інструменти можуть сприяти саморегуляції та зменшенню симптомів депресії, особливо у віддалених або сільських районах, де доступ до традиційної психологічної допомоги обмежений. Соня Ливінгстон (Sonia Livingstone), професорка Лондонської школи економіки і політичних наук, Ливінгстон спеціалізується на дослідженні впливу інтернет-технологій на ментальне здоров'я дітей та підлітків. Її роботи аналізують, як соціальні медіа і цифрові платформи впливають на психологічний розвиток молоді та які можливості вони створюють для підтримки. Джон Торус (John Torous) як психіатр і директор цифрового психічного здоров'я у Медичній школі Гарварда, він досліджує використання мобільних додатків і онлайн-платформ для підтримки ментального здоров'я пацієнтів. Торус займається також питаннями етичного використання цифрових технологій і конфіденційності в цій сфері. Гізер Лейкі (Heather Leith), науковиця з Австралії, займається розробкою цифрових інтервенцій для підтримки ментального здоров'я людей у сільських і віддалених районах. Її роботи зосереджені на створенні доступних платформ для тих, хто не має змоги отримати традиційну терапевтичну підтримку. Елісон Дарсі (Alison Darcy), засновниця Woebot Health (США), розробила один із найвідоміших чат-ботів для

підтримки ментального здоров'я, який застосовує когнітивно-поведінкову терапію для допомоги користувачам. Її дослідження спрямовані на створення більш доступних і ефективних інструментів для психотерапії з використанням штучного інтелекту. Ніколас Аллен (Nicholas Allen), професор психології з Австралії, вивчає як цифрові інструменти можуть підтримувати психічне здоров'я підлітків, а також потенціал використання технологій для виявлення ранніх ознак депресії та тривожних розладів серед молоді [10]. Отже, проведений нами аналіз сучасних наукових досліджень українських та зарубіжних вчених доводить високий рівень зацікавленості до проблеми соціально-психологічної допомоги за допомогою інтернет-технологій, сприяє впровадженню інноваційних підходів у сфері ментального здоров'я.

Мета. Визначити місця сучасних інтернет-технологій та мобільних застосунків у сучасній системі психологічної допомоги, а також оцінку їхнього впливу на емоційний стан користувачів.

Результати дослідження. Інтернет-технології стали потужним інструментом для надання соціально-психологічної підтримки, особливо в умовах зростаючого попиту на дистанційну допомогу. Визначимо та проаналізуємо ключові ресурси:

1. Платформи для онлайн-консультацій. Сервіси, як-от Zoom, Skype та інші відеоконференц-засоби, дозволяють психологам проводити індивідуальні та групові сесії, зберігаючи при цьому конфіденційність та забезпечуючи якісну взаємодію на відстані. Такий формат став особливо затребуваним під час пандемії, коли особистий контакт був обмежений й сьогодні в умовах вимушених переселень.

2. Чати та месенджери. Багато платформ підтримують текстову комунікацію (Telegram, WhatsApp, Messenger), що дає змогу отримати психологічну допомогу навіть у тих випадках, коли клієнт не готовий до особистого спілкування або потребує негайної підтримки. Анонімність таких сервісів знижує бар'єри для тих, хто вагається звертатися до психолога.

3. Мобільні додатки для психологічної підтримки. Наприклад, додатки на кшталт Calm або Headspace надають ресурси для зняття стресу, медитації та

покращення сну, а також пропонують техніки самодопомоги. Такі програми можуть інтегруватися з іншими методами психологічної підтримки, доповнюючи терапію та надаючи клієнтам інструменти для підтримки ментального здоров'я щодня.

4. Групи підтримки та форуми. Інтернет дозволяє створювати спільноти для людей, які проходять через схожі життєві випробування. Такі групи допомагають людям обмінюватися досвідом, що створює відчуття єдності та взаємопідтримки. Це також особливо важливо для людей у важких життєвих ситуаціях, які шукають розуміння.

5. Анонімні гарячі лінії та чати для кризової допомоги. Чимало організацій використовують інтернет для забезпечення кризової допомоги через гарячі лінії або чати, де люди можуть отримати миттєву підтримку. Це може бути важливо для профілактики кризових станів, таких як депресія чи суїцидальні думки.

6. Технології штучного інтелекту. Чати на базі AI можуть допомагати користувачам у питаннях емоційної саморегуляції та відстеження настрою. Деякі боти здатні надавати базові консультації, відправляти поради чи пропонувати вправи з релаксації, а також направляти до фахівців при виявленні гострої потреби.

Таким чином, інтернет-технології відкривають широкий спектр можливостей для надання соціально-психологічної підтримки, роблячи її більш доступною, оперативною і персоналізованою. Це важливо як для індивідуальної допомоги, так і для підтримки на рівні спільнот. Тому важливою частиною даного дослідження є виявлення стану використання сучасних інтернет-технологій фахівцями психологічної сфери в Україні та їх оцінку ролі даних технологій в наданні психологічної підтримки. З цією метою було проведено анонімне анкетування з використанням Google-форми. В анкетуванні взяли участь 56 психологів, які працюють з українцями.

Аналіз відповідей на запитання анкети дозволяє стверджувати, що 100% респондентів використовують сучасні інформаційні технології та мобільні застосунки в своїй професійній діяльності, 63% психологів в умовах воєнного часу працюють виключно в режимі «онлайн». Серед основних переваг використання інтернет-технологій фахівці називають доступність – 82 %, (з різних куточків

планети, будь-де та будь-коли), ресурсність – 73% (економія часу на дорогу, відсутність потреби в організації простору), комфортність використання – 79% («можливість отримання допомоги не перевзуючи домашніх капців»).

Серед основних ресурсів, що затребувані українськими фахівцями є платформи для онлайн-консультацій (сервіси Zoom, Skype, Google-meet), чати та месенджери (Telegram, WhatsApp, Messenger, Viber) з можливістю письмової комунікації та відеодзвінків.

Узагальнені результати анкетування щодо переваг використання інтернет-технологій та мобільних застосунків у роботі психолога представлено на інфографіці (рис. 1).

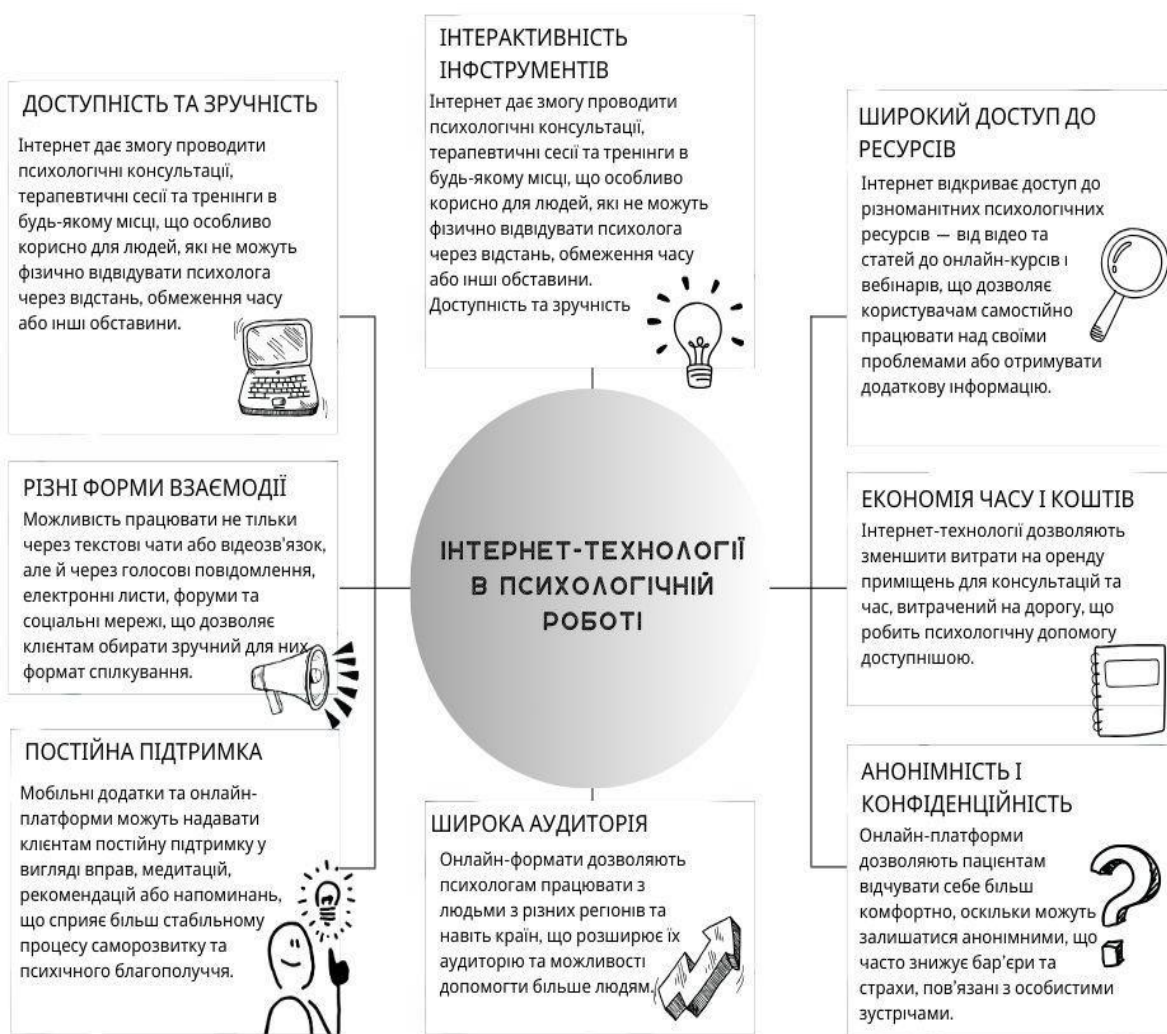


Рис 1. Основні переваги використання інтернет-технологій в психологічній роботі

Висновки. Сучасні інтернет-технології значно змінили підхід до надання психологічної підтримки, забезпечуючи доступність і зручність для широкої аудиторії. Онлайн-консультації, мобільні додатки, чат-боти та інші цифрові інструменти сприяють ефективному наданню психологічної допомоги, роблячи її доступною для людей, що стикаються з фізичними чи соціальними бар'єрами. Інтернет дозволяє подолати географічні, фінансові та часові обмеження, забезпечуючи людям можливість отримати психологічну допомогу в будь-якому місці та у зручний час. Анонімність і конфіденційність онлайн-форматів знижують рівень стресу та страху у клієнтів, що сприяє більш відкритому та ефективному спілкуванню. Важливо, що інтернет-платформи надають можливість використання інтерактивних інструментів для підтримки клієнтів. Онлайн-терапія дозволяє психологам більш точно відслідковувати прогрес, надавати індивідуальні рекомендації та залучати клієнтів до активної участі в процесі терапії через мобільні додатки, відео-консультації чи форуми.

Попри численні переваги, використання інтернет-технологій у психологічній підтримці не позбавлене ризиків. Це включає можливі проблеми з конфіденційністю даних, обмежену ефективність онлайн-формату для серйозних психічних розладів, а також ризики зловживання ресурсами, такими як кібервтручання або недотримання етики в онлайн-просторі.

З розвитком технологій та зростанням попиту на онлайн-послуги психологічна підтримка буде продовжувати адаптуватися до нових форматів, таких як віртуальна реальність, штучний інтелект та автоматизовані програми підтримки. Це відкриває нові можливості для більш ефективної, персоналізованої та доступної психологічної допомоги в майбутньому.

Загалом, роль інтернет-технологій у наданні психологічної підтримки є ключовою для розвитку сучасних підходів у психотерапії та психосоціальній підтримці. Вони дозволяють створювати нові, більш доступні та зручні механізми підтримки, що відповідають потребам сучасного суспільства.

Література.

1. Гречанюк І. С. Інтернет-технології в психологічній допомозі: сучасний стан та перспективи розвитку. Актуальні питання психології та педагогіки: Збірник наукових праць. Київ: Ліра-К. 2017. С. 155–161.
2. Демченко О. В., Шевченко Н. С. Використання інтернет-технологій у психотерапевтичній практиці: проблеми та перспективи. Науковий вісник Ужгородського університету. Психологія. 2018. № 1. С. 65–72.
3. Калініченко Т. С. , Черняк О. В. Інтернет-терапія як новий напрям психологічної допомоги. Актуальні питання психології та соціальної роботи: Збірник наукових праць. Київ: Психологічна служба. 2020. С. 98–106.
4. Козлова Т. В. Роль інтернет-консультування у психологічній допомозі молоді. Психологія і суспільство: Збірник наукових праць. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. 2015. С. 112–118.
5. Рибак М. О., Чернявська, О. П. Онлайн-консультування як інструмент психологічної допомоги в умовах соціальних мереж. Психологічний тренінг: теорія і практика: Збірник наукових праць. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. 2016. С. 102–110.
6. Семенець О. О., Лаврентьєва О. В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у психологічній допомозі: перспективи та бар'єри. Психологія: наука і практика. 2020. №6. С. 85–93.
7. Смірнова Т. О., Новикова Н. А. Мобільні додатки та онлайн-платформи в психологічному консультуванні. Психологія розвитку: Збірник наукових праць. Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова. 2017. С. 119–127.
8. Тищенко І. М. Сучасні технології в психології: інтернет-ресурси та їх використання для корекції психічного здоров'я. Науковий журнал «Психологія». 2021. №3. С. 55–63.
9. Шевченко І. В. Інтернет-ресурси в психологічній допомозі: ефективність та етичні аспекти. Вісник Черкаського університету. Психологічні науки. 2019. №4, С. 42–50.
10. Andersson G., Titov N. Internet-delivered psychological treatments. Annual Review of Clinical Psychology. 2014. №, 10. P. 241–267.

2.6. Психологічні аспекти резильєнтності персоналу агроіндустрії в ситуації невизначеності та ризику

Ісак А.М.

Актуальність. Згідно з дослідженнями компанії Gradus щодо психічного здоров'я українців у березні 2024 р. 77,0 % респондентів відчували стрес або сильну знервованість. Найпоширенішими емоціями, незалежно від місця проживання, були втома та напруженість. Водночас, серед основних бар'єрів для звернення за психологічною допомогою залишаються сумніви щодо серйозності своїх проблем [1]. Вказане безпосередньо стосується персоналу у сфері агропромислового сервісу, де часто не враховуються основні психологічні фактори, що впливають на поведінкові наміри працівників. Важливість сприйняття напруженості, тривоги, ризику та ставлення до нього у контексті стійкості з точки зору розуміння індивідуальної ризикованої поведінки поєднується в комплексному підході надання психологічної допомоги особистості. Проте, соціально-психологічні чинники, які мотивують чи демотивують персонал під час тривалої невизначеності та ризиків, не завжди враховуються.

За останні п'ятнадцять років кількість наукових публікацій щодо стійкості (резильєнтності від англ. Resilienc – пружність, еластичність) зросла з 250 до понад 6000 публікацій. Стійкість стала частиною практики, політики та бізнесу, починаючи від боротьби з бідністю і закінчуючи політичними рамками та бізнес-стратегіями для передбачення та реагування на зміни та кризи, з метою забезпечення не лише виживання, а й розвитку. Стійкість – це психологічна здатність вистояти перед викликами змін та продовжувати розвиватися в умовах, що постійно змінюються. У розумінні стійкості адаптація відноситься до людських дій, які підтримують розвиток на звичному шляху, тоді як трансформація передбачає його перенесення на інші траєкторії або навіть створення нових. Розуміння стійкості засновується на інтегративному підході до вирішення проблеми сталого розвитку. Йдеться посилення здатності підтримувати розвиток всупереч змінам, поступовим і різким, очікуваним і несподіваним, по відношенню

до різноманітних шляхів і порогів і переломних точок між ними. Розуміння стійкості можна розглядати як підмножину науки про стійкість, що зосереджує значну увагу на складних адаптивних і справді взаємопов'язаних соціально-екологічних системах індивідів, спільнот, економік, суспільств, культур, які взаємодіють у просторових і часових масштабах з екосистемами як частиною біосфери. Масштаб, швидкість і зв'язок людських дій у глобалізованому та взаємопов'язаному світі створюють нову складну динаміку, яка розгортається новими, невизначеними та дивовижними способами та по-різному для різних людей і місць. Стійкість системи означає здатність розвиватися та підтримувати добробут людини в різних контекстах перед викликами таких змін, як поступових, так і різких, а також шляхом адаптації або трансформації у відповідь на зміни [2].

Однак, нині в Україні виникла ситуація невизначеності та ризику, що безпосередньо позначається на стійкості у професійній діяльності осіб в агробізнесі. Адже вони мають працювати та забезпечувати продовольчу безпеку держави в умовах військового вторгнення, почасти в ситуаціях ризику для життя. Така діяльність у травматичному полі може знижувати психологічну стійкість та спричинювати ментальні розлади у вигляді депресії, тривоги та психосоціального стресу. Саме тому важливим й актуальним в сучасних умовах є розуміння особистісної резильєнтності, рівня тривоги, типу поведінки в умовах ризику та здатності персоналу аграрного бізнесу сприймати соціальну підтримку в умовах невизначеності та ризику.

Мета. Дослідити психологічні особливості порушення резильєнтності персоналу аграрної сфери в ситуації невизначеності та ризику.

Результати дослідження. Незважаючи на визнання того, що сільське господарство має суттєву економічну невизначеність, небагато останніх досліджень вивчали як економічний стрес може вплинути на сімейну динаміку серед сімейних фермерів. Дослідження Sprung, J. M. намагалася усунути цю прогалину в літературі шляхом вивчення як особистого, так і глобального економічного стресу як предикторів сімейного лиха та конфлікту між роботою та сім'єю серед вибірки сімейних пар. У дослідженні взяли участь 217 пар (434

людини), в яких сільське господарство було основним заняттям чоловіка. Для оцінки економічного стресу, сімейного стресу та конфлікту між роботою та сім'єю використовувався дизайн перехресного опитування. Досліджені як індивідуальні, так і перехресні ефекти. Виявлено, що особистий економічний стрес фермерів був позитивно пов'язаний з особистим і сімейним стресом. Сімейний стрес є посередником зв'язку між особистим економічним стресом і конфліктом між роботою та сім'єю як для фермерів, так і для їхнього подружжя. Крім того, особистий економічний стрес мав більший вплив на сімейні негаразди та конфлікти між роботою та сім'єю, ніж глобальний економічний стрес. Автор зазначає, що результати дослідження дозволять краще розуміння сімейні механізми за допомогою яких економічний стрес може впливати на фермерські пари, а поточні результати можна використати для допомоги в розробці та застосуванні ресурсів психічного здоров'я для фермерських сімей [3].

У дослідженні «Управління психосоціальними ризиками на європейських робочих місцях – дані другого європейського опитування підприємств щодо нових ризиків (ESENER-2)» вказується, що психосоціальні ризики можуть мати серйозні наслідки для здоров'я та благополуччя працівників. Дослідження показали, що вони пов'язані з погіршенням психічного здоров'я, депресією, серцево-судинними захворюваннями та розладами опорно-рухового апарату. Психосоціальні ризики пов'язані зі способом планування, організацією та управлінням роботою, а також із соціальним контекстом роботи. Дані зміни підвищили вразливість працівників до психосоціальних ризиків. Драйверами та бар'єрами на організаційному рівні управління психосоціальним ризиком автори виокремлюють кілька факторів, що відіграють важливу роль. Важливими рушійними факторами при цьому є підтримка керівництва, залучення працівників, прозора комунікація та процедурна справедливість. Найважливішими перешкодами для управління психосоціальними ризиками є брак досвіду або спеціалістів, а також недостатня обізнаність керівництва. Треба зазначити, що контекстуальними детермінантами управління психосоціальним ризиком є висока дистанція з керівництвом та низький рівень уникнення невизначеності [4].

Дослідження «Майбутнє сільського господарства в Європі та його вплив на безпеку та гігієну праці» вказує, що психосоціальні ризики для психічного здоров'я та стрес часто сприймаються персоналом агроіндустрії як одні з найважливіших проблем, з якими стикається галузь. Міжнародні та французькі дані вказують на вищий рівень самогубств серед фермерів, який на 20,0 % перевищує середній національний рівень самогубств в інших професіях, коли мова йде про французьких фермерів-чоловіків. Встановлено, що персонал агроіндустрії піддається численним «стресам»:

1. Зміна клімату: невизначеність і непередбачуваність, сезонність, змінюваність погоди, виникнення екстремальної погоди, втрата врожаю, проблеми планування;
2. Фінансовий тиск: зменшення впливу фермерів у ланцюжку вартості продуктів. Послаблення переговорної сили проти великих роздрібних торговців, зниження цін на сільськогосподарську продукцію та зниження норми прибутку;
3. Зростаючий регуляторний та адміністративний тиск: безпека харчових продуктів, здоров'я та добробут тварин, біотехнології та ГМО, екологічні стандарти;
4. Зростаючі вимоги споживачів і суспільства до виробництва харчових продуктів: зростаючий попит на якість, розвиток систем вивчення якості (щодо органічної їжі, без ГМО, стосовно добробуту тварин і безпеки кормів), скорочення споживання і виробництва м'яса;
5. Дискримінація фермерів і відсутність привабливості сільського господарства: фермери вважаються відповідальними за етичні та екологічні аспекти сільського господарства на тлі умов праці, які вважаються непривабливими для багатьох молодих людей;
6. Нові зміни в охороні здоров'я та виникнення хвороб/шкідників, що з'являються у тварин/рослин: COVID-19 підкреслив вплив хвороб на виробництво сільськогосподарської продукції, а також актуалізувався вплив хвороб та шкідників, пов'язаних з рослинами та тваринами;

7. Фізичні напади та погрози: більш екстремальні захисники навколишнього середовища та захисту тварин, які чинять посилений тиск на фермерів і лісівників через громадський PR-тиск і кампанії ганьби (критика фермерів), коли навіть здійснюються прямі дії чи напади, особливо щодо інтенсивних методів ведення сільського господарства;

8. Злочинність у сільській місцевості: крадіжки (іноді з насильством або загрозою насильства) худоби, сільськогосподарських товарів і техніки, вплив на відчуття незахищеності, витрати на страхування та фінансові втрати від крадіжки [5].

Дослідження Logstein, B., присвячене аналізу занепокоєння щодо економіки ферми, робочого часу та психічних скарг серед норвезьких фермерів, вказує на значні структурні зміни у діяльності персоналу. У вибірці основних власників-операторів та менеджменту персоналу агроіндустрії ($n = 2676$) виявлено високий рівень коефіцієнту занепокоєння щодо навантаження симптомами психічними скаргами. За аналізом зв'язків між характеристиками роботи (економічні проблеми, велике робоче навантаження, додаткова зайнятість) та психічним здоров'ям встановлено, що персоналу агроіндустрії притаманне збільшення симптомів психічних розладів [6]. Greig B. із співавторами у випадковому опитуванні фермерів Нової Зеландії з метою побудови рейтингів їх занепокоєння методом кількісної оцінки зв'язків у рамках регресійні моделі виявили пом'якшення тривоги, занепокоєння та стресу. Автори вказали на вагомість механізмів копінг-подолання, таких як спілкування зі значущими людьми, висловлювання, планування, самокритичність та позитивне мислення. Також важливими є особисті характеристики конкретних фермерів, а саме: поставлені цілі, віра в здатність контролювати результати, освіта та вік. У свою чергу проблемою є небажання фермерів озвучувати труднощі та звертатися за допомогою. У висновку автори зазначають необхідність спрямування зусиль у консультуванні на зміну особистих зниження такої тривоги у довгостроковій перспективі [7]. Petit, P. із співавторами досліджували керівників ферм у Франції в рамках створення адміністративної бази даних охорони здоров'я, доступної для проекту TRACTOR у

загальнонаціональному ретроспективному когортному дослідженні. Дані аналізувалися з січня 2021 року по грудень 2022 року. Вимірюваним результатом був встановлений зв'язок між 26 видами сільськогосподарської діяльності та ризиком виникнення депресії та співвідношення ризиків її виникнення. Дослідники виявили, що сільськогосподарська діяльність піддається ризику депресії серед усієї робочої сили французького сільського господарства. Спостерігалися статеві відмінності, причому здебільшого ризику були вищими для жінок, ніж для чоловіків. Результати досліджень та висновки покладено у впровадження ефективних профілактичних заходів проти депресії із визначенням напрямів виділення додаткових ресурсів для виявлення депресії разом із втручанням [8].

На стурбованість проблемами психічного здоров'я персоналу аграрної сфери та її значущості вказує зростання кількості досліджень останнім часом у всьому світі. Так, у систематичному огляді досліджень Daghigh Yazd, S. із співавторами, які мали на меті заповнити важливу прогалину в розумінні потенційних ключових факторів ризику, що впливають на психічне здоров'я фермерів у всьому світі, дослідили 167 статей про психічне здоров'я фермерів. По результатах було встановлено, що більшість досліджень проводилися у розвинутих країнах, зокрема у Сполучених Штатах, Австралії та Великобританії. Порівняльні дослідження показали результати, що більша частина розладів психологічного здоров'я що зустрічаються у фермерів і робітників є тривога, депресія, стрес [9].

На поширеність психічних розладів і суїцидів серед сільгоспвиробників, як глобальну проблему, вказує дослідження Younker, T. із співавторами, спрямоване на вивчення психічного здоров'я фермерів упродовж 50 років, ефективність та обмеження впливів на нього. У цьому дослідженні було розглянуто широкий спектр чинників втручання у психічне здоров'я, а загалом 92 статті про психічне здоров'я фермерів було включено до остаточного систематичного огляду. Зазначається, що все ще існує потреба в більш потужній і великій базі доказів у сфері втручання щодо психічного здоров'я фермерів, яка має зосереджуватися як на цілісних, багатокомпонентних програмах, так і на цільових підходах [10]. Дослідження Chiswell H. щодо психічного здоров'я фермерської спільноти в

промислово розвинутих країнах вказує на неоднозначність, яка різко контрастує з однозначно тривожною статистикою самогубств фермерів. Автором вказується на нездатність сучасних методів точно оцінити стан психічного здоров'я фермерів. Рекомендується більше досліджувати «шлях» фермерів до самогубства та підкреслює потребу в спеціалізованій та міждисциплінарній програмі дослідження методів, яка забезпечить більш культурно прийнятні та ефективні засоби розуміння психічного здоров'я фермерської спільноти [11].

Цікавим є дослідження Findlater, K. M. Із співавторами, щодо прийняття рішень персоналом агроіндустрії. Автори виявили, що персонал використовує дві важливі неоптимізуючі стратегії, які називаються когнітивними порогами та туманним хеджуванням для прийняття практичних рішень в умовах повсюдної невизначеності. Ці результати можуть інформувати про продовження досліджень таких поведінкових тенденцій у більш вузьких лабораторних дослідженнях і дослідженнях на основі моделювання [12].

У дослідженні Gunn, K. M. із співавторами, метою якого був аналіз стресових факторів, а також перешкод для доступу до традиційних форм підтримки психічного здоров'я для фермерів автори виявили наступне. Зменшення дистресу та підвищення психічного благополуччя було пов'язано зі зменшенням психологічної негнучкості, когнітивного злиття та правдоподібності думок, а також підвищенням рівня подолання через прийняття та уважність. Автори зробили висновок, що ефективне психологічне втручання допоможе фермерам зменшити рівень дистресу та покращити психічне благополуччя, дозволить покращити психологічну гнучкість, здатність зосереджуватися на сьогоденні та приймати те, що поза їхнім контролем, а також зменшувати віру марним думкам [13].

У іншому дослідженні Gunn, K. M. із співавторами оцінювали модифіковані психологічні та поведінкові стратегії подолання, пов'язані з низьким рівнем психологічного дистресу у вибірці фермерів, які повідомили, що нещодавно зазнали стресової події. Було досліджено 309 фермерів віком від 24 до 85 років, серед яких 40,0 % складали жінки. Психологічний дистрес вимірювався за допомогою шкали психологічного дистресу Кесслера, а стратегії подолання

вимірювалися за допомогою ситуативної версії інвентарю COPE. П'ять факторів особистості (екстраверсія, нейротизм, відкритість, сумлінність і приємність) були оцінені за допомогою Quickscales-R. Виявлено, що у багатоваріантній моделі дистрес був підвищений серед осіб, які повідомляли про вищий невротизм і поведінкову незалученість, і нижчий у осіб, які повідомляли про більше використання стратегії прийняття. Ці три змінні пояснюють 44,0 % дисперсії у стражданні. Тому автори зробили висновок, що фермери, які нещодавно зазнали значного стресового фактору, використовували прийняття як стратегію подолання, мали низький рівень невротизму та найменше відчували дистрес. Враховуючи стабільність особистісних факторів психологічна допомога сприяє меншому застосуванню фермерами негативних поведінкових стратегій подолання, що допомагає їм в управлінні майбутніми стресовими факторами [14].

Висновки. Узагальнюючі результати дослідження можна зазначити, що проблема ментального здоров'я та психологічних особливості порушення резильєнтності у персоналу аграрної сфери в ситуації невизначеності та ризику вивчається у наукових дослідженнях. Проте, особистісна резильєнтність, депресивні та тривожні явища, психосоціальний стрес, поведінка в умовах невизначеності й ризику та здатність персоналу аграрного сектору економіки сприймати психологічну підтримку вивчені не достатньо й потребують подальших досліджень, у тому числі й з урахуванням чинників травматичних подій у наслідок війни в Україні.

Література.

1. Під тиском: як сильно і чому стресують офісні працівники в Україні та Європі? Компанія «Gradus» <https://gradus.app/uk/open-reports/under-pressure-survey-reveals-european-office-workers-stress-landscape/>
2. Folke C. Resilience (Republished). Екологія та суспільство. 2016. №21(4) 44 p. <https://doi.org/10.5751/ES-09088-210444>
3. Sprung J. M. Economic Stress, Family Distress, and Work-Family Conflict among Farm Couples. Journal of Agromedicine. 2021. №27(2). P. 154–168. <https://doi.org/10.1080/1059924X.2021.1944417>

4. Управління психосоціальними ризиками на європейських робочих місцях – дані другого європейського опитування підприємств щодо нових ризиків (ESENER-2) OSHwiki. <https://oshwiki.osha.europa.eu/en/themes/management-psycho-social-risks-european-workplaces-evidence-second-european-survey>
5. Майбутнє сільського господарства в Європі та його вплив на безпеку та гігієну праці. OSHwiki. <https://oshwiki.osha.europa.eu/en/themes/future-agriculture-europe-and-its-impact-occupational-safety-and-health-osh>
6. Logstein B. Farm-Related Concerns and Mental Health Status Among Norwegian Farmers. *Journal of Agromedicine*. 2016. №21(4). P. 316–326. <https://doi.org/10.1080/1059924X.2016.1211055>
7. Greig B., Nuthall P., Old K. An Analysis of Farmers' Human Characteristics as Drivers of Their Anxiety. *Journal of Agromedicine*. 2019. №25(1). P. 135–146. <https://doi.org/10.1080/1059924X.2019.1656692>
8. Petit P., Gandon G., Dubuc M., Vuillerme N., Bonneterre V. Agricultural activities and risk of treatment for depressive disorders among the entire French agricultural workforce: the TRACTOR project, a nationwide retrospective cohort study. *The Lancet regional health. Europe*. 2023. №31. <https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2023.100674>
9. Daghigh Yazd S., Wheeler S. A., Zuo A. Key Risk Factors Affecting Farmers' Mental Health: A Systematic Review. *International journal of environmental research and public health*. 2019. №16(23). <https://doi.org/10.3390/ijerph16234849>
10. Younker T., Radunovich H. L. Farmer Mental Health Interventions: A Systematic Review. *International journal of environmental research and public health*. 2021. №19(1). 244 p. <https://doi.org/10.3390/ijerph19010244>
11. Chiswell H. Psychological Morbidity in the Farming Community: A Literature Review. *Journal of agromedicine*. 2023. №28(2). P. 151–176. <https://doi.org/10.1080/1059924X.2022.2089419>
12. Findlater K. M., Satterfield T., Kandlikar M. Farmers' Risk-Based Decision Making Under Pervasive Uncertainty: Cognitive Thresholds and Hazy Hedging. *Risk*

analysis : an official publication of the Society for Risk Analysis. 2019. №39(8). P. 1755–1770. <https://doi.org/10.1111/risa.13290>

13. Gunn K. M., Skaczkowski G., Dollman J., Vincent A. D., Brumby S., Short C. E., Turnbull, D. A Self-Help Online Intervention Is Associated with Reduced Distress and Improved Mental Wellbeing in Australian Farmers: The Evaluation and Key Mechanisms of www.ifarmwell.com.au. Journal of Agromedicine. 2022. №28(3). P. 378–392. <https://doi.org/10.1080/1059924X.2022.2156642>

14. Gunn K. M., Turnbull D. A., Dollman J., Kettler L., Bamford L., Vincent A. D. Why are some drought-affected farmers less distressed than others? The association between stress, psychological distress, acceptance, behavioural disengagement and neuroticism. The Australian journal of rural health. 2021. №29(1). P. 106–116. <https://doi.org/10.1111/ajr.12695>

2.7. Підвищення мотивації до працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів через психологічний супровід в умовах стресогенності

Ларченко І.В.

Актуальність. Сучасний ринок праці висуває підвищені вимоги до конкурентоспроможності випускників професійно-технічних навчальних закладів. Економічна нестабільність, глобальні кризи, такі як пандемія COVID-19 та воєнний стан, створюють хронічно стресове середовище, яке значно ускладнює процес професійного становлення молоді. У таких умовах недостатній рівень мотивації до працевлаштування, емоційна нестабільність, відсутність чітких професійних цілей та низька самооцінка стають вагомими бар'єрами для успішної адаптації випускників до викликів сучасного ринку праці.

Теоретичне підґрунтя дослідження базується на класичних концепціях мотивації, які визначають основні аспекти, що впливають на поведінку індивіда у професійній діяльності. Зокрема, концепція ієрархії потреб А. Маслоу визначає, що для забезпечення стійкої мотивації особистість повинна задовольнити базові фізіологічні потреби, потреби у безпеці, соціальні потреби, потреби у повазі та визнанні, перш ніж перейти до самоактуалізації [2]. Ця концепція підкреслює важливість внутрішніх мотивів, таких як самореалізація, прагнення до творчості та розвиток власного потенціалу, що є ключовими аспектами професійного становлення. Ф. Херцберг у своїй двофакторній теорії мотивації акцентує увагу на розподілі мотиваційних чинників на дві групи: гігієнічні та мотиваційні [10]. Гігієнічні чинники, такі як умови праці, заробітна плата, міжособистісні відносини, не створюють тривалої мотивації, але їх відсутність може призводити до незадоволеності працею. Мотиваційні чинники, такі як досягнення, визнання та можливості розвитку, забезпечують довготривале залучення та задоволеність. У контексті професійно-технічної освіти ця теорія наголошує на необхідності створення сприятливих умов для навчання, водночас формуючи стимули для внутрішньої мотивації.

Теорія очікувань В. Врума розглядає мотивацію як функцію очікувань, що зусилля призведуть до бажаного результату, ймовірності винагороди за цей результат та цінності винагороди для працівника [5]. Цей підхід є особливо важливим для молоді, яка лише починає професійний шлях, адже очікування від обраної професії та їхній зв'язок із реальними можливостями впливають на рівень мотивації та задоволеності працею.

Сучасні підходи до мотивації, зокрема модель самотрансценденції С. Кауфмана, доповнюють класичні концепції, акцентуючи увагу на творчості, духовному розвитку та зв'язку із суспільством. Розширена піраміда потреб С. Кауфмана пропонує інтегрувати ідею зв'язку з чимось більшим, ніж власне «Я», що включає соціальну відповідальність та прагнення до створення позитивного впливу на суспільство [6]. У контексті професійного становлення випускників професійно навчальних закладів ця модель підкреслює важливість формування цінностей, які стимулюють професійний розвиток через соціально орієнтовану діяльність. Значний внесок у теорію мотивації зробили дослідження Д. Мак Клеелланда, який запропонував модель потреб у досягненні, афіліації та владі [9]. У контексті професійного становлення молоді потреба в досягненні є ключовим фактором, що спонукає до самореалізації та підвищення ефективності у професійній діяльності. Окрім цього, модель самоефективності А. Бандури відіграє важливу роль у розумінні процесів професійної адаптації [1]. Самоефективність визначає, наскільки людина впевнена у своїй здатності досягти мети, і прямо впливає на рівень зусиль, які індивід готовий докласти для досягнення цієї мети. Дана концепція є важливою у контексті формування впевненості у випускників професійно навчальних закладів щодо власної здатності адаптуватися до мінливих умов ринку праці [3].

У сучасних умовах стресогенності особливу увагу заслуговують підходи, спрямовані на управління стресом та емоційною регуляцією. Концепція резилієнтності (психологічної стійкості) наголошує на необхідності розвитку навичок подолання стресових ситуацій, що є критично важливими для успішного професійного становлення молоді. Праці Дж. Кобаси та М. Селігмана

підкреслюють, що розвиток оптимізму, здатності до саморегуляції та формування позитивного мислення сприяють підвищенню стійкості до стресу та загальної адаптації до професійного середовища [7].

Незважаючи на існування різноманітних теорій мотивації, всі вони акцентують увагу на важливості комплексного підходу до формування мотивації, який включає взаємодію внутрішніх і зовнішніх чинників. У контексті нашого дослідження та запропонованої програми психологічного супроводу ці концепції слугують науковою основою для формування інноваційного підходу до підвищення мотивації до працевлаштування випускників професійно навчальних закладів. Актуальність даної проблематики зумовлена тим, що сучасна система освіти приділяє недостатню увагу питанням розвитку навичок управління стресом, зміцнення стресостійкості та формування мотивації до професійної діяльності. Значна частина програм професійної підготовки орієнтована переважно на розвиток технічних і практичних умінь, тоді як аспекти, пов'язані з психологічною стійкістю та здатністю адаптуватися до динамічних умов ринку праці, часто залишаються поза увагою. Такий дисбаланс спричиняє розрив між рівнем підготовки випускників та актуальними вимогами роботодавців, що особливо критично в умовах зростаючої стресогенності сучасного середовища. Унікальність дослідження полягає в розробці та впровадженні комплексної програми психологічного супроводу, яка не має аналогів у сучасній науково-практичній діяльності. Запропонована програма поєднує когнітивно-поведінкові техніки, соціально-психологічний тренінг, методи емоційної регуляції та саморегуляції, спрямовані на формування стресостійкості, підвищення мотивації та професійного самовизначення випускників професійно-технічних навчальних закладів.

Значущість роботи зумовлена також врахуванням сучасних викликів, таких як пандемія COVID-19 та воєнний стан, які значно підвищують рівень стресу та створюють додаткові бар'єри для професійного розвитку молоді. У цьому контексті програма пропонує ефективні стратегії управління стресом, розвитку емоційного інтелекту та адаптації до мінливих умов, що дозволяє випускникам професійно-технічних навчальних закладів більш впевнено долати виклики

сучасного світу. Таким чином, дослідження спрямоване на науково обґрунтоване вирішення актуальних проблем, пов'язаних із професійним самовизначенням, емоційною стійкістю та мотивацією молоді до працевлаштування. Запропонована програма є вагомим внеском у сферу освіти, психологічної практики та соціальної політики, забезпечуючи випускників професійно-технічних навчальних закладів необхідними інструментами для ефективної професійної адаптації та розвитку.

Мета дослідження: обґрунтування та оцінка ефективності комплексної програми психологічного супроводу для підвищення мотивації до працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів в умовах стресогенності.

Матеріал та методи дослідження. Дослідження проводилось у 2023 році під час воєнного стану, що дозволило оцінити вплив екстраординарних умов на психоемоційний стан, мотиваційні процеси, професійне самовизначення та адаптацію учасників до зміненого соціального середовища. Досліджено 62 випускники Вознесенського професійного аграрного ліцею №32 (42 жінки та 20 чоловіків), віком 16–17 років. Учасники груп брали участь у комплексній програмі психологічного супроводу для зростання мотивації до працевлаштування, яка включала різноманітні методи та техніки особистісної психокорекції. Дослідження здійснювалось відповідно до принципів етики Американської психологічної асоціації [11], «Кодексу етики» (протокол № 10 від 14.07.2016) [12] та «Положення про академічну доброчесність Академії праці, соціальних відносин і туризму» протокол № 7 від 12.04.2018 [13]. Для оцінки ефективності комплексної програми використовувались двоетапне інтерв'ю та методика «Діагностика психологічної структури особистості» для аналізу змін у мотивації, стресостійкості та професійній готовності випускників професійно-технічних навчальних закладів.

Результати дослідження. Для забезпечення ефективного психологічного супроводу випускників професійно-технічних навчальних закладів була розроблена комплексна програма, яка охоплювала три основні етапи: діагностичний, планування та психокорекційний. Програма спрямована на підвищення мотивації до працевлаштування, розвиток стресостійкості та

формування професійної готовності випускників професійно-технічних навчальних закладів до сучасних викликів ринку праці.

На діагностичному етапі проводилася комплексна оцінка психоемоційного стану випускників, визначалися їхні потреби та виклики. Використовувалися методика «Діагностика психологічної структури особистості», короткі інтерв'ю, бланки оцінювання та вправи спостереження, що дозволило ідентифікувати рівень саморегуляції та здатність до управління стресом. Основними джерелами стресу виявлено невизначеність щодо кар'єри, нестабільність ринку праці та низьку самооцінку. Згідно з результатами методики, 51,6 % випускників професійно-технічних навчальних закладів мали низький рівень мотивації, 37,1 % – середній рівень, а 11,3 % – високий. Крім того, 60,0 % учасників відзначали високий рівень стресу, тоді як 70,0 % демонстрували високу емоційну реактивність у стресових ситуаціях.

На етапі планування розроблено індивідуальні та групові стратегії інтервенцій, орієнтовані на розвиток ключових компетенцій. Програма враховувала сучасні виклики ринку праці, зокрема технологічні зміни, економічну нестабільність і зростаючу конкуренцію. Групові навчальні модулі сприяли розвитку критичного мислення, самоаналізу та адаптації до швидкозмінних умов. За результатами попередньої діагностики, 42,0 % випускників професійно-технічних навчальних закладів потребували розвитку навичок професійного планування, а 35,0 % – посилення внутрішньої мотивації до працевлаштування. Важливою складовою планування був активний зворотний зв'язок із випускниками, що дозволяло коригувати програму відповідно до їхніх потреб.

На психокорекційному етапі впроваджено тренінги, консультації та вправи для зміцнення психологічного благополуччя. Вправа «Стійкість під тиском» сприяла ідентифікації та нейтралізації стресорів, «Емоційний компас» допомагала розвивати емоційний інтелект, а «Дихальна станція» навчала швидко знижувати рівень стресу. Після завершення програми 85,0 % випускників професійно-технічних навчальних закладів повідомили про зростання впевненості у своїх силах, а 80,0 % активно застосовували техніки подолання стресу. Частка учасників із високим рівнем стресостійкості зросла з 50,0 % до 95,0 %.

Оцінка ефективності програми проводилася за допомогою двоетапного інтерв'ю та методики «Діагностика психологічної структури особистості». Результати показали значні позитивні зміни частка випускників професійно-технічних навчальних закладів із чіткими професійними цілями зростає з 40,0 % до 90,0 %, а рівень внутрішньої мотивації до працевлаштування зріс із 35,0 % до 85,0 %. Емоційна реактивність до стресових ситуацій зменшилася з 70,0 % до 30,0 %, а частота відчуття стресу знизилася з 60,0 % до 25,0 %. Кількість випускників, які використовували техніки подолання стресу, зростає з 30,0 % до 80,0 %.

Детальний аналіз за методикою «Діагностика психологічної структури особистості» продемонстрував, що кількість випускників професійно-технічних навчальних закладів із високим рівнем мотивації зростає з 11,3 % до 27,4 %, тоді як частка з низьким рівнем мотивації зменшилася з 51,6 % до 17,7 %. У віковому розрізі було виявлено, що серед випускників віком 16 років високий рівень мотивації зріс на 15,0 %, а серед 17-річних – на 12,5 %. Статевий аналіз показав, що частка жінок із високим рівнем мотивації зростає з 10,0 % до 26,0 %, тоді як серед чоловіків – із 12,0 % до 28,5 %.

Загальний рівень стресостійкості покращився, що підтверджується зростанням кількості випускників професійно-технічних навчальних закладів, які швидко заспокоюються після стресу, із 40,0 % до 75,0 %. Також 90,0 % випускників відзначили зростання продуктивності у стресових умовах, порівняно з 50,0 % на початку дослідження.

Узагальнюючи результати, стверджуємо, що комплексна програма психологічного супроводу підвищила мотивацію до працевлаштування, стресостійкість та професійну готовність випускників професійно-технічних навчальних закладів. Інтегративний підхід, що поєднував когнітивно-поведінкові методи, соціально-психологічні тренінги та індивідуальну роботу, підтвердив свою ефективність і може бути основою для подальших інтервенцій у сфері підтримки молоді на сучасному ринку праці.

Подальший аналіз результатів дослідження дозволяє виділити кілька ключових аспектів, які сприяли ефективності програми. Зокрема, використання

коротких інтерв'ю дозволило отримати детальну інформацію про індивідуальні потреби учасників. Наприклад, 45,0 % респондентів зазначили, що потребують додаткової допомоги у формуванні професійних цілей, а 40,0 % підкреслили важливість розвитку навичок саморегуляції. Ці дані стали основою для індивідуалізації підходу в рамках програми. Важливим аспектом програми стало залучення сучасних цифрових інструментів. Так, 60,0 % учасників активно використовували онлайн-платформи для виконання завдань і проходження навчальних модулів. Це сприяло підвищенню доступності та зручності програми, а також дозволило забезпечити регулярний зворотний зв'язок із учасниками. Наприклад, використання інтерактивних опитувальників і тестів допомогло оперативно оцінювати динаміку змін у рівнях мотивації та стресостійкості. Значну увагу було приділено роботі з емоційним інтелектом. Вправи «Емоційний компас» і «Стійкість під тиском» сприяли підвищенню рівня самоконтролю та емпатії серед учасників. Згідно з результатами опитування, 75,0 % випускників відзначили покращення здатності розуміти та керувати власними емоціями. Це, у свою чергу, позитивно вплинуло на їхню здатність ефективно спілкуватися з роботодавцями.

Оцінка ефективності програми включала також аналіз змін у професійній готовності. Рівень впевненості у власних професійних навичках зріс із 50,0 % до 85,0 %, а частка учасників, які почали активно планувати свою кар'єру, зросла з 35,0 % до 80,0 %. Крім того, 65,0 % респондентів відзначили, що після завершення програми вони стали більш впевненими у своїй здатності адаптуватися до змін. Результати дослідження підтверджують, що інтегративний підхід, використаний у програмі, дозволив забезпечити всебічну підтримку випускників у період переходу від навчання до працевлаштування. Комплексна програма продемонструвала високу ефективність у підвищенні рівнів мотивації, стресостійкості та професійної готовності випускників професійно-технічних навчальних закладів, що робить її актуальною для впровадження у ширший освітній контекст.

Висновки. Розроблена «Комплексна програма психологічного супроводу для зростання мотивації до працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів» довела свою ефективність у підвищенні готовності

випускників до професійної діяльності та адаптації до викликів сучасного ринку праці. Програма сприяла розвитку стресостійкості, формуванню внутрішньої мотивації, вдосконаленню професійних навичок і створенню умов для успішної професійної самореалізації в умовах постійної невизначеності.

Важливим аспектом програми стало впровадження гнучкого підходу до організації навчального процесу, що дозволило адаптувати його до специфічних потреб випускників професійно-технічних навчальних закладів та особливостей навчальних закладів. Значну увагу було приділено забезпеченню рівних можливостей для представників обох статевих груп, що сприяло розвитку рівноправного доступу до професійного зростання.

Ключові елементи програми включали навчання методам управління стресом, розвитку емоційного інтелекту, формуванню професійних цілей і стратегій їх досягнення, а також вдосконаленню командних і міжособистісних навичок. Модульна структура програми дозволила ефективно інтегрувати різні компоненти навчання, забезпечивши комплексний підхід до професійного розвитку. Практичні вправи, майстер-класи та інтерактивні заняття сприяли засвоєнню навичок і підвищенню впевненості у власних силах.

Результати дослідження свідчать про статистично значимий вплив програми на рівень мотивації до працевлаштування, стресостійкості та професійної готовності випускників професійно-технічних навчальних закладів. Зростання частки учасників із високим рівнем мотивації, покращення емоційної регуляції та зменшення частоти відчуття стресу демонструють ефективність програми у підготовці випускників професійно-технічних навчальних закладів до викликів сучасного ринку праці. Кореляційний аналіз підтвердив зв'язок між участю в програмі та позитивними змінами в психологічному стані випускників, що підкреслює доцільність її впровадження на ширшому рівні.

Таким чином, комплексна програма є дієвим інструментом підтримки випускників професійно-технічних навчальних закладів у процесі професійного становлення, забезпечуючи розвиток важливих компетенцій, необхідних для успішної адаптації до умов сучасного ринку праці. Її інтегративний підхід може

бути використаний як основа для розробки подальших інтервенцій з метою підтримки молоді у професійному зростанні та самореалізації.

Література.

1. Бандура А. Теорія соціального научіння. м. Київ: Академвидав, 2018. 390 с.
2. Маслоу А. Мотивація та особистість – Київ: PSYLIB, 2020. 480 с.
3. Особистість у сучасній психології. Психологічна характеристика. [Електронний ресурс.] <http://ru.osvita.ua/vnz/reports/psychology/10026/>.
4. Селігман М. Оптимізм як набута навичка. Київ: Наш Формат. 2020. 368 с.
5. Vroom V. H. Work and Motivation / V. H. Vroom. N. Y.: Wiley. 1964. 453 p.
6. Kaufman S. Transcend: The New Science of Self-Actualization. TarcherPerigee, 2020. 432 p.
7. Kobasa S. C. Commitment and Coping in Stress Resistance among Lawyers // Journal of Personality and Social Psychology. 1982. Vol. 42. №. 4. P. 707–717. DOI: <https://doi.org/10.1037/0022-3514.42.4.707>
8. Locke E. A. The Nature and Causes of Job Satisfaction / E.A. Locke // Handbook of Industrial and and Organisational Psychology. Rand-McNally. 1976. P. 1297 – 1349.
9. McClelland D. C. The Achieving Society. Princeton: Van Nostrand, 1961. – 512 p.
10. Herzberg F. The motivation to work. New York / F. Herzberg, B. Mausner, S. Snyderman // John Wiley and Sons. 1959. № 5. P. 7–18.
11. Ethical principles of psychologists and code of conduct. (2016). American Psychological Association. Effective June 1, 2003 (as amended 2010, 2016). Effective January 1, 2017. Available from: <https://www.apa.org/ethics/code/ethics-code-2017.pdf>
12. «Code of Ethics» (2016). Protocol 10, Available from: <https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/KodeksEtyky.pdf>
13. Regulations on academic integrity (2018). Academy of Labour Social Relations and Tourism, protocol 7. Available from: <https://drive.google.com/file/d/1roDEHIZC9MERTAjCeIP41Bgp249Ree38/view?usp=sharing>

2.8. Чинники психологічного благополуччя ветеранів в організації.

*Мілютіна К.Л.
Лебединська В.В.*

Актуальність. Інтеграція ветеранів в корпоративну структуру має велике значення не лише з соціальної та етичної точок зору, але і для забезпечення ефективної та продуктивної роботи. Проте цей процес може бути супроводжений психологічними труднощами як для самих ветеранів, так і для їхніх колег:

Травми та посттравматичний стресовий розлад (ПТСР): деякі ветерани можуть переживати травматичні події, і адаптація в новому середовищі може загострювати симптоми ПТСР, що потребує спеціального підходу та психологічної підтримки;

Мета. Виявити і проаналізувати психологічні аспекти інтеграції ветеранів у корпоративні структури, визначити фактори, що сприяють успішній адаптації, та розробити рекомендації для підвищення ефективності цього процесу.

Аналіз попередніх досліджень. Західні дослідження підкреслюють важливість інклюзивної організаційної культури, яка враховує унікальні потреби та досвід ветеранів. Наприклад, компанії, які впровадили політики підтримки ветеранів, мають на 25% вищий рівень задоволеності роботою серед цієї групи працівників [1].

Microsoft [1] реалізує програму «Military Affairs», яка включає адаптаційні курси та менторські програми для ветеранів, що бажають працювати в галузі ІТ. За даними внутрішнього звіту компанії, ветерани, які пройшли програму, мали на 30% вищий рівень продуктивності в перший рік роботи, ніж їхні колеги.

Deloitte впровадила ініціативу «Veterans Integration Program», яка включає спеціальні тренінги з керування стресом та розвитку лідерських навичок [2]. Програма показала, що ветерани, які брали участь, мали вищий рівень залученості та задоволеності роботою на 40,0 %.

Менторські програми є одним із найефективніших засобів підтримки ветеранів під час інтеграції. Ветерани, які брали участь у менторських програмах у компаніях General Electric та Ford Motor Company, повідомляли про зниження рівня

стресу на 50,0 % та покращення кар'єрного розвитку на 30,0 %[3]. Програма менторства у Google, яка включає наставників з числа колишніх ветеранів, що успішно інтегрувалися в компанію, допомогла знизити рівень плинності кадрів серед ветеранів на 20,0 % [4]. Cisco впровадила програму «Veteran Career Transition», яка поєднує професійне наставництво з навчанням технічним навичкам. Понад 85,0 % учасників програми залишилися працювати в компанії протягом двох років після закінчення навчання [5].

Підкреслюється важливість програм психологічної підтримки на робочому місці. Виявлено, що компанії, які впроваджують такі програми, спостерігають зниження рівня вигорання серед ветеранів на 30% та підвищення їхньої задоволеності роботою на 20,0 % [6]. Amazon реалізує ініціативу «Warrior Partnership Program», яка включає регулярні сеанси з психологами, тренінги з управління стресом та групи взаємодопомоги. Внаслідок цього програма знизилася рівень звільнень серед ветеранів на 25% та підвищила їхню продуктивність на 15%.

Дослідження в Pfizer показує, що введення програм підтримки психічного здоров'я, таких як «Mindfulness Training for Veterans», допомогло знизити рівень депресії та тривожності серед ветеранів на 35,0 %.

Наприклад, у Сполучених Штатах Америки існують програми підтримки ветеранів на робочому місці, такі як Veterans' Employment and Training Service (VETS) [5]. Ця ініціатива допомагає ветеранам знаходити роботу через навчальні програми і гранти для роботодавців. Ще один важливий проект – Hiring Our Heroes, який організовує ярмарки вакансій і надає роботодавцям ресурси для ефективного найму та інтеграції ветеранів у робоче середовище.

Програма Veterans' Employment and Training Service (VETS) в США є ключовою ініціативою, що підтримує ветеранів і їх сім'ї у пошуку роботи та отриманні професійного навчання. Основна мета цієї програми – забезпечити успішну інтеграцію ветеранів у цивільний ринок праці, підтримати роботодавців у наймі ветеранів і захистити їхні права в сфері працевлаштування.

VETS пропонує різноманітні тренінги, що допомагають ветеранам набувати необхідні навички для успішного працевлаштування. Програми включають як

короткострокові курси, так і довготривалі сертифікаційні та ступеневі курси у співпраці з навчальними закладами та іншими організаціями.

Наприклад, Transition Assistance Program (TAP) є важливою частиною VETS і надає обов'язкові семінари для військовослужбовців, які готуються до демобілізації. Програма включає навчання з написання резюме, стратегій пошуку роботи, технік проходження співбесід і фінансового планування. Ще одна програма – Veterans Educational Assistance Program (VEAP) [9] – сприяє продовженню освіти ветеранів, фінансуючи їх навчання в коледжах, технічних школах та на професійних курсах. Програма GI Bill забезпечує фінансування для освіти ветеранів, покриваючи витрати на навчання, підручники та проживання. Через мережу American Job Centers [8] VETS пропонує доступ до різних тренінгів, які можуть тривати від кількох тижнів до кількох місяців. Ці програми фокусуються на специфічних навичках, таких як комп'ютерна грамотність, управління проектами або спеціальні технічні навички, необхідні в різних індустріях. VETS активно співпрацює з приватним і державним секторами для забезпечення ветеранів робочими місцями. Програма організовує ярмарки вакансій, де ветерани можуть зустрічатися з роботодавцями, зацікавленими в їх наймі. Ці заходи проводяться як на національному, так і на місцевому рівнях і дозволяють ветеранам безпосередньо взаємодіяти з роботодавцями, демонструвати свої навички і дізнаватися більше про вакантні позиції. VETS також співпрацює з рекрутинговими агенціями, що спеціалізуються на пошуку та підборі персоналу для ветеранів, допомагаючи їм адаптувати їхні військові навички до цивільного ринку праці та знаходити роботу, що відповідає їх досвіду і інтересам. Багато компаній створюють спеціальні програми для найму ветеранів, включаючи вакансії, зарезервовані для колишніх військовослужбовців, і VETS допомагає ветеранам отримати доступ до цих можливостей, надаючи їм пріоритет у процесі найму.

Ця програма також гарантує дотримання прав ветеранів на робочому місці, включаючи право на бездискримінаційний розгляд їхніх кандидатур та захист від будь-якої дискримінації. VETS організовує тренінги та семінари для роботодавців,

на яких висвітлюються права ветеранів і обов'язки роботодавців. Це дозволяє роботодавцям краще розуміти свої обов'язки і забезпечувати справедливе ставлення до ветеранів.

Крім того, програма надає ветеранам доступ до юридичних ресурсів для захисту їхніх прав у випадку порушень. Ветерани мають можливість отримувати консультації та, у разі потреби, юридичне представництво для захисту своїх інтересів. Важливою частиною програми є зворотний зв'язок, що включає активну комунікацію з ветеранською спільнотою для моніторингу і оцінки ефективності. Це дозволяє адаптуватися до нових потреб і проблем. Ветерани можуть звертатися до служби з будь-якими питаннями, що стосуються дискримінації або порушень їх прав. Все це створює комплексну систему, яка не лише гарантує права ветеранів, але й активно працює на попередження їх порушень у майбутньому.

Програма VETS демонструє значні успіхи в підтримці ветеранів у працевлаштуванні, і має безліч прикладів ветеранів, які успішно перейшли на цивільні професії, зокрема в сферах ІТ, медицини та управління. Ветерани, які скористались цією програмою, часто відзначають значне покращення якості життя, зростання кар'єрних можливостей та підтримку, яку вони отримали від VETS у процесі навчання і пошуку роботи.

Проведений Лебедєвою С. Ю., Овсянніковою Я.О. та Похілько Д.С. [10] аналіз закордонного досвіду інтеграції ветеранів у цивільне життя звертає увагу на важливість не лише працевлаштування, а й психологічної підтримки на робочому місці. Інтеграція подібних програм в Україні може значно поліпшити підтримку ветеранів, що сприятиме їх успішній соціальній адаптації і професійній інтеграції.

Організація та хід дослідження В опитуванні взяли участь працівники промислового підприємства критичної інфраструктури – 80 осіб, з них 40 – ветерани (як АТО так і звільнені у період повномасштабного вторгнення). На підприємстві реалізується програма інтеграції ветеранів, яка включає в себе індивідуальну психологічну підтримку та наставництво на виробництві. Для дослідження психічного здоров'я та благополуччя персоналу організації використано методики: 1. Опитувальник «самооцінка станів тривожності,

фрустрації, агресивності та ригідності» (адаптований варіант методики Г. Айзенка); 2. Тест «Стійкість до стресу»; 3. Опитувальник для вимірювання локусу контролю здоров'я (K.A. Wallston, B.S. Wallston, & R. DeVellis) (адаптація Л.М. Карамушки, К.В. Терещенко, О.В. Креденцер); 4. Методика «Шкала позитивного ментального здоров'я» (Positive Mental Health Scale (PMH-Scale)) (J. Lukat, J. Margraf, R. Lutz, W. M. van der Veld, & E. S. Becker) (адаптація Л.М. Карамушки, О.В. Креденцер, К.В. Терещенко); 5. Опитувальник «Стабільність психічного здоров'я – коротка форма» («The Mental Health Continuum – Short Form») (К. Кіз) (адаптація Е.Л. Носенко, А.Г. Четверик-Бурчак); 6. Методика «Модифікована шкала суб'єктивного благополуччя Бібісі» (The Modified BBC Subjective Well-Being Scale (BBC-SWB)) (P. Pontin, M. Schwannauer, S. Tai, & M. Kinderman) (адаптація Л.М. Карамушки, К.В. Терещенко, О.В. Креденцер); 7. Методика «Шкала негативного впливу роботи» (Д. Ватсон) (адаптація С. Д. Максименка, О.М. Кокуна, Є.В. Тополова); 8. Методика «Індекс організаційної напруженості» (Р.Л. Кан та ін.) (модифікація Л.М. Карамушки, К.В. Терещенко); 9. Методика «Як розвивається ваша організація?» (В. Зігерт, Л. Ланг) (модифікація Л.М. Карамушки); 10. Методика «Оцінка привабливості організаційної культури».

Результати дослідження. За результатами дослідження було проведено статистичний аналіз отриманих даних за допомогою програми Jamovi. Було використано порівняння середніх за допомогою критерію Стюдента, вісоткового аналізу та кореляційного аналізу. Важливим було виявлення наявності (або відсутності) розбіжностей психологічних характеристик ветеранів та інших працівників. Порівняння середніх показників проводилося за всіма використаними методиками. За результатами критерію Стюдента було виявлено достовірні розбіжності на рівні $p \leq 0,005$ лише за шкалою фрустрації, при чому рівень фрустрації у ветеранів був нижчим, ніж в працівників, які не мали бойового досвіду. Це можна пояснити успішністю програми адаптації, впровадженій на даному підприємстві, та посттравматичним зростанням ветеранів.

Таблиця 1

**Порівняльний аналіз особистісних характеристик та
емоційних станів працівників**

		Досліджувана група	Контрольна група	Відхилення
1	Самооцінка станів тривожності, фрустрації, агресивності та ригідності. Шкала тривожності.	5,325	6,175	13,77%
2	Самооцінка станів тривожності, фрустрації, агресивності та ригідності. Шкала фрустрації.	4,625	6,200	25,40%
3	Самооцінка станів тривожності, фрустрації, агресивності та ригідності. Шкала агресивності.	7,525	7,675	1,95%
4	Самооцінка станів тривожності, фрустрації, агресивності та ригідності. Шкала ригідності.	6,600	7,300	9,59%
5	Стійкість до стресу	32,400	34,375	5,75%
6	вимірювання локусу контролю здоров'я. Шкала «внутрішнього локусу контролю»	19,150	19,025	-0,66%
7	вимірювання локусу контролю здоров'я. Шкала «контролю «могутніми іншими».	18,550	17,425	-6,46%
8	вимірювання локусу контролю здоров'я. Шкала «контролю випадку».	17,000	15,875	-7,09%
9	Шкала позитивного ментального здоров'я	28,475	27,750	-2,61%
10	Стабільність психічного здоров'я – коротка форма.	50,075	44,225	-13,23%
11	Модифікована шкала суб'єктивного благополуччя БіБіСі. Субшкала «психологічне благополуччя».	41,125	39,700	-3,59%
12	Модифікована шкала суб'єктивного благополуччя БіБіСі. Субшкала «фізичне здоров'я та благополуччя».	21,800	20,900	-4,31%

Наступним питанням стало виявлення ставлення як ветеранів, так і представників контрольної групи до роботи та корпоративної культури організації.

Шкала негативного впливу роботи. Показники: Досліджувана група – 17,450; Контрольна група – 19,175; Рівень значущості (p) – 0,1832. Показник негативного впливу роботи трохи нижчий у досліджуваній групі (17,450 проти 19,175), але ця різниця не є статистично значущою ($p > 0,05$). Це може свідчити про те, що ветерани менш схильні відчувати негативний вплив роботи на свій емоційний стан. Напруженість щодо робочого навантаження та рівня інформованості персоналу. Показники: Досліджувана група – 1,935; Контрольна група – 2,053; Рівень значущості (p) – 0,1815. Індекс організаційної напруженості щодо робочого навантаження та рівня інформованості персоналу трохи нижчий у досліджуваній групі (1,935 проти 2,053), але різниця не є статистично значущою ($p > 0,05$). Це

може свідчити про те, що ветерани мають схожий рівень сприйняття робочого навантаження та інформованості, як і працівники контрольної групи. Напруженість персоналу у взаємодії по «вертикалі» та по «горизонталі». Показники: Досліджувана група – 1,958; Контрольна група – 2,153; Рівень значущості (p) – 0,1169. Напруженість у взаємодії по «вертикалі» та по «горизонталі» дещо нижча у досліджуваній групі (1,958 проти 2,153), але різниця не є статистично значущою ($p > 0,05$). Це може вказувати на схожі рівні взаємодії і комунікації з керівництвом та колегами в обох групах. Напруженість щодо організаційно-психологічних умов роботи в організації. Показники: Досліджувана група – 1,750; Контрольна група – 1,928; Рівень значущості (p) – 0,1708. Індекс організаційної напруженості щодо організаційно-психологічних умов роботи трохи нижчий у досліджуваній групі (1,750 проти 1,928), але різниця не є статистично значущою ($p > 0,05$). Це може свідчити про те, що ветерани оцінюють організаційно-психологічні умови роботи на подібному рівні, як і працівники контрольної групи. Напруженість щодо змін у порядку просування по службі та участі персоналу в управлінні організацією. Показники: Досліджувана група – 2,205; Контрольна група – 2,065; Рівень значущості (p) – 0,5856. Показник напруженості щодо змін у порядку просування по службі та участі в управлінні організацією трохи вищий у досліджуваній групі (2,205 проти 2,065), але ця різниця не є статистично значущою ($p > 0,05$). Це може означати, що обидві групи мають однаковий рівень задоволеності умовами просування по службі та управлінськими змінами. Напруженість щодо соціально-економічних та побутових умов. Показники: Досліджувана група – 2,975; Контрольна група – 2,820; Рівень значущості (p) – 0,5816. Показник напруженості щодо соціально-економічних та побутових умов трохи вищий у досліджуваній групі (2,975 проти 2,820), але різниця не є статистично значущою ($p > 0,05$). Це свідчить про схожі рівні напруженості, що пов'язані з соціально-економічними умовами в обох групах.

Загальний індекс організаційної напруженості. Показники: Досліджувана група – 2,025; Контрольна група – 2,123; Рівень значущості (p) – 0,2437. Загальний індекс організаційної напруженості трохи нижчий у досліджуваній групі (2,025

проти 2,123), але ця різниця не є статистично значущою ($p > 0,05$). Це може свідчити про схожі рівні сприйняття організаційної напруженості серед ветеранів і звичайних працівників. Як загальний рівень організаційної напруженості, так і його субшкали перебувають на низькому та середньому рівні в обох групах. Це свідчить про сприятливий організаційний клімат, який і впливає позитивно на процес інтеграції ветеранів.

«Організаційна зрілість» (зрілість організаційного розвитку). Показники: Досліджувана група – 13,850; Контрольна група – 14,925; Рівень значущості (p) – 0,3043. Показник організаційної зрілості трохи нижчий у досліджуваній групі (13,850 проти 14,925), але різниця не є статистично значущою ($p > 0,05$). Це свідчить про те, що обидві групи мають схожі погляди на зрілість розвитку своєї організації і вважають її достатньо організаційно зрілою.

«Проблемність організаційного розвитку». Показники: Досліджувана група – 7,150; Контрольна група – 6,100; Рівень значущості (p) – 0,3612. Показник проблемності організаційного розвитку трохи вищий у досліджуваній групі (7,150 проти 6,100), але різниця не є статистично значущою ($p > 0,05$). Це може свідчити про подібне сприйняття проблем розвитку організації в обох групах, які вважають організаційний розвиток проблемним на рівні нижче середнього. В результаті даного етапу дослідження було виявлено, що в організації достатньо сприятливий організаційний клімат, відсутні суттєві управлінські та організаційні проблеми, що позитивно впливає на стосунки працівників та інтеграцію ветеранів.

Другим питанням дослідження стало виявлення зв'язків між психологічним благополуччям ветеранів та їхніми особистісними характеристиками. Результати наведено у табл. 2. Виявлено, що психологічне благополуччя ветеранів тісно пов'язано з наступними параметрами: суб'єктивне благополуччя, стресостійкість, ментальне здоров'я, стосунки з оточенням. Фізичне здоров'я також має достовірний вплив на характеристики благополуччя та ментального здоров'я. Завдяки результатам проведеного дослідження на підприємстві було впроваджено роботу спортивного залу та спортивних секцій, а також психологічну групову тренінгову програму по розвитку комунікативних навичок та самоконтролю у спілкуванні.

**Результати кореляційного аналізу чинників
психологічного благополуччя ветеранів на виробництві**

Показники	Суб'єктивне благополуччя	Стресостійкість	Ментальне здоров'я	Стабільність	Психологічне благополуччя
Стресостійкість	0.603***	—			
Ментальне здоров'я	0.468**	0.687***	—		
Стабільність	0.488**	0.679***	0.605***	—	
Психологічне благополуччя	0.585***	0.603***	0.602***	0.809***	—
Фізичне здоров'я	0.437**	0.434**	0.491**	0.692***	0.675***
Стосунки	0.545***	0.666***	0.632***	0.970***	0.902***
Суб'єктивне благополуччя	0.518***	0.591***	0.518***	0.678***	0.549***
Розчарування	0.419**	0.282	0.451**	0.458**	0.381*

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

Висновки. Виявлено, що психологічне благополуччя ветеранів тісно пов'язано з наступними параметрами: суб'єктивне благополуччя, стресостійкість, ментальне здоров'я, стосунки з оточенням. Сприятливий організаційний клімат також позитивно впливає на інтеграцію ветеранів до корпоративної культури. Фізичне здоров'я також має достовірний вплив на характеристики благополуччя та ментального здоров'я. Впровадження регулярних фізичних активностей та забезпечення доступу до медичних послуг також є ключовими елементами успішної інтеграції. Крім того, варто звернути увагу на розвиток соціальних зв'язків серед ветеранів та надання психологічної підтримки, що може значно покращити їхнє загальне благополуччя. Компаніям слід активно працювати над створенням дружнього та підтримуючого середовища, що допоможе ветеранам успішно адаптуватися до нового професійного життя. Успішна інтеграція ветеранів у структуру компанії не лише сприяє їхньому особистому благополуччю, але й покращує загальну ефективність компанії, оскільки задоволені працівники зазвичай демонструють вищу продуктивність та лояльність.

Література.

1. Employment Situation of Veterans – 2022 // Bureau of Labor Statistics U.S. Department of Labor – 2023. <https://www.bls.gov/news.release/pdf/vet.pdf>
2. Veterans’ Preference Act of 1944–still relevant today // The Postal Record. – 2018. <https://www.nalc.org/member-benefits/body/page-19-veterans.pdf>
3. Veterans Employment Opportunity Act of 1998 // United States Office of Personnel Management website. <https://www.usajobs.gov/help/working-in-government/unique-hiring86paths/veterans/veoa/>
4. Veterans’ Employment and Training Service // U.S. department of labor. <https://www.dol.gov/agencies/vets>.
5. Transition Assistance Program // Veterans’ Employment and Training Service. <https://www.dol.gov/agencies/vets/programs/tap>.
6. Local Veterans’ Employment Representative // The Employment Development Department. <https://www.calcareers.ca.gov/CalHrPublic/Jobs/JobPostingPrint.aspx?jcid=130047>
7. Troops to Teachers // USAMilitaryBenefits. <https://www.usamilitarybenefits.com/troops-to-teachers-california.html>.
8. Disabled Veterans’ Outreach Program // NY Department of Labor. <https://dol.ny.gov/services-veterans>
9. Disabled Veterans Affirmative action Program DVAAP //Veteran Employment Services Office. https://www.vaforvets.va.gov/docs/DVAAP_FactSheet.pdf
10. Лебедєва С. Ю., Овсяннікова Я.О., Похілько Д.С. Психологічна допомога та реабілітація учасників збройних конфліктів та фахівців ризиконебезпечних професій: світовий досвід. Габітус. 2023. Вип. 45. 139–145 www.doi.org/10.32782/2663-5208.2023.45.23

2.9. Резильєнтність менеджерів у контексті продажів

Мілютіна К. Л.

Панасюк В. В.

Актуальність. Сфера продажів є однією з найбільш динамічних та стресових галузей, де успіх значною мірою залежить від психологічної стійкості працівників. Менеджери з продажу щоденно стикаються з відмовами клієнтів, високими планами продажів, змінами ринкових умов і конкуренцією. Все це вимагає не лише професійної компетентності, але й високого рівня адаптивності та емоційної стійкості. Зокрема, під час війни і економічної кризи, компанії стикнулися з необхідністю швидко перебудовувати свої стратегії продажів, що стало серйозним випробуванням для працівників. При таких умовах розвиток резильєнтності стає не просто бажаним, а критично важливим елементом для досягнення успіху.

Мета. Дослідити і проаналізувати вплив резильєнтності на ефективність роботи менеджерів з продажу.

Результати дослідження. Останніми роками в світі спостерігається актуалізація дослідження тематики резильєнтності, що напряду пов'язано з потребою в розвитку резильєнтності у фахівців різних галузей, зокрема менеджерів з продажу. В українському сьогоденні, тема успішного подолання негативних наслідків травматичного досвіду є надважливою також через тривале проведення бойових дій, внутрішнє переміщення населення, війну і наслідки пов'язані з нею.

Серед вітчизняних науковців проблематикою дослідження резильєнтності займаються: Грішин Е., Кокун О., Мельничук Т., Лазос Г. та інші.

В україномовній літературі термін «resilience» перекладають як «стресостійкість», «життєстійкість», «життєздатність», «стійкість до травми», «психологічна пружність», «психологічна стійкість», що призводить до певної термінологічної плутанини. Відмінність у змісті понять резилієнсу («resilience») та резильєнтності («resiliency»), полягає в тому, що резилієнс є процесом, а резильєнтність – властивістю (або здатністю) особистості [7].

Варто сказати, що термін «резильєнтність» до нас прийшов з фізики, де він позначає властивість матерії набувати початкової форми після деформації, отриманої в результаті тиску, а далі цей термін вже перейшов в психологічну площину. Нам імponує визначення Ф. Лозеля: резильєнтність – це здатність людини або соціальної системи вибудовувати нормальне, повноцінне життя в складних умовах. Ця концепція передбачає не тільки стабілізацію і відновлення після травмивних подій, але й «вихід на новий рівень» і отримання позитивного результату, який досягається попри високий ризик (наприклад, коли людині доводиться долати багато факторів, що викликають стрес та напругу), і збереження основних властивостей особистості під час небезпеки, і повне відновлення після травмування та досягнення успіху згодом.

Також варто наголосити, що науковці відокремлюють дві основні складові резильєнтності: фізичну, як показник стресостійкості й толерантності та психологічну, що містить у собі розвиток та підтримку соціальних контактів, використання соціальної підтримки, віднайдення смислів у важких подіях або ситуаціях, підвищення освітнього рівня та опанування різних психотехнологій, що допомагають розвитку та подоланню негативних наслідків після стресу, за D. Hellerstein.

Загалом, усі визначення резильєнтності вказують на здатність особистості відновлюватися після несприятливих подій у житті. При цьому багато дослідників визначають резильєнтність як певну характеристику особистості, яка притаманна тій або іншій людині (наприклад, J. R. T. Davidson, V. M. Payne, K. M. Connor) [3,4]. Інші дослідники розглядають резильєнтність як динамічний процес, якій змінюється («змінний процес») (D. Cicchetti, N. Garmezy, S. S. Luthar, A. Masten) [5,6]. Як зазначають науковці, що є прихильниками саме цього підходу до визначення резильєнтності, динамічний процес складається з: 1) контакту з несприятливими подіями чи факторами ризику; 2) активації захисних факторів і їхньою взаємодією з факторами уразливості; 3) в результаті створення резильєнтності або ні (вихід до патологічного реагування психіки). Як зазначає K. Bolton, для того, щоб людина вважалася резильєнтною, вона має після контакту з несприятливими подіями

демонструвати позитивну адаптацію в певних сферах своєї життєдіяльності, тобто мати подальший здоровий психологічний розвиток [9].

Психологічний словник APA (American Psychological Association) визначає термін «resilience», або стійкість, як процес і результат успішної адаптації до складного або складного життєвого досвіду, особливо через розумову, емоційну та поведінкову гнучкість і пристосування до зовнішніх і внутрішніх вимог [1].

Найбільш розгорнутим і притаманним для досліджуваної тематики, ми вважаємо наступне визначення. Резильєнтність – це психологічний ресурс особистості з подолання стресу та адаптації після травмуючої ситуації до нових обставин життя, що забезпечує її повноцінне функціонування та обумовлений регулятивними (здатність до саморегуляції, життєстійкості, самоконтроль, мотивація успіху, активні копінги), когнітивними (оптимістичний атрибутивний стиль, когнітивна гнучкість, осмисленість життя, його націленість на досягнення певної мети, розвинутий духовний інтелект), емоційними (перевага позитивних емоцій, доброго настрою, здатність регулювати емоції) та соціально-поведінковими (ефективний холдинг у дитинстві, добре виховання, добрі стосунки із дорослими у дитинстві, наявність партнерів та друзів, наявність соціальної підтримки та спроможність звертатись за підтримкою до інших) якостями та здатностями [8].

Повертаючись до тематики продажів, зокрема до дослідження впливу резильєнтності на ефективність роботи менеджерів з продажу, можемо зазначити, що резильєнтність у контексті продажів означає здатність продавців адаптуватися до змін, долати труднощі та стійко реагувати на невдачі чи несприятливі умови ринку.

Сучасні ринки характеризуються високим рівнем конкуренції, що вимагає від менеджерів з продажу значної стійкості та гнучкості. Згідно з опитуванням, близько 40% працівників продажів відчувають хронічний стрес, а 30% з них знижують продуктивність через емоційне вигорання. Наприклад, у США втрата продуктивності через вигорання щорічно коштує бізнесу понад 190 мільярдів доларів. У кризових ситуаціях, пов'язаних з пандемією, подальшим зниженням

рівня економіки і ескалацією конфліктів у світі багато організацій зазнали значного скорочення обсягів продажу. Проте компанії, які інвестували у розвиток резильєнтності своїх менеджерів, змогли адаптуватися до нових умов і навіть розширити клієнтську базу. Наприклад, використання інструментів підтримки працівників допомогло знизити плинність кадрів на 25% в одній з провідних міжнародних компаній з продажу техніки. Інший приклад – компанія у сфері фінансових послуг, яка впровадила тренінги з управління стресом, що дозволило збільшити рівень виконання продажів на 15% у перший квартал після початку програми.

Згідно з дослідженнями Sales Management Association, менеджери з продажу з високим рівнем резильєнтності краще пристосовуються до змін в ринкових умовах та досягають більшого комерційного успіху. А резильєнтні менеджери з продажу показують більшу стійкість до стресу і здатність до відновлення після невдач.

Так менеджер з продажу, який після втрати ключового клієнта не здається, а розвиває нові стратегії управління продажами і успішно здійснює нові угоди. Інший спеціаліст, який стикається з відмовами, не розчаровується, а використовує ситуацію відмови для вдосконалення власних професійних навичок.

Таким чином спираючись на сучасні теорії резильєнтності, аналізуючи концепт і розуміючи тенденції світового ринку, можна розглянути складові, що допоможуть менеджерам з продажу розвинути резильєнтність, стати більш стійкими і успішними спеціалістами, а також підвищити ефективність роботи:

- психологічна стійкість; здатність менеджерів з продажу залишатися вмотивованими і продуктивними навіть після відмов або складних ситуацій;
- гнучкість у стратегіях; швидка адаптація методів продажу до нових умов чи змін на ринку;
- інноваційність; пошук нових підходів до роботи з клієнтами та підтримки стосунків в умовах невизначеності;

- управління стресом; важливо навчитися справлятися з тиском та стресовими ситуаціями, які виникають у процесі, це гарантує збереження, прийняття обдуманих рішень і підтримку високого рівня продуктивності;
- розвиток навичок комунікації; здатність ефективно спілкуватися з клієнтами, навіть у складних ситуаціях, будувати довірчі стосунки та знаходити рішення для незадоволених клієнтів;
- навчання та самовдосконалення; постійне вдосконалення професійних навичок, знань про ринок та продаж, готовність до будь-яких змін, які можуть виникнути;
- підтримка команди; в умовах складних ситуацій важливо працювати в команді, обмінюватися досвідом і взаємно підтримувати один одного, це створює атмосферу, де кожен член команди може подолати труднощі, знаючи, що він не самотній у своїх зусиллях;
- здатність до відновлення після невдач; важливо не зупинятися на невдачах чи відмовах; резильєнтні продавці здатні швидко відновлюватися, аналізувати свої помилки та використовувати їх для вдосконалення своїх стратегій; невдача сприймається не як кінець, а як можливість для навчання та покращення;
- фокус на довгострокових цілях; стійкість тримати фокус на довгих цілях навіть у моменти короткострокових труднощів, це дозволяє продавцям не відволікатися на тимчасові проблеми, а зберігати стратегічний курс;
- позитивне мислення; особливо важливо збереження оптимізму навіть у складних ситуаціях; позитивний підхід дозволяє побачити можливості там, де інші бачать лише проблеми, це не лише підвищує ефективність продажів, але й полегшує взаємодію з клієнтами;
- розвиток емоційного інтелекту; здатність розуміти і управляти своїми емоціями, а також емоціями клієнтів, є важливою складовою стійкістю; емоційно розумні продавці можуть краще справлятися з труднощами, зберігаючи спокійний і позитивний настрій, що в свою чергу покращує взаємодію з клієнтами;
- підтримка здорового балансу між роботою та життям; резильєнтність також включає в себе здатність підтримувати здоровий баланс між професійними

зобов'язаннями та особистим життям; перевтома може негативно вплинути на ефективність продажів, важливо залишати час для відпочинку, щоб зберегти високу продуктивність і мотивацію в довгостроковій перспективі;

- пошук можливостей у кризових ситуаціях; резильєнтні менеджери з продажу не лише адаптуються до змін, а й вміють знаходити нові можливості навіть у кризових ситуаціях;

- ініціативність і проактивність; здатність продавця не чекати, а діяти, брати ініціативу в свої руки, завжди шукати нові можливості для розвитку, не чекаючи ідеальних умов; це включає в себе постійну роботу над собою, вміння запитувати клієнтів про їхні потреби, прогнозувати майбутні зміни та створювати нові стратегії ринку;

- адаптивність до змін; здатність менеджерів швидко адаптуватися до змін на ринку, у технологіях чи в самій організації; ринок постійно змінюється, і продавці, які здатні швидко освоювати нові інструменти, методи та підходи, залишаються конкурентоспроможними;

- самоконтроль та дисципліна; резильєнтність забезпечує здатність до самоконтролю, що дозволяє продавцям залишатися сфокусованими і організованими; дисципліновані продавці можуть підтримувати високий рівень продуктивності, навіть коли працюють в умовах стресу або невизначеності, тому що вони здатні планувати свої дії і виконувати їх, незважаючи на труднощі;

- оптимізація процесів; продавці, які володіють резильєнтними навичками, постійно шукають способи оптимізувати свої робочі процеси; це може включати впровадження нових технологій для автоматизації рутинних завдань, покращення взаємодії з клієнтами через CRM-системи чи інші інструменти; оптимізація дозволяє знизити стрес і підвищити ефективність роботи;

- стратегічний підхід до управління часом; вміння ефективно керувати своїм часом, навіть в умовах невизначеності; розстановка пріоритетів дозволяє зберегти високий рівень продуктивності та уникати перенавантаження;

- збереження клієнтської лояльності; продавці не шукають тільки нових клієнтів, але й працюють над тим, щоб зберегти вже існуючих, що є важливою складовою для сталого розвитку бізнесу;

- розвиток творчого підходу до вирішення проблеми; здатність розглядати проблеми з різними перспективами, знаходити нестандартні шляхи їх вирішення; нові підходи до продажів, незвичайні канали комунікації або інноваційні пропозиції для клієнтів, дозволяють підвищити ефективність роботи менеджерів з продажу, навіть у важких умовах;

Як ми бачимо, складові що допоможуть менеджерам з продажу розвинути резильєнтність і досягти успіху, класифікуються не тільки як м'які і жорсткі навички, а також як група навичок: властиві особисті та засновані на знаннях [2].

Висновки. Резильєнтність є критично важливим фактором у сфері продажів, який позитивно впливає на роботу менеджерів. Резильєнтність успішних менеджерів з продажу визначається здатністю пристосовуватися до стресових ситуацій, витримувати труднощі і досягати цілей незважаючи на перешкоди. Загалом, резильєнтність у продажах дозволяє не тільки переживати негативні моменти, а й використовувати їх як можливість для росту та розвитку. Вона зміцнює здатність досягати цілей навіть в умовах невизначеності та змін. Організації, які активно працюють над розвитком резильєнтності, отримують конкурентні переваги на ринку та створюють стабільне середовище для своїх працівників. Подальші дослідження у цій сфері є актуальними в найближчій перспективі, вони дозволять більш ефективно інтегрувати концепцію резильєнтності в сферу продажів і управління персоналом організацій.

Література.

1. Психологічний словник APA (American Psychological Association)
<https://dictionary.apa.org/resilience>
2. The 5 Types Of Skills (Transferrable, Personal, Knowledge)
<https://helpfulprofessor.com/types-of-skills>
3. Connor K.M., Davidson J. R. Development of a new resilience scale: the Connor-Davidson Resilience Scale. // Depression and Anxiety. 2003. № 18. 76 p.

4. Davidson J., Payne V., Connor K. Trauma, resilience, and saliostasis: Effects of treatment in post-traumatic stress disorder // International Clinical Psychopharmacology. 2005. №20. pp. 43–48.
5. Germezy N., Masten A. The study of stress and competence in children: a building block for developmental psychopathology. // Child development. 1984. №55. P. 97–111.
6. Luthar S.S. The construct of resilience: A critical evaluation and guidelines for future work / S.S. Luthar, D. Cicchetti, B. Becker // Child development. 2000. №71. P. 543–562.
7. Кокур О. М., Мельничук Т. І. Резилієнс-довідник: практичний посіб. Київ: Ін-т психології імені Г. С. Костюка НАПН України. 2023. 25 с.
8. Едуард О. Грішин Резильєнтність особистості: сутність феномену, психодіагностика та засоби розвитку. 2021. <https://doi.org/10.34142/23129387.2021.64.04>
9. Лазос Г. П. Резильєнтність: концептуалізація понять, огляд сучасних досліджень / Г. П. Лазос // Актуальні проблеми психології. Том 3.: Консультативна психологія і психотерапія. Вип. 14. Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; Вінниця, ФОП Рогальська І. О. 2018. Вип. 14. С. 26–64.

2.10. Психологічні стреси у діяльності працівників агробізнесу в довготривалих кризових умовах

Міщенко Д.А.

Актуальність. Військові дії проти України та пов'язані з ними стреси є травмуючими чинниками, що впливають на емоційний стан населення. Саме емоції сигналізують про благополучний або неблагополучний розвиток подій, про визначеність становища особистості в системі його предметних і міжособистісних взаємин, забезпечують регулювання та корекцію поведінки людини в умовах спілкування й професійної діяльності [1]. Соціально-економічна криза, яка виникла в Україні внаслідок військового вторгнення, є детермінантом психологічного впливу на усі версти населення, у тому числі на представників сфери агробізнесу. Поряд з цим, відомі й інші чисельні аграрні стресори, усунення яких є важливим аспектом управління стресом і втручання клінічних фахівців-психологів для захисту психічного здоров'я працівників аграрного сектору від стресових факторів. Фермери та керівників агробізнесу здебільшого поділяють думки психологів та погоджуються з необхідністю об'єднання професіоналів із різноманітним досвідом для надання найбільш відповідної допомоги працівникам агробізнесу для покращення їх психічного здоров'я. Забезпечення емоційної стійкості у довготривалій кризі та зменшення психологічного навантаження на персонал є умовою його якісної професійної діяльності. Тому для успіху психологічної та професійної адаптації персоналу агробізнесу необхідними стають дослідження особливостей праці у кризових умовах з аналізом впливу кризи на міжособистісні стосунки та емоційне виснаження. З огляду на це, екскурс у питання психологічних детермінант професійної діяльності працівників агробізнесу в довготривалих кризових умовах здійснено з різних дослідних аспектів, а саме стосовно вигорання, ставлення, психоемоційного стресу, депресії. Можна зазначити, що сьогодні актуальним питанням психології є проблема дослідження психологічних стресів працівників агробізнесу в довготривалих кризових умовах. Спеціальних праць,

присвячених вивченню даної проблеми, дуже мало й проблема залишається недостатньо вивченою.

Мета. Дослідити психологічні детермінанти стресових чинників у діяльності працівників агробізнесу в довготривалих кризових умовах.

Матеріали та методи. Аналіз літературних джерел проводився в період 2023–2024 рр. Також проведено комплексне обстеження 190 осіб, в межах якого кожен працівник агробізнесу, що став учасником дослідження, надав інформаційну згоду щодо своєї участі. У дослідження дотримувалися «Принципи біоетики та деонтології» Американської психологічної асоціації [2], «Кодексу етики» [3], «Положення про академічну доброчесність АПСВТ» [4].

Результати дослідження. Актуальність проблематики психічного здоров'я населення у сільському господарстві у всьому світі підтверджується оглядом досліджень Hagen B. із співавтор., які проаналізували 9906 результатів досліджень та вказують, що найбільш вимірюваними показниками є стрес – 41,9 %, самогубство – 33,1 %, депресія – 32,6 % [5]. Стурбованість дослідників проблемами психічного здоров'я фермерів вказується у систематичному огляді Yazd S. із співавтор., які вивчали результати, плани, методи поточних досліджень психічного здоров'я фермерів. Аналіз 167 статей з використанням стандартизованої стратегії пошуку електронної літератури та рекомендацій PRISMA щодо психічного здоров'я фермерів дозволив зазначити, що вплив на психічне здоров'я фермерів мають фінансові труднощі, мінливість клімату, погане фізичне здоров'я, пов'язане із травмами. Більшість досліджень проводилися у розвинутих країнах, зокрема у США, Австралії та Великобританії, де вказувалося, що розлади психологічного здоров'я у фермерів і робітників корелюють із знанням факторів ризику розвитку психологічних розладів та їх впливом, що є важливими для зменшення тягара психічних захворювань [6]. Відомо, що робота працівників агробізнесу є дуже важкою як фізично, так і розумово. У європейському сільськогосподарському секторі 42,0 % працівників вважають, що робота негативно впливає на їх здоров'я. Шкідливий вплив, який робота має на здоров'я працівників, частково пояснюється різними психосоціальними небезпеками, а саме: тривалим робочим днем,

ізоляцією, фінансовою невизначеністю, труднощами планування, адміністративними вимогами, взаємодією з стресовими чинниками й впливом багатьох фізичних ризиків. Виявлено, що збільшення кількості стресових факторів, пов'язаних з роботою, було пов'язане зі зростанням рівнів як депресії, так і тривоги серед респондентів [7].

За дослідженням Hovey, J. із співавторами прояв стресових факторів і пов'язаних з ними стратегій подолання різняться залежно від того, чи є особи власником чи керуючим агробізнесу, або найнятою особою як робітник. Очевидно, що власники агробізнесу та найнятий персонал по різному піддаються ризику розвитку стресу та інших проблем, пов'язаних із психічним здоров'ям, таких як тривога, депресія та суїцид [8]. За дослідженням Колструп К. із співавторами працівників агробізнесу та члени сімей стикаються з багатьма вимогами та стресовими факторами у своїй повсякденній роботі, і, здається, вони є спільними для різних країн і культур. Високі робочі вимоги та очікування в поєднанні з низьким контролем і відсутністю соціальної підтримки призводять до травмуючого психосоціального середовища на роботі, підвищеного рівня стресу, погіршення психічного здоров'я, депресії та у гіршому випадку до самогубства. У міжнародному масштабі працівники агробізнесу з розладами психічного здоров'я мають різні варіанти медичних послуг залежно від свого місцезнаходження. Проте, незалежно від місця розташування початкова відповідальність за психічне здоров'я персоналу агробізнесу за вплив стресу, який може бути коротко- чи довгостроковим, лежить на власниках та керівниках агробізнесу [9]. У свою чергу Torske M. та ін. вказують, що за останні десятиліття сільське господарство зазнало глибоких змін і фермери почали стикатися з різноманітними стресовими факторами. Дослідивши рівні симптомів тривоги та депресії серед норвезьких фермерів віком 19-66,9 років за шкалою тривоги та депресії (HADS) за опитування The Nord-Trondelag Health Study у 2006-2008 рр., автори зазначають, що як чоловіки, так і жінки мали вищий рівень симптомів депресії, ніж загалом працююче населення. Відмінності в рівнях симптомів депресії між фермерами та працюючим населенням збільшувалися з віком. Чоловіки-фермери мали вищий рівень випадків

депресії, ніж жінки. Фермери виявляли високий та середній рівень симптомів депресії та тривоги порівняно з іншими професійними групами [10].

Досліджуючи ризик наслідків для психічного здоров'я, таких як хронічний стрес, депресія та тривога, Jones-Bitton A. із співавтор. вказують на недостатню кількість досліджень щодо вигорання у працівників агробізнесу. У онлайн-опитуванні 1075 фермерів у продовж 2015-2016 рр., за результатами загального опитування Maslach Burnout Inventory серед фермерів, вимірювалися три компоненти вигорання (виснаження, цинізм і професійна ефективність), вивчалися потенційні супутні фактори ризику, а також визначалася поширеність різних профілів вигорання (залученість, неефективність, надмірна напруженість, незалученість, власне вигорання). Виявлено, що виснаження, цинізм та професійна неефективність є вищими за міжнародні норми. Так, 44,0 % респондентів були віднесені до неефективних з надмірно розширеним профілем вигорання, а 12,0 % віднесені до профілю сформованого вигорання [11]. Досліджуючи проблему вигорання на вибірці 4000 швейцарських фермерів, Reissig L. встановив, що хоча фермерство часто вважається традиційною професією, яка може бути вільною від викликів сучасного життя, фермери зовсім не застраховані від виснаження. Поширеність синдрому вигорання серед фермерів відповідає середньому серед населення Швейцарії на рівні 6,1% [12].

Рудольфі Д. вказує, що ранні дослідники сільськогосподарської безпеки та здоров'я визнавали потенційний вплив професійного стресу на психічне здоров'я фермерів. Незважаючи на те, що протягом останніх 30 років спостерігається певна послідовність досліджень психічного здоров'я в сільському господарстві, зростає занепокоєння щодо психічного здоров'я сільськогосподарських виробників і працівників через несприятливі ринкові умови, самогубство фермерів, банкрутство ферм [13]. Данна думка підтверджується дослідженням Furey E. із співавторами, які вказують на психосоціальні і контекстуальні фактори, які мають відношення до психічного здоров'я фермера. Результати інтерв'ю з 30 працівниками агробізнесу показали, що респонденти визнали впливи психічного, фінансового, фізичного стресу на їхнє психічне здоров'я вагомим та діяльністю [14]. У свою чергу Brigance

С. із співавторами дослідили 121 працівника агробізнесу й виявили, що сільське господарство небезпечне, кількість смертельних випадків є однією з найвищих у будь-якій професії. Фермери часто працювали поодиноці, протягом довгих годин, з ненадійним обладнанням і в складних погодних умовах з небезпечними хімікатами та худобою. Крім того, фермери брали на себе значні фінансові зобов'язання, що наражало їх на високий рівень фінансового ризику. Вплив такого фінансового ризику може призводити до суб'єктивного досвіду фінансової загрози, який є психологічно важким та травмуючим у вигляді депресії, тривоги, стресу та загальної небезпеки для здоров'я [15].

Вивчаючи поширеність психічних симптомів серед фінських аграрних підприємців у 1994 р. (928 фермера) та 2004 р. (1182 фермера) Kallioniemi M. із співавторами дослідили зв'язок між симптомами та фоновими факторами. Найпоширенішими симптоми автори виявили слабкість/втому, безсоння/труднощі із засипанням, адже кожен четвертий фермерський підприємець мав такі симптоми, а напруженість життя та сільськогосподарська робота мали зв'язок із психічними симптомами та підвищили ризик їх виникнення [16]. Дана думка підтверджується дослідженням Thomas H. із співавторами, де оцінено поширеність невротичних симптомів у вибірці британських фермерів та зв'язок особливостей ведення сільського господарства з психіатричною захворюваністю. Досліджено 425 фермерів із Херефорда, Норвіча та Престона за допомогою клінічного інтерв'ю (CIS-R). Автори вказують, що є достовірний зв'язок між депресією та суїцидальними ідеями, проте у порівнянні із не фермерськими вибірками він є різним за факторами виникнення серед фермерів [17]. У дослідженні Kallioniemi M. з співав. найпоширенішими стресорами у представників агробізнесу встановлено великий обсяг роботи та непередбачуваність. Поширеність стресу дорівнювала 42,0 % та була вищою, ніж серед працюючого населення в цілому. Усі досліджені мали незначні симптоми вигорання, а 9,0 % виражене вигорання. При цьому стресори, пов'язані з робочим навантаженням і здоров'ям, були пов'язані з симптомами вигорання, а до факторів, що захищають від вигорання, належали позитивні якості персоналу [18]. У перехресному онлайн-опитуванні з

використанням валідної психометричної шкали сприйняття стресу Jones-Bitton A. із співав., досліджуючи стрес, тривогу, депресію та стійкість у канадських фермерів, класифікували у 57,0 % і 33,0 % учасників симптоми тривоги та депресії. Автори стверджують, що показники стресу, тривоги та депресії були вищими, а показники стійкості нижчими, при чому жінки отримали менш сприятливі оцінки за всіма вивченими показниками психічного здоров'я, що є гендерно важливою відмінністю [19].

Gorgievski-Duijvestein M. із співавторами дослідили 260 голландських власників сільськогосподарського бізнесу (у проміжку часу в один рік) та вивчали взаємозв'язки між фінансовим становищем підприємства та психологічними труднощами. У результаті виявили негативну спіраль занепаду ферм, у якій психологічні змінні відігравали ключову роль. Переживання фінансових проблем викликало психологічний стрес, що посилювало наміри залишити бізнес та призводило до погіршення об'єктивного фінансового стану бізнесу через один рік. Фермери, які відчували більше психологічного стресу, мали більше шансів потрапити в цю негативну спіраль, ніж власники бізнесу з кращим психічним здоров'ям, оскільки відчували більше фінансових проблем, незалежно від свого об'єктивного фінансового становища. Автори зазначають, що довгостроковий психологічний дистрес, а не тимчасові коливання рівнів дистресу мають більш важливий негативний ефект впливу [20].

Niott A., досліджуючи стрес працівника аграрної сфери та його наслідки для психічного здоров'я, виявив п'ять окремих областей стресових факторів: легальність і логістика роботи, соціальна ізоляція, умови праці, сім'я та зловживання психоактивними речовинами. Автор вказує, що окремі типи стресорів мали різний вплив на симптоми тривоги та депресії. Зокрема, хоча більша соціальна ізоляція та більш стресові умови праці були пов'язані з вищими оцінками тривоги та симптомами депресії, величина впливу була різною. Соціальна ізоляція мала найсильніший потенційний вплив на тривожність особистості, тоді як більш стресові умови праці мали найсильніший потенційний вплив на симптоми депресії [21].

У дослідженні Carvajal S. із співав. вивчалися фактори, пов'язані зі станом здоров'я працівників сільського господарства залежно від соціокультурних чинників, у тому числі стресу та депресії, пов'язаного з роботою, та контекстом громади. Результати включали три стандартні заходи національного спостереження США за психічним, фізичним статусом та самооцінкою здоров'я. Моделі логістичної регресії показали, що більш високі рівні стресу були суттєво пов'язані ($p < 0,001$) із підвищеним ризиком погіршення психічного та фізичного здоров'я. Зазначається, що для пом'якшення стресових факторів у фермерів, необхідна розробка стратегії зміцнення психологічного здоров'я на клінічному та системному рівнях [22]. Aroga K. із співав., досліджуючи питання здоров'я та безпеки, а також психологічні стресові фактори серед власників-операторів аграрного бізнесу Середнього Заходу, виявили, що фінанси, клімат/погода, робоче навантаження та управління є найбільшими психологічними факторами стресу. Автори зазначають необхідність розробки заходів втручання та освітніх ресурсів для вирішення проблем здоров'я і безпеки, зменшення впливу психологічних стресових факторів [23]. Ця думка підтверджується Petit P. із співав., які досліджували депресії серед персоналу сільського бізнесу у Франції та виявили, що сільськогосподарська діяльність сильніше пов'язана з депресією, ніж інші її види. У загальнонаціональному ретроспективному когортному дослідженні за даними з адміністративної бази даних охорони здоров'я з 2012–2022 рр. проекту TRACTOR автори дійшли висновку про переважання рівня депресії у керівництва (менеджменту та провідних спеціалістів) середнього віку 46,6 років. Виявлено статеві відмінності, де ризики є вищими для жінок, ніж для чоловіків. Стверджується, що сільськогосподарська діяльність викликає ризик депресії серед усієї робочої сили французького сільського господарства. Це стало важливим кроком на шляху до впровадження ефективних профілактичних заходів проти депресії із визначенням напрямів, за якими доцільно виділити додаткові ресурси для виявлення депресії разом із втручанням [24].

Grzywacz Joseph G. із співав., досліджуючи потенційні впливи організації роботи в сільському господарстві на гігієну праці, виявили, що низький рівень

контролю над роботою, високі психологічні вимоги та високе навантаження на роботі мають більший ризик погіршення самооцінки фізичного здоров'я та посилення симптомів депресії. Дослідження перехресних даних (N= 3691), отриманих за допомогою модуля організації праці та психосоціальних факторів Національного опитування сільськогосподарських працівників США, проведеного в 2009–2010 рр., дозволило його авторам зазначити, що 22,4 % мали задовільне/погане здоров'я, а 8,7 % повідомили про посилення симптомів депресії. Також автори вказали на необхідність психологічної підтримки персоналу сільського господарства з метою зниження ризиків для професійного здоров'я серед уразливої групи працівників [25].

Висновки. Узагальнюючі результати дослідження можна зазначити, що у сучасному науковому середовищі проблема психологічних стресів у діяльності працівників агробізнесу в довготривалих кризових умовах розглядається із багатьох аспектів. Проте, чинники тривоги, ціннісні орієнтації, міжособистісні стосунки, емоційне вигорання, копінг-стратегії поведінки, опір змінам в контексті успішності соціально-психологічної та професійної адаптації персоналу в довготривалих кризових умовах вивчені не достатньо та потребують подальших досліджень.

Література.

1. Prib H., Beheza L., Markova M., Raievska Y., Lapinska T., Markov A. Psycho-emotional burnout of the personality in the conditions of war. Journal of Intellectual Disability – Diagnosis and Treatment. 2023. V. 11. № 1. P. 36–46.
2. Ethical principles of psychologists and code of conduct. American Psychological Association. Effective June 1, 2003 (as amended 2010, 2016). <https://www.apa.org/ethics/code/ethics-code-2017.pdf>
3. Code of Ethics. Protocol №10. Available from: 2016. <https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/KodeksEtyky.pdf>
4. Regulations on academic integrity. Academy of Labour Social Relations and Tourism, protocol №7. 2018. <https://drive.google.com/file/d/1roDEHIZC9MERTAjCeIP41Bgp249Ree38/view?usp=sharing>.

5. Hagen B., Albright A., Sargeant J., Triberti S. Research trends in farmers' mental health: A scoping review of mental health outcomes and interventions among farming populations worldwide. *PLoS One*. 2019. 14(12). P. 1–20. doi:10.1371/journal.pone.0225661.
6. Yazd S.D., Wheeler S.A., Zuo A. Key Risk Factors Affecting Farmers' Mental Health: A Systematic Review. *Int J Environ Res Public Health* . 2019 pik; 16 (23):1–23. doi:10.3390/ijerph16234849.
7. Psychosocial issues in the agriculture sector – OSHwiki | European Agency for Safety and Health at Work. 2017. <https://oshwiki.osha.europa.eu/en/themes/psychosocial-issues-agriculture-sector>
8. Hovey, J.D., Seligman, L.D. The Mental Health of Agricultural Workers. In: Lessenger, J.E. (eds) *Agricultural Medicine*. Springer. 2006. New York, NY. https://doi.org/10.1007/0-387-30105-4_22
9. Lunner Kolstrup C., Kallioniemi M., Lundqvist P., Kymäläinen H. R., Stallones L., Brumby S. International perspectives on psychosocial working conditions, mental health, and stress of dairy farm operators. *Journal of agromedicine*. 2013. №18(3). P. 244–255. <https://doi.org/10.1080/1059924X.2013.796903>
10. Torske M. O., Hilt B., Glasscock D., Lundqvist P., Krokstad S. Anxiety and Depression Symptoms Among Farmers: The HUNT Study, Norway. *Journal of agromedicine*. 2016. 21(1). P.24–33. <https://doi.org/10.1080/1059924X.2015.1106375>
11. Jones-Bitton A, Hagen B, Fleming SJ, Hoy S. Farmer Burnout in Canada. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2019. №16(24). 5074 p. <https://doi.org/10.3390/ijerph16245074>
12. Reissig L, Cramer A, von Wyl A. Prevalence and predictors of burnout in Swiss farmers – Burnout in the context of interrelation of work and household. *Mental Health & Prevention*. 2019. V 14. <https://doi.org/10.1016/j.mph.2019.200157>
13. Rudolphi J. Diversity of Mental Health Issues in Agriculture. *Journal of Agromedicine*. 2019. 25(1). P.1. <https://doi.org/10.1080/1059924X.2020.1694821>
14. Furey E. M., O'Hora D., McNamara J., Kinsella S., Noone C. The Roles of Financial Threat, Social Support, Work Stress, and Mental Distress in Dairy Farmers'

Expectations of Injury. *Frontiers in public health*. 2016. 4. P. 126.
<https://doi.org/10.3389/fpubh.2016.00126>

15. Brigance C., Soto Mas F., Sanchez V., Handal A. J. The Mental Health of the Organic Farmer: Psychosocial and Contextual Actors. *Workplace health & safety*. 2018. 66(12). P. 606–616. <https://doi.org/10.1177/2165079918783211>

16. Kallioniemi M. K., Simola A. J., Kymäläinen H. R., Vesala H. T., Louhelainen, J. K. Mental symptoms among Finnish farm entrepreneurs. *Annals of agricultural and environmental medicine : AAEM*. 2009. 16(1). P. 159–168.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19572488/>

17. Thomas H. V., Lewis G., Thomas D. R., Salmon R. L., Chalmers R. M., Coleman T. J., Kench S. M., Morgan-Capner P., Meadows D., Sillis M., Softley, P. Mental health of British farmers. *Occupational and environmental medicine*. 2003. 60(3). P. 181–186. <https://doi.org/10.1136/oem.60.3.181>

18. Jones-Bitton A., Best C., MacTavish J., Fleming S., Hoy, S. Stress, anxiety, depression, and resilience in Canadian farmers. *Social psychiatry and psychiatric epidemiology*. 2020. 55. P. 229-236. doi:10.1007/s00127-019-01738-2.

19. Kallioniemi M., Simola A., Kaseva J. Stress and Burnout Among Finnish Dairy Farmers. *Journal of Agromedicine*. 2016. 21(3). P. 259–268.
<https://doi.org/10.1080/1059924X.2016.1178611>

20. Gorgievski-Duijvestein M.J., Bakker A.B., Schaufeli W.B. та ін. Financial problems and psychological distress: Investigating reciprocal effects among business owners. *J Occup Organ Psychol*. 2010. 83(2). P. 513–530. doi:10.1348/096317909X434032.

21. Hiott A.E., Grzywacz J.G., Davis S.W., Quandt S.A. Arcury T.A. Migrant Farmworker Stress: Mental Health Implications. *The Journal of Rural Health*. 2008. 24: P. 32-39. <https://doi.org/10.1111/j.1748-0361.2008.00134.x>.

22. Carvajal S.C., Kibor C., McClelland D.J., Ingram M., de Zapien J.G., Torres E., Redondo F., Rodriguez K., Rubio-Goldsmith R., Meister J., Rosales C. Stress and Sociocultural Factors Related to Health Status Among US–Mexico Border Farmworkers.

Journal of Immigrant and Minority Health. 2014. 16 (6). P. 1176-1182, <https://doi.org/10.1007/s10903-013-9853-1>

23. Arora K., Cheyney M, Gerr F., Bhagianadh D., Gibbs J., Renée T. Assessing Health and Safety Concerns and Psychological Stressors among Agricultural Workers in the U.S. Midwest. *Journal of Agricultural Safety and Health*. 2020. 26(1). P. 45-58. doi:10.13031/jash.13660

24. Petit P., Gandon G., Dubuc M., Vuillerme N., Bonneterre V. Agricultural activities and risk of treatment for depressive disorders among the entire French agricultural workforce: the TRACTOR project, a nationwide retrospective cohort study. *The Lancet Regional Health – Europe*. 2023. V.31. <https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2023.100674>.

25. Grzywacz J. G., Alterman T., Gabbard S., Shen R., Nakamoto J., Carroll D. J., Muntaner C. Job control, psychological demand, and farmworker health: evidence from the national agricultural workers survey. *Journal of occupational and environmental medicine*. 2014. 56(1). P. 66–71. <https://doi.org/10.1097/JOM.0000000000000025>

2.11. Роль soft skills та емоційного інтелекту у подоланні наслідків професійного стресу працівників сфери обслуговування

Лосієвська О.Г.

Мальнєв А.С.

Актуальність. У сучасних умовах динамічного розвитку суспільства, підвищення вимог до професійної діяльності та зростання конкуренції працівники сфери обслуговування часто стикаються з високим рівнем стресу. Цей стрес негативно впливає на емоційний стан, продуктивність, взаємодію з клієнтами та загальний рівень професійного функціонування. Професійний стрес у цій сфері пов'язаний з інтенсивністю робочого ритму, складністю комунікацій, необхідністю відповідати очікуванням клієнтів та швидко адаптуватися до змін.

Водночас розвиток soft skills (гнучких навичок) та емоційного інтелекту є важливими інструментами, які допомагають ефективно подолати наслідки стресу. Soft skills сприяють формуванню міцного колективу, підвищенню якості міжособистісної взаємодії, управлінню конфліктами та зменшенню емоційної напруги. Емоційний інтелект, у свою чергу, забезпечує здатність усвідомлювати та контролювати власні емоції, регулювати емоційний стан та знаходити ресурси для протидії стресовим факторам.

Вивчення ролі soft skills та емоційного інтелекту в подоланні професійного стресу є актуальним не лише для психології праці, а й для створення ефективних програм навчання та розвитку працівників сфери обслуговування. Це дозволяє формувати середовище, сприятливе для їхньої професійної реалізації, збереження психічного здоров'я та підвищення якості обслуговування клієнтів.

Мета дослідження полягає у визначенні ролі soft skills та емоційного інтелекту в запобіганні стресу працівників сфери обслуговування. Це включає: 1. Аналіз чинників, що спричиняють стрес у професійній діяльності працівників сфери обслуговування. 2. Визначення основних компонентів soft skills та емоційного інтелекту, які сприяють ефективному подоланню стресу. 3. Виявлення

механізмів впливу емоційного інтелекту та м'яких навичок на адаптацію працівників до професійних викликів і підвищення їхньої стресостійкості.

Результати дослідження. Дослідження виявило, що основними стресогенними факторами для працівників сфери обслуговування є емоційне навантаження, часті конфліктні ситуації, інтенсивний робочий графік та необхідність швидкої адаптації до змін. Серед суб'єктивних чинників особливу роль відіграють низький рівень емоційної саморегуляції, недостатня впевненість у собі та відсутність навичок управління стресом.

У той же час, розвиток soft skills та емоційного інтелекту позитивно впливає на здатність працівників долати наслідки професійного стресу. Працівники, які мають розвинутий емоційний інтелект показали себе більш спроможними контролювати свої емоції в складних ситуаціях, ефективно комунікувати з клієнтами та колегами, вирішувати конфлікти та підтримувати позитивний емоційний фон у роботі.

Також було встановлено, що такі soft skills, як уміння працювати в команді, адаптивність, ефективна комунікація та стресостійкість, знижують імовірність вигорання, підвищують продуктивність праці та забезпечують гармонійнішу взаємодію з клієнтами. Працівники, які володіють цими навичками, менш схильні до хронічного стресу та зберігають високу якість обслуговування навіть у складних умовах. Як вважають психофізіологи, у різні періоди розвиток наукових уявлень про стрес супроводжувався створенням багатьох концепцій, теорій та моделей, які відображають різноманітні підходи до цього явища. Вони включають загальнобіологічні, фізіологічні та психологічні аспекти, що стосуються сутності стресу, причин його виникнення, механізмів регуляції, характеру проявів та методів його запобігання.

Сучасні дослідники значну увагу приділяють аналізу різних форм стресових станів, особливо в контексті професійної діяльності (І. Аршава, І. Жигаренко, Н. Завацька, В. Корольчук та ін.). Стресові фактори дедалі частіше визначаються як основне джерело проблем у роботі, оскільки вони негативно впливають як на продуктивність, так і на особистісне благополуччя. Пролонгований стрес може

призводити до психосоматичних розладів, соціальної ізоляції та професійних деформацій (Купер, Маршалл). Це вимагає своєчасної діагностики та корекції стресу, зокрема виявлення індивідуальних схильностей до стресових реакцій і використання адаптивних стратегій. У професіях, що передбачають взаємодію «людина-людина», особливо важливо розуміти стиль подолання стресу як набір стійких психологічних механізмів, що допомагають зберегти оптимальний рівень психічної напруги та автентичність особистості (М. Корольчук, С. Миронець, Ю. Позднишев) [7].

Аналіз емпіричних даних, проведений авторами, показує, що особистісна стресостійкість не є жорстко зумовленою нейродинамічними характеристиками. Більшість досліджуваних із «незадовільним» або «задовільним» рівнями нервово-психічної стійкості не проявляли високої сприйнятливості до стресу. Це дало підстави для гіпотези про наявність у них певних психологічних ресурсів, які формують індивідуальний стиль стресостійкості, що знижує ризик нервово-психічних зривів. Ця гіпотеза була підтверджена експериментально: у респондентів з високою стресостійкістю рівень організаційного стресу був значно нижчим, ніж у тих, хто був більш сприйнятливим до стресу.

Як зазначають Н. Юр'єва і В. Пасічник, ресурси подолання стресу включають проблемно-орієнтовані зусилля, пошук інформаційної, дієвої та емоційної підтримки, регулювання емоцій і дій, а також переоцінку стресових ситуацій. Вони виділяють три типи копінг-стратегій, що залежать від нейродинамічних характеристик і реагування на стрес [6].

Мотиваційне ядро особистості, яке забезпечує стресостійкість, характеризується акцентом на завдання та метакогнітивний контроль дій. У осіб з сильною нейродинамікою стресостійкість проявляється під час невдач, а у тих, хто має слабку нервово-психічну стійкість – у процесі планування. Ці якості формують індивідуальний стиль подолання стресу. Особистості з недостатньою стресостійкістю орієнтуються на ситуаційний контроль, що знижує їх потенціал до стресорів. Розвиток соціальної креативності та адаптивності є важливими ресурсами для підвищення стресостійкості. Дослідники також припускають

існування продуктивних та непродуктивних стилів подолання стресу, залежно від комбінації індивідуальних ресурсів, що вимагає подальшого вивчення [8].

У сучасних дослідженнях опанування складних життєвих ситуацій часто пов'язують з процесом психологічної адаптації. О. Кокун підкреслює, що пошук внутрішніх ресурсів для адаптації до несприятливих зовнішніх умов дедалі більше зосереджується на аналізі копінг-поведінки. Він визначає копінг-стратегії як способи управління стресом, спрямовані на вирішення проблеми, яка викликала стресову реакцію [4].

З погляду психології адаптації, прагнення подолати складну ситуацію виникає лише тоді, коли внутрішня потреба вирішення проблеми активує адаптивні можливості людини. У цьому контексті копінг визначається як спроба подолання важкої ситуації та створення нових умов. Е. Хейм, аналізуючи форми копіngu з точки зору їх адаптивних і неадаптивних властивостей, виділив 26 стратегій. Вони охоплюють емоційну (оптимізм, спротив труднощам), когнітивну (ціннісні установки, аналіз ситуації) та поведінкову (співпраця, комунікація) сфери [10].

Дослідники професійного стресу особливо акцентують увагу на стресах, що виникають у процесі діяльності. Увага приділяється їхнім причинам, наслідкам, формам прояву та динаміці переживання. Виділяють кілька груп факторів, що спричиняють стрес і впливають на ефективність роботи.

До об'єктивних чинників відносяться стресори соціального походження. Їхніми джерелами є інтенсивний розвиток сучасного суспільства, прискорення ритму життя, зростання складності й вимог системи навчання та атестації. Це може призводити до невідповідності між генетичними програмами людини та сучасними умовами життя. Виникає розрив між психобіологічними можливостями організму і темпом соціальних змін, адаптація яких не завжди відбувається швидко.

Суб'єктивні чинники утворюють другу групу. Вони включають стреси, спричинені неадекватними переконаннями, помилками мислення, емоційними переживаннями чи змінами соціального статусу. В окрему категорію можна виділити мотиваційні чинники, що впливають на діяльність через потреби, установки та цінності особистості. Дослідження демонструють, що низька

мотивація до виконання завдань і відсутність контролю над ситуацією сприяють розвитку стресу. Наприклад, у процесі організаційних змін негативне ставлення до цих змін супроводжується зростанням показників стресу, зниженням активності та негативною динамікою загального стану колективу.

Різні мотиваційні фактори по-різному впливають на розвиток стресу. Процесуальна мотивація, що ґрунтується на самому процесі діяльності, сприяє мобілізації ресурсів і підвищенню ефективності. Водночас мотивація самоствердження викликає емоційну напругу, що може провокувати інтенсивні емоційні переживання та критичну оцінку діяльності.

Зростання рівня стресу у сучасному світі є критичною проблемою, що відображає значний вплив глобальних змін, технологічного прогресу, економічної нестабільності та соціальних криз. Сфера обслуговування вимагає високого рівня емоційної залученості до взаємодії з клієнтами, що провокує стрес у працівників та створює ризик емоційного вигорання. Сучасні дослідження акцентують увагу на декількох аспектах:

1. Колективний стрес на фоні викликів сучасності. У звіті Stress in America 2023 [7] від Американської психологічної асоціації зазначається, що рівень стресу зріс серед усіх вікових груп. Наприклад, у дорослих 35-44 років частота діагностування психічних розладів зростає з 31% у 2019 році до 45% у 2023 році. Основними джерелами стресу стали фінансові труднощі (77%) та економічна невизначеність (74%). Зокрема, пандемія COVID-19 спрацювала, як кризовий фактор.

2. Технологічний стрес. Використання технологій, зокрема, засобів цифрової комунікації, стало значним чинником інформаційного стресу. Постійна доступність та інформаційне перевантаження спричиняють тривогу та знижують здатність до концентрації, що помітно у працівників сфери обслуговування, де потрібно швидко реагувати на запити клієнтів.

3. Економічна та соціальна нестабільність. Війни, зміна клімату, зростання нерівності та нестабільність на ринку праці створюють додатковий психологічний

тиск. Багато працівників почуваються емоційно виснаженими через страх втрати роботи та відсутність соціальної підтримки.

4. Важливість софт-скіллс для подолання стресу. Дослідження демонструють, що розвинений емоційний інтелект (EQ), комунікативні навички та здатність управляти конфліктами є ключовими для адаптації до стресових умов. Наприклад, якщо навчати співробітників та розвивати в них навички саморегуляції, це може значно зменшити емоційне вигорання, що підтверджують сучасні тренінги у великих організаціях.

Розвинуті навички soft skills як фактор запобігання та подолання стресу активно вивчаються науковцями, які акцентують увагу на важливості заглиблюватись в тему саме «м'яких навичок» з метою покращення результатів професійної діяльності.

Сучасні глобалізаційні процеси диктують необхідність визначення ключових вимог ринку праці до фахівців «нового покоління», в тому числі в сфері обслуговування. Пріоритетними стають здатність до особистісного та професійного розвитку, постійного самовдосконалення, самоосвіти й реалізації свого потенціалу. Окрім професійних компетенцій, актуальними є гнучкі навички, відомі, як «soft skills», які сприяють створенню конкурентоспроможного професійного іміджу. Сьогодні роботодавці дедалі частіше звертають увагу саме на ці навички, вносячи їх до переліку ключових вимог до кандидатів на вакансії.

Ринок праці високо цінує працівників, які не лише володіють теоретичними знаннями та практичними вміннями («hard skills»), але й демонструють готовність до постійного розвитку, здатність працювати в команді, вирішувати нестандартні завдання, долати труднощі й ефективно управляти власним професійним зростанням. «Soft skills» стають визначальними для успішної комунікації та взаємодії в будь-якій сфері професійної діяльності, в тому числі в сфері обслуговування, бо виступають важливим чинником досягнення успіху.

Розвиток гнучких навичок є важливим елементом підготовки конкурентоспроможного спеціаліста на всіх етапах його професійного становлення.

У наукових дослідженнях, присвячених «soft skills», значна увага приділяється особистісним характеристикам і соціальним навичкам, таким, як комунікативність, доброзичливість і вміння вселяти оптимізм. Ці якості сприяють ефективній взаємодії з іншими та підвищують продуктивність у професійній діяльності.

Зважаючи на сучасну динаміку бізнес-середовища та аналізуючи результати наукових досліджень, розуміти «soft skills» можна, як увагу до поведінкових стратегій, які допомагають професіоналам успішно виконувати свої обов'язки, працювати в колективі та адаптуватися до соціального середовища.

Умовно «soft skills» можна поділити на три основні групи:

1. Навички комунікації, які охоплюють ефективне спілкування, активне слухання, здатність переконувати, а також вміння чітко формулювати свої думки й ідеї.

2. Навички взаємодії, що включають здатність до співпраці, ефективну роботу в команді, управління конфліктами та підтримання позитивних стосунків.

3. Навички саморозвитку, до яких належать контроль емоцій, подолання стресу, а також формування креативного й інноваційного мислення.

Таким чином, «soft skills» формують основу для професійного та особистісного зростання, допомагаючи фахівцям адаптуватися до сучасних вимог ринку праці.

На відміну від hard skills, які охоплюють конкретні знання, технічні вміння та професійний досвід у певній галузі, soft skills базуються на особистісних якостях, що є універсальними і застосовними у будь-якій сфері діяльності. Hard skills можна виміряти за допомогою об'єктивних критеріїв, таких як тести чи практичні завдання, і вони включають, наприклад, знання товарної групи, маркетингу, математичні вміння.

Soft skills, натомість, стосуються таких якостей, як комунікативність, емоційний інтелект, лідерські здібності, креативність, адаптивність, вміння працювати в команді та здатність до вирішення проблем. Згідно з дослідженнями Гарвардського університету та Стенфордського дослідницького інституту, саме ці

навички складають 85% успіху професіонала, тоді як на частку hard skills припадає лише 15% [9, с. 79-82].

Попри те, що soft skills важко оцінити за допомогою тестів чи стандартних методик, вони відіграють ключову роль у побудові успішної кар'єри та професійної реалізації. У сучасних умовах, коли технології та вимоги ринку праці стрімко змінюються, ці навички стають ще більш актуальними, оскільки сприяють адаптації до нових викликів і швидкому професійному розвитку.

Розвиток soft skills (м'яких навичок) відіграє ключову роль у формуванні стресостійкості, особливо у працівників сфер із високим рівнем взаємодії з іншими людьми, таких як обслуговування, медицина чи освіта.

Навички soft skills сприяють управлінню стресом за рахунок певних складових:

1. Емоційний інтелект. Емоційний інтелект є центральною софт-скіл, яка допомагає ідентифікувати, розуміти та регулювати свої емоції, а також ефективно реагувати на емоції інших. Високий рівень емоційного інтелекту асоціюється зі зниженням тривожності та здатністю уникати емоційного вигорання. Приклад дослідження: дослідження Анні Медарис (Medaris A. 2022) для американської психологічної асоціації 2022 року показало, що ті працівники, які мають високий рівень емоційного інтелекту на 30% рідше відчувають виснаження, ніж їхні колеги із низьким емоційним інтелектом.

2. Комунікативні навички. Розвинені навички комунікації сприяють зменшенню міжособистісних конфліктів, які часто є джерелом стресу. Уміння слухати, висловлювати свої думки та ставити коректні питання допомагає уникати непорозумінь.

3. Управління розподілом часу. Ефективний тайм-менеджмент знижує рівень стресу, пов'язаного з дедлайнами та багатозадачністю. Люди з добре розвиненим управлінням часом здатні краще структурувати свою роботу, що зменшує напругу.

4. Навички вирішення конфліктів. Конструктивне вирішення конфліктів допомагає уникати накопичення негативу в колективі, що може знижувати загальний рівень стресу на робочому місці.

5. Адаптивність та гнучкість. Ці навички дозволяють швидко пристосовуватися до змін, що є необхідним у сучасному швидкоплинному світі. Люди, яким притаманна гнучкість, легше долають стрес, пов'язаний із несподіваними обставинами чи новими умовами праці.

Недостатнє володіння soft skills, особливо брак навичок комунікації, адаптивності та управління емоціями у працівників посилює негативний вплив стресу.

Тема розвитку soft skills є надзвичайно актуальною через зростання складності професійного середовища та високі вимоги до психологічної стійкості працівників. Впровадження тренінгів з розвитку м'яких навичок може суттєво вплинути на зменшення рівня стресу, підняти відчуття задоволення роботою на більш високий рівень та сприяти професійному росту.

Швидкий розвиток технологій та потреба адаптуватися до змін постійно підкреслюють значущість soft skills для сучасної людини.

Навичкам які варто розвинути фахівцю сфери обслуговування, щоб знизити вплив стресових факторів:

1. Аналітичне мислення та інноваційність. Уміння розподіляти інформацію на складові, систематизувати дані та встановлювати зв'язки між ними дозволяє приймати обґрунтовані та оптимальні рішення в різних ситуаціях.

2. Активне навчання та стратегії навчання. Роботодавці віддають перевагу працівникам, які не лише володіють необхідними компетенціями, а й прагнуть постійно вдосконалювати свої знання та вміння, навіть в умовах динамічних змін.

3. Комплексне вирішення проблем. Здатність знаходити, аналізувати та використовувати якісну інформацію, оцінювати можливі наслідки рішень і пропонувати ефективні шляхи виходу з будь-яких ситуацій є надзвичайно важливою навичкою.

4. Критичне мислення та аналітика. Це вміння чітко формулювати власні думки, аргументувати їх у дискусіях та обґрунтовувати прийняті рішення.

5. Креативність, оригінальність та ініціативність. Здатність комбінувати на перший погляд несумісні ідеї, пропонувати нестандартні підходи й створювати новаторські рішення стає ключовою конкурентною перевагою.

6. Лідерство та соціальний вплив. Справжня цінність співробітника полягає не лише в його особистих досягненнях, але й у позитивному впливі на команду та сприянні її успіху.

7. Використання, моніторинг і контроль технологій. Сучасні фахівці мають інтегрувати новітні технології у свою діяльність, адже сьогодні й майбутнє без них уже неможливі.

8. Розробка ідей та вирішення завдань. Інформація, що надходить до людини, має слугувати поштовхом для створення нових ідей, здатних забезпечити вирішення складних завдань або досягнення амбітних цілей.

9. Стресостійкість і гнучкість. Вміння зберігати спокій в непростих обставинах, приймати зважені рішення й адаптуватися до обставин є невід’ємними рисами сучасного фахівця.

Ці навички формують основу професійної успішності в умовах змін і невизначеності, знижуючи таким чином стрес від зазначених факторів.

Теоретичне підґрунтя для вивчення сутності, структури та концепцій емоційного інтелекту, а також механізмів його впливу на успішність особистості є предметом уваги багатьох науковців, як іноземних (Р. Бар-Он, Г. Гарднер, Д. Гоулман, Д. Дестено, Дж. Майєр, П. Саловей, Д. Карузо, Д. Фрейзер, Д. Хессон), так і українських (Г. Березюк, Ю. Бохонкова, В. Бочелюк, Ю. Бреус, С. Дерев’янка, С. Гаркавець, Н. Діомідова, Н. Завацька, Є. Карпенко, Т. Кириленко, Н. Коврига, М. Кузнецов, О. Лосієвська, О. Милословська, Е. Носенко, І. Поповіч, О. Філатова, О. Шевяков). Їхні дослідження значно розширюють розуміння впливу різних факторів на досягнення успіху та самореалізацію особистості [1].

Емоційний інтелект визначають як здатність усвідомлювати свої емоції та керувати ними, мати вплив на думки та поведінку, приділяти увагу мотивації (мотивацію) та регулювати свій емоційний стан. Він також охоплює вміння

впливати на емоції інших людей, розуміти їхні потреби, проявляти співчуття та допомагати розкривати сильні сторони.

На думку Деніела Гоулмана [2], емоційний інтелект полягає у здатності розпізнавати й розуміти емоції як власні, так і чужі, а також використовувати це розуміння для покращення взаємин і управління власною поведінкою. Д Гоулман виділяє п'ять основних складових емоційного інтелекту: самоусвідомлення, саморегуляція, мотивація, емпатія та соціальні навички.

Варто детальніше визначити, яку роль відіграє емоційний інтелект у формуванні стресостійкості: 1. Регуляція емоцій. Дослідження показують, що високий рівень емоційного інтелекту знижує вироблення кортизолу – гормону стресу. Люди з високим рівнем розвитку емоційного інтелекту легше справляються з кризовими ситуаціями, зберігаючи спокій і раціональність. 2. Поліпшення комунікації. Емоційний інтелект сприяє кращому розумінню емоцій оточуючих, що допомагає уникати конфліктів та ефективніше вирішувати робочі питання навіть у стресових ситуаціях. 3. Підтримка фізичного здоров'я. Зниження рівня стресу завдяки емоційному інтелекту допомагає запобігати психосоматичним захворюванням, зокрема серцево-судинним проблемам, імунodefіциту тощо.

В якості ефективних засобів, що сприяють розвитку емоційного інтелекту, можна зазначити: 1. Навчання управління емоціями. Техніки, такі як усвідомленість (mindfulness) і когнітивно-поведінкові вправи, допомагають розвивати емоційний інтелект і, як наслідок, посилювати стресостійкість. 2. Створення сприятливого середовища. Підтримуюча корпоративна культура, яка цінує емоційний інтелект, сприяє більшій емоційній стійкості персоналу.

Висновки. Дослідження підтверджує, що soft skills та емоційний інтелект є важливими ресурсами для подолання професійного стресу працівників сфери обслуговування. Розвиток цих навичок сприяє не лише підвищенню професійної ефективності, а й збереженню психічного здоров'я. Такі soft skills, як здатність до ефективної комунікації, управління конфліктами, командна робота та адаптивність, дозволяють працівникам успішно реагувати на стресові ситуації та забезпечують комфортне робоче середовище. Емоційний інтелект, зі свого боку, сприяє

усвідомленню власних емоцій, їх регуляції та створенню умов для конструктивної взаємодії з іншими людьми.

Результати дослідження можуть бути використані для розробки тренінгів та освітніх програм, спрямованих на розвиток soft skills та емоційного інтелекту серед працівників сфери обслуговування, що, у свою чергу, сприятиме підвищенню якості послуг та рівня задоволеності клієнтів. На основі вищезазначених досліджень є розуміння, що емоційний інтелект є важливою складовою психологічного ресурсу особистості. Він підвищує ефективність діяльності завдяки здатності розуміти й керувати своїми емоціями, а також підсилює соціальну взаємодію через вміння розпізнавати й впливати на емоційні стани інших людей. Крім того, в умовах стресу емоційний інтелект допомагає оптимізувати витрати енергії, управляти стресовими чинниками, і більш результативно виконувати поставлені завдання. Здатність до командної роботи та результативно взаємодіяти з оточуючими є одними з основних soft skills, необхідних для досягнення успіху в бізнесі. Злагоджена команда здатна виконувати більш складні завдання та досягати високих результатів, які неможливо досягти поодиночі. Командний дух передбачає підтримку колег і налагодження взаємодії, а співпраця вимагає розвинених комунікативних навичок, розуміння один одного та готовності допомагати. Ці компетенції є основою для досягнення стратегічних цілей компанії і формування колективної атмосфери, що спрямована на результат. Сучасні суспільні реалії, такі, як стрімка інформатизація, зміни технологій управління та організації праці, змінюють вимоги до професійних компетенцій. Постійне вдосконалення soft skills, робота з підвищенням рівня емоційного інтелекту сприяє працівникам сфери обслуговування досягати успіху в різних сферах життя, в тому числі бути затребуваним фахівцем в професійному плані та зазнавати меншого стресу, що є найкращою профілактикою як самого стресу, так і подолання його наслідків.

Література.

1. Гайдукевич К., Поліщук Л. Емоційний інтелект як важлива складова успіху в професійній діяльності івент-менеджера. Питання культурології. 2023. №, 78–88.

2. Гоулман Д. Емоційний інтелект. Переклад з англійської Гумецька С.-Л. – Харків: Vivat. 2018. 512 с.
3. Ковальова Д. В., Мачуліна І. І., Сорокіна Л. М., Неформальна педагогіка як ресурс формування «м'яких» навичок у здобувачів ЗВО. *Pedagogy and Psychology in the Modern World: the art of teaching and learning* : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Влоцлавек, Республіка Польща, 26–27 лютого 2021 р. Рига : Baltija Publishing, 2021. С. 64–67.
4. Кокун О. М., Клименко В. В., Корніяка О. М. Психофізіологічні закономірності життєстійкості фахівців соціономічних професій : монографія / за ред. О. М. Кокуна. Київ ; Львів : Видавець Вікторія Кундельська. 2021. 236 с.
5. Лосієвська О., Ляшко А. Неконфліктне середовище закладу вищої освіти як складова успішності організації освітнього простору. *Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом*. 2022. Психологія. №4 (53). С. 46-51. <https://doi.org/10.32689/maup.psych.2021.4.8>
6. Юр'єва, Н. В. Мотиваційні ресурси стресостійкості військовослужбовців підрозділів Національної гвардії України з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних : монографія / Н. В. Юр'єва, В. І. Пасічник. – Харків : НАНГУ. 2019. – 197 с.
7. Bethune S. Stress in America 2023. American Psychological Association. <https://www.apa.org/news/press/releases/stress/2023/collective-trauma-recovery>
8. Frank E. J. Soft skill development in a total enterprise simulation. *Business Education Innovation Journal*. December 2019. Vol. 11. P. 79–82.
9. Heim E. Coping and psychosocial adaptation. *J. Ment. Health Couns.* 1988. Vol. 10. P. 136–144. DOI:10.17323/1813-8918-2017-3-555-566.
10. Medaris A. 6 things researchers want you to know about stress. American Psychological Association. 2022. <https://www.apa.org/topics/stress/research-findings>
11. Teng E., Zhang L., Lou M. I Am talking but are you listening? The effects of challenge and hindrance stressors on effective communication. *Human Performance*. 2020. № 33(4). P. 241–257.

2.12. Психологічні основи формування резильєнтності медіатора у кризових умовах

*Лосієвська О. Г.
Мироненко С. М.*

Актуальність. В умовах війни, економічної нестабільності та інших криз, в Україні зростає кількість конфліктних ситуацій, які потребують ефективних механізмів їх вирішення. Медіація як метод альтернативного врегулювання спорів продовжує активно розвиватись як у світі, так і в Україні. При цьому, медіатор виступає ключовою фігурою у процесі врегулювання конфліктів та створення умов для конструктивного діалогу. Працюючи у кризових умовах, медіатори часто зіштовхуються з підвищеним емоційним навантаженням, стресом і необхідністю спрямовувати процеси вирішення конфліктів в умовах тиску та невизначеності.

Надзвичайно важливими постають питання розвитку та формування таких чинників, які б давали можливість медіаторам успішно адаптуватись до постійних змін, зберігаючи ефективність своєї діяльності, емоційну стабільність під час виконання своїх обов'язків, спроможність швидкого реагування на непередбачувані ситуації та самореалізацію. Резильєнтність визначається як здатність зберігати стабільний рівень психологічного та фізичного функціонування в несприятливих умовах і виходити з них без тривалих порушень. Це здатність особистості ефективно адаптуватися та відновлюватися після впливу стресу чи складних життєвих випробувань. Резильєнтність допомагає ефективно долати труднощі, використовуючи життєвий досвід, уміння аналізувати власні переживання та навчатися на прикладах інших. Спроможність медіатора проявляти резильєнтність є ключовим фактором для підтримання соціальної гармонії та вирішення конфліктів, особливо в кризових ситуаціях.

Мета – теоретично вивчити, експериментально дослідити психологічні основи формування резильєнтності медіатора у кризових умовах, розробити рекомендації щодо розвитку та підтримки резильєнтності медіаторів у професійній діяльності.

Результати досліджень. Хоча в Україні питання резильєнтності медіаторів у кризових ситуаціях досі не отримало достатньої уваги, загалом феномен резильєнтності активно досліджується в науковій спільноті. Поняття резильєнтності, яке спочатку виникло в інженерії та фізиці для опису матеріалів, здатних відновлюватись після деформації, в середині XX століття прийшло в психологію та інші наукові галузі, коли дослідники почали цікавитися, чому одні люди краще справляються з життєвими труднощами, ніж інші. Резильєнтність також є об'єктом активних міждисциплінарних досліджень.

Сучасні наукові підходи спрямовані на поглиблене вивчення резильєнтності та створення її теоретичної та емпіричної бази. Варто згадати таких дослідників як A. Masten, G. Bonanno, K.M. Connor, J. R. Davidson, D.S. Charney, G. Richardson, N. Garmezy та інших. Різні концептуальні підходи висвітлюють специфічні аспекти формування резильєнтності, акцентуючи увагу на тих чи інших факторах, що визначають її розвиток.

Концепція резильєнтності також цікавить українських дослідників (Н. Гусак, О. Коkun, Г. Лазос, С. Лукомська, А. Максименка, О. Хамініч, В. Чернобровкін, В. Чернобровкіна, О. Чиханцова та ін.).

Особливий інтерес до вивчення резильєнтності проявляють психологи, психотерапевти та представники допоміжних професій, оскільки розуміння механізмів позитивної психологічної адаптації в умовах стресу дозволяє фахівцям у сфері психічного здоров'я розробляти ефективні психотехнології. Такі методики сприяють профілактиці психологічних труднощів, підвищенню життєстійкості й стресостійкості, а також формуванню навичок самостійного подолання стресових обставин і життєвих труднощів.

Феномен резильєнтності на ранніх етапах здебільшого досліджувався в контексті психології розвитку, де акцент робився на здатності дітей та підлітків адаптуватися до несприятливих умов [10, 13].

У зарубіжній літературі важливий внесок у розвиток концепції резильєнтності зробили провідні дослідники, такі як George Bonanno та Ann S. Masten. Їхні роботи значно розширили розуміння цього феномену та показали, що

резильєнтність є універсальною здатністю, яка проявляється не лише на індивідуальному, але й на соціальному рівні [13].

George Bonanno підкреслював, що резильєнтність є поширеним і природним явищем. Він показав, що більшість людей здатні впоратися з екстремальними подіями, такими як втрата або травма, і при цьому зберігають психічне здоров'я та здатність до адаптації. Bonanno також ввів поняття «потенційна резильєнтність», що підкреслює здатність людей справлятися з труднощами навіть після великих потрясінь, наголошуючи, що ми часто недооцінюємо людську здатність до адаптації [5].

Ann S. Masten визначає резильєнтність як процес, який дозволяє людям зберігати стабільність психологічного й фізичного стану в складних обставинах і ефективно адаптуватися до змін та підкреслює, що резильєнтність – це не унікальна властивість, а «звичайна магія» (eng. «ordinary magic»), яка природно допомагає людям долати стресові ситуації [10].

M. W. Fraser та J. M. Jenson у своїй роботі (2006) визначають резильєнтність як здатність людини зберігати психічну рівновагу під час або після стресових подій. Вони підкреслюють, що ця здатність залежить від індивідуальних рис, таких як емоційна регуляція, і соціальної підтримки, зокрема сім'ї та громади [6].

На відміну від M. W. Fraser і J. M. Jenson, M. Margalit у своїй роботі (2003) визначає резильєнтність як динамічний процес, який призводить до адаптації в умовах значних потрясінь. M. Margalit підкреслює, що резильєнтність не є статичною властивістю, а постійно змінюється в залежності від ситуацій та контексту [8]. Цей підхід ставить акцент на тому, що резильєнтність формується через активну взаємодію між індивідом і його середовищем, де кожна нова ситуація сприяє розвитку нових стратегій адаптації [8].

S. M. Southwick & D. S. Charney (2014) розглядають резильєнтність як здатність протистояти життєвим кризам і травмам. Вони підкреслюють, що резильєнтність формується не лише через індивідуальні риси, але й через соціальні та культурні фактори, такі як підтримка близьких, участь у громадському житті та вплив культурних норм [14].

S. M. Southwick, G. A. Bonanno, Ann S. Masten, Catherine Panter-Brick and Rachel Yehuda у спільній роботі (2014) розглядали резильєнтність з міждисциплінарної перспективи. У цій праці дослідники підкреслюють, що резильєнтність є складним процесом, який залежить від біологічних, психологічних, соціальних та культурних чинників [13].

У своїй праці R. Kalisch, M. Müller & O. Tüscher (2014) автори пропонують нову концептуальну модель для вивчення нейробиологічних аспектів резильєнтності. Метою цього дослідження є вивчення нейронних механізмів, що забезпечують адаптацію до стресу та подолання його негативних наслідків [12].

У своїй праці A. Feder, E. J. Nestler та D. S. Charney (2009) досліджують резильєнтність з точки зору психобіології та молекулярної генетики, розкриваючи взаємозв'язок між генетичними факторами, гормональними реакціями на стрес і нейрохімічними процесами [11].

Дослідження John Fleming, Robert J. Ledogar (2008) зосереджене на вивченні резильєнтності серед корінних народів. Автори підкреслюють, що резильєнтність для корінних народів пов'язана не лише з індивідуальними рисами, але й з відновленням культурних ідентичностей, традицій та спільнот [7].

Catherine Panter-Brick та James Leckman підкреслюють, що резильєнтність є не лише індивідуальним процесом, але й значною мірою формується через взаємодію з соціальними та культурними чинниками, такими як колективна підтримка, традиції та культура [9].

В українській психологічній науці дослідники, як-от Е. Грішин, О. Кокун, Т. Мельничук та інші, також приділяють значну увагу вивченню цього феномену. Наприклад, роботи Д. Асонова та О. Хаустова (2019) сприяють уточненню термінології, диференціюючи резильєнс як процес і резильєнтність як рису особистості.

Н. Гусак та інші (2017) визначають резилієнтність як спроможність індивідів, сімей та колективів пристосовуватись та функціонувати, попри психологічні, соціальні, культурні чи фізичні труднощі. Вони зазначають, що резилієнтність у тлумаченні поняття і процесу супроводжує людину увесь його життєвий шлях [4].

Г. Лазос (2018) визначає резильєнтність як біо-психо-соціальне явище, що охоплює особистісні, міжособистісні та суспільні переживання і є результатом тривалих процесів розвитку. Залежно від предмета дослідження резильєнтність розглядається як особистісна характеристика або як процес, що знаходиться у постійної динаміці. Підкреслюється також її важлива роль у формуванні посттравматичного стресового зростання [3].

О. Кокун та інші (2022) визначають резильєнтність як здатність людини адаптуватися, відновлюватися та розвиватися в умовах ризику, викликів, небезпеки чи труднощів, а також вчитися й вдосконалюватися після невдач. Резильєнтність є дуже мобільна субстанція, яка знаходиться у постійному розвитку. Резильєнтність формується через взаємодію між особистістю, її досвідом і життєвим контекстом [1]. Нам імпонує такий підхід у дослідженні питання формування резильєнтності медіаторів у кризових умовах.

Для медіаторів, які постійно працюють у середовищі конфліктів та емоційної напруги, розвиток резильєнтності є не просто бажаним, а й необхідним фактором професійного успіху. Резильєнтність щодо медіаторів є також дуже мобільний процес, що дозволяє ефективно справлятися зі стресом, адаптуватися до змін та відновлюватися після складних ситуацій, що в свою чергу, сприяє їхньому професійному зростанню.

Фахівці підтримуючих професій, зокрема медіатори, стикаються з підвищеним рівнем відповідальності, що часто спричиняє стрес і тривожність. Для збереження психологічного благополуччя важливо усвідомлювати власні цінності, піклуватися про свої потреби, розвивати адаптивність і здатність швидко реагувати на зміни. Контроль навантаження, підтримання енергії та використання технік для її відновлення є ключовими елементами професійного становлення та формування резильєнтності медіатора.

Компетентність медіатора включає соціально-психологічні, конфліктологічні, комунікативні та когнітивні аспекти, а також знання у сфері людської поведінки й взаємодії. Медіаторська компетентність визначається як

поєднання професійних знань, умінь, навичок, цінностей та особистого досвіду, що забезпечують ефективну роботу у процесі медіації [2].

Аналіз наявної літератури свідчить, що резильєнтність медіатора ґрунтується на таких важливих чинниках: емоційній саморегуляції, стресостійкості, когнітивній гнучкості, емпатії, позитивному мисленні та орієнтації на вирішення, самоефективності, соціальній підтримці, толерантності до невизначеності.

Розвиток цих якостей допомагає медіаторам успішно працювати в складних ситуаціях і зберігати професійну ефективність. Важливо розуміти, що розвиток резильєнтності – це тривалий процес, який вимагає систематичної роботи над собою. Регулярна практика навичок, самоспостереження і підтримка з боку колег і близьких допоможуть медіаторам ефективно справлятися зі стресом і бути успішним фахівцем у професійній галузі.

Зазначене дослідження включало медіаторів, що працюють у кризових умовах, результати продемонстрували широкий спектр рівнів резильєнтності. Було виявлено, що значна частина респондентів має низький або середній рівень стійкості до стресу, що обґрунтовує необхідність подальшої підтримки.

Використання методик CD-RISC-25, опитувальника професійної життєстійкості О. Кокун та опитувальника емоційного інтелекту Н. Холла дозволило виявити основні фактори, які впливають на формування резильєнтності: здатність до емоційної регуляції, професійна життєстійкість та розвиток когнітивної гнучкості.

На основі отриманих даних було створено тренінгову програму «На шляху до стійкості: тренінг для підвищення резильєнтності медіаторів». Розробка тренінгу з формування резильєнтності медіаторів у кризових умовах спирається на інтеграцію декількох теоретичних підходів, що довели свою ефективність у психологічній підготовці. В основу програми були покладені когнітивно-поведінковий підхід, гуманістична психологія, концепція емоційного інтелекту, позитивна психологія, теорія самоефективності та принципи співчутливого ставлення до себе.

Кожен із цих підходів дозволяє вирішувати різні аспекти розвитку резильєнтності. Когнітивно-поведінковий підхід допомагає формувати адаптивні патерни мислення, що сприяють стабільності у стресових ситуаціях. Гуманістичний підхід спрямований на розвиток самосвідомості, емпатії та самореалізації. Позитивна психологія та теорія самоефективності надають медіаторам інструменти для розвитку оптимістичного мислення та управління власною поведінкою через саморегуляцію, а співчутливе ставлення до себе знижує ризик виникнення посттравматичних розладів і сприяє емоційній стійкості.

Підготовка тренінгу передбачає комплексний підхід, який поєднує активні методи навчання (лекції, обговорення, групові вправи), а також арт-терапевтичні та тілесно-орієнтовані техніки для покращення навичок саморегуляції. Такий підхід сприяє не лише розвитку професійних компетенцій медіаторів, але й формує навички емоційного контролю, необхідні для ефективного функціонування в умовах високого стресу. Основними темами тренінгу стали: розвиток емоційної саморегуляції, самомотивація, робота з переконаннями, запобігання професійному вигоранню та підтримка балансу між професійною та особистою сферами. Проведене тестування після участі в тренінгу показало статистично значуще покращення у рівнях резильєнтності, емоційного інтелекту та професійної життєстійкості учасників. Аналіз за допомогою t-критерію Ст'юдента підтвердив, що тренінгова програма сприяла значному підвищенню адаптивності медіаторів, зниженню рівня стресу та вигорання.

Висновки. На основі дослідження розроблено рекомендації щодо розвитку резильєнтності медіаторів, які можуть бути інтегровані у навчальні програми для підготовки фахівців. Ці рекомендації включають впровадження регулярних тренінгів, акцент на емоційну регуляцію, розвиток професійної життєстійкості, самомотивацію та турботу про себе. Дослідження підтвердило актуальність вивчення та формування резильєнтності медіаторів у кризових умовах. Розроблені теоретичні та практичні рекомендації можуть бути використані для підготовки та підтримки медіаторів, сприяючи підвищенню їхньої ефективності, емоційної стійкості та професійного благополуччя.

Література.

1. Кокун О. М., Мельничук Т. І. Резилієнс-довідник: практичний посібник. Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 2023. 25 с.
2. Кузів М., Компетентність медіатора та її особливості. [Електронний ресурс]:https://www.researchgate.net/publication/339614756_Kompetentnist_mediator_a_ta_ii_osoblivosti.
3. Лазос Г. П. Резильєнтність: концептуалізація понять, огляд сучасних досліджень. Актуальні проблеми психології. Т. 3: Консультативна психологія і психотерапія: збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Вінниця, 2018. Вип. 14. С. 26–64.
4. Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій: підхід резилієнс: навч.-метод. посіб. / Н. Гусак, В. Чернобровкіна, В. Чернобровкін, А. Максименко, С. Богданов, О. Бойко; за заг. ред. Н. Гусак.; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА. 2017. – 92 с.
5. Bonanno G. A. Loss, Trauma, and Human Resilience: Have We Underestimated the Human Capacity to Thrive After Extremely Aversive Events? / George Bonanno // American Psychologist. – 2004. – Vol. 59, Issue 1. – P. 20–28, <https://doi.org/10.1037/0003-066X.59.1.20>.
6. Jeffrey M. Jenson, Mark W. Fraser. Social Policy for Children and Families: A Risk and Resilience Perspective. https://books.google.com.ua/books?hl=en&lr=&id=sR6MBgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=info:c5bZpc3d_XcJ:scholar.google.com&ots=qURGQzdmqX&sig=tfhwjikSLeAPteAl162tGvoHhS0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
7. Ledogar R.J., Fleming J. Resilience, an Evolving Concept: A Review of Literature Relevant to Aboriginal Research. PMID: 20963184 PMCID: PMC2956753.
8. Margalit, M. (2003). Resilience Model Among Individuals with Learning Disabilities: Proximal and Distal Influences. Learning Disabilities Research & Practice, 18, 82–86. <https://doi.org/10.1111/1540-5826.00062>.

9. Mark Eggerman, Understanding Culture, Catherine Panter-Brick, Resilience, and Mental Health: The Production of Hope, 2011: DOI: 10.1007/978-1-4614-0586-3_29.
10. Masten, A. S. (2001). Ordinary magic: Resilience processes in development. *American Psychologist*, 56(3), 227–238. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.56.3.227>.
11. Psychobiology and Molecular Genetics of Resilience / Feder A., Nestler Eric J., Charney D. Review Article, Published: June 2009 *Nature Reviews Neuroscience* volume 10, pages 446–457. <https://www.nature.com/articles/nrn2649>.
12. Raffael Kalisch, Marianne B Müller, Oliver Tiescher, A conceptual framework for the neurobiological study of resilience: 2014. *Behavioral and Brain Sciences* №38. P.1–21. DOI: 10.1017/S0140525X1400082X, <https://www.cambridge.org/core/journals/behavioral-and-brain-sciences/article/abs/conceptual-framework-for-the-neurobiological-study-of-resilience/E07B7728571B9D3F82B1D44DDD134E>.
13. Resilience definitions, theory, and challenges: interdisciplinary perspectives / Steven M. Southwick, George A. Bonanno, Ann S. Masten, Catherine Panter-Brick, Rachel Yehuda. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/ejpt.v5.25338> та онлайн доступ <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4185134/pdf/EJPT-5-25338.pdf>.
14. Southwick, S. M., Charney, D. S. Resilience: The science of mastering life's greatest challenges. Cambridge University Press. 2012. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139013857>.

2.13. Психологічні особливості та рівень задоволеності працю персоналом організацій в ситуації невизначеності

Пріб Г.А.

Актуальність. Американський психолог А. Маслоу головною характеристикою особистості вважав потяг до самоактуалізації, самовираження, розкриття потенцій до творчості та любові, в основі яких лежить гуманістична потреба приносити людям добро. Потреба в самоактуалізації своїх можливостей і здібностей властива здоровій людині [1]. За А. Маслоу, ядро особистості утворюють гуманістичні потреби в добрі, моральності, доброзичливості, з якими народжується людина і які вона може реалізувати в певних умовах. Однак ці потреби в самоактуалізації задовольняються лише за умов задоволення інших потреб і передусім фізіологічних. Більшості ж людей не вдається досягти задоволення навіть нижчих потреб. Ієрархію потреб згідно з Маслоу, складають: фізіологічні потреби; потреби в безпеці; потреби в любові й прихильності; потреби у визнанні та оцінці; потреби в самоактуалізації – реалізації здібностей і талантів [1]. На думку А. Адлера, детермінантою розвитку особистості є потяг до вищості, прагнення влади, самоствердження.

У питанні задоволеності працею потрібно вивчити чинники, що впливають на їхню діяльність та на показники їхньої продуктивності. До таких чинників відноситься задоволеність персоналу організацій роботою, яка по-різному трактується дослідниками: як емоційний стан працівника, пов'язаний з його оцінками трудової діяльності і робочої ситуації в колективі; ступінь позитивного ставлення індивідуума до своєї роботи; ставлення до роботи, яке засноване на сприйнятті роботи і організаційного середовища.

Існує багато досліджень (В. Врум, Т. Кітвель, Е. Мейо, А. Муратар, Ф. Херцберг, В. Ядов), що розкривають суть задоволеності працею, її структури і різні чинники. Деякі вчені стверджують, що існує пряма залежність між задоволеністю і результативністю роботи, проте емпіричні дані свідчать про відсутність такої взаємозалежності [2, 3]. Дослідження вказують на переважання непрямих зв'язків

між результативністю роботи персоналу організацій та їх задоволеністю роботою: так, емпірично підтверджено, що високий рівень задоволеності роботою скорочує прогули і плинність кадрів [4]. Крім того [5, 6], працівники, які задоволені своєю роботою, більш схильні до виконання робіт, що виходять за межі їх безпосередніх обов'язків.

За теорією Герцберга, задоволеність працею залежить від двох типів характеристик, властивих даній роботі – мотиваційних (пов'язаних з підвищенням рівня людського капіталу) і гігієнічних (які визначаються вимогами працівників до умов праці) [2]. В основі теорії невідповідності потребам лежить гіпотеза про те, що задоволеність роботою є мірою відповідності між потребами працівника і одержуваною ним віддачею від роботи [6]. Інструментальна теорія ставить задоволеність роботою в залежність від відповідності між одержаними працівником винагородами і його очікуваннями [6], тоді, як згідно з теорією цінностей основним джерелом задоволеності працівників є можливість досягнення ними за допомогою роботи важливих для них цілей [7]. Незважаючи на концептуальні відмінності між сучасними теоріями задоволеності персоналом роботою, у всіх з них можна виділити дві основні категорії чинників, які впливають на задоволеність, а саме: організаційні характеристики та індивідуальні характеристики працівників. Таким чином, вивчення задоволеності працівників працею дає можливість одержати інформацію про ступінь відданості і лояльності працівників до організації.

Мета дослідження: виявити взаємозв'язок типу темпераменту із рівнем задоволеності особистості в ситуації невизначеності.

Матеріал та методи дослідження. У період 2022–2024 рр., досліджено 70 осіб у віці 30–50 рр. персоналу організацій з різними формами власності. Дослідження проведено з дотриманням принципів етики Американської психологічної асоціації [8], «Кодексу етики» протокол № 10 від 14.07.2016 [9], «Положення про академічну доброчесність Академії праці, соціальних відносин і туризму» протокол № 7 від 12.04.2018 р. [10]. Методи дослідження: «Методика

визначення задоволеності працею» А.В. Батрашева, «Опитувальник Г. Айзенка, «Тест Розанової».

Результати дослідження. Під ситуацією невизначеності у даному дослідженні розуміється ситуація війни з відносно невідомими змінними або тими, які швидко змінюються для прийняття рішення (неповна інформація). Це стосується усіх ситуацій «тут та зараз», а також планування майбутнього в усіх сферах соціального функціонування (побутова, трудова діяльність, відпочинку і т. ін.). Аналіз результатів дослідження задоволеності працею виявив, що за показником інтересу до роботи 66,6 % респондентів мають середній рівень зацікавленості у своїй роботі, 20,3 % високий рівень, 13,0 % низький рівень зацікавленості. Загалом 50,0 % респондентів показали оптимальні результати, що відповідають високому рівню зацікавленості (5-7 балів), а решта 50,0 % – неоптимальні.

За показником задоволеності досягненнями в роботі 70,4 % респондентів мали середній рівень, 18,5 % – високий рівень, 9,3 % – низький рівень. Загалом 39,0 % респондентів мали оптимальний рівень задоволеності своїми досягненнями, а 61 % – неоптимальний. Отже, основна кількість персоналу достатньо реалізувалися, проте майже 10,0 % респондентів незадоволені своїми досягненнями.

За задоволеністю стосунками у колективі 86,3 % виявили середній рівень, 11,1 % – низький рівень, 5,6 % – високий. Отже, 32,0 % респондентів задоволені психологічним мікрокліматом у колективі.

За показником задоволеності взаємососунків з керівництвом 72,3 % респондентів виявили середній рівень, 23,6 % – низький рівень, 3,7 % – високий рівень, що свідчить що однакові оптимальні результати за рівнем задоволеності стосунками зі співробітниками та з керівництвом мають 31,5 % респондентів.

Оцінка рівня домагань у професійній діяльності виявила, що 79,7 % респондентів мали середній рівень, 12,7 % – низький рівень і лише 7,4 % високий рівень. Загалом 43,0 % опитаних мали рівень домагань, що відповідають оптимально можливому, що свідчить що для підвищення рівня домагань потрібно ввести систему стимулювання. За показником переваги високого рівня оплати праці над

виконуваною роботою виявлено, що 72,2 % респондентів мали середній рівень, 14,9 % – високий рівень, 13 % – низький рівень. Оптимальні результати встановлено у 39,0 % респондентів, що свідчать про бажання працювати відповідно до своїх професійних інтересів. За рівнем задоволеності умовами праці 72,2 % респондентів оцінюють умови праці як середній рівень, 18,5 % – високий, 9,3 % – не задоволені умовами праці. Отже, 44,0 % респондентів мають оптимально позитивне відношення до умов праці на робочому місці. За показником професійної відповідальності 77,8 % респондентів мали середній рівень відповідальності, 11,2 % – високий рівень і 11,2 % – низький рівень. Загалом 43,0 респондентів проявляли позитивне відношення до необхідності сумлінно працювати, решта 57,0 % показали неоптимальний результат. Отже, незважаючи на відносно позитивні результати, персонал організацій має істотні побажання до керівництва.

Аналіз результатів дослідження за опитувальником Г. Айзенка за шкалою нейротизму середній рівень виявлено у 66,7 % респондентів, 9,3 % високий рівень, тобто є емоційно стабільними особистостями, завищених показників не виявлено.

За показником екстраверсії–інтроверсії 18,5 % респондентів отримали оцінку 12 – середнє значення. Екстравертами, які мали не менше 15 балів виявлено 24,1 % респондентів. Інтровертами, які мали не більше 9 балів, виявлено 3,7 % респондентів. Разом з тим, 16,7 % мають 13 балів, 14,8 % – 14 балів, 18,5 % – 10 балів, 3,7 % опитаних отримали 11 балів. Відповідно персонал організацій можна поділити за типами темпераменту таким чином: 50,0 % є холериками, 24,1 % – сангвініками, 20,4 % – меланхоліками, 5,6 % – флегматиками. Загальною характеристикою персоналу організацій за типами темпераменту можна надати наступну: особистість по холеричному типу є активними, оптимістичними, часто імпульсивними; по сангвінічному відзначалися стабільною нервовою системою, є сильними, врівноваженими, рухливими, відкритими для спілкування з іншими, здатні швидко приймати рішення в екстремальних ситуаціях; флегматичний тип це сильні, врівноважені, проте інертні, які стримані, надійні, розсудливі; меланхолічного типу, мають слабку нервову систему, швидко піддаються паніці, є досить замкненими особистостями. Отже, результати дослідження за

опитувальником Г. Айзенка відповідають психологічним особливостям персоналу організацій, де переважна кількість активних, стабільних особистостей є оптимальним показником для ефективної роботи організації.

Результати дослідження за тестом Розанової виявило, що переважна більшість респондентів незадоволені своєю професійною діяльністю. Загальні результати дослідження встановили, що 72,2 % респондентів незадоволені своєю професійною діяльністю: 40 балів мають 16,7 % , 44 бала – 16,7 %, 41 бал – 11,1 %, 45 балів – 7,4 %, 42 бала – 5,6 %, 46 балів – 5,6 %, 47 балів – 3,7 %. Лише 27,8 % опитаних задоволені своєю професійною діяльністю, бо мають показники, менші 40 балів: 39 балів – 11,1, 38 балів – 7,4 %, 37 балів – 7,4 %, 36 балів – 1,9 %. Щоб проаналізувати причини ситуації, яка склалася, потрібно з'ясувати критерії, які викликають найбільше незадоволення серед працівників. Отже, перше твердження опитувальника стосувалося задоволеності підприємством (організацією), де працюють респонденти. Відзначимо, що більшість персоналу задоволені своєю організацією – 42,6 %, цілком задоволені – 40,7 %, вкрай незадоволені – 11,1 %, незадоволені – 3,7 %, не зовсім задоволені – 1,9 %.

Наступний критерій – задоволеність фізичними умовами (спека, холод, шум і т. ін.). Так 27,8 % респондентів є вкрай незадоволені, проте 22,2 % порівну є цілком задоволеними і незадоволеними відповідно, 16,7 % не зовсім задоволені, а 11,1 % задоволені фізичними умовами праці. Опитані респонденти оцінили задоволеність роботою за шкалою від 1 до 5 балів. Результати свідчать про те, що 24,1 % незадоволені роботою, порівну 20,4 % цілком задоволені і не зовсім задоволені, задоволені роботою 18,5 % і вкрай незадоволені 16,7 % респондентів. Персонал організації також мав оцінити рівень задоволеності злагожденістю діяльності на роботі. Отже, 27,8 % цілком задоволені за цим параметром, 24,1 % вкрай незадоволені, порівну по 16,7 % не зовсім задоволені і незадоволені, 14,8 % задоволені. Тест охоплював також критерій задоволеності працівників стилем керівництва свого керівника. Відзначимо, що 24,1 % цілком задоволені стилем керівництва, порівну по 20,4 % задоволені, незадоволені та вкрай незадоволені, 14,8 % не зовсім задоволені. Наступне

твердження пов'язане з рівнем задоволеності працівників професійною компетентністю їхнього керівника. Дані дослідження свідчать про те, що 27,8 % цілком задоволені за цим критерієм, 24,1 % незадоволені, не зовсім задоволені 22,2 %, вкрай незадоволені 14,8 %, задоволені 11,1 %. Респондентів також оцінили рівень задоволеності заробітною платою, а саме 27,8 % незадоволені, порівну 18,5 % цілком задоволені, задоволені та вкрай незадоволені, а 16,7 % не зовсім задоволені. За критерієм задоволеності зарплатою в порівнянні з тим, скільки за таку ж роботу платять на інших підприємствах (організаціях), отримано наступні результати: 33,3 % незадоволені, 29,6 % навпаки задоволені, 16,7 % вкрай незадоволені, 11,1 % цілком задоволені, а 9,3 % не зовсім задоволені.

Кар'єрне зростання – важливий аспект у мотивації персоналу організацій до виконання обов'язків. За показником службового (професійного) зростання відзначимо, що 33,3 % не зовсім задоволені, 31,5 % незадоволені, порівну по 13 % цілком задоволені і задоволені, а 9,3 % вкрай незадоволені. Із попереднім показником пов'язаний наступний – задоволеність можливостями кар'єрного просування. Отже, 25,9 % незадоволені можливостями, 24,1 % задоволені, 22,2 % не зовсім задоволені, 14,8 % цілком задоволені, а 13 % вкрай незадоволені. Задоволеність тим, як працівник може використовувати свій досвід і здібності, є важливим показником також. Тому за результатами дослідження з'ясовано, що однакова кількість спеціалістів по 25,9 % одночасно задоволені та незадоволені, 22,2 % не зовсім задоволені, 20,4 % вкрай незадоволені, а лише 5,6 % цілком задоволені за цим показником.

Задоволеність тривалістю робочого дня виявила, що 27,8 % не зовсім задоволені, 25,9 % незадоволені, порівну по 16,7 % задоволені та вкрай незадоволені, а 13 % цілком задоволені. Останнє запитання стосувалося того, якою мірою задоволеність роботою вплинула б на пошуки іншої роботи з боку респондента. Отже, 29,6 % задоволені своєю роботою, порівну по 20,4 % цілком задоволені (не збираються змінювати роботу), не зовсім задоволені та незадоволені (готові шукати інше місце роботи), а 9,3 % вкрай незадоволені своєю роботою, тому

будуть шукати іншу роботу. Загалом можна відзначити оптимальні результати, що стосуються відношення респондентів до підприємства в цілому та до колективу, у якому вони працюють. Водночас присутня суттєва кількість неоптимальних результатів, що стосуються конкретних аспектів діяльності, умов праці та вимог до працівників. Серед причин загальної незадоволеності своєю професійною діяльністю у респондентів виокремлюються: задоволеність фізичними умовами, самим характером роботи, заробітною платою, можливостями службового (професійного) зростання, вимогами роботи до інтелекту, тривалістю робочого дня. Отже, для подолання цих проблем потрібне впровадження системи стимулювання працівників до виконання своєї роботи на найвищому рівні.

За кореляційним аналізом, метою якого було підтвердити або спростувати гіпотезу, що тип темпераменту персоналу організації є суттєвим чинником, що впливає на рівень задоволеності працею виявлено, що даний взаємозв'язок відсутній. У дослідженні було використано метод виявлення коефіцієнту рангової кореляції Спірмена. Оптимальні показники задоволеності працею, так само як і неоптимальні, спостерігаються у персоналу із кардинально різними типами темпераменту. Результати показали, що кореляція між типом темпераменту та рівнем задоволеності не досягає рівня статистичної значущості. Можна стверджувати, що великий об'єм неоптимальних результатів дослідження має причини, пов'язані із більш ширшим колом факторів, аніж темперамент особистості. Незадовільні результати дослідження мають за причину неналежні умови праці, недостатню мотивацію діяльності людей, низький рівень заохочення активної діяльності тощо. Ці фактори вимагають розгляду керівництва та мають бути враховані для покращення загального виробничого клімату.

Висновки. Показники інтересу до своєї роботи, задоволеності досягненнями в роботі, стосунками зі співробітниками, стосунками з керівництвом, рівнем домагань у професійній діяльності, надання переваги високому заробітку над виконуваною роботою, рівнем задоволеності умовами праці та професійною відповідальністю знаходяться на середньому рівні. Такі результати є загалом оптимальними з позиції стабільності та ефективності

робочого процесу організації. Виявлено, що 66,7 % респондентів мають середні показники за шкалою нейротизму, тобто вони є емоційно стабільними людьми. Завищених показників за цим параметром не виявлено. 24,1 % респондентів є екстравертами, а 3,7 % – інтровертами. Серед респондентів є представники усіх типів темпераменту: 50,0 % із них є холериками, 24,1 % – сангвініками, 20,4 % – меланхоліками, 5,6 % – флегматиками.

Встановлено, що 72,2 % респондентів незадоволені своєю професійною діяльністю і лише 27,8 % опитаних задоволені. Загалом рівень задоволеності своєю працею усього колективу свідчить, що респондентів не зовсім задоволені своєю роботою. Неоптимальні результати у цій методиці торкаються різних аспектів діяльності організацій. Найбільше нарікань з боку респондентів викликають фізичні умови, самий характер роботи, заробітна плата, можливості службового (професійного) зростання, тривалість робочого дня. Серед оптимальних результатів можна відзначити, що респондентів не мають жодних претензій до злагожденості, стилю керівництва, професійної компетентності їхнього керівника. Результати емпіричного дослідження взаємозв'язку типу темпераменту із рівнем задоволеності праці свідчать про те, що рівень взаємозв'язку між цими характеристиками лежить нижче рівня статистичної значущості, тому варто вважати, що рівень задоволеності працею впливає значно ширший комплекс факторів, аніж тільки темперамент. Проведене дослідження, яке стосувалося взаємозв'язку типу темпераменту із рівнем задоволеності праці персоналу, показало, що колектив на 50,0 % складається з холериків, на 24,1 % – із сангвініків, на 20,4 % – із меланхоліків, на 5,6 % – із флегматиків. Відповідно до цих результатів отримано, що переважна більшість працівників незадоволені своєю професійною діяльністю з багатьох причин, серед яких: фізичні умови праці, характер роботи, заробітна плата, недостатні можливості службового (професійного) зростання, тривалість робочого дня. Незважаючи на це, респонденти задоволені злагоженістю у колективі, стилем керівництва, професійною компетентністю їхнього керівника. Результати дослідження свідчать, що існують проблеми, які хвилюють персонал організацій.

Найважливішою складовою трудової мотивації є ступінь задоволеності місцем роботи і виконуваної роботою. Підвищення задоволеності працівників працею в організації призведе до підвищення їх продуктивності діяльності, а висока задоволеність покращує ставлення до роботи і до організації в цілому.

Література.

1. Особистість у сучасній психології. Психологічна характеристика. <http://ru.osvita.ua/vnz/reports/psychology/10026/>.
2. Herzberg F. The motivation to work. New York / F. Herzberg, B. Mausner, S. Snyderman // John Wiley and Sons. 1959. № 5. P. 7–18.
3. Ting Y. Determinants of job satisfaction of federal government employees / Y. Ting // Public Personnel Management. 1997. № 26 (3). P. 46–57.
4. Vroom V. H. Work and Motivation / V. H. Vroom. N. Y.: Wiley. 1964. 453 p.
5. Locke E. A. The Nature and Causes of Job Satisfaction / E.A. Locke // Handbook of Industrial and Organisational Psychology. Rand-McNally, 1976. P. 1297–1349.
6. Organ D. W. A restatement of the satisfaction-performance hypothesis / D. W. Organ // Journal of Management. 1988. № 14(4). P. 547 – 557.
7. Iaffaldano M. T. Job satisfaction and job performance: A meta-analysis / M. T. Iaffaldano, P. M. Muchinsky // Psychological Bulletin. 1985. – № 97(2). P.251–273.
8. Ethical principles of psychologists and code of conduct. American Psychological Association. Effective June 1, 2003 (as amended 2010, 2016). Effective January 1, 2017. Available from: <https://www.apa.org/ethics/code/ethics-code-2017.pdf>
9. «Code of Ethics». 2016. Protocol 10, Available from: <https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/KodeksEtyky.pdf>
10. Regulations on academic integrity (2018). Academy of Labour Social Relations and Tourism, protocol 7. Available from: <https://drive.google.com/file/d/1roDEHIZC9MERTAjCeip41Bgp249Ree38/view?usp=sharing>

2.14. Аналіз психологічної готовності молоді до сімейного життя

*Пріб Г. А.
Яковенко О. С.*

Актуальність. Сім'я є важливою соціальною структурою, що складає основу суспільства. Утворення та функціонування сім'ї є необхідними для продовження існування соціуму та запорукою його процвітання. У сучасному світі сімейні цінності та уявлення про шлюб швидко і неперервно змінюються, що робить необхідним регулярні дослідження рівня психологічної готовності молоді до сімейного життя. Від нього залежить не лише особисте щастя молодих людей, а й стабільність суспільства в цілому.

Але гармонійне сімейне життя потребує високого рівня емоційної зрілості, взаєморозуміння та вміння вирішувати конфлікти. В умовах швидких змін у суспільстві, таких як зміни в ролях чоловіка та жінки, важливими є також господарсько-економічні навички і вміння планувати сімейне життя. Крім того, молодь стикається з новими викликами, серед яких економічні труднощі, відсутність стабільної роботи та доступного житла, що впливає на їх позицію щодо створення сім'ї. Психологічна готовність до сімейних відносин включає в себе не лише готовність до партнерства, а й здатність до виховання дітей, що є важливою частиною добробуту родини та її майбутнього. Тому дослідження цього питання є необхідним для розробки програм підтримки молоді, що мають на меті підвищення психологічної готовності до створення та забезпечення сім'ї.

В Україні та світі спостерігається криза молодих сімей, викликана низкою політичних та соціальних чинників. Велике число розлучень, спотворення сімейної структури та зсув сталих парадигм свідчать про низьку готовність молоді до сімейного життя і зумовлюють необхідність та актуальність дослідження.

Мета. Здійснити аналіз та сформувані уявлення про причини і наслідки соціальних процесів початку сімейного життя молоддю.

Результати дослідження. Варто почати з визначення поняття «сім'ї». Одне з них наводить О. А. Столярчук[1]: Сім'я –група людей, об'єднаних родинними

зв'язками, що мають спільний побут. Вона обмежена ззовні впливом соціальним оточенням, а зсередини – міжособистісними взаємодіями. Таким чином відносини в сім'ї формуються під дією відповідних категорій чинників [2]. Зовнішніми чинниками вважаються матеріальні і психологічні умови що існують в суспільстві (економічна ситуація, суспільні норми та звичаї). Внутрішні чинники є наслідком взаємодій між членами родини, і впливають на їх психологічний стан.

Для сім'ї на відміну від інших колективів характерні неофіційні зв'язки, відсутність формальності, та загострене сприйняття подій, що відбуваються за участі членів родини. Також у сім'ї можуть існувати власні специфічні норми та відносини, сформовані в процесі її утворення та розвитку.

Відносини в сім'ї поділяються на три типи: домінування(за принципом панування-підкорення), відповідальність (зв'язок через обов'язки) та афіліація (сентиментальна прив'язаність) [3].

При домінуванні зазвичай одна особа приймає роль лідера, що визначає напрямки діяльності членів родини, керує побутом та відповідає за прийняття рішень. Вона також формує правила поведінки у групі та корегує відносини між її членами. Тим не менш при домінуванні однієї особи над іншими останніми втрачається своя автономія, що часто призводить до зниження задоволеності сімейним станом. Це може призвести до дестабілізації сімейних відносин, кризи і, як наслідок, розпаду сім'ї [4].

При зв'язках, породжених відповідальністю, поведінка членів родини визначається орієнтованістю (всередину або назовні) та спрямуванням (конструктивне чи деструктивне).

Конструктивна відповідальність, що орієнтована назовні проявляється у вигляді залученості, цікавості, плідній конкуренції. Деструктивна зовнішньоорієнтована відповідальність призводить до дискримінації та психологічного тиску. Конструктивна внутрішня відповідальність означає відповідальність перед собою за свої власні рішення та їх наслідки незалежно від суспільних поглядів на вчинені дії. Аналогічно деструктивна внутрішня

відповідальність є причиною самоушкодження, саботажу, халатності та безвідповідальності, разом з іншими негативними явищами та процесами.

Рівень відповідальності є пропорційним до вираженості почуття контролю за перебігом ситуації та її результатом, а також за долею інших людей. Будь-який з членів родини може бути носієм відповідальності за будь-якого іншого учасника (наприклад партнера чи дітей), або за сім'ю в цілому. В останньому випадку мається на увазі відповідальність за всі теперішні, майбутні чи минулі події у сім'ї, емоційний стан та добробут її членів. Цю відповідальність особа несе перед собою, сім'єю, та перед суспільством, що її оточує.

Іншим видом відносин у сім'ї є афіліація, тобто психологічна наближеність однієї особи до іншої. Такі зв'язки формуються під тиском людської потреби у прив'язаності, соціалізації, відчутті приналежності. Ознаками афіліації є намагання розділити свої емоції з іншими, підтримувати їх, співпрацювати та спілкуватися, розвиватися та рости. Тим не менш, в такому випадку можливі не лише позитивні прояви, як вищезазначені, але й негативні (боязнь відторгнення, переживання при відсутності контакту, співзалежність, тощо). Роллю афіліації є підтримка тих звичних і базових взаємодій, що дозволяють отримати задоволення, взаємну користь та вигоду.

Структуру сім'ї утворюють сукупно зв'язки і відносини між її членами. До яких належать зокрема родинні, моральні, владні, духовні та інші. Таке визначення було сформульоване Ейдемільлером Є.Г. та Юстицькісом В.В. (2001р) [5]. Вони вважають, що найбільш стабільною буде та сім'я, в якій відповідальність та владу сконцентровано в руках однієї особи, яка поділяє симпатії інших членів родини.

Щоб якісно описати структуру сім'ї прийнято використовувати параметри, що оцінюють взаємодію між елементами її структури. До них відносяться: згуртованість, ієрархія, гнучкість [6].

Згуртованість характеризує психологічну близькість членів сім'ї. Її використовують з метою оцінки граничної інтенсивності відносин, за якої члени сім'ї ще сприйматимуть одне одного як частину колективу. Існує чотири рівні цього показника:

Роз'єднаний – у сім'ї панує відчуження та відстороненість.

Розділений – означає наявність певної емоційної дистанції між членами сім'ї.

Пов'язаний – присутня лояльність у взаєминах, взаємоповага та інтерес.

Заплутаний – згуртованість надмірно висока, члени сім'ї втрачають автономію та особистісність.

Серед них найбільш збалансованому та оптимальному функціонуванню сім'ї відповідають розділений і пов'язаний рівні згуртованості.

Ієрархія оцінює відносини домінування-підпорядкування в сім'ї і визначається як міра впливу певного члена сім'ї на інших, його здатності керувати рішеннями та діями цих осіб. За наявності змін рольової структури сім'ї та правил всередині неї ієрархія відображатиме їх характер та ступінь

Одним з найбільш розповсюджених порушень структури сім'ї цією характеристикою вважається *ієрархічна інверсія*. Прикладом може слугувати така ситуація, за якої дитина має більший вплив на батьків, ніж кожен з них один на одного та на дитину. Таке часто трапляється, коли у вихованні дітей частіше беруть участь попередні покоління (бабусі та дідусі) чи сторонні люди, а не безпосередньо батьки. Причиною може слугувати наявність:

- союзу між дитиною та одним з батьків іншого;
- залежності будь-якого типу у батьків;
- недієздатності батьків внаслідок хвороби або інших причин;
- систематичних дій дитини, внаслідок яких вона отримала надмірний

вплив та здатність контролювати сімейні відносини.

Гнучкість виражає кількість адаптивних ресурсів сім'ї та її здатності пристосовуватися до мінливості умов життя, в той же час зберігаючи власну структуру та функціонування стабільними. Сім'ї поділяють на гнучкі та інертні (консервативні).

Гнучка Сім'я здатна швидко переорієнтовуватися, якщо того вимагає життя. Інертні сім'ї адаптуються до нових життєвих умов із затримкою, в результаті складного і тривалого процесу, або не адаптуються взагалі. Для них характерні обмежене спілкування, нав'язування рішень, тощо.

Виділяють також *хаотичні* сім'ї, в яких влада прийняття рішень переходить з рук у руки або є частковою. В такому випадку характерною є імпульсивна і непродумана поведінка, а також відсутність відповідальності.

Діяльність сім'ї визначається розподілом *ролей* та *функцій* між її членами.

Сімейними ролями називають сфери відповідальності та авторитету, що зумовлюють права і обов'язки члена родини, його позицію у сім'ї та соціумі. За родинним статусом ролі поділяються на:

- партнерські (між чоловіком та дружиною);
- батьківська-опікунські;
- братерські, сестринські;
- родичів різного ступеня спорідненості.

За місцем у побуті виділяють ролі [3]:

- господаря, що керує побутом;
- годувальника, що утримує сім'ю;
- вихователя, що забезпечує розвиток дітей;
- організатора, що ініціює діяльність та дозволяє

Цей розподіл є умовним, адже ролі можуть виконувати кілька осіб одночасно, або одна особа може займати дві чи більше ролі.

Функції членів родини визначаються їх потребами і спрямовані на їх задоволення. Традиційними сімейними функціями є : господарсько-економічна, комунікативна, рекреативна, сексуальна, репродуктивна, освітньо-виховна, регенеративна [1; 2; 3].

Господарсько-економічна функція реалізується особою, що забезпечує сім'ю харчуванням, домашнім майном, одягом та взуттям. Вона доглядає житло, забезпечує затишок, організовує побут, тощо. Найбільше значення ця роль має для новоутворених молодих сімей, адже саме спільний побут формує внутрішньо-сімейні відносини та визначає області можливих конфліктів.

Комунікативна функція полягає у реалізації зручного та дієвого методу спілкування між членами сім'ї, та між сім'єю і зовнішнім світом – рідними, друзями, тощо.

Рекреативна функція покладається на особу, що має піклуватися про відпочинок членів сім'ї, цікаве дозвілля, а також підтримувати їх фізичне і психологічне здоров'я.

Сексуальна функція відповідає за регулювання та задоволення сексуальних потреб одне одного. Вона може виконуватися одночасно або поперемінно обома учасниками шлюбу. Втілення цієї функції полягає у забезпеченні регулярних цікавих та взаємних інтимних взаємодій, а також увазі до сексуального здоров'я партнерів.

Репродуктивна функція є запорукою продовження роду та зміцнення подружньої любові, водночас вона відображає ставлення подружжя до питання народження дітей. У сучасних умовах це питання часто набуває суперечливого характеру: з одного боку, діти сприймаються як елемент стабільності сім'ї, а з іншого – як джерело серйозних проблем, починаючи від складних умов для їхнього виховання і закінчуючи негативними змінами в подружніх стосунках. Тому в сучасному контексті репродуктивна функція охоплює також управління процесом дітонародження.

Освітньо-виховна функція спрямована на реалізацію потреб батьків у вихованні дітей, налагодженні зв'язків з ними та самовираженні через процес їхнього розвитку. Вона включає первинну соціалізацію дітей у сім'ї в ранньому віці, а також підтримку їхнього розвитку через навчання в інших соціальних групах та установах, таких як дитсадок, школа і університет.

Регенеративна функція охоплює збереження статусу, репутації, майна та соціального становища родини. Окрім того, вона включає збереження та передачу родинних цінностей і реліквій, від ювелірних виробів до старовинних альбомів з фотографіями.

Зміни в структурі сім'ї ускладнюють виконання її функцій, оскільки порушення взаємин між її членами стає перепорою для задоволення їхніх потреб. Прикладом може бути уникання одним з членів сім'ї виконання побутових і господарських обов'язків. Через це у сферах відповідальності виникає дисбаланс, що призводить до дестабілізації сім'ї, оскільки додаткове навантаження

перешкоджає задоволенню потреб того члена сім'ї, який його отримає. Визначення того, що необхідно вважати нормальною структурою сім'ї, а що порушенням є центральною проблемою сучасної сімейної психології.

Велика кількість досліджень присвячена проблемам молоді сім'ї та її формуванню [1; 7; 8]. Проте більшість із них зосереджені на соціологічних та демографічних аспектах. Психологічні механізми розвитку сімейної ідентичності, реакції на подружні кризи, функціонально-рольова поведінка молодих партнерів та інші подібні питання розглядаються в наукових працях значно рідше. Тому доцільним буде провести аналіз сучасних тенденцій.

За останні роки особистісні характеристики молоді зазнали значних змін, зокрема у таких аспектах, як соціальний статус, готовність до незалежного життя, рівень відповідальності тощо. Соціологічні дослідження показали, що значна частина шлюбів укладається в молодому віці: наразі близько 2/3 усіх шлюбів реєструються до 24 років. Шлюб у такому віці може вказувати, зокрема, на соціальну незрілість партнерів.

Багато досліджень звертають увагу на проблему інфантилізму серед сучасної молоді [9]. Зниження віку пар, що вступають в шлюб та пізнє залучення молоді до трудової діяльності призвели до того, що період навчання майже збігся з етапом створення сім'ї. У таких родинах процес досягнення самостійності молодих партнерів ще не завершений: особистість продовжує розвиватися, але при цьому економічна та соціальна незалежність залишаються недосягнутими.

У процесі розвитку сім'ї змінюється як ієрархія, так і зміст її функцій. Для молоді родини особливе значення має експресивна функція, що спричиняє зміщення акцентів у цінностях подружнього життя. Пріоритетами стають підтримка, відкритість до допомоги, чуйність та здатність розуміти почуття іншого.

Хоча психологічні та емоційні аспекти стосунків молодих партнерів мають велике значення, не менш важливим є економічний аспект, що впливає на стабільність і добробут родини.

Крім того, молоді пари все частіше обирають жити окремо від своїх батьків. За даними соціологічних опитувань лише 9 % респондентів висловили бажання

мешкати разом з родичами, тоді як більшість чоловіків (74 %) і жінок (78 %) виступають рішуче проти цього. Причиною цього є те, що втручання з боку батьків часто стає причиною розпаду шлюбу. З іншого боку, процес відокремлення подружжя дозволяє створити самотійну родину, що є більш стабільною.

У разі спільного проживання відносини молодих пар з родинами їхніх батьків зазнають суттєвих змін. Більше 50 % молодих родин звертаються до своїх батьків за підтримкою. Проте, якщо кілька років тому взаємини базувалися на беззаперечному підпорядкуванні старшим, то нині вони спираються на взаємодію та співпрацю. Однак деякі традиційні форми стосунків із родиною все ще зберігаються, хоча вони значно змінилися за своєю суттю.

Зміни відбулися й у структурі обов'язків та ролей молодих партнерів. Жінки все частіше демонструють більш прогресивний підхід у питанні ролей. Вони вимагають рівності у правах та обов'язках всередині родини та активно беруть участь у фінансовому забезпеченні. Чоловік може підтримувати таку позицію або відстоювати традиційні погляди, що інколи призводить до зростання напруги в родині та навіть її розпаду.

В той же час, попри зростання активності жінок в стосунках, спостерігається зменшення залученості чоловіків до домашніх обов'язків на початкових етапах шлюбу, що призводить до збільшення навантаження на жінок. При цьому, зазвичай чим більший дисбаланс у розподілі побутових задач, тим менше подружжя задоволене своїм шлюбом.

Перехід до більш демократичної структури сім'ї є необхідним та безумовно позитивним етапом в її розвитку. Однак в процесі цих змін через відсутність чітких соціальних норм можуть виникнути небажані наслідки, наприклад [10]:

- домінування жінки у відносинах попри неготовність до відповідальності;
- безвідповідальна поведінка чоловіка;
- уникання чоловіками участі у виконанні домашніх обов'язків;
- схильність жінки до маніпуляції;
- відстороненість чоловіка від виховання дітей;

- погіршення відносин з сторонніми особами, що мають традиційні погляди.

З точки зору психології готовність до сімейного життя визначається сумарних впливом безлічі внутрішніх і зовнішніх факторів. та поділяється на чотири взаємопов'язані компоненти [3; 7]:

Мотиваційно-ціннісна складова вказує на наявність у партнерів сильного, усвідомленого бажання створити сім'ю. Вона проявляється через особисті установки, переконання, життєві принципи, моральні норми та життєву орієнтацію. Цей компонент є добре розвиненим, коли людина має високий рівень самопізнання, стійкі життєві орієнтири, працює над розвитком своєї особистості та розуміє основні мотиви поведінки у сімейних стосунках.

Пізнавальний аспект передбачає наявність у партнерів комплексу знань, необхідних для ведення спільного господарства. Також сюди входять знання, які дозволяють адекватно оцінювати свою роль у родині. Цей аспект розглядається як добре розвинений, якщо майбутній член родини:

- здатен аналізувати свою поведінку та зрозуміти, що викликає його емоційні реакції;
- має можливість оцінити, як його сприймають інші люди, і побачити себе з боку;
- розпізнає ситуації, які призводять до суперечок та конфліктів;
- може з'ясувати приховані мотиви своїх почуттів в складних моментах;
- враховує соціальні стандарти та правила під час спілкування з іншими людьми;
- розуміє особливості розвитку особистих зв'язків, сімейних ролей і взаємодій.

Емоційно-регулятивний компонент відповідає за здатність особи до самостійної оцінки власної поведінки й подальшої саморегуляції. Велику роль при цьому грає усвідомленість в процесі дій, а не після їх завершення. Важливою навичкою є контроль за гнівом, стриманість у конфлікті.

Цей компонент вважається добре розвинутим, якщо майбутній сім'янин:

- відзначається відкритістю та об'єктивністю у ставленні до себе і до інших людей.
- здатний усвідомлювати та чітко виражати власні емоції через спілкування.
- вміє адаптувати свою поведінку залежно від обставин.
- враховує думки та потреби оточуючих.
- турбується про своє самопочуття та якість взаємин з людьми іншої статі.

Поведінковий аспект охоплює соціально-психологічні навички, пов'язані з особливостями гендерних та сексуальних ролей, а також специфікою самоорганізації життєдіяльності. Ознаками добре розвинутого поведінкового аспекту є:

- здатність легко і природньо спілкуватися на складні та особисті теми;
- відповідальність за власні вчинки перед суспільством;
- прагнення до співробітництва і конструктивних взаємодій;
- гнучкість поведінки, ситуативна обізнаність;
- адекватність суджень і висновків, увага до обох сторін конфлікту.

Підготовка до сімейного життя включає й інші важливі аспекти, такі як соціальна адаптація, розвиток етичних і психологічних рис, правова грамотність, побутова та фінансова грамотність, а також емоційна і сексуальна зрілість. Всі ці складові взаємно доповнюють одна одну, сприяючи досягненню головної мети – формуванню гармонійних і здорових стосунків у родині.

Дещо іншою є готовність особистості до шлюбу і сімейного життя на суспільному рівні. У цьому контексті вона формується через ставлення суспільства до індивіда, зокрема через соціальні норми та очікування.

Соціальна готовність передбачає, що майбутні подружжя є повноцінними та рівноправними членами суспільства, здатними виконувати свої соціальні функції та зобов'язання. Вони розуміють правові аспекти подружжя, готові нести відповідальність за себе, партнера та дітей, а також забезпечити матеріальне благополуччя родини.

Однак критерії готовності до сімейного життя на рівні суспільства та особистості часто перетинаються, а інколи й повністю збігаються.

Попри всі зміни в ціннісних орієнтаціях молоді, що часто ведуть до більш практичного або скептичного сприйняття реальності, навіть за умов дерегульованих демократичних поглядів на шлюб і сім'ю та ліберального ставлення до міжстатевих відносин, створення родини залишається важливою складовою частиною щасливого життя для молодих людей.

Висновки. Сімейне життя включає в себе побут, роботу, дозвілля та особисті стосунки кількох незалежних осіб. У процесі цього природно виникають різноманітні взаємодії, які визначають ролі, права, обов'язки та емоційні зв'язки між членами родини. В результаті формується складна система, яку молода сім'я повинна налаштувати та регулювати самостійно. Для цього необхідні не лише знання та вміння, а й здатність до адаптації та вирішення конфліктів, емоційна зрілість, широкий спектр моральних якостей, тощо. Роль психолога полягає у тому, щоб шляхом інформування, рекомендацій та настанов допомогти особі набутти всіх цих рис і розвинути їх.

Для успішного та ефективного виконання психологом цих функцій необхідно детально описати поняття та явища, що зустрічаються в роботі з молодими сім'ями. Розуміння термінів, характеристик структури та особливостей функціонування молодої сім'ї, а також процесів, пов'язаних з адаптацією партнерів в перші роки спільного проживання, дає змогу робити обґрунтовані висновки про рівень підготовленості досліджуваної групи до сімейного життя. Разом з тим, стрімкі зміни суспільних та економічних умов життя сучасних сімей ведуть до суттєвих відмінностей в реаліях кожної окремої родини, їх потребах та індивідуальних характеристиках. Тому неможливо створити універсальні рекомендації та методики підготовки, які підійшли б кожному. При створенні сім'ї молоді не може покладатися на попередній чи запозичений досвід, оскільки за обмежений час складно прийняти обґрунтовані та виважені рішення з усіх важливих питань. Саме тому молоді люди мають формувати власну систему переконань і уявлень стосовно сімейного життя безпосередньо у процесі адаптації до нього. Для цього їм потрібно

регулярно і цілеспрямовано поглиблювати знання з питань психології міжособистісних стосунків і сексуальності, конфліктології, виховання дітей, та інших аспектів сімейної діяльності.

Література.

1. Психологія сучасної сім'ї : навч.посіб. / О. А. Столярчук. Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2015. 136 с.
2. Психологія сім'ї та шлюбу: таблиці, схеми, коментарі : навчально-наочний підручник / за заг. ред. О. М. Цільмак. Київ : Видавництво Ліра-К. 2020. 266 с.
3. Федоренко Р. П. Психологія сім'ї : навч. посіб. / Раїса Петрівна Федоренко. Луцьк : Вежа-Друк. 2015. 364 с.
4. Максимова Н.Ю. Сімейне консультування: Навч. посіб. К.: ДП „Видавничий дім Персонал». 2011. 304 с.
5. Психологічна енциклопедія / Автор-упорядник О.М. Степанов. К.: Академвидав, 2006. 424 с.
6. Помиткіна Л. В., Злагодух В. В., Хімченко Н. С. , Погорільська Н. І. Психологія сім'ї. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К: Вид-во Нац. авіац. ун-ту. «НАУ-друк». 2010. 270с.
7. Мушкевич М. І., Федоренко Р. П., Магдисюк Л. І. Психологія молодшої сім'ї : монографія / Мирослава Іванівна Мушкевич, Раїса Петрівна Федоренко, Тамара Іванівна Дучимінська, Людмила Іванівна Магдисюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 235 с.
8. Вербець В. В. Соціологія : навч. посіб. / В. В. Вербець, О. А. Субот, Т. А. Христюк. К. : КОНДОР. 2009. – 550 с.
9. Сім'я та сімейні відносини в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку. – К.: ТОВ «Основа-Принт». 2009. 248 с.
10. Кравець В.П. Підготовка учнівської молоді до сімейного життя в Україні ХХІ століття: стан, тенденції, шляхи вдосконалення : монографія. / В.П. Кравець. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка. 2020. 584 с.

2.15. Вплив війни на психічне здоров'я працівників адвокатури

Скиданова Ю. О.

Актуальність. Війна та збройні конфлікти завжди залишають глибокий слід на людському житті, впливаючи не тільки на фізичний стан, але й на психічне здоров'я. В умовах збройного конфлікту значні психоемоційні стреси переживають не тільки військовослужбовці, але й цивільні особи, серед яких важливу роль відіграють працівники адвокатури. Юристи стають свідками численних правопорушень, порушень прав людини та інших злочинів, що обтяжує їх психічний стан та вимагає підвищеної емоційної витривалості. У воєнний час адвокати опиняються під тиском не лише через свою професійну діяльність, а й через складні моральні та етичні дилеми, пов'язані з війною. Вони часто надають правову допомогу жертвам війни, включаючи біженців, постраждалих від насильства, військовополонених та інших осіб, які потребують захисту своїх прав. Це може призводити до хронічного стресу, емоційного виснаження, тривоги, депресії та інших психічних розладів. Наразі, високий рівень відповідальності, інтенсивні темпи роботи і висока ціна помилок, якщо такі трапляються, особиста незахищеність та інші морально-психологічні фактори негативно впливають на здоров'я працівників судової системи та вимагають від працівників адвокатури професійної стресостійкості [2].

Мета. Дослідити психічне здоров'я працівників адвокатури як складову їх професійної діяльності та особистого благополуччя.

Результати дослідження. Дослідження впливу війни на психічне здоров'я працівників адвокатури є важливою та актуальною темою, яка привертає увагу науковців у всьому світі. Зокрема, А. Бекк, О. Горбунова, І. Лебедєв, С. Матвієнко, Л. Пилипенко, Р. Стер та інші досліджували різні аспекти психологічної підтримки, які необхідні працівникам адвокатури під час війни; основні методи когнітивної терапії, які можуть бути застосовані для лікування депресії у працівників адвокатури, які перебувають у стані постійного стресу через військові дії; загальні психічні наслідки війни для цивільних осіб, включаючи працівників адвокатури;

різні психічні розлади, які можуть виникати у працівників адвокатури через постійний контакт із жертвами війни та збройних конфліктів.

Досліджуючи тему психічного здоров'я, неможливо оминати поняття стресу. Адже його розуміння розкриває низку відповідей на різні питання профілактики вигорання. Слід зазначити, що стрес це неспецифічна реакція організму у відповідь на дуже сильну дію/подразник зовні, яка перевищує норму, а також відповідна реакція нервової системи. Це фізіологічна та психологічна реакція, яка є природною та адаптивною, і допомагає адекватно відповідати на дію подразників, орієнтуватись в складних обставинах та ефективно вирішувати життєві виклики. Стрес – це неспецифічна захисна реакція організму у відповідь на дуже сильну дію (подразник) зовні, яка перевищує норму, а також відповідна реакція нервової системи. Під стресом Г. Сельє (1979 р.) розумів систему реакцій організму у відповідь на будь-яку вимогу до нього, яка спрямована на створення адаптації чи пристосування організму до труднощів [8].

У класичних дослідженнях Г. Сельє, а пізніше – Р. Лозаруса, Р. Розенмана, М. Фрідмана було виявлено, що тривалий вплив стресу спричиняє такі наслідки, як зниження загальної психічної стійкості організму, поява відчуття незадоволення результатами своєї діяльності, тенденція до відмови від виконання завдань у ситуаціях підвищених вимог, невдач та поразок [9, с 294].

Біологічною функцією стресу є адаптація. Природою закладено так, що стрес забезпечує захист організму від загрозливих та руйнівних впливів, як психічних так і фізичних. Виникнення стресу вказує на те, що людина включилася в певну діяльність, спрямовану на протидію небезпечним для неї впливам. При цьому в організмі розвивається функціональний стан, який характеризується комплексом реакцій нервової, гормональної та інших систем організму. Таким чином, стрес це нормальна реакція здорової людини. Але здатність до адаптації не є безмежною. І в тому випадку коли інтенсивність впливу та його тривалість перевищують функціональні можливості протидії на перевагу позитивному стресу (еустресу), виникає дистрес.

Досліджуючи професійний стрес, ми визначаємо його як результат взаємодії людини з соціальним середовищем, як клас станів, що відображає механізм регуляції діяльності нервової системи та як індивідуально пристосувальну реакцію людини на ускладнення ситуації.

До джерел професійного стресу належать особистісні характеристики конкретної людини. Науковці розглядають зокрема, індивідуальну конституцію нервової системи, індивідуальні особливості особистості. Далі йде професійне навантаження, соціальне оточення, синдром психічного знесилання, виснаження, складність завдання, фактор часу.

Поряд з дефініцією «професійного стресу» у психологічній науці досліджують і такі поняття як емоційне і професійне вигорання.

Герберт Фрейденберг (1974 р.) вперше звернув увагу на феномен, який він описав, як виснаження, або зношення що відбувається з людиною внаслідок завищення вимог до власних ресурсів, або сил.

Одна з найбільш розповсюджених на теперішній час теорій, які вивчають емоційне вигорання є багатофакторна теорія. Ця теорія була розроблена в 1970-х роках американськими дослідниками К. Маслач і С. Джексон. Вони пробували знайти в явищі емоційного вигорання структури, які б дозволили більш глибоко дослідити даний феномен і якісно діагностувати його наявність у спеціалістів, в результаті чого К. Маслач і Джексон стали авторами опитувальників, адаптованих під різні професійні спільноти. К. Маслач надає своє визначення емоційного вигорання: «вигорання-тривала відповідь (реакція) працівника на хронічні міжособистісні стресори на роботі». К. Маслач розробляла підхід до емоційного вигорання, як до психологічного синдрому, який представлено трьома симптомами: емоційне виснаження, деперсоналізація і редукція професійних досягнень. Зупинимося на них більш детально.

Емоційне виснаження, це почуття збідненого емоційного реагування, зниження емоційного фону, байдужість. Основними джерелами даного симптому автори називають робоче перевантаження і конфлікти на роботі. Людина відчуває себе використаною та спустошеною і не відчуває в собі сил та енергії спілкуватися

з іншими людьми. Даний компонент визначається К. Маслач, як базовий у розвитку вигорання.

Деперсоналізація в даній теорії розуміється, як негативна, цинічна та надмірно відсторонена реакція при спілкуванні з іншими людьми. Виникає, як відповідь на емоційне виснаження, і, перш за все є захисною реакцією організму. Однак існує ризик переходу деперсоналізації в дегуманізацію. Даний компонент можна назвати міжособистісним компонентом вигорання.

Редукція професійних досягнень характеризується, як зниження відчуття власної компетенції та продуктивності. Вона обумовлена неможливістю справитись з вимогами на роботі і може загострюватись через відсутність соціальної підтримки і можливостей професійного розвитку. Людина відчуває неможливість справлятися з задачами і вважає, що її переслідують провали на роботі. Даний компонент можна назвати самооціночним компонентом вигорання.

К. Маслач вважає, що шляхом включення двох компонентів (ставлення до інших – деперсоналізація і ставлення до себе – редукція професійних досягнень) розширюється поняття індивідуального реагування на стрес і поняття вигорання стає ширшим, ніж просто професійний стрес.

Поняття «професійне вигорання» К. Маслач визначила як синдром фізичного та емоційного виснаження, встановила його складові: розвиток негативної самооцінки, пасивне ставлення до роботи, втрата розуміння й співчуття. Підґрунтям професійного вигорання особистості є стрес-фактори.

Особливості професійного стресу та професійного вигорання у працівників судової системи полягають в постійній напрузі через гіпервідповідальність, та велику навантаженість з одного боку, і відсутність компенсаційного сприятливого психологічного середовища, яке би могло послабляти почуття вини і гіпервідповідальності – з іншого. Часті непорозуміння в колективі, між членами колективу і керівником суду, можуть обумовлюватись напруженою конфліктною атмосферою. Таким чином, судді та інші працівники судів перебувають в тій чи іншій мірі в стані постійного стресу, тобто мають сукупність неспецефічних адаптаційних реакцій організму, на вплив різних несприятливих факторів –

стресорів, які порушують гомеостаз, а також нервову систему організму в цілому [3].

Як правило, з часом зростає емоційне виснаження, що призводить відповідно, до емоційного та у цілому до професійного вигорання. Емоційне вигорання – це синдром постійної втоми, емоційного виснаження, який посилюється з часом. Як наслідок можуть з'являтися психосоматичні захворювання, такі як артеріальна гіпертензія, мігрень, біль в тілі невідомої етіології та інші психосоматози, якщо працівник суду не справляється зі стресом на рівні психічного відреагування [4].

Основою емоційного вигорання є реакція на зовнішні та внутрішні фактори. Це захист, щоб відсторонитися від занадто інтенсивного впливу на психіку. Щоб знизити цей вплив, людина робить крок назад від занадто інтенсивного впливу, але робить цей крок психіка у вигляді відстороненості, байдужості, зниженні мотивації, прокрастинації тощо. Бо це механізми, які нас можуть захистити від агресивного оточуючого середовища.

«Вигорання» виникає як захисна реакція організму людини на різні стресові ситуації і проявляється у відчутті виснаженості, особистісної відстороненості на роботі і вдома, зниженні мотивації до виконання професійних обов'язків.

На даний час не існує однозначної відповіді на запитання про те, що ж є головним у виникненні професійного вигорання, що є основною причиною – особистісні характеристики людини чи організаційні. Синдром вигорання – це фізичне, емоційне або мотиваційне виснаження.

Психологи на сучасному етапі розвитку науки виділяють психофізіологічні, соціально-психологічні та поведінкові симптоми вигорання:

1) Серед основних психофізичних симптомів вигорання, виділяють: відчуття постійної втоми, яке не проходить не тільки вечорами, але і вранці, відразу після сну (симптом хронічної втоми); відчуття емоційного і фізичного виснаження; зниження реакції сприйняття на зміни зовнішнього середовища (відсутність реакції цікавості на чинник новизни); загальна астенизація (слабкість, зниження активності і енергії); часті безпричинні головні болі; різка втрата або різке збільшення ваги; повне або часткове безсоння; постійний загальмований, сонливий стан і бажання

спати протягом всього дня; задуха або порушення дихання при фізичному або емоційному навантаженні; помітне зниження зовнішньої і внутрішньої сенсорної чутливості: погіршення зору, слуху, нюху і дотику.

2) Серед соціально-психологічних симптомів вигорання, виділяють: байдужість, нудьга, пасивність (знижений емоційний тонус, відчуття пригніченості); підвищена дратівливість на незначні, дрібні події; часті нервові «зриви» (спалахи невмотивованого гніву або відмова від спілкування); постійне переживання негативних емоцій, для яких в зовнішній ситуації причин немає (відчуття провини, образи, підозрілості, сорому, скутості); відчуття неусвідомленого неспокою і підвищеної тривожності (відчуття, що «щось не так, як треба»); відчуття гіпервідповідальності і постійне відчуття страху, що «не вийде» або людина «не справиться».

3) Серед основних поведінкових симптомів вигорання, виділяють: відчуття, що робота стає обтяжливою; людина міняє свій робочий режим дня (рано приходить на роботу і пізно йде або, навпаки, пізно приходить на роботу і рано йде); незалежно від об'єктивної необхідності людина постійно бере роботу додому, але удома її не робить; людина відмовляється від ухвалення рішень, формулюючи різні причини для пояснень собі та іншим; зниження ентузіазму по відношенню до роботи, байдужість до результатів; невиконання важливих, пріоритетних завдань і «застрягання» на дрібних деталях; не відповідна службовим вимогам витрата більшої частини робочого часу на мало усвідомлюване або не усвідомлюване виконання автоматичних і елементарних дій; дистанційованість від колег і людей.

Разом з тим, в межах нашого дослідження слід визначити стрес-фактори присутні саме в адвокатській діяльності. Отже, до специфічних стрес-факторів працівників, які здійснюють адвокатську діяльність слід віднести: велика інтелектуальна завантаженість в умовах постійного дефіциту часу; відсутність балансу між досягнутою метою і витраченими зусиллями; неочікувані результати праці; високий рівень відповідальності за очікувані результати; необхідність постійно підтримувати велику кількість соціальних зв'язків; необхідність бути готовим до швидкого реагування та розв'язання проблеми клієнта, в тому числі за

межею робочого часу, маючи для себе умовні часи відпочинку; зіткнення з великою кількістю негативних емоцій під час роботи з деякими кримінальними справами зважаючи, що внутрішньо адвокат може засуджувати клієнта за вчинене, мати протилежну і відмінну думку про моральність поведінки клієнта; постійне включення в конфлікт між клієнтом і його опонентом; включення у складнощі взаємодії клієнта і органу досудового слідства, в подробиці кримінального злочину, чи то адміністративного правопорушення; постійні зміни в законодавстві, відсутність сталої практики, зміни правової позиції щодо застосування норм права Верховним Судом; конфлікти з клієнтом за оплату праці, виконання рекомендацій і необхідність постійно відстоювати особисті кордони за межі робочого часу.

Психологи виділяють такі основні особливості психічного стану адвоката під час воєнних конфліктів: хронічний стрес, тривожність, емоційне виснаження, депресія, моральні та етичні дилеми тощо.

Адвокати, які працюють у воєнних умовах, стикаються з постійними стресовими ситуаціями. Вони часто мають справу з жертвами війни, що пережили травматичні події, що може призводити до перенасичення емоцій та зниження здатності до емоційної регуляції. Постійна загроза насильства та небезпеки викликає у адвокатів високий рівень тривоги. Це може включати страх за власне життя та життя своїх близьких, а також переживання за клієнтів. Адвокати можуть втратити здатність співчувати та емоційно підтримувати своїх клієнтів, що впливає на їхню професійну ефективність.

Тривала експозиція до стресових та травматичних подій може сприяти розвитку депресії. Адвокати можуть відчувати безнадійність, втрату інтересу до роботи та життя в цілому.

Під час війни адвокати часто стикаються з складними моральними та етичними питаннями, що можуть викликати внутрішній конфлікт і додатковий стрес. Вони можуть опинитися перед необхідністю приймати важкі рішення, що впливають на життя людей. Досить розповсюдженим є синдром вторинного травматичного стресу (СТС). Адвокати, які постійно працюють з жертвами війни, можуть страждати від СТС, що є результатом тривалого контакту з травматичними

розповідями та досвідом інших людей. Це може призводити до симптомів, схожих на посттравматичний стресовий розлад.

Висновки. Адвокати, які працюють у воєнних умовах, потребують спеціальної підтримки та допомоги для збереження свого психічного здоров'я. Це може включати професійну психотерапію, групову підтримку, навчання навичкам управління стресом та запровадження програм психоемоційної підтримки на робочому місці. Війна та збройні конфлікти мають значний вплив на психічне здоров'я працівників адвокатури. Дослідження показало, що адвокати, які працюють в умовах війни, часто стикаються з підвищеним рівнем стресу, тривоги та депресії через свою професійну діяльність та морально-етичні дилеми. Виявлено основні фактори ризику, які включають постійний контакт з жертвами війни, високе емоційне навантаження та необхідність швидко приймати складні рішення. Довготривале перебування в токсичному середовищі це завжди питання розподілу ресурсу. Індивідуальна адаптація до стресу частково «зашията» в нашій генетиці, а частково – це життєвий досвід особистості. Якщо життєвий досвід йде проти індивідуальної адаптації, то будь-яка генетика з певного моменту починає «сипатися». Результати цього дослідження підкреслюють важливість психотерапевтичної підтримки та створення спеціальних програм допомоги для працівників адвокатури з метою збереження їх психічного здоров'я. Збереження психоемоційної стабільності адвокатів є критично важливим для забезпечення ефективного правозастосування та захисту прав людини в умовах збройних конфліктів.

Література.

1. Бекк А. Т., Стер Р. А. Когнітивна терапія депресії: Практичний підхід. Київ: Наукова думка. 2011.
2. Бочелюк В. Й. Юридична психологія: навч. посібник. Київ: «Центр учбової літератури». 2010. 336 с.
3. Гірник А. М. Основи конфліктології. Київ: Києво-Могилянська академія. 2010. 222 с.

4. Кухта С. О. Проблема захопленості та вигорання в професійній діяльності особистості. Наука і освіта. 2013. № 7. С. 247–250. http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2013_7_57.
5. Лебедева І. В. Психологічна допомога в умовах збройного конфлікту. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. 2017.
6. Матвієнко С. М., Горбунова О. В. Вплив війни на психічне здоров'я цивільного населення. Психологічні дослідження. 2020. № 15(2). 123–134.
7. Пилипенко Л. А. Психологічні наслідки травматичного досвіду в умовах війни. Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 2019.
8. Сельє Г. Стрес без дистреса. <http://lib.ru/PSIHO/SELYE/distree.txt>.
9. Синдром «професійного вигорання» та професійна кар'єра працівників освітніх організацій: тендерні аспекти / за ред. С. Д. Максименка, Л.М. Карамушки, Т.В. Зайчикової. 2006. К. 365 с.
10. Сміт Дж., Кларк, Р. Юристи в умовах війни: Психологічні аспекти професійної діяльності. Психологія та право. 2016. №22(3). Р. 201–215.
11. Шевченко М. П., Іванов А. О. Адвокатура в умовах збройного конфлікту: Соціально-психологічні виклики. Журнал правознавства. 2018. №31(1). Р. 45–59.
12. Weiss D. S., Marmar C. R. The Impact of Event Scale – Revised. In J. P. Wilson & T. M. Keane (Eds.), Assessing psychological trauma and PTSD. New York: Guilford Press. 1997. Р. 399–411.

2.16. Розвиток резильєнтності як методу профілактики професійного вигорання медичних працівників стаціонарних відділень

Синицька О.

Актуальність. Боротьба з професійним вигоранням є надзвичайно актуальною проблемою, особливо в умовах роботи медичних працівників. Щоденна взаємодія з пацієнтами та їх родинами, спілкування з колегами, багатогодинні зміни, надання невідкладної допомоги в екстрених випадках – це лише частина факторів, що сприяють виникненню цього стану. Однак природну здатність особистості адаптуватись до складних умов роботи в стресі можливо та потрібно цілеспрямовано розвивати, тим самим сприяючи розвитку резильєнтності у медичних працівників як важливого інструменту подолання професійного вигорання, який дозволяє знижувати негативні наслідки стресу, зберігаючи емоційний баланс і працездатність.

Мета. Дослідити концептуальні засади розвитку резильєнтності як методу профілактики та подолання професійного вигорання медичного персоналу стаціонарних відділень.

Результати дослідження. Американський психіатр Г. Фрейденберг у 1974 р. використав термін професійне вигорання для опису стану фізичного та емоційного виснаження, з яким зіткнувся сам під час роботи в клініці для наркозалежних.

Г. Фрейденберг виокремив три основні аспекти концепції вигорання :

1. Емоційне виснаження: людина відчуває хронічну втому, втрату енергії та емоційну спустошеність.
2. Деперсоналізація: професійна діяльність стає механічною, людина починає негативно ставитися до пацієнтів, клієнтів чи колег.
3. Зниження професійної ефективності: виникає відчуття, що зусилля марні, а робота втрачає сенс.

Вчений пов'язував вигорання з високим рівнем ідеалізму, притаманним професіям, що передбачають допомогу іншим (медики, соціальні працівники, педагоги). За його спостереженнями, люди в таких професіях схильні ставити

надмірні вимоги до себе, нехтуючи власними потребами. Це, у свою чергу, створює основу для розвитку виснаження.

У 1976 році був введений термін «емоційне вигорання» американською дослідницею Масlach К. Замість терміну «staff burn-out» вона стала використовувати поняття «вигорання» (припинення горіння). За її словами, емоційне вигорання, яке є причиною професійного вигорання – це розплата за співчуття. У 1981 році К. Масlach розробила шкалу Maslach Burnout Inventory, яка залишається одним із найвідоміших і найефективніших інструментів для діагностики цього стану [1].

Професійне вигорання можна визначити як психічний стан, що виникає в результаті накопичення негативних емоцій та переживань, пов'язаних із роботою, взаєминами в колективі та діяльністю підприємства в цілому. Це реакція організму та психологічної сфери людини на тривалий вплив стресових факторів середньої інтенсивності, характерних для професійної діяльності. Основними проявами такого стану є емоційна спустошеність, хронічна втома, а також втрата мотивації та інтересу до професійної роботи [5].

К. Масlach і С. Джексон розглядають синдром «професійного вигорання» як трикомпонентну систему [10], яка складається з емоційного виснаження, деперсоналізації та редукції власних особистісних прагнень та проявляється як один з видів деформації особистості.

Ознаки професійного вигорання, на думку вчених поділяються на - психофізичні, соціально-психологічні та поведінкові [7]:

1.Психофізичні симптоми: відчуття постійної втоми не тільки ввечері, але і вранці, відразу після сну (симптом хронічної втоми); відчуття емоційного і фізичного виснаження; зниження сприйнятливості і реактивності у зв'язку зі змінами зовнішнього середовища (відсутність реакції зацікавленості на чинник новизни або реакції страху на небезпечну ситуацію); загальна астенизація (слабкість, зниження активності та енергійності, погіршення біохімії крові і гормональних показників); частий безпричинний головний біль; постійні розлади шлунково-кишкового тракту; повне або часткове безсоння; постійний

загальмований, млявий стан і бажання спати протягом всього дня; задишка або порушення дихання при фізичному або емоційному навантаженні; помітне зниження зовнішньої та внутрішньої сенсорної чутливості: погіршення зору, слуху, нюху і дотику, втрата внутрішніх, тілесних відчуттів.

2. Соціально-психологічні симптоми: байдужість, нудьга, пасивність і депресія (знижений емоційний тонус, відчуття пригніченості); підвищена дратівливість на незначні, дрібні події; часті нервові зриви (спалахи невмотивованого гніву або відмова від спілкування, замикання у собі); постійне переживання негативних емоцій, для яких у зовнішній ситуації немає причин (відчуття провини, образи, сорому, підозрілість, скутість); відчуття неусвідомленого неспокою і підвищеної тривожності (відчуття, що «щось не так, як треба»); відчуття гіпервідповідальності і постійне відчуття страху, що «щось не вдасться» або «я не впораюся»; загальна негативна настанова на життєві і професійні перспективи (за типом «як не намагайся, все одно нічого не вийде»).

3. Поведінкові симптоми: відчуття, що робота стає все важчою і важчою, і виконувати її – все важче і важче; співробітник помітно змінює свій робочий режим (збільшує або скорочує час роботи); постійно, без необхідності, бере роботу додому, але і вдома її не робить; керівникові важко ухвалювати рішення; відчуття даремності, зневіра, що справи поліпшаться, зниження ентузіазму у ставленні до роботи, байдужість до її результатів; дистанційність від співробітників і клієнтів, підвищення неадекватної критичності; зловживання алкоголем, різке зростання викурених за день цигарок, вживання наркотичних засобів.

Проблема професійного вигорання є об'єктом активного наукового дослідження і сьогодні. Так, у своїй статті «Психологічні особливості медичних працівників в умовах емоційного виснаження» Лапінська Т.В. звертає увагу на те, що фактично в умовах, які призводять до професійного вигорання, змінюється характер особистості, знижується адаптивні процеси та продуктивність праці. Виникають нервові зриви, що приводить до негативної поведінки медичних працівників [4] і як результат, виникнення медичних та немедичних конфліктних ситуацій з колегами і пацієнтами, погіршення якості життя та інше.

Сьогодні професійне вигорання визнане ВООЗ, як синдром, що виникає внаслідок хронічного стресу на робочому місці.

Ганс Сельє (Hans Selye), відомий як «батько стресу», у своїй теорії вперше описав загальний адаптаційний синдром, який пояснює реакцію організму на стресові ситуації [5].

Його концепція дозволяє краще зрозуміти механізми розвитку професійного вигорання, оскільки це явище часто виникає через тривалий вплив стресу на особистість в процесі надання медичної послуги та спілкування з пацієнтом і його родиною. Постійний вплив стресорів на роботі – таких як перевантаження завданнями, емоційно складні ситуації чи конфлікти – може порушувати природний механізм адаптації, описаний Г. Сельє [7].

Оскільки професія медичного працівника стаціонару постійно пов'язана з людьми, які мають тілесні чи душевні проблеми (хворі, їхня родина), то в лікарській діяльності неминучі психологічні стресові ситуації, які можуть призводити до так званого феномену вигорання, коли зникає зацікавленість у роботі, знецінюються людські страждання та почуття пацієнта чи його родини.

У зв'язку з цим особливого значення набуває розвиток здатності особистості до резильєнтності. Резильєнтність (resilience) визначається як здатність людини справлятися зі складними життєвими обставинами, адаптуватися до змін і відновлюватися після стресових ситуацій. Ця якість надає психологічну стійкість, необхідну для подолання викликів, які є невід'ємною частиною професійної діяльності [8].

Резильєнтність також розглядається як здатність підтримувати психологічне благополуччя навіть у складних умовах. Важливо зазначити, що ця характеристика не є вродженою і може бути розвинута за допомогою свідомих зусиль, зокрема через практичні методики, зміну способу мислення та спеціальні техніки [2].

В україномовній літературі термін «resilience» перекладають як «стресостійкість», «життєстійкість», «життєздатність», «стійкість до травми», «психологічна пружність», «психологічна стійкість», що призводить до певної термінологічної плутанини. Відмінність у змісті понять резилієнсу («resilience») та

резильєнтності («resiliency»), полягає в тому, що резилієнс є процесом, а резильєнтність – властивістю (або здатністю) особистості[2].

Отже, резильєнтність є набутою здатністю, що розвивається через усвідомлені практики саморефлексії, управління емоціями, розвиток здорових звичок та соціальної підтримки. Для медичних працівників, які працюють у стаціонарі, це може включати техніки майндфулнес, розвиток емоційного інтелекту та фізичну активність. Таким чином, резильєнтність не лише допомагає долати вигорання, але й виступає основою для довготривалої професійної ефективності.

Поєднання теоретичного розуміння вигорання та практичного підходу до розвитку резильєнтності створює системний підхід, спрямований на покращення якості життя медичних працівників і зниження негативного впливу стресу.

У разі прояву симптомів вигорання, втрати інтересу до роботи або іншої ознаки професійного розвитку, необхідно здійснити оцінку власного стану. Аналіз власного стану буде першим кроком виявлення початку професійного вигорання в вирішенні питання самодопомоги, або приводом звернутись за допомогою до спеціаліста.

Особи, які швидко відновлюються після стресових ситуацій, демонструють віру у власні сили, оптимістичне сприйняття труднощів, а також адаптивну та гнучку поведінку, можуть бути охарактеризовані як резильєнтні. Така здатність до відновлення є важливим ресурсом для ефективної протидії професійному вигоранню.

Усвідомлення себе як об'єкта переживання негативних емоцій, аналіз порушень, пов'язаних із емоційним станом, а також використання концепції «управління емоціями», яка є складовою емоційного інтелекту, дозволяють визначити власну спроможність до самовдосконалення. Застосування особистісних методів розвитку резильєнтності, таких як саморефлексія, управління емоціями та використання відповідних практик, може значно підвищити стійкість до стресу та забезпечити збереження професійної ефективності.

Коkun О, Мельничук Т. [2] виділяють ключові принципи саморозвитку резильєнтності, які є основою для підвищення стійкості особистості до стресових ситуацій:

Перший принцип – *усвідомленість та саморефлексія*. Регулярний аналіз власних емоцій, думок і реакцій дозволяє своєчасно розпізнавати стресові фактори. Для медичних працівників важливим є вміння управляти стресом через такі практики, як контрольоване дихання, фізичні вправи та техніки релаксації. Крім того, здатність розмежовувати роботу та особисте життя значно знижує ризик емоційного виснаження.

Другий принцип – практичні методи саморозвитку резильєнтності, серед яких особливе місце посідають техніки усвідомленості (майндфулнес). Згідно з дослідженнями, ці техніки сприяють зниженню рівня тривожності та поліпшенню емоційного стану [6].

Основні елементи майндфулнес включають: щоденні медитації (5–10 хвилин) для фокусування уваги на теперішньому моменті; практика «усвідомленого дихання» для швидкого зняття стресу в екстрених ситуаціях; фізична активність та здоровий спосіб життя; регулярні фізичні вправи (йога, пілатес, кардіотренування) допомагають знижувати рівень кортизолу; збалансоване харчування та достатній сон підтримують фізичний і психологічний стан.

Також до практичних методів належить ведення рефлексивного журналу: щоденне записування своїх емоцій і думок дозволяє краще розуміти себе та свої реакції на стрес; аналіз подій і пошук позитивних аспектів допомагає зменшити негативний вплив стресорів.

Додатково ефективними є практики, орієнтовані на роботу з емоціями: практика подяки: щоденне фіксування трьох речей, за які людина вдячна, підвищує стійкість до негативних емоцій; вміння переключати увагу з проблем на рішення сприяє конструктивному підходу до викликів.

Планування та управління часом – встановлення чітких пріоритетів і виділення часу для відпочинку дозволяють уникати перевантаження, що є важливим для зменшення ризику професійного вигорання.

Третій принцип – емоційна саморегуляція. Розвиток навичок розпізнавання та управління емоціями дозволяє уникати імпульсивних рішень у стресових ситуаціях. Наприклад, техніки самозаспокоєння, такі як прогресивна м'язова релаксація, сприяють швидкому відновленню після психологічного напруження.

Четвертий принцип – побудова підтримуючих стосунків. Якісні відносини з колегами, друзями та родиною забезпечують необхідну емоційну підтримку. Участь у групових обговореннях, супервізіях чи тренінгах сприяє розвитку взаємної довіри та формуванню колективної стійкості.

П'ятий принцип – особистісний розвиток та навчання. Постійне підвищення кваліфікації, освоєння нових знань та методів роботи не лише допомагають долати професійні виклики, але й сприяють зростанню професійної компетентності та самооцінки.

Дотримання цих принципів дозволяє медичним працівникам ефективно розвивати резильєнтність, підвищуючи їхню здатність протистояти стресу та підтримувати психологічне благополуччя [10].

Першочергове завдання керівництва у збереженні стабільності робочого процесу закладу та його людського ресурсу – профілактика і подолання негативних наслідків організаційних стресів.

Розробка профілактичних і реабілітаційних програм, що знижують ризики виникнення професійного вигорання, впроваджується керівництвом, спирається на результати аналізу стрес-факторів характерних для закладу.

Серед ключових заходів, які можуть бути впроваджені, важливу роль відіграє залучення психолога до штатної роботи медичного колективу на постійній основі. Це дозволяє забезпечити своєчасну діагностику емоційного стану персоналу, проводити тренінги з підвищення стійкості до стресу та надавати індивідуальні консультації.

Запровадження програм психосоціальної підтримки на робочому місці є ще одним важливим кроком для зміцнення здоров'я та добробуту працівників. Такі програми можуть включати широкий спектр ініціатив, зокрема групові заняття з психологічної підтримки, семінари з управління стресом, створення ресурсних

кімнат для відпочинку та розробку індивідуальних планів реабілітації після значних професійних навантажень. Комплексний підхід до профілактики стресу та професійного вигорання дозволяє ефективно підтримувати високу працездатність і моральний дух медичного персоналу. Ось деякі елементи такої програми: психологічні консультації: надання працівникам можливості звертатися за конфіденційною психологічною підтримкою та консультаціями щодо особистих та професійних проблем; семінари та тренінги: організація занять з психологічного тренінгу, які допомагають працівникам вміти краще управляти стресом, розв'язувати конфлікти, підтримувати психічне здоров'я тощо; стрес-менеджмент та релаксація: забезпечення доступу до методів та технік стрес-менеджменту, таких як медитація, йога, або глибоке дихання; програми фітнесу та здорового способу життя: підтримка фізичного здоров'я працівників через організацію спортивних заходів, відвідування тренажерного залу, або надання доступу до корисної інформації про здоровий спосіб життя; створення сприятливого середовища: забезпечення психологічно здорового та підтримуючого робочого середовища, включаючи політику розуміння, толерантності та взаємоповаги; система зворотного зв'язку: встановлення механізмів зворотного зв'язку для працівників, де вони можуть висловлювати свої побажання, скарги чи пропозиції щодо покращення програми підтримки; ресурси для розвитку кар'єри: надання можливостей для навчання та професійного зростання, що може позитивно вплинути на самооцінку та емоційний стан працівників; моніторинг емоційного стану співробітників на постійній основі. Індивідуальні та колективні сесії психологічного розвантаження.

Запровадження програми може покращити загальний клімат на робочому місці, знизити рівень стресу та підвищити задоволеність працівників своєю роботою, що в свою чергу сприятиме підвищенню продуктивності та зниженню втрати кадрів. Практичний досвід набутий науковцями на початку воєнного стану в медичному закладі м. Києва, щодо виявлення професійного вигорання та методів його подолання надає можливість наочно переконатись в дієвих методах роботи з розвитку резильєнтності медичного персоналу.

За даними досліджень, які проводили 2022-2023 рр. на базі КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 Подільського району м. Київ» [9] в групі медичних працівників сформованих у випадкову репрезентативну вибірку з 50 медичних працівників віком 25-64 років з наявними ознаками професійного вигорання залежно від ознак та ступеню вираженості. Учасників, які демонстрували ознаки вигорання, було розподілено на три групи відповідно до ступеня вираженості та характеру симптомів. До першої групи (18%) увійшли працівники з легкими проявами емоційного напруження, які проявлялися у вигляді забудькуватості, дрібних помилок у роботі та підвищеної нервово-психічної напруги. Друга група (71%) включала осіб, які втратили інтерес до професійної діяльності, знизили потребу у спілкуванні та демонстрували підвищену дратівливість. У третій групі (11%) були працівники із проявами апатії, депресивних станів та зниженням життєвих цінностей.

Виявлення симптомів професійного вигорання здійснювалося за критеріями глобальної програми WHO Mental Health Gap Action Programme (mhGAP), що спрямована на поліпшення доступу до послуг із підтримки психічного здоров'я.

Майже всі медичні працівники (97%), залучені до дослідження, зазначили погіршення стану здоров'я з початком професійної діяльності. У відповідь на ці виклики керівництво медичного закладу впровадило низку заходів, спрямованих на зменшення рівня професійного вигорання та підтримку психоемоційного благополуччя працівників. Зокрема, значна увага приділялася активній участі працівників у професійній та освітній діяльності, що включало проведення тренінгів із розвитку життєвих і соціальних навичок, а також базових принципів надання психологічної допомоги.

Ключовим елементом профілактики професійного вигорання стала психоосвіта, спрямована на підвищення обізнаності медичних працівників щодо ознак емоційного виснаження, його наслідків та стратегій самодопомоги в стресових ситуаціях. Для цього співробітникам було надано детальну інформацію про механізми виникнення стресу, психологічні вправи для саморегуляції та навички управління емоційним станом.

Одним із важливих компонентів програми стало мотиваційне консультування, яке проводилося як для ідентифікації чинників стресу, так і для обговорення шляхів його подолання без осуду чи стигматизації. Це дозволило медичним працівникам краще усвідомити причини емоційного виснаження, а також розробити індивідуальні моделі поведінки для зниження ризику вигорання. Упродовж року, залежно від ступеня проявів вигорання, для кожного працівника проводили повторні консультації, що сприяли покращенню їхнього загального психоемоційного стану та формуванню відповідального ставлення до власного здоров'я. Ці комплексні заходи стали основою для створення сприятливого психологічного середовища у закладі та забезпечення довготривалого покращення емоційного добробуту працівників.

Через рік після впровадження комплексу заходів було проведено повторне анкетування, результати якого вказують на значне покращення психоемоційного стану медичних працівників та соціальної атмосфери в колективі. Встановлено, що стосунки між співробітниками покращилися на 78%, рівень самооцінки працівників зріс на 20%, а бажання допомагати іншим збільшилося на 72%, що позитивно позначилося на рівні довіри пацієнтів до закладу охорони здоров'я.

Серед працівників 1-ї групи, які раніше демонстрували дрібні помилки, забудькуватість та нервово-психічну напругу, ці симптоми майже повністю зникли, що свідчить про ефективність застосованих методів психоосвіти та консультування. У 2-й групі зниження вираженості симптомів професійного вигорання становило 54%. Працівники цієї категорії зазначили відновлення інтересу до професійної діяльності, покращення спілкування з колегами та пацієнтами, що свідчить про формування позитивного емоційного клімату в колективі. У 3-й групі медичних працівників, які раніше мали ознаки апатії та депресії, спостерігалось зростання життєвих цінностей і зниження інтенсивності депресивних симптомів на 60,0 %. Отримані результати підтверджують ефективність комплексного підходу, що поєднує заходи психоосвіти, мотиваційного консультування та індивідуальної підтримки. Це дозволило не лише зменшити прояви професійного вигорання, але й створити умови для зростання

довіри між працівниками та пацієнтами, покращення взаєморозуміння в колективі й підвищення якості надання медичних послуг. Отже, комплексні реабілітаційні заходи, спрямовані на профілактику та подолання професійного вигорання, виявилися ефективними в покращенні емоційного стану медичних працівників, їхньої професійної мотивації та загальної атмосфери в колективі. Це підкреслює необхідність подальшого впровадження систематичних програм психосоціальної підтримки в медичних закладах для забезпечення стійкого розвитку персоналу та підвищення якості охорони здоров'я.

Висновки. Розвиток резильєнтності є ключовим фактором у запобіганні професійному вигоранню, особливо серед медичних працівників, які регулярно стикаються з високим рівнем стресу. Хоча певна частина людей володіє вродженою здатністю до резильєнтності, для більшості ця якість формується в результаті систематичної роботи та впровадження цілеспрямованих інтервенцій. Поєднання особистісних підходів, таких як саморегуляція та розвиток емоційного інтелекту, із заходами на рівні організаційної культури, включаючи підтримку персоналу та справедливий розподіл робочого навантаження, значно підвищує здатність працівників ефективно протистояти викликам професійного середовища. Формування резильєнтності у медичних працівників вимагає комплексного підходу, що включає розвиток корисних звичок, регулярну роботу над собою та впровадження практичних методів управління стресом. Серед найбільш ефективних практик виділяють майндфулнес, емоційну саморегуляцію та підтримання фізичної активності, які сприяють зміцненню стійкості до стресових ситуацій і підвищенню загальної працездатності. Крім того, такі підходи знижують рівень емоційного виснаження та покращують загальний стан психічного здоров'я. Інтеграція заходів з управління стресом, створення сприятливого робочого середовища та гармонійне поєднання особистісних і організаційних методів розвитку резильєнтності є критично важливими для збереження емоційної рівноваги, ефективності професійної діяльності та високої якості життя медичних працівників. Комплексний підхід дозволяє мінімізувати ризики професійного

вигорання, сприяючи стійкості персоналу до навантажень, які є невід'ємною частиною їхньої роботи.

Література.

1. Діагностика професійного вигорання (К. Маслач, С. Джексон в адаптації Н. Е. Водоп'янової) <https://studfile.net/preview/5258391/page:37/>
2. Коkun О. М., Мельничук Т. І. Резилієнс-довідник: практичний посібник. Київ: Інститут психології імені Г. С. Костюка, НАПН України. 2023. 25с.
3. Коцан І. Я., Ложкін Г. В., Мушкевич М. І. Психологія здоров'я людини. Луцьк: РВВ Вежа. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2011. С. 130–136.
4. Лапінська Т. В. Психологічні особливості медичних працівників в умовах емоційного виснаження. Монографія. Академія праці, соціальних відносин і туризму / За заг. ред.: Г.А. Пріба, Л.Є. Бегеза. Київ : АПСВТ. 2024. 416 с.
5. Наугольник Л. Б. Психологія стресу: підручник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. С. 9–15.
6. Простими словами про майндфулнес або п'ять переваг усвідомленості, що покращують якість життя. <https://moz.gov.ua/uk/prostimi-slovami-pro-majndfulness-abo-p-yat-perevag-usvidomlenosti-sho-pokrashuyut-yakist-zhittya>
7. Радченко О. Теорія стресу та філософські погляди Г.Сельє: значення для сучасної медицини. Медична газета «Здоров'я України 21 ст. № 15-16. 2022. С. 532–533.
8. Словник психологічних термінів. веб-сайт. <https://nuph.edu.ua/slovník-psihologichnih-terminiv/>
9. Титова Т.А., Бухановська Т.М. Професійне вигорання та методи його подолання. Український медичний часопис. №7 (165). С. 1–2. <https://umj.com.ua/uk/publikatsia-259310-profesijne-vigorannya-ta-metodi-jogo-podolannya>
10. Управління в організації: навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/iebmd/prishak_psihologiya_upravlinnya_v_organizaciyi/ar2/index_2_3_3.html

2.17. Соціально-психологічні бар'єри професійної діяльності фахівців сфери ІТ

Янушевський А.О.

Актуальність. У сучасному світі фахівці сфери ІТ (інформаційних технологій) відіграють ключову роль у розвитку бізнесу, освіти, науки та інших сфер. У межах даного дослідження фахівець сфери ІТ розуміється як працівник, що займається створенням, розробкою, підтримкою та оптимізацією програмного забезпечення, обробкою даних та іншими технологічними процесами, пов'язаними з інформаційними системами. Ця діяльність часто вимагає високої когнітивної напруженості, технічної компетенції, стійкості до стресу, здатності до самонавчання та швидкої адаптації до технологічних змін. Втім, професійна діяльність ІТ-фахівців нерідко супроводжується впливом соціально-психологічних бар'єрів. За визначенням Массанова А. В. [1], психологічний бар'єр – це психічний стан, що виникає перед або під час виконання діяльності [1]. Перед виконанням діяльності бар'єр не дозволяє початися діяльності, а під час виконання діяльності – зупиняє її. Психологічні бар'єри суттєво впливають на якість життя, адже обмежують спектр діяльності людини, ускладнюють задоволення її потреб та реалізацію потенціалу. Причини таких бар'єрів можуть залишатися неусвідомленими, а їх подолання потребує цілеспрямованих зусиль. Для ІТ-фахівців соціально-психологічні бар'єри часто асоціюються з такими викликами, як соціальна ізоляція, надмірні робочі навантаження, тиск дедлайнів і порушення балансу між роботою та особистим життям. Особливу увагу слід звернути на прояви соціально-психологічних бар'єрів у професійному середовищі ІТ, такі як синдром самозванця, емоційне вигорання та зниження мотивації.

Мета. Здійснити аналіз сутності соціально-психологічних бар'єрів, причин їх виникнення, проявів та впливу на професійну діяльність ІТ-фахівців.

Результати досліджень. Незважаючи на те, що не всі ІТ-фахівці працюють у віддаленому форматі, комунікація в цій сфері стає дедалі більш залежною від цифрових технологій. Це змінює характер взаємодії між працівниками, зменшуючи

кількість особистих зустрічей та зводячи спілкування до обміну повідомленнями через електронну пошту або чати. Подібні зміни створюють соціально-психологічні бар'єри, які негативно впливають як на міжособистісні стосунки, так і на психологічне здоров'я та продуктивність працівників. Відповідно до дослідження [2], навіть у разі інтеграції користувачко-орієнтованих інструментів для підтримки працівників, багато розробників програмного забезпечення повідомляють про зменшення можливостей для «неформального спілкування», яке традиційно слугує важливим чинником соціальної підтримки. Особливо це помітно серед працівників, які працюють на проєктах із глобально розподіленими командами. Дослідники зазначають, що в умовах віддаленої роботи знижується не лише кількість міжособистісних контактів, але й якість професійного обміну ідей, що безпосередньо впливає на ефективність виконання завдань [2].

Соціально-психологічні бар'єри, пов'язані з ізоляцією, мають кілька важливих наслідків. Згідно з аналізом [3], ізоляція може призводити до зменшення залученості працівників та погіршення їхньої здатності до співпраці. Навіть якщо цифрові інструменти забезпечують технічні можливості для взаємодії, вони не можуть повністю замінити особисту присутність, яка сприяє створенню довіри та емпатії між членами команди. Ці інструменти часто не враховують емоційні та соціальні потреби працівників, що може посилювати відчуття відчуженості та послаблювати психологічний комфорт. Соціальна ізоляція також впливає на здатність працівників отримувати неформальну підтримку. У традиційних офісних умовах працівники мають змогу обговорювати професійні труднощі з колегами під час перерв або неформальних зустрічей. У дистанційному форматі така підтримка значною мірою втрачається, що створює додатковий емоційний тиск. У дослідженні [2] зазначено, що відсутність можливості ділитися переживаннями з колегами може спричинити збільшення рівня стресу, що особливо помітно у високонавантажених командах [2].

Ще одним важливим аспектом є вплив соціальної ізоляції на організаційну культуру. Дистанційна робота значно ускладнює створення спільного розуміння цінностей і цілей компанії. Як зазначають автори [3], це може призводити до

зниження командного духу та появи почуття відчуженості, особливо серед нових працівників, які ще не встигли адаптуватися. Відсутність спільних цінностей – це суттєвий бар'єр, що ускладнює взаємодію в колективі в довгостроковій перспективі [3]. Робота в одноманітному середовищі є значним викликом для фахівців ІТ-сфери. Незалежно від того, чи це офіс, чи домашній кабінет, одноманітність оточення негативно впливає на психологічний стан та загальний рівень задоволення працею, та сприяє появі психологічних бар'єрів. Одноманітність спричиняє емоційне виснаження, зниження мотивації та розвиток апатії.

Згідно з дослідженням [4], працівники, які виконують однакові завдання в незмінному середовищі, частіше стикаються з почуттям емоційного вигорання. Це явище особливо характерне для тих, хто працює в умовах, де відсутні нові враження або зміни обстановки. У результаті працівники можуть втрачати інтерес до виконання своїх обов'язків та загалом до професійного розвитку. Розвивається відчуття «застрягlosti» у буденності, що не лише знижує ефективність роботи, але й створює психологічний бар'єр для освоєння нових навичок [4].

Крім того, одноманітне середовище може стримувати креативність, оскільки відсутність нових стимулів та різноманітності обмежує можливості для генерування нових ідей. Як зазначається в [5], такі умови можуть створювати відчуття застою, що знижує продуктивність та зацікавленість у нестандартних рішеннях. Для ІТ-фахівців, які працюють над інноваційними проєктами, це серйозна перепона. Зменшення варіативності обстановки також впливає на загальний тонус працівника, що може підсилювати втомленість навіть після коротких перерв [5].

В цілому, лікарі наголошують, що відсутність змін у робочому середовищі може призводити до фізичних проблем, таких як напруження зору, погіршення постави та зниження рівня фізичної активності. Це підтверджується численними дослідженнями, які виявляють, що тривале перебування в одному й тому ж положенні без достатньої рухливості впливає як на продуктивність, так і на загальний стан здоров'я. Щоб подолати проблему одноманітності, фахівці вносять зміни у свою щоденну рутину. Наприклад, ротація завдань, участь у нових

проектах, регулярне навчання або неформальні зустрічі можуть допомогти підтримувати мотивацію та покращити загальний психологічний стан. Участь у креативних командних заходах, таких як мозкові штурми або обговорення нових підходів до вирішення завдань, може значно сприяти розвитку гнучкості мислення.

Заохочується також створення середовища, яке стимулює креативність, через використання нових технологій чи зміну робочого простору. Наприклад, робота у коворкінгах або тимчасова зміна робочої локації, навіть на домашньому рівні, може сприяти створенню нових вражень. Крім того, участь у віртуальних воркшопах, спільних навчальних сесіях або неформальних онлайн-зустрічах може значно урізноманітнити робочий процес. Навіть дрібні зміни, як-от перерва для фізичної активності або зміна місця для роботи, можуть мати позитивний вплив на емоційний стан працівника.

Варто зауважити, що кожен ІТ-фахівець знаходить власний підхід до боротьби з одноманітністю, враховуючи свої індивідуальні потреби. Це може включати як зміни у фізичному середовищі, так і впровадження нових звичок, спрямованих на збагачення робочих буднів. Тим не менш, подолання одноманітності вимагає цілеспрямованих зусиль, які інколи потребують додаткового часу та ресурсів і часто не знаходять належного відгуку у працівників і роботодавців сфери ІТ.

Постійний розвиток технологій вимагає від фахівців постійного навчання, що часто супроводжується почуттям недостатньої компетенції. ІТ-сфера характеризується швидкими змінами, де нові інструменти та підходи з'являються настільки швидко, що навіть досвідчені спеціалісти можуть відчувати труднощі у підтримці актуальності своїх знань. Це створює додатковий психологічний тиск, адже фахівці змушені витрачати значну частину свого часу на освоєння нових технологій і методик, часто поза межами робочого часу. Водночас така необхідність може порушувати баланс між роботою та особистим життям, посилюючи емоційне виснаження. Такі динамічні умови формують низку соціально-психологічних бар'єрів, які можуть негативно впливати на їхню професійну активність.

Технологічні зміни суттєво ускладнюють характеристики роботи, підвищуючи її складність. Це вимагає від фахівців здатності швидко адаптуватися до нових умов та розвивати нові компетенції. Постійний інформаційний потік і необхідність навчатися новим технологіям створюють відчуття перевантаженості, що може негативно впливати на продуктивність і психічне здоров'я працівників [6].

Високі кваліфікаційні вимоги також створюють конкурентне середовище серед працівників. Замість того, щоб співпрацювати та ділитися знаннями, багато фахівців змушені конкурувати за отримання нових сертифікацій, участь у престижних проєктах або доступ до тренінгів, які допомагають залишатися конкурентоспроможними на ринку праці. Така конкуренція може посилювати почуття ізоляції та знижувати рівень командної роботи, що особливо критично для проєктів із високим ступенем складності.

Окрім того, проблема посилюється через те, що роботодавці часто очікують від своїх співробітників швидкої адаптації до нових стандартів і технологій. Це збільшує рівень стресу серед працівників, адже навіть найефективніші фахівці не завжди мають ресурси для швидкого засвоєння нових знань. Як наслідок, працівники можуть відчувати страх перед втратою робочого місця, що додатково посилює їхню емоційну напруженість.

Зростаючі кваліфікаційні вимоги часто викликають бар'єр страху невідповідності або втрати актуальності на ринку праці. Працівники можуть сумніватися у своїй спроможності встигати за швидким темпом змін, що призводить до підвищеного рівня тривожності. Особливо це стосується спеціалістів, які працюють у галузі вже тривалий час і відчують, що їхній досвід може ставати застарілим у порівнянні з молодшими колегами, які володіють більш актуальними знаннями.

Соціально-психологічний аспект цього бар'єру проявляється у вигляді синдрому самозванця, коли працівники починають недооцінювати свої здібності та відчують себе невідповідними до виконання завдань, навіть якщо їхні компетенції відповідають вимогам. Це може спричиняти зниження впевненості у собі, уникнення складних завдань або навіть бажання змінити професію.

Психологічний тиск, який виникає внаслідок цього, може мати тривалі наслідки для емоційного здоров'я працівника.

Іншим важливим бар'єром є дефіцит часу, необхідного для навчання. ІТ-фахівці часто змушені балансувати між виконанням робочих обов'язків, особистим життям і потребою здобувати нові знання. У таких умовах стрес від неможливості виділити достатньо ресурсів на розвиток призводить до емоційного виснаження та зниження мотивації. Відсутність часу на навчання також може створювати відчуття професійної стагнації, коли працівник не бачить можливостей для свого кар'єрного зростання або вдосконалення. Крім того, важливо враховувати, що зростаючі кваліфікаційні вимоги не лише впливають на окремих працівників, але й змінюють характер роботи команди в цілому. Нові інструменти чи технології, які швидко впроваджуються, можуть створювати ситуації, коли частина команди опановує їх швидше, ніж інші. Це призводить до асиметрії в розподілі завдань, коли одні працівники змушені брати на себе більший обсяг роботи, тоді як інші залишаються на другорядних ролях, що спричиняє напруження та нерівність у команді.

Постійні зміни у попиті на певні технології та спеціалізації формують невизначеність у кар'єрі, що впливає на соціально-психологічний стан ІТ-фахівців. Ринок праці в ІТ-секторі характеризується не лише зростаючими вимогами до кваліфікації, але й стрімкими змінами в популярності певних професій та навичок, що створює бар'єри для відчуття стабільності та безпеки. Такі зміни не обмежуються лише місцевими ринками, а мають глобальний характер, що ще більше ускладнює прогнозування довгострокових кар'єрних перспектив. Невизначеність у майбутньому створює емоційний тиск, посилює тривожність і може сприяти виникненню синдрому самозванця.

Дослідження [7] вводить модель життєвого циклу професій (Occupation Life Cycle, OLC), яка описує п'ять стадій розвитку професій: зростання, пік, коливання, зрілість та спад. Використовуючи дані про вакансії за 2018–2023 роки, дослідження виявляє, що ІТ-фахівці часто опиняються у ситуації, коли певні спеціалізації досягають зрілості або починають втрачати актуальність. Це створює постійний соціально-психологічний тиск щодо необхідності переорієнтації на нові технології чи

навіть зміни професійного напрямку. Крім того, нестабільність ринку вимагає від фахівців активної участі у моніторингу тенденцій і регулярного оновлення своїх знань, що може призводити до емоційного вигорання через перевантаження інформацією [7]. Інше дослідження [8] аналізує вплив штучного інтелекту (ШІ) на ринок праці. Автори зазначають, що автоматизація та впровадження ШІ створюють значні можливості для інновацій, але водночас спричиняють значне скорочення робочих місць у традиційних спеціалізаціях. Це підвищує ризик професійного застою для тих, хто не може швидко адаптуватися до нових умов. Зокрема, відзначається, що робочі місця з низьким рівнем технічної складності є найбільш вразливими до скорочення. Для ІТ-фахівців це також означає необхідність постійного розвитку так званих «гнучких навичок» (soft skills), таких як адаптивність, комунікація та здатність працювати у мультидисциплінарних командах [8].

Соціально-психологічні бар'єри, пов'язані з нестабільністю ринку, проявляються також у відчутті ізоляції та страху втратити свою професійну ідентичність. Нemoжливість прогнозувати майбутнє та зберігати стабільність у професії створює додаткові перешкоди для формування довгострокових планів. Працівники можуть відчувати відсутність контролю над своїм розвитком, що сприяє зниженню впевненості у своїх силах. Це також посилює напруження у професійних спільнотах, де конкуренція за ресурси та можливості зростає.

Зміни ринку змушують фахівців шукати нові підходи до побудови кар'єри. Це може включати активну участь у професійних тренінгах, здобуття додаткових сертифікацій чи навіть спроби змінити спеціалізацію. Багато працівників використовують мережеві контакти і участь у спільнотах фахівців як важливі інструменти для підтримки конкурентоспроможності. Водночас такі заходи часто вимагають значних ресурсів, як фінансових, так і часових, що стає додатковим джерелом стресу. Нерідко працівники відчують «перевантаження навчанням», коли нові знання стають обтяжливими через швидкість змін і кількість необхідної інформації. Тиск з боку клієнтів і роботодавців створює значне навантаження, сприяючи розвитку хронічного стресу, який є одним із ключових соціально-психологічних бар'єрів у професійній діяльності ІТ-фахівців. У цій сфері високі

очікування щодо якості роботи супроводжуються жорсткими дедлайнами, високою конкуренцією та рівнем відповідальності за кінцевий результат. Ці фактори не лише створюють емоційне й фізичне навантаження, але й значною мірою впливають на психологічний комфорт працівників, їхню задоволеність життям, міжособистісні відносини та загальний стан здоров'я. Згідно з дослідженням [9], стрес на робочому місці виникає, коли вимоги перевищують знання і навички працівника, що створює бар'єри для ефективного виконання завдань. Це знижує не лише продуктивність, але й мотивацію, викликає почуття тривожності та призводить до проблем із фізичним і психічним здоров'ям. У ІТ-проектах працівники часто стикаються з високими очікуваннями, що вимагають швидкої адаптації до нових стандартів, технологій та умов праці. У результаті формується постійний психологічний тиск, який у багатьох випадках поступово переростає у хронічний стрес. Цей стан супроводжується зниженням емоційної стійкості, що спричиняє емоційне вигорання та втрату професійного інтересу [9].

Дослідження [10] показує, що працівники ІТ-сфери оцінюють рівень свого стресу в середньому як 7,5 із 10, що значною мірою обумовлено жорсткими дедлайнами, обмеженими ресурсами та великим обсягом робочих завдань. У цих умовах значно підвищується ризик емоційного вигорання, яке супроводжується зниженням концентрації, погіршенням когнітивної функції та загальною виснаженістю. Тривалий стрес також негативно впливає на міжособистісні відносини, створюючи бар'єри у взаємодії між колегами, сприяючи виникненню конфліктів у командах, втраті довіри та ізоляції [10].

Працівники, що опинилися в таких обставинах, використовують різні стратегії для мінімізації негативного впливу стресу. Деякі намагаються встановлювати чіткі межі між роботою та особистим життям, плануючи графік таким чином, щоб виділяти час на відновлення енергії. Цей підхід допомагає зменшити емоційний тиск і відновити баланс між професійним і особистим життям. Інші практикують релаксаційні техніки, такі як медитація, йога чи регулярні фізичні вправи, що допомагають знижувати рівень тривожності та

підтримувати емоційний баланс. Ці методи сприяють не лише фізичному, але й психологічному відновленню, зменшуючи ризик емоційного вигорання.

Для багатьох працівників ключовою стратегією є пошук соціальної підтримки, включаючи обговорення проблем із колегами, близькими людьми або професійними психологами. Соціальна підтримка відіграє важливу роль у подоланні стресу, адже вона сприяє створенню атмосфери довіри, яка зменшує відчуття бар'єру ізоляваності та поліпшує міжособистісні відносини. Обговорення проблем у команді допомагає працівникам відчувати спільність у подоланні викликів, що є потужним засобом зниження соціально-психологічного тиску. Деякі працівники звертаються до формальних і неформальних освітніх заходів, таких як воркшопи чи семінари, спрямовані на підвищення кваліфікації або розвиток навичок тайм-, стрес-менеджменту. Такі заходи не лише полегшують виконання професійних завдань, але й сприяють зниженню бар'єру стресу через підвищення впевненості у власних силах. Інші, навпаки, обирають зміну місця роботи або навіть професійного напрямку, аби знайти менш стресові умови праці та зберегти своє фізичне й психічне здоров'я. Такий вибір часто пов'язаний із бажанням уникнути соціально-психологічного тиску, спричиненого високими вимогами чи невідповідністю очікувань роботодавця.

Висновки. Високі вимоги до якості праці залишаються значним джерелом бар'єрів у професійній діяльності ІТ-фахівців. Цей виклик потребує гнучкості, самодисципліни та здатності до самоорганізації, а також розвитку соціальних навичок, таких як ефективна комунікація та робота в команді. Незважаючи на широкий спектр індивідуальних стратегій подолання стресу, ключовим фактором залишається пошук балансу між кар'єрою та особистим благополуччям.

Література.

1. Массанов А. В. Психологічні бар'єри в діяльності людини // Наука і освіта. 2009. Вип. 4. УДК 155+155.6+150. https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2009/4_2009/5.pdf.
2. Samuel A., Garcia-Constantino M. User-centred prototype to support wellbeing and isolation of software developers using smartwatches // Advanced Notes in

Information Science. 2022. ISBN 978-9916-9760-0-5. DOI: 10.47909/anis.978-9916-9760-0-5.125. <https://anis.pro-metrics.org/index.php/a/article/view/33/34>.

3. Uddin G., Alam O., Serebrenik A. A qualitative study of developers' discussions of their problems and joys during the early COVID-19 months // Empirical Software Engineering. 2022. T. 27, №5. C. 117. DOI: 10.1007/s10664-022-10156-z. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10664-022-10156-z>.

4. Bailey D., Kurland N. A Review of Telework Research: Findings, New Directions, and Lessons for the Study of Modern Work // Journal of Organizational Behavior. 2002. T. 23. C. 383–400. DOI: 10.1002/job.144.

5. Sauter S. L., Murphy L. R., Hurrell J. J. Jr. Prevention of work-related psychological disorders: A national strategy proposed by the National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) // American Psychologist. 1990. T. 45. №10. C. 1146.

6. Beer P., Mulder R. H. The Effects of Technological Developments on Work and Their Implications for Continuous Vocational Education and Training: A Systematic Review // Frontiers in Psychology. 2020. T. 11. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.00918. <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2020.00918>.

7. Chen L., Ji Y., Yao X., Zhu H. Occupation Life Cycle: Analyzing the Trajectories of Professional Development // ArXiv preprint. 2024. <https://arxiv.org/abs/2406.15373>.

8. Engel U., Dahlhaus L. Artificial Intelligence and the Labor Market: Expected Development and Ethical Concerns in the German and European Context // Engel U. (ред.) Robots in Care and Everyday Life: Future, Ethics, Social Acceptance. Cham: Springer International Publishing, 2023. C. 27–48.

9. Палько Т. В. Професійний стрес: причини та наслідки // Актуальні проблеми психології. 2020. Т. 9. №13. <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/47326/1/Професійний%20стрес.pdf>.

10. Bindu N. H., Sridevi P. S. K. A Study on Stress Management Among IT Employees // International Journal of Creative Research Thoughts. 2024. T. 12, №1. <https://ijcrt.org/papers/IJCRTZ020036.pdf>.

ВИСНОВКИ

Теоретично досліджено фактори, які впливають на професійну діяльність лікаря, які в свою чергу опосередковано впливають на його розвиток, комунікацію як внутрішньолікарняному середовищі так із керівництвом й пацієнтом. Враховуючи взаємо-співзалежні стани лікар-пацієнт-керівник визначено фактори, що впливають на систему їх комунікації. Дані фактори сприяють глибинному розумінню розвитку та прогресу як одиниці медичної ланки – лікаря, так і розуміння розвитку та прогресу, популярності серед пацієнтів того чи іншого закладу.

Діяльність фахівців-психологів допомагає у організації просвітницько-профілактичної роботи у формуванні здоров'язберігаючих підходів до попередження чинників, які можуть негативно вплинути на психічний розвиток дівчат старшого шкільного віку щодо формування відповідального ставлення до майбутнього материнства.

Процес адаптації обумовлений взаємозалежністю фізіологічних та психологічних особливостей особистості, особливостей психологічних реакцій на стреси, особливостей професійної діяльності людини, технологічного, науково-інформаційного розвитку суспільства. Адаптація є складним та багатогранним процесом, який передбачає резерви людини і їх оптимальне використання у професійній реалізації за умови пристосування до підвищеної стресогенності.

На першій план психокорекційного супроводу жінки виходять проблеми відчуття жінкою психологічно та емоційно чужою в умовах війни з наростаючим відчуттям «змушено» відторгнутою у мікро- та макро-соціальному середовищі. Виявлено коло причинно-наслідкових зв'язків функціонування жінки, а саме: знижена адаптивна здатність вирішення психосоціальних проблем у суспільстві та родини є наслідком ситуаційно-обумовленого травмуючого впливу війни, що у свою чергу посилюється зниженням комунікативних ланок між жінкою та середовищем внаслідок тривожного стану.

Депресивні стани в юнацькому віці є складним явищем, що вимагає системного підходу до їх діагностики, лікування та профілактики. Ефективні методи подолання депресії включають когнітивно-поведінкову терапію, групові заняття та творчі підходи, а також медикаментозне лікування в тяжких випадках. Превентивні заходи мають бути спрямовані на розвиток емоційного інтелекту, підтримку психічного здоров'я в школах та університетах і зміцнення соціальних зв'язків.

Встановлено руйнуючу дію психологічних особливостей сексуальності на функціонування родини. Виявлено зав'язок між не прийнятністю, не реалізованістю та розчарування партнерів наявними сексуальними відносинами та до бажаними сексом як задоволенням. Виявлено конфлікт між внутрішніми переконаннями й внутрішніми імпульсами. Встановлено, що ставлення до партнера як до сексуального об'єкту без пошуку чуттєвого задоволення корелює з не терпимістю до вербального опису постільних сцен. Статева сором'язливість властива парам з сексуальною пасивністю й огидою до сексуальних проявів. У свою чергу складність набуття сексуального збудження корелювала із захопленням лише фізичного сексу без її духовної складової.

Успішна адаптація ветеранів із посткомуністичним синдромом вимагає комплексного підходу, що поєднує психологічну, соціальну та економічну підтримку. Психотерапевтичні методи, зокрема когнітивно-поведінкова терапія, EMDR, майндфулнес і арт-терапія, довели свою ефективність у роботі з травматичними наслідками, зменшенні тривожності та депресії. Разом із цим соціальна підтримка, участь сім'ї та громадські ініціативи сприяють відчуттю прийняття та інтеграції у суспільство.

У складних життєвих обставинах наявність і включення ресурсів життєстійкості може запобігти розвитку наслідків травматичного стресу. Для прояву життєстійкості під час виникнення складних життєвих ситуацій потрібно тренувати свою психологічну гнучкість для того, щоб вистояти викликам долі, адаптуватись до раптових змін в будь-якому місці і вміти ефективно діяти при любых обставинах.

Самооцінка не обов'язково відображає фактичні здібності чи риси індивідуума, а в основному відноситься до того, як він думає чи відчуває про ці якості та характеристики. Для глибшого розуміння через систематизацію властивостей, запропоновано класифікаційні ознаки видів самооцінки індивідуума, зокрема за: рівнем самооцінки (висока, середня та низька); предметом відображення внутрішньої реальності (інтенційна, потенційна, посіденційна); ступенем саморозвитку (когнітивна, емоційна); важливістю (глобальна, доменно-специфічна); ступенем саморозвитку (когнітивна, емоційна); важливістю (глобальна, доменно-специфічна).

Терапевтична робота з дружинами військовослужбовців спрямована на розвиток стресостійкості в сімейній, особистій та професійній сферах та проводиться у наступних напрямках: психоедукації з питань ПТСР та вторинної травматизації; підтримка у налагодженні гармонійних стосунків із чоловіком, дітьми, колегами; розвиток нових навичок при комунікації із чоловіком; підтримка у пошуку ресурсів для турботи про себе; розвиток навичок самодопомоги при появі різних емоційних реакцій, технікам емоційного регулювання; підтримка у поясненні причинно-наслідкових зв'язків дітям щодо кожної ситуації, особливо що стосується питань втрати та змін; пропарювання важливих питань щодо минулого травматичного досвіду.

Розлади харчової поведінки у дітей та підлітків демонструють тісний взаємозв'язок між психологічними чинниками їх виникнення та ефективністю діагностично-корекційних заходів. Комплексне розуміння особистісних, сімейних та соціальних факторів ризику дозволяє розробляти індивідуалізовані терапевтичні програми, що враховують унікальний патерн психологічних проблем кожного пацієнта. Перфекціонізм, низька самооцінка, порушення образу тіла та проблеми емоційної регуляції виступають ключовими мішенями психотерапевтичної роботи, визначаючи вибір специфічних методів та технік втручання.

Формування та розвиток стресостійкості сприяє розвитку адаптаційних реакцій, що, у свою чергу, підвищує індивідуальну працездатність і сприяє зниженню ризику психосоціальних проблем. Стійкість до стресу включає такі

навички, як емоційний інтелект, планування, гнучке прийняття рішень та ефективне спілкування. Ці навички допомагають людям адаптуватися до складних обставин і підтримувати продуктивне життя. Крім того, стресостійкість також можна тренувати та покращувати.

Підтримка психічного здоров'я працівників під час війни є надзвичайно важливою. Впровадження заходів для зменшення стресу, забезпечення емоційної підтримки, створення безпечних умов роботи та забезпечення доступу до необхідних ресурсів допоможуть зберегти мотивацію та працездатність працівників. Організації мають бути гнучкими та чуйними до потреб своїх співробітників, щоб забезпечити їхнє благополуччя в умовах надзвичайних ситуацій.

Професійна дезадаптація у діяльності медичної сестри пов'язана з підвищеними психоемоційними навантаженнями в поєднанні з відповідальністю в прийнятті рішень при різних екстремальних ситуаціях. Найбільше психоемоційне напруження викликають взаємини з пацієнтами, котрі відчувають біль, тих, хто боїться лікарського втручання, є стурбованими і напруженими, іноді агресивно налаштованими, недовірливими і їх родичами; *запобіжником* професійної дезадаптації ї розвиток емоційно-інтелектуального боку медичної практики, творчий і особистісний ріст професіонала.

Розуміння того, як жінки (матері), чиї діти часто хворіють, здатні вистояти, відновитися і навіть психологічно зміцніти після важких життєвих подій, є викликом для психологічної спільноти, і суспільства в цілому. Дослідження життєстійкості та факторів, що визначають умови її цілеспрямованого формування та розуміння здатності жінки до позитивної психологічної адаптації в несприятливих обставинах допомагає психологам розробити програми психологічної підтримки, розвитку стресостійкості.

Психологічна готовність жінок до материнства відрізняється в залежності від їхнього віку, що підкреслює необхідність розуміння та врахування вікових особливостей у психологічній підготовці до материнства. На психологічну готовність до материнства впливають мотивація жінки стати матір'ю, її потреби та

пізнання в материнстві, усвідомлення важливості своєї ролі як матері, її емоційне ставлення до материнства. Поруч з цим, значний вплив на рівень психологічної готовності має вік майбутньої матері, індивідуальні особливості характеру, мотиви материнства.

Ставлення внутрішньо переміщених осіб до життєвої кризи визначається як індивідуальними, так і зовнішніми чинниками. Ця група людей часто стикається зі значними емоційними, соціальними та економічними викликами, що змушують їх переосмислювати свої життєві цінності, адаптуватися до нових умов та шукати шляхи подолання труднощів. Ефективні стратегії подолання кризи включають мобілізацію внутрішніх і зовнішніх ресурсів, розвиток адаптивних навичок та механізмів саморегуляції, що дозволяють справлятися зі стресом і зберігати баланс.

Агресивність та девіантність виявляється у всіх людей, але у кожної людини вона характеризується різним рівнем і певними особливостями. Сила агресивно-девіантних реакцій, їхня частота, а також спрямованість і тривалість залежать від багатьох причин, тому вони повинні аналізуватися з точки зору впливу на людину фізіологічних, психологічних, соціальних та ситуаційних чинників. Прояв агресивної-девіантності є наслідком невдоволення людини навколишньою дійсністю, рівнем свого життя, іншими людьми або ж самим собою.

Віктимна поведінка є формою дезадаптивної поведінки, що проявляється у комплексі стійких властивостей, які обумовлюють схильність підлітку стати жертвою несприятливих умов соціалізації. Факторами віктимної поведінки підлітків можуть бути індивідуально-психологічні якості (емоційна нестійкість, тривожність, низька самооцінка), відсутність комунікативних навичок у взаємодії із членами родини та соціальним середовищем.

Під час перебування в зоні бойових дій військовослужбовці зазнають постійного впливу на них стрес-факторів, що має негативні наслідки для психоемоційного та фізичного стану воїнів. Процес психологічної реабілітації військовослужбовців, що повернулись з зони бойових дій, спрямований на покращення їх психоемоційного стану, опрацювання травмального досвіду, отриманого у зоні бойових дій, а також на полегшення процесу адаптації до умовах

цивільного життя. Психологічна реабілітація охоплює значну кількість методів психологічного консультування та психотерапії, зокрема, КПТ, арттерапію, зоотерапію, музичну терапію, тілесно-орієнтовану терапію тощо.

Визначення дисгармонійної родини вимагає врахування не лише внутрішньо-сімейних проблем, але й між поколінних факторів, таких як передача травматичного досвіду або рольові моделі. Важливим завданням сучасної психології є розробка інструментів, які допомагають сім'ям виходити з кризових ситуацій, усувати джерела дисгармонії та створювати здоровий емоційний клімат для розвитку особистості кожного з її членів.

В компаніях потрібно проводити систему заходів, спрямованих на предмет менеджменту своїх станів, формувати вміння повертати себе до нормального стану. Розуміння психологічних особливостей професійної діяльності ІТ-фахівців є ключовим для розробки ефективних стратегій підтримки їхнього емоційного та професійного благополуччя. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на вивчення впливу організаційної культури на психологічний стан ІТ-спеціалістів, а також на розробку програм профілактики емоційного вигорання в комерційних організаціях.

Значна частина досліджень, пов'язаних з емоційним інтелектом та його розвитком у підлітковому віці, показує, що саме у цій віковій категорії він є критичною та вирішальною складовою, яка сприятиме формуванню їхньої особистісної та міжособистісної поведінки. Навчання умінню керувати власними емоціями та розрізненню чужих емоцій є важливими компонентами у підвищенні рівня емоційного інтелекту, які впливають на формування самосвідомості, розвитку та умінню емпатії, умінню адаптуватися, самоконтролю та оптимізму, що в цілому сприятимуть вибудові позитивного емоційного клімату та гармонійному розвитку не лише однієї особи, але і всього колективу, в якому перебуває індивід.

Першочерговим у переліку цінностей майбутнього фахівця галузі психології, має бути збереження власного психічного здоров'я і власної резильєнтності та надання психологічної допомоги з метою підтримки і захисту психічного здоров'я найбільш вразливих членів суспільства. Завданням вищого закладу освіти є вибір

стратегій формування ціннісних орієнтацій студентів для застосування знань в системі збереження психічного здоров'я.

Навчання протягом життя позиціонується як повноправне освітнє поле з відповідною увагою до контролю й перевірки якості та забезпеченням визнання різноманітних форм освіти. Зростаюче різноманіття пізнавально-інформаційних запитів різних верств населення неможливо задовольнити в рамках існуючих дотепер форм традиційної освіти. Освіта протягом життя покликана підвищувати рівень загальних знань і розширювати можливості участі громадян у культурній, соціальній і політичній діяльності країни.

Сучасні інтернет-технології значно змінили підхід до надання психологічної підтримки, забезпечуючи доступність і зручність для широкої аудиторії. Анонімність і конфіденційність онлайн-форматів знижують рівень стресу та страху у клієнтів, що сприяє більш відкритому та ефективному спілкуванню. Важливо, що інтернет-платформи надають можливість використання інтерактивних інструментів для підтримки клієнтів. Онлайн-терапія дозволяє психологам більш точно відслідковувати прогрес, надавати індивідуальні рекомендації та залучати клієнтів до активної участі в процесі терапії через мобільні додатки, відео-консультації чи форуми.

Проблема ментального здоров'я та психологічних особливості порушення резильєнтності у персоналу аграрної сфери в ситуації невизначеності та ризику вивчається у наукових дослідженнях. Проте, особистісна резильєнтність, депресивні та тривожні явища, психосоціальний стрес, поведінка в умовах невизначеності й ризику та здатність персоналу аграрного сектору економіки сприймати психологічну підтримку вивчені не достатньо й потребують подальших досліджень, у тому числі й з урахуванням чинників травматичних подій у наслідок війни в Україні.

Розроблена «Комплексна програма психологічного супроводу для зростання мотивації до працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів» довела свою ефективність у підвищенні готовності випускників до професійної діяльності та адаптації до викликів сучасного ринку праці. Програма

сприяла розвитку стресостійкості, формуванню внутрішньої мотивації, вдосконаленню професійних навичок і створенню умов для успішної професійної самореалізації в умовах постійної невизначеності.

Психологічне благополуччя ветеранів тісно пов'язано з параметрами: суб'єктивне благополуччя, стресостійкість, ментальне здоров'я, стосунки з оточенням. Сприятливий організаційний клімат також позитивно впливає на інтеграцію ветеранів до корпоративної культури. Фізичне здоров'я також має достовірний вплив на характеристики благополуччя та ментального здоров'я. Впровадження регулярних фізичних активностей та забезпечення доступу до медичних послуг також є ключовими елементами успішної інтеграції ветеранів.

Резильєнтність є критично важливим фактором у сфері продажів, який позитивно впливає на роботу менеджерів. Резильєнтність успішних менеджерів з продажу визначається здатністю пристосовуватися до стресових ситуацій, витримувати труднощі і досягати цілей незважаючи на перешкоди. Загалом, резильєнтність у продажах дозволяє не тільки переживати негативні моменти, а й використовувати їх як можливість для росту та розвитку. Організації, які активно працюють над розвитком резильєнтності, отримують конкурентні переваги на ринку та створюють стабільне середовище для своїх працівників.

Проблема психологічних стресів у діяльності працівників агробізнесу в довготривалих кризових умовах розглядається із багатьох аспектів. Проте, чинники тривоги, ціннісні орієнтації, міжособистісні стосунки, емоційне вигорання, копінг-стратегії поведінки, опір змінам в контексті успішності соціально-психологічної та професійної адаптації персоналу в довготривалих кризових умовах вивчені не достатньо та потребують подальших досліджень.

Дослідження підтверджує, що soft skills та емоційний інтелект є важливими ресурсами для подолання професійного стресу працівників сфери обслуговування. Розвиток цих навичок сприяє не лише підвищенню професійної ефективності, а й збереженню психічного здоров'я. Такі soft skills, як здатність до ефективної комунікації, управління конфліктами, командна робота та адаптивність, дозволяють працівникам успішно реагувати на стресові ситуації та забезпечують

комфортне робоче середовище. Емоційний інтелект, зі свого боку, сприяє усвідомленню власних емоцій, їх регуляції та створенню умов для конструктивної взаємодії з іншими людьми.

Розроблено рекомендації щодо розвитку резильєнтності медіаторів, які можуть бути інтегровані у навчальні програми для підготовки фахівців. Ці рекомендації включають впровадження регулярних тренінгів, акцент на емоційну регуляцію, розвиток професійної життєстійкості, самомотивацію та турботу про себе. Рекомендації можуть бути використані для підготовки та підтримки медіаторів, сприяючи підвищенню їхньої ефективності, емоційної стійкості та професійного благополуччя.

Дослідження трудової мотивації та задоволеності праці виявило, що переважна більшість працівників незадоволені своєю професійною діяльністю з багатьох причин, серед яких: фізичні умови праці, характер роботи, заробітна плата, недостатні можливості службового (професійного) зростання, тривалість робочого дня. Найважливішою складовою трудової мотивації є ступінь задоволеності місцем роботи і виконуваної роботою. Підвищення задоволеності працівників працею в організації призведе до підвищення їх продуктивності діяльності, а висока задоволеність покращує ставлення до роботи і до організації в цілому.

Сімейне життя включає в себе побут, роботу, дозвілля та особисті стосунки кількох незалежних осіб. Молоді люди мають формувати власну систему переконань і уявлень стосовно сімейного життя безпосередньо у процесі адаптації до нього. Для цього їм потрібно регулярно і цілеспрямовано поглиблювати знання з питань психології міжособистісних стосунків і сексуальності, конфліктології, виховання дітей, та інших аспектів сімейної діяльності.

Адвокати, які працюють в умовах війни, часто стикаються з підвищеним рівнем стресу, тривоги та депресії через свою професійну діяльність та морально-етичні дилеми. Виявлено основні фактори ризику, які включають постійний контакт з жертвами війни, високе емоційне навантаження та необхідність швидко приймати складні рішення. Результати дослідження підкреслюють важливість

психотерапевтичної підтримки та створення спеціальних програм допомоги для працівників адвокатури. Збереження психоемоційної стабільності адвокатів є критично важливим для забезпечення ефективного правозастосування та захисту прав людини в умовах збройних конфліктів.

Формування резильєнтності у медичних працівників вимагає комплексного підходу, що включає розвиток корисних звичок, регулярну роботу над собою та впровадження практичних методів управління стресом. Інтеграція заходів з управління стресом, створення сприятливого робочого середовища та гармонійне поєднання особистісних і організаційних методів розвитку резильєнтності є критично важливими для збереження емоційної рівноваги, ефективності професійної діяльності та високої якості життя медичних працівників.

Високі вимоги до якості праці залишаються значним джерелом бар'єрів у професійній діяльності ІТ-фахівців. Цей виклик потребує гнучкості, самодисципліни та здатності до самоорганізації, а також розвитку соціальних навичок, таких як ефективна комунікація та робота в команді. Незважаючи на широкий спектр індивідуальних стратегій подолання стресу, ключовим фактором залишається пошук балансу між кар'єрою та особистим благополуччям.

[illegible]



Навчатись психології – варто!



КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ



ЄВРОПЕЙСЬКА ОСВІТА

Освітні програми



АКАДЕМІЯ ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН І ТУРИЗМУ

НАВЧАТИСЯ В АКАДЕМІЇ - ЦЕ ЦІКАВО!
Високий професійний рівень викладання,
сучасні навчальні програми



EUROPEAN EDUCATION

*Бакалаврат
Магістратура
Аспірантура*

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Education - Experience Effect

📍 Київ, 17 вул. Кілієва дорога, 3-А, 03187 Україна
☎ +380 (93) 969-58-99, (044) 526-06-64

Освіта - Досвід Результат

АКАДЕМІЯ ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН І ТУРИЗМУ

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ 053 ПСИХОЛОГІЯ

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

БАКАЛАВРАТ



Підготовка фахівців, здатних професійно розв'язувати проблеми та вирішувати завдання науково-теоретичного та практичного характеру в галузі психології та інших гуманітарних і суспільних сферах, що передбачає застосування професійних компетентностей

- Розв'язування складних задач і проблем у сфері психології
- Навички проведення психологічних досліджень та здійснення інновацій
- Володіння технологіями психологічного консультування та психотерапії

ПСИХОЛОГІЯ БІЗНЕСУ ТА УПРАВЛІННЯ

- Отримання компетентностей з психології управління підприємством,
- Підготовка висококваліфікованих кадрів, які володіють сучасним мисленням, теоретичними знаннями та прикладними вміннями

КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

- Набуття компетентностей з клінічної психології, психосоматичної медицини, нейропсихології
- Навички кризового психологічного консультування, групової психотерапії і супервізії, клінічної психодіагностики

МАГІСТРАТУРА



АСПІРАНТУРА



ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ОВОЛОДІННЯ ЗНАННЯМИ ЗДІЙСНЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ З ПСИХОЛОГІЇ

- Підвищення рівня професійної та викладацької майстерності
- Розвиток науково-дослідницьких навичок
- Поглиблення рівня аналітичної спрямованості мислення
- Розвиток навичок підготовки та оформлення результатів наукових робіт, аналітичних доповідей, монографій тощо

European Community Course Credit Transfer System

Бакалавр з психології. Термін навчання 3 роки 10 місяці. Форма навчання: денна, заочна. Обсяг програми 240 кредитів ECTS. Цікаве навчання із здобуттям навичок та знань, які забезпечують зайнятість за спеціальністю психолога, можливість подальшої освіти, кар'єрного зростання та самозайнятості приватного психолога.

Магістр з психології, психолог, викладач вищого навчального закладу. Форма навчання: денна, заочна. Студентоцентризоване, проблемно-орієнтоване та ініціативне самонавчання. Інтерактивні, проектні, інформаційно-комп'ютерні, саморозвиваючі, колективні та інтегративно-контекстні технології навчання.

Доктор філософії з психології (Ph.D.). Навчання 4 роки (за спорідненою та неспорідненою спеціальністю). Форма навчання: денна, заочна. Обсяг програми 60 кредитів ECTS. Асистентська педагогічна практика тривалістю 3 тижні. Підготовка здійснюється шляхом ефективного поєднання традиційних та сучасних педагогічних технологій, таких як: інформаційно-комунікаційне навчання, використання інтерактивних методик, навчання за технологією тренінгу.

Наукове видання

**ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я ТА
РЕЗИЛЬЄНТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ**

Монографія

За загальною редакцією

Г.А. Приба, Л.Є. Бебези

Матеріали друкуються в авторській редакції.

*Автори несуть відповідальність за достовірність фактичних
даних і мовностилістичний рівень матеріалів.*

Підписано до друку 30.01.2025. Формат 60х84 1/16

Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman.

Умов. друк. арк. 19.6.

Наклад 100 шт.

Видавець і виготовлювач: Ф-ОП Гуляєв О.В.

